

总主编 周丽莎 朱书秀
主编 朱书秀 吴绪平

针灸名师
临床笔记丛书

筋伤病证卷

JIN SHANG BING ZHENG JUAN

汇集临床经验案
汇聚特色疗法

中国医药科技出版社

策划编辑/白极
责任编辑/白极
封面设计/山设计

针灸名师
临床笔记丛书

筋伤病证卷

JIN SHANG BING ZHENG JUAN



上架建议 中医·针灸

ISBN 978-7-5067-3943-6



9 787506 739436 >

定价：32.00元

《筋伤病证卷》编委会

- 主 编

朱书秀 吴绪平

- 副主编

柯东港 朱青艳

- 编 委 (以姓氏笔画为序)

冯美果 朱书秀 朱青艳

吴绪平 孟 迂 周长胜

柯东港

总主编 周丽莎 朱书秀
主编 朱书秀 吴绪平

针灸名师
临床笔记丛书

筋伤病证卷

JIN SHANG BING ZHENG JUAN

中国医药科技出版社

《针灸名师临床笔记丛书》编委会

• 总 主 编

周丽莎 朱书秀

• 副总主编 (以姓氏笔画为序)

马 骏 王维宁 孔立红 付艾妮
苏 飞 吴绪平 张 英 涂 乾
梁 忠

• 编 委 (以姓氏笔画为序)

马 利 马 骏 王小月 王 芳
王维宁 孔立红 付艾妮 付 蔷
冯美果 朱书秀 朱青艳 全国芳
苏 飞 杜艳军 吴绪平 张 英
周丽莎 孟培燕 涂 乾 望庐山
梁 忠 褚 伟

• 主 审

孙国杰

图书在版编目(CIP)数据

针灸名师临床笔记丛书. 筋伤病证卷/朱书秀, 吴绪平主编. —北京: 中国医药科技出版社, 2008. 9

ISBN 978 - 7 - 5067 - 3943 - 6

I. 针... II. ①朱... ②吴... III. 筋膜疾病—针灸疗法 IV. R245

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 143222 号

美术编辑 陈君杞

版式设计 郭小平

出版 中国医药科技出版社

地址 北京市海淀区文慧园北路甲 22 号

邮编 100082

电话 责编: 010 - 62250159 发行: 010 - 62227427

网址 www.cspyp.com.cn

规格 958 × 650mm¹/₁₆

印张 19

字数 276 千字

印数 1—5000

版次 2008 年 9 月第 1 版

印次 2008 年 9 月第 1 次印刷

印刷 北京市通州皇家印刷厂

经销 全国各地新华书店

书号 ISBN 978 - 7 - 5067 - 3943 - 6

定价 32.00 元

本社图书如存在印装质量问题请与本社联系调换



博采众长
拓業岐黃

李维衡

二〇〇七年九月

中国针灸学会会长 李维衡

《筋伤病证卷》编委会

- 主 编

朱书秀 吴绪平

- 副主编

柯东港 朱青艳

- 编 委 (以姓氏笔画为序)

冯美果 朱书秀 朱青艳

吴绪平 孟 迂 周长胜

柯东港

《针灸名师临床笔记丛书》编委会

• 总 主 编

周丽莎 朱书秀

• 副总主编 (以姓氏笔画为序)

马 骏 王维宁 孔立红 付艾妮
苏 飞 吴绪平 张 英 涂 乾
梁 忠

• 编 委 (以姓氏笔画为序)

马 利 马 骏 王小月 王 芳
王维宁 孔立红 付艾妮 付 蔷
冯美果 朱书秀 朱青艳 全国芳
苏 飞 杜艳军 吴绪平 张 英
周丽莎 孟培燕 涂 乾 望庐山
梁 忠 褚 伟

• 主 审

孙国杰

博采众长
拓業岐黃

李维衡

二〇〇七年九月

中国针灸学会会长 李维衡

荟萃數百匠家之經驗

驅除千萬患者之痼疾

石學敏

2007.9.

中國工程院院士 石學敏

孙 序

针灸是中医学中的一颗璀璨明珠，几千年来为我国人民的健康、保健做出了巨大贡献。从公元 6 世纪传到朝鲜、日本以后，又传到了东南亚、欧洲等许多国家。针灸医学已在全球范围内得到了广泛的推广和运用，为世界人民的防病治病做出了卓越贡献。

早在 20 世纪 80 年代，世界卫生组织原总干事中岛宏博士就指出：“中国传统医学能够治疗西洋医学束手无策的许多疾病”，“针灸已成为世界通行的一门新的医学科学”。针灸医学有着悠久的历史，在历史长河中形成了完整的理论体系，积累了丰富的临床经验，发明创造了多种行之有效的操作技术。我坚信它必将成为世界主流医学的一个组成部分。

针灸医学在我国的疾病预防、治疗和康复中，以简、便、验、廉和疗效显著而被广泛运用，每年发表的有关针灸基础研究和临床运用的论文有 2000 篇左右。其中临床报道占了大多数。但不少医家的学术思想、治疗方法、临床经验未能很好地得到发扬和推广。为此，周丽莎教授组织有关专家学者，查阅历代医籍、医学刊物和临床专著，在重视科学性、先进性，注重实用性的同时，将散在各医家宝贵的针灸临床经验精华，编撰成《针灸名师临床笔记丛书》。丛书编写注重于临床，着重总结医家的学术思想、临床特色、治疗方法，并附典型病例加以佐证，是广大医务人员临床工作的重要的案头参考书。

《针灸名师临床笔记丛书》，经过参编专家的艰苦努力，即将付梓问世，这必将能嘉惠医林，启迪后学，造福民众。值该书出版之际，欣然作序、以表祝贺。

中国针灸学会副会长

孙国杰

2007 年 10 月 8 日

前言

针灸是中医学宝库中一门独特的遗产，是中医学的重要组成部分。几千年来，针灸学经历代医家不断发展、完善，已形成一门独立的学科，获得国内外医学界的广泛重视和赞誉。近年来，随着高科技手段在针灸领域的运用，扩大了针灸治疗的范围，提高了治疗效果，使这门学科更加丰富、更臻完善。

随着健康保健知识的日益普及，人们对化学合成药品不良反应的担心日渐增加，相反，对针灸外治等自然疗法越来越愿意接受。因此，具有验、便、廉和独特效果的针灸治疗方法，在治疗各种疾病方面不断取得新的突破性发展。

近年来，大量针灸医学的书籍、期刊出版发行，对指导临床研究和推广、普及针灸医学知识起到了积极深远的影响。然而，不少医家的学术思想、新的疗法和宝贵的经验，仍然只是散见于文献刊物之中，且缺乏系统的整理与分类，使学者不易领会，研究者搜寻亦难，难以最大限度地满足广大医务工作者学习和借鉴的需要。有鉴于此，我们组织有关专家，查阅收集了近现代医籍、医学刊物和临床专著，在重视科学性、实用性的同时，将各医家散在的针灸临床治疗方法和经验编撰成《针灸名师临床笔记丛书》。

该套丛书注重于临床，在病种选录上，力求收集针灸科常见、且疗效显著的疾病种类，在内容上，突出每一种病证的独到的针

灸治疗精法验案，同时又百花齐放，竟显各家学说的光彩，并且在每一个治疗经验前，都以一句精炼的标题概括其与众不同的特点，旨在两意：一是尊重各个第一作者的学术成就；二是方便读者理解。丛书分为《妇儿病证卷》、《心脑血管病证卷》、《肺系病证卷》、《筋伤病证卷》、《皮肤病证卷》、《脾胃病证卷》、《肾膀胱病证卷》、《内分泌代谢病证卷》共8个分册。可供针灸教学、临床、科研人员及在校中医专业学生参考使用。

编写该套丛书工作量繁重，由于人员分散，缺乏经验，虽做了极大努力，但限于水平，缺点和疏漏在所难免，恳请读者赐教与指正。

此书在编写过程中，承蒙中国针灸学会会长李维衡教授指点与题词，中国工程院院士石学敏教授题词并提出宝贵意见，中国针灸学会副会长、博士生导师孙国杰教授为本书写序言并赠墨宝，在此一并表示谢意。

《针灸名师临床笔记丛书》编委会

2008年1月

编写说明

本书是《针灸名师临床笔记丛书》中的一个分册。随着人们生活节奏的加快，生活、工作方式的改变，工作压力的加大，筋伤病证已成为严重影响人们生活的常见疾病。多年来，医学界对该类疾病的研究取得了重大进展，针灸医学由于在该领域治疗效果独特、迅速且操作简便、无毒性和不良反应，受到广大患者的欢迎。但是因各种原因，不少医家的学术思想、新的疗法和宝贵经验，散在于大量的文献刊物之中，难以为医务工作者总结和借鉴，不易于继承和发扬，有鉴于此，我们组织了有关专家学者，收集了诸多筋伤病证的文献资料，荟萃了各家的证治经验，在重视科学性、实用性的同时，试图从多方位、多层次来反映中医针灸在筋伤病证方面的经验精华，融古汇今，力求其系统完整，经过仔细遴选，汇编成书。

本书注重于临床，力求以收集针灸科常见的筋伤病证，以及各医家的临床治验或特色治疗为原则。对颈椎病、落枕、肌性斜颈、肩关节周围炎、肱骨外上髁炎、腕管综合征、腱鞘囊肿、急性腰扭伤、慢性腰痛、腰椎间盘突出症、第三腰椎横突综合征、腰椎管狭窄症、梨状肌综合征、坐骨神经痛、膝关节炎、踝关节扭挫伤、足跟痛、外伤性截瘫等 18 种疾病进行了分述。在每种病（证）之前均有内容提要，简要介绍该病证的病因病机，治疗原则，以及各医家的诊治特点，便于读者选择应用。在每位医家的经验之中，重点介绍个人的辨治方法，经穴配方的运用与具体操作技巧，以求实用，切合临床。每种病证中收录了多种治疗方法，诸如毫针法、头针法、耳针法、梅花针法、电针法、穴位注射法、三棱针等。总之，在治疗方法上，各有千秋，别具特色。

此书虽广集历代学术理论和各名家之诊疗精华，但由于我们的经验不足，加之时间仓促，还有许多经验未能收入，致有遗珠之憾，同时在内容的广度和深度方面亦有未尽人意之处，热切期望广大读者批评指正。

本书在编写过程中，得到了许多著名专家教授的悉心指导帮助，在此表示衷心感谢。并向为本书编辑、出版、发行做出了辛勤劳动的人士表示谢忱。

《筋伤病证卷》编委会

2008 年 1 月

目 录

颈椎病

1-28

- 一、经验取穴 关刺治疗 /2
- 二、小醒脑针 养脑安神 /3
- 三、夹脊穴为主 气至而有效 /3
- 四、大椎-完骨-百会 隔姜灸 /4
- 五、辨证分型 重针刺浅深 /5
- 六、远近配穴 雀啄刺 /6
- 七、后溪-颈夹脊 重在于通 /7
- 八、局部取穴为主 短刺 电针 /8
- 九、针刺夹脊 丹参穴位注射 /9
- 十、颈四穴 电针 /10
- 十一、针刺刮痧 两法并用 /10
- 十二、针推牵 综合治疗 /11
- 十三、定喘-大椎 三针齐刺 /12
- 十四、独取大椎 梅花针叩刺 /13
- 十五、经验取穴 抬肩通络法 /13
- 十六、颈夹脊穴埋线 作用持久 /14
- 十七、针药并用 动引其气 /15
- 十八、针推刮 分步施治 /16
- 十九、疏调太阳 行气活血 /17
- 二十、夹脊穴 配纳络取穴 /18
- 二十一、综合治疗 通络止痛 /19
- 二十二、治分六步 通则不痛 /21
- 二十三、辨经取穴 通经活络 /23
- 二十四、随症取穴 刺络配角法 /25

- 五、局部取穴 青龙摆尾 /83
- 六、围针刺拔罐 结合穴注 /83
- 七、以痛为腧 小宽针配火罐 /84
- 八、杨刺阿是 通经活络止痛 /85
- 九、梅花针配点穴 止痛 /86
- 十、针推并用 通则不痛 /87
- 十一、独取曲池 穴注艾灸 /88

腕管综合征

91 - 100

- 一、局部取穴 随症加减 /92
- 二、腕三针 - 内关 - 间使 气至有效 /92
- 三、据解剖取穴 平刺单向捻转 /93
- 四、小钹针 以松为主 /94
- 五、独取大陵 穴位埋针 /95
- 六、针药并用 通则不痛 /96
- 七、大陵 - 内关 隔姜灸 /97
- 八、水针配推拿 活血化瘀 /98
- 九、针推并用 舒筋通络 /98

腱鞘囊肿

101 - 106

- 一、火针速刺 软坚散结 /101
- 二、局部取穴 恢刺 /102
- 三、齐刺温针灸 祛瘀散结 /103
- 四、三棱针点刺 简单效佳 /103
- 五、局部取穴 围针刺加灸 /104
- 六、循经取穴 药物外敷 /105
- 七、局部取穴 围刺挑刺 /105

急性腰扭伤

107 - 126

- 一、循经远取 互动式针刺 /108

二十五、电针刺络拔罐 三法并用 /26

落 枕

29 - 45

- 一、独取悬钟 赤凤迎源 /30
- 二、单刺犊鼻 驱风止痛 /30
- 三、落枕穴 重刺激 /31
- 四、巨刺后溪 散瘀止痛 /32
- 五、外关巨刺拔罐 立竿见影 /32
- 六、手三针治落枕 针到即愈 /33
- 七、温针走罐 祛风通络 /34
- 八、针刺天宗 舒经活络 /35
- 九、手足配穴 后溪-束骨 /35
- 十、耳穴针刺压丸 祛痛快 /36
- 十一、顽固性落枕 针罐推 /37
- 十二、液门透中渚 左右捻转 /38
- 十三、辨经取穴 快针拔罐 /38
- 十四、落枕-阿是穴 阻力针刺配推拿 /39
- 十五、针罐并用 /40
- 十六、多法并用 法分五步 /41
- 十七、自配刮痧油 泻补结合 /42
- 十八、意气针灸 远端针刺拔罐 /43

肌性斜颈

46 - 55

- 一、重取穴 通少阳-阳明经气 /46
- 二、缓刺不留针 配按摩 /47
- 三、针刺为主 配中药外敷 /48
- 四、独取太溪 气至有效 /49
- 五、针刺治疗 祛邪缓急 /50
- 六、针刺推拿 软坚散结 /50
- 七、头穴体穴 电针治疗 /51

八、阿是穴分刺 直捣病所 /53

九、穴位注射 舒筋活血 /53

肩关节周围炎

56 - 78

一、透刺 - 巨刺 通则不痛 /57

二、肩髃 - 肩前 - 肩后 多针透刺 /58

三、独取阳陵泉 互动式针刺 /59

四、肩髃穴 三透法 /60

五、巨刺 配运动疗法 /61

六、左右配穴 埋针电针 /61

七、循经远取 针罐并用 /63

八、肩内陵为主 傍针刺 /64

九、主配穴并用 针刺耳压 /65

十、随症选穴 针刺穴注 /65

十一、阳明经穴 顺序针刺 /66

十二、透穴丛刺 分步施治 /67

十三、局部取穴 温针灸 /68

十四、运动针法 配刺络拔罐 /68

十五、主穴三个 热补针法 /69

十六、循经三步针法 通络止痛 /70

十七、肩部三针 讲究手法 /72

十八、六经分治 针灸并用 /73

十九、针刺运动疗法 通络止痛 /74

二十、条口透承山 针通两经 /76

肱骨外上髁炎

79 - 90

一、阿是穴关刺 活血止痛 /80

二、苍龟探穴 重在取穴 /80

三、曲池 - 手三里 电针配温针 /81

四、远端辨证选穴 虚补实泻 /82

- 五、局部取穴 青龙摆尾 /83
- 六、围针刺拔罐 结合穴注 /83
- 七、以痛为腧 小宽针配火罐 /84
- 八、杨刺阿是 通经活络止痛 /85
- 九、梅花针配点穴 止痛 /86
- 十、针推并用 通则不痛 /87
- 十一、独取曲池 穴注艾灸 /88

腕管综合征

91 - 100

- 一、局部取穴 随症加减 /92
- 二、腕三针 - 内关 - 间使 气至有效 /92
- 三、据解剖取穴 平刺单向捻转 /93
- 四、小钹针 以松为主 /94
- 五、独取大陵 穴位埋针 /95
- 六、针药并用 通则不痛 /96
- 七、大陵 - 内关 隔姜灸 /97
- 八、水针配推拿 活血化瘀 /98
- 九、针推并用 舒筋通络 /98

腱鞘囊肿

101 - 106

- 一、火针速刺 软坚散结 /101
- 二、局部取穴 恢刺 /102
- 三、齐刺温针灸 祛瘀散结 /103
- 四、三棱针点刺 简单效佳 /103
- 五、局部取穴 围针刺加灸 /104
- 六、循经取穴 药物外敷 /105
- 七、局部取穴 围刺挑刺 /105

急性腰扭伤

107 - 126

- 一、循经远取 互动式针刺 /108

- 二、独取大肠俞 强刺激 /109
- 三、针罐并用 通则不痛 /109
- 四、夹脊穴 长针深刺 /110
- 五、后溪-阿是穴 运动针刺 /111
- 六、独取命门 长针深刺 /111
- 七、全息腰穴-人中 针刺配合运动 /112
- 八、殷门 强刺 /113
- 九、上髂穴 多发针而深之 /114
- 十、急性腰扭伤 取委中-人中 /114
- 十一、天柱针刺 局部叩刺拔罐 /115
- 十二、深刺秩边 配推拿治疗 /115
- 十三、针推罐 三法并用 /116
- 十四、针药并用 化瘀止痛 /118
- 十五、滞针运动 针用泻法 /119
- 十六、急性腰痛 治法有三 /119
- 十七、鼻针疗法 消瘀散滞 /120
- 十八、独取膻中 粗长针针刺 /120
- 十九、排针透刺 镇痛力强 /121
- 二十、攒竹-阳陵泉 针刺推拿 /122
- 二十一、合穴委中 刺血拔罐 /123
- 二十二、急性腰痛 针到痛止 /123

慢性腰痛

127 - 134

- 一、以痛为腧 温针合谷刺 /128
- 二、局部取穴 温针灸走罐 /128
- 三、循经取穴 手法为先 /129
- 四、手针疗法 见效快 /130
- 五、病因不同 治法各异 /131
- 六、三法并用 综合治疗 /132
- 七、针刺穴注 疏经通络 /133

腰椎间盘突出症

135 - 154

- 一、脊柱九针 定位明确 /136
- 二、夹脊穴 短刺 /137
- 三、水针注射 华佗夹脊穴 /137
- 四、扬刺为主 综合治疗 /138
- 五、腰突点-腰眼 短刺法 /140
- 六、深刺为主 配刺络拔罐 /141
- 七、辨证取穴 气至而有效 /142
- 八、针推并用 疏经通络 /143
- 九、足三阳郄穴 通络止痛 /144
- 十、人中-委中 强刺激 /145
- 十一、针推穴注 标本兼治 /146
- 十二、腰夹脊穴 傍针刺 /147
- 十三、白虎摇头 泻实通经 /148
- 十四、后顶交叉透刺为主 配合运动疗法 /148
- 十五、接气通经 气至病所 /149
- 十六、辨证分型 针药并用 /150
- 十七、远针近推 综合治疗 /151

第三腰椎横突综合征

155 - 176

- 一、刮痧配拔罐 行气通络止痛 /156
- 二、阿是穴 合谷刺加拔罐 /157
- 三、以痛为腧 梅花针叩刺 /158
- 四、三针齐刺 直达病所 /159
- 五、齐刺配温针灸 通经止痛 /160
- 六、气海俞为主 电针配火罐 /161
- 七、阿是穴-委中 透穴刺 /162
- 八、腕踝针加推拿 解痉止痛 /162
- 九、围刺加推拿 针到气到 /163

- 十、温针灸 配经穴按摩 /165
- 十一、针刀治疗 疏通经脉 /166
- 十二、扬刺滞针法 通则不痛 /167
- 十三、针拔配穴注 活血化瘀 /168
- 十四、综合治疗 消肿止痛 /169
- 十五、压痛点 髂针埋藏 /171
- 十六、穴注配针刀 分期治疗 /171
- 十七、针刺为主 气至有效 /173

腰椎管狭窄症

177 - 190

- 一、次髂穴位注射 镇痛 /178
- 二、调椎整曲法 综合治疗 /179
- 三、钩针松解术 刺激量大 /180
- 四、从肾督着手 针药并用 /181
- 五、小针刀为主 三管齐下 /182
- 六、针刺夹脊穴 配手法治疗 /183
- 七、针推药 三法并用 /184
- 八、综合治疗 松则不痛 /186
- 九、针药结合 辨证施治 /187
- 十、中药穴位注射 配硬脊膜外封 /188

梨状肌综合征

191 - 204

- 一、以痛为俞 傍针刺 /192
- 二、刺血配小针刀 局部整体同治 /193
- 三、局部取穴 多向刺 /193
- 四、阿是穴 巨刺拔罐 /194
- 五、阿是电针 环跳穴注 /195
- 六、辨证取穴 白虎摇头 /196
- 七、腿三针为主 气至病所 /197
- 八、膀胱俞-胞育 重在手法 /197

- 九、局部用穴 综合治疗 /198
- 十、八髎-秩边 重刺法 /199
- 十一、阿是穴小针刀 通络止痛 /200
- 十二、综合治疗 标本兼顾 /201
- 十三、辨经取穴 齐刺配火罐 /202

坐骨神经痛

205 - 220

- 一、长针刺环跳 诱导循经感传 /206
- 二、循经取穴 火针刺 /206
- 三、经络辨证 首尾齐刺 /207
- 四、主穴阳陵泉 龙虎交战 /208
- 五、循经取穴 盘针刺 /209
- 六、理据内经 主穴齐刺 /210
- 七、委阳-飞扬-跗阳 顺序针刺 /211
- 八、次髎-环跳 温针灸 /211
- 九、行气针 重手法 /212
- 十、攒竹-风池 疏导经气 /213
- 十一、环跳为主 随症加减 /214
- 十二、辨经取穴 温和灸配针刺 /215
- 十三、头穴缪刺 疼痛自除 /216
- 十四、阿是穴为主 齐刺输刺 /217
- 十五、长针一支 独刺环跳 /218
- 十六、针药并用 疏通经络 /218

膝关节炎

221 - 235

- 一、局部取穴为主 短刺恢刺 /221
- 二、透刺膝眼 祛风散寒 /222
- 三、散寒除湿 温针灸 /223
- 四、局部针刺 拔罐发泡 /224
- 五、针刺为主 中药外敷 /225

- 六、针罐并用 重在手法 /226
- 七、足三里-鹤顶 拔河针法 /227
- 八、针刺调之 中药电疗通之 /228
- 九、针推并用 温经通络 /229
- 十、膝三针 标本兼治 /230
- 十一、飞针配水针 随症取穴 /231
- 十二、温针灸配水针 活血化瘀 /232
- 十三、扬刺为主 标本兼治 /233

踝关节扭挫伤

236 - 252

- 一、威灵-精灵 运动疗法 /236
- 二、巨刺法 配紧松补泻 /237
- 三、内外关 配交经刺 /238
- 四、据生物全息 综合治疗 /239
- 五、阿是穴 傍针刺 /240
- 六、运动针刺 舒经通络 /241
- 七、独取上廉 强刺激 /241
- 八、外关-三阴交 消肿止痛散瘀 /242
- 九、循经远取 巨刺 /243
- 十、八脉交会穴 配阿是穴扬刺 /244
- 十一、电针为主 大七厘散外敷 /245
- 十二、丘墟-照海 电针透刺 /246
- 十三、针刺放血 疏通经脉 /246
- 十四、针刺穴注 消肿止痛 /247
- 十五、独刺攒竹 配合运动 /248
- 十六、独取阿是 扬刺 /249
- 十七、针推并用 通则不痛 /250

足跟痛

253 - 260

- 一、局部多针刺 通则不痛 /254

- 二、隔姜灸 祛湿散寒 /254
- 三、自拟经验穴 针药并用 /255
- 四、雀啄灸 温经散寒 /256
- 五、针刺肩奇 立竿见影 /257
- 六、针刺强刺激 配中药外洗 /257
- 七、同名经远取 运动针刺 /258
- 八、独取足跟穴 巨刺 /259

外伤性截瘫

—261 - 276

- 一、调补督脉 益气活血 /262
- 二、督脉电针 补肾益精填髓 /263
- 三、夹脊穴为主 随症加减 /263
- 四、足三阳配夹脊 排针治疗 /264
- 五、局部取穴为主 齐刺 /265
- 六、针药并用 疏通督脉 /266
- 七、疏调督脉 益气活血 /267
- 八、醒脑开窍针法 疏通督脉 /268
- 九、电针推拿 分期治疗 /269
- 十、督脉温针 宣通气血 /270
- 十一、夹脊-背俞穴 交替取穴深刺 /271
- 十二、针灸为主 综合治疗 /272
- 十三、上中下三部同取 综合治疗 /274

总主编 周丽莎 朱书秀
主编 朱书秀 吴绪平

针灸名师
临床笔记丛书

筋伤病证卷

JIN SHANG BING ZHENG JUAN

中国医药科技出版社

电针夹脊穴为主治疗神经根型颈椎病，取得满意疗效。

取穴：主穴颈4~5或5~6两侧夹脊穴。配穴：根据临床症状，如：手臂疼痛者加肩髃、肩贞、肩内陵，手臂麻木握物无力者加曲池、合谷、八邪。颈项僵直转动不利者加大椎、崇骨，疼痛剧烈者可在痛点针后拔火罐。

操作：两侧颈部夹脊穴4~5或5~6垂直进针1~1.2寸，调整针刺方向，使针感向肩臂或头颈部传导为佳，再根据症状选用配穴，然后接6805电针仪，频率100次/min以下。每次针20min，每天1次，10次为1个疗程。

根据临床和自觉症状采用不同针刺方向，使针感向病位区传导这一点很重要，如针夹脊穴，直进针稍偏向脊椎方向刺，针感可向后枕头部传导，直进针稍偏离脊椎方向刺，针感可向肩臂传导，按此治疗的效果较佳。电针夹脊穴要两侧同取，才能平衡和解除颈部软组织的紧张度，这切中了中医的协调和平衡阴阳的治疗原则；针后压痛点拔火罐，吸出适量瘀血。对改善局部血液循环，促进新陈代谢，消除局部无菌性炎症，缓解肌痉挛，从而减轻疼痛。

李某，男，50岁，工人，1995年10月10日初诊，自述，颈项部不适，右肩臂酸痛麻木月余。臂丛神经牵拉试验，压顶试验均为阳性，颈椎正侧位片显示：颈椎5椎体前缘有明显骨质增生，颈椎生理曲度变直。诊断为颈椎病（根型）取颈5~6双侧夹脊穴电针，配患侧肩髃、曲池、外关、合谷，针刺20min，起针后压痛点拔火罐10min。共治疗10次症状消失，告愈，半年随访无复发。

四、大椎 - 完骨 - 百会 隔姜灸

颈性眩晕是椎动脉型颈椎病的主要表现，多因颈部软组织病变致颈椎中上段失稳引起椎基底动脉供血不足，产生眩晕。曾小香采用隔姜灸治疗该病，疗效显著。

取穴：大椎、完骨、百会。

操作：患者取坐位，俯头桌上，双手屈曲平放桌面，额枕于双手上，暴露后颈部。将新鲜生姜切成3cm×3cm×0.5cm薄片，在中心用棉签棒穿4个小孔，上置艾炷，在上穴皮肤外涂万花油后施灸。当患者感皮肤灼热时，将姜片上提离开皮肤，旋即又放上行灸，反

目 录

颈椎病

1-28

- 一、经验取穴 关刺治疗 /2
- 二、小醒脑针 养脑安神 /3
- 三、夹脊穴为主 气至而有效 /3
- 四、大椎-完骨-百会 隔姜灸 /4
- 五、辨证分型 重针刺浅深 /5
- 六、远近配穴 雀啄刺 /6
- 七、后溪-颈夹脊 重在于通 /7
- 八、局部取穴为主 短刺 电针 /8
- 九、针刺夹脊 丹参穴位注射 /9
- 十、颈四穴 电针 /10
- 十一、针刺刮痧 两法并用 /10
- 十二、针推牵 综合治疗 /11
- 十三、定喘-大椎 三针齐刺 /12
- 十四、独取大椎 梅花针叩刺 /13
- 十五、经验取穴 抬肩通络法 /13
- 十六、颈夹脊穴埋线 作用持久 /14
- 十七、针药并用 动引其气 /15
- 十八、针推刮 分步施治 /16
- 十九、疏调太阳 行气活血 /17
- 二十、夹脊穴 配纳络取穴 /18
- 二十一、综合治疗 通络止痛 /19
- 二十二、治分六步 通则不痛 /21
- 二十三、辨经取穴 通经活络 /23
- 二十四、随症取穴 刺络配角法 /25

复如此。共灸3壮（中型艾灶，高1cm，底径0.8cm，重约1g。采用华佗牌药艾条，折搓而成），治疗时间约20min，10次为1个疗程，休息2天继续下1个疗程。

颈性眩晕属中医学眩晕范畴，病位属于督脉、足太阳和足少阳循行范围，多由劳损或体虚，脑髓空虚、失养后复感风寒湿邪，致颈部经络痹阻，寒凝血瘀，气血不能上荣清窍引起。其发病虚证居多。百会为手足三阳经、督脉之会，督脉并主一身之阳气；大椎穴乃手足三阳与督脉之交会穴；完骨为足少阳经穴。艾条多为辛温通透、芳香走窜、振阳补虚之品；生姜有温中止呕、散寒祛痰功效，灸之温通督脉，直达病所。局部施灸，综合发挥热、火、药、特定腧穴效应，加强疗效。另外，曾小香体会到，百会为止晕要穴，有开窍醒神、升阳熄风等作用，是用于治疗眩晕的特定穴，以其有温热感逐渐扩散至全头、热力内渗至全头时效果尤佳。

五、辨证分型 重针刺浅深

王进运用浅深刺法，针刺颈夹脊穴为主治疗颈型、神经根型、椎动脉型颈椎病，疗效显著。

取穴：主穴取颈夹脊。颈型配肩井（双）；神经根型，肩胛上背酸痛配肩井、天宗、臂中；手臂麻木配曲池、外关、合谷、后溪；椎动脉型配风池、百会。

操作：颈夹脊：颈型浅刺0.5~1寸，斜刺，针尖指向脊柱，针感为局部酸胀为佳；椎动脉型刺1~1.5寸，斜刺，针尖指向横突孔，针感以酸胀传至头顶为佳；神经根型深刺1.5~2寸，斜刺，针尖指向椎间孔，针感以酸麻放射至手臂为佳。肩井：颈型浅刺0.5~0.8寸，直刺，针感为局部酸胀；神经根型刺0.8~1.5寸，直刺，针感为酸胀放射至肩部。风池、百会、天宗、臂中、曲池、外关、合谷、后溪均常规针刺，施以捻转补泻手法。在治疗早期以泻法为主，中期以补法为主，后期全用补法。每日治疗1次，每次留针30min，10次为1个疗程，疗程间休息3天。

王进根据此病临床症状进行辨证分析，即颈型病变在卫、肌肉，属浅层；椎动脉型病位在血、脉，属中层；神经根型病位在骨，属深层。根据《调经论》所云：“病在脉调之血，病在血调之络，病

【颈椎病】

颈椎病又称颈椎综合征，是增生性颈椎炎、颈椎间盘脱出以及颈椎间关节、韧带等组织的退行性改变刺激和压迫颈神经根、脊髓、椎动脉和颈部交感神经等而出现的一系列综合征候群。其部分症状分别见于中医学的项强、颈筋急、颈肩痛、头痛、眩晕等病证中。好发于40~60岁中老年人。

西医学认为，本病是由于颈椎间盘慢性退变（髓核脱水、弹性降低、纤维环破裂等）、椎间隙变窄、椎间孔后缘唇样骨质增生等压迫和刺激颈脊髓、神经根及椎动脉而致。

中医学认为，本病因年老体衰、肝肾不足、筋骨失养；或久坐耗气、劳损筋肉；或感受外邪、客于经脉，或扭挫损伤、气血瘀滞，经脉痹阻不通所致。

本篇收录了25位针灸医家的临床治验，有的采用关刺法；有的采用小醒脑针，养脑安神；有的以夹脊穴为主，电针治疗；有的辨证分型，强调针刺浅深；有的以局部取穴为主，短刺加电针；有的针刺夹脊穴配合丹参穴注；有的采用针刺配合刮痧治疗；有的取大椎穴梅花针叩刺；有的治分六步，通则不痛；有的取颈夹脊穴埋线等。

针灸治疗颈椎病有一定疗效，对于缓解颈

项痛、肩背痛、上肢痛、头晕头痛等，效果尤为明显。长期伏案或低头工作者，要注意颈部保健。工作 1~2h 后要活动颈部，或自我按摩局部，放松颈部肌肉。

一、经验取穴 关刺治疗

黄丽萍根据《内经》中关于关刺治疗筋痹的理论，临床上应用关刺治疗各型颈椎病，均取得了良好的疗效。

操作：分四组定位：①当枕部，上项线外端下缘凹陷处，从斜方肌肌腱起点外缘处，平行于上项线向正中线方向呈 15°角刺入约 1.5 寸。②当肩背部，肩胛骨内侧角，肩胛提肌肌腱止点处，直刺约 1 寸。③当侧颈部，发生病变椎体的横突端处，直刺约 1~1.5 寸。④当颈后部，选取与第三组中所取横突的同一椎体的棘突两侧，与斜方肌内侧缘之间的凹陷处，直刺约 1 寸。以上各位置均左右同刺，以垂直于肌腱、韧带方向进针，达到适当深度后，小幅度捻转针体并调节进针方向，当针下有沉紧得气的感觉时留针，约 30min，其间不使用提插捻转等补泻手法。每天 1 次，2 周为 1 个疗程。

关刺一法首见于《内经》，此种刺法原本用于四肢关节部，肌肉的尽端，因多连关节，经云“筋会于节”，四肢肌肉的尽端都在关节附近，故名“关刺”。颈椎系统是由多组关节、肌肉、韧带、肌腱等组成的一组关节群，因此黄丽萍认为：只要选取部位得当，多用于四肢关节的“关刺”疗法，同样也适用于颈椎病的治疗。

上述 4 组针刺部位，是根据颈部活动相关的肌肉及肌腱的起止点为依据。第一组中，上项线处附近为斜方肌、头上斜肌及头半棘肌等肌腱的附着处；第二组中，肩胛内侧角为肩胛提肌和部分斜方肌的止点；第三组中，横突是肩胛提肌、斜角肌群、头长肌等的起点，头夹肌、颈长肌等的止点；第四组中，棘突为项韧带、部分菱形肌等的附着点。以上四组部位所涉及的肌肉、肌腱及韧带构成了支持颈部和支配颈部运动的主要部分。因此，针刺以上部位即可直接影响到颈部的大部分软组织系统，通过针刺的双向正面调节作用，可以使失调的动态平衡系统重新恢复平衡，从而起到调节颈部各组织器官相互关系的作用，改善颈椎系统的病理状态，最终达到治疗的目的。

患者，女，33岁，会计师。症状：颈肩部疼痛，伴有沉重感，以右侧为重，入夜尤甚，严重影响工作和睡眠。颈椎X片提示：颈椎曲度变直，骨质未见明确异常。诊断：颈肩综合征。经上法治疗（其中第三组定位椎体为两侧压痛明显的横突1处，相当于C₄椎横突处）3次后，疼痛明显减轻，夜寐安，仍有沉重感，共治疗10次，诸症均消失。

二、小醒脑针 养脑安神

李智采用“小醒脑”针法配合推拿手法治疗颈性眩晕，获得理想疗效。

取穴：采用“小醒脑”针法。取风池、完骨、天柱、四神聪、印堂、上星、百会。

操作：风池、完骨、天柱以28号毫针，针向喉结，进针1~1.5寸，双手同时行针，施用小幅度高频率捻转补法，每对穴行针1min；四神聪，针向百会穴，进针0.5~0.8寸；印堂，向鼻根部斜刺0.3~0.5寸，施用雀啄泻法30s；上星、百会沿皮平刺，进针0.5~1寸，施用捻转泻法30s，留针20min。

推拿：取穴同上，循督脉、足少阳胆经经脉依次用点、拿、揉、擦、拔伸等手法，各种手法每穴1min，反复进行3次。

颈性眩晕是由于颈椎进行性改变或椎间盘膨出而引起的一种继发性眩晕，临床主要表现为椎动脉供血不足，出现前庭中枢性眩晕，属于中医学眩晕范畴。李智认为应属气血不足型，因经脉空虚，经气不足，气血不能上荣清窍，脑失所养而致。临床观察结果证明，通过针刺风池、完骨、天柱，可以显著改善椎-基底动脉的供血状态，使脑血流量增加，缓解血管平滑肌的痉挛，调动局部乃至全身的代偿因素，改善脑血管的自身调节系统，提高脑灌注压，从而保持脑血流量的相对稳定，进而改善机体内环境，增加抗病能力。上星、印堂、百会、四神聪具有开窍醒神、祛痛止晕之功。配合推拿手法以活血通络、养脑安神。

三、夹脊穴为主 气至而有效

在各型颈椎病中，神经根型颈椎病，发病率最高，王常印采用

电针夹脊穴为主治疗神经根型颈椎病，取得满意疗效。

取穴：主穴颈4~5或5~6两侧夹脊穴。配穴：根据临床症状，如：手臂疼痛者加肩髃、肩贞、肩内陵，手臂麻木握物无力者加曲池、合谷、八邪。颈项僵直转动不利者加大椎、崇骨，疼痛剧烈者可在痛点针后拔火罐。

操作：两侧颈部夹脊穴4~5或5~6垂直进针1~1.2寸，调整针刺方向，使针感向肩臂或头颈部传导为佳，再根据症状选用配穴，然后接6805电针仪，频率100次/min以下。每次针20min，每天1次，10次为1个疗程。

根据临床和自觉症状采用不同针刺方向，使针感向病位区传导这一点很重要，如针夹脊穴，直进针稍偏向脊椎方向刺，针感可向后枕头部传导，直进针稍偏离脊椎方向刺，针感可向肩臂传导，按此治疗的效果较佳。电针夹脊穴要两侧同取，才能平衡和解除颈部软组织的紧张度，这切中了中医的协调和平衡阴阳的治疗原则；针后压痛点拨火罐，吸出适量瘀血。对改善局部血液循环，促进新陈代谢，消除局部无菌性炎症，缓解肌痉挛，从而减轻疼痛。

李某，男，50岁，工人，1995年10月10日初诊，自述，颈项部不适，右肩臂酸痛麻木月余。臂丛神经牵拉试验，压顶试验均为阳性，颈椎正侧位片显示：颈椎5椎体前缘有明显骨质增生，颈椎生理曲度变直。诊断为颈椎病（根型）取颈5~6双侧夹脊穴电针，配患侧肩髃、曲池、外关、合谷，针刺20min，起针后压痛点拨火罐10min。共治疗10次症状消失，告愈，半年随访无复发。

四、大椎 - 完骨 - 百会 隔姜灸

颈性眩晕是椎动脉型颈椎病的主要表现，多因颈部软组织病变致颈椎中上段失稳引起椎基底动脉供血不足，产生眩晕。曾小香采用隔姜灸治疗该病，疗效显著。

取穴：大椎、完骨、百会。

操作：患者取坐位，俯头桌上，双手屈曲平放桌面，额枕于双手上，暴露后项部。将新鲜生姜切成3cm×3cm×0.5cm薄片，在中心用棉签棒穿4个小孔，上置艾炷，在上穴皮肤外涂万花油后施灸。当患者感皮肤灼热时，将姜片上提离开皮肤，旋即又放上行灸，反

复如此。共灸3壮（中型艾灶，高1cm，底径0.8cm，重约1g。采用华佗牌药艾条，折搓而成），治疗时间约20min，10次为1个疗程，休息2天继续下1个疗程。

颈性眩晕属中医学眩晕范畴，病位属于督脉、足太阳和足少阳循行范围，多由劳损或体虚，脑髓空虚、失养后复感风寒湿邪，致颈部经络痹阻，寒凝血瘀，气血不能上荣清窍引起。其发病虚证居多。百会为手足三阳经、督脉之会，督脉并主一身之阳气；大椎穴乃手足三阳与督脉之交会穴；完骨为足少阳经穴。艾条多为辛温通透、芳香走窜、振阳补虚之品；生姜有温中止呕、散寒祛痰功效，灸之温通督脉，直达病所。局部施灸，综合发挥热、火、药、特定腧穴效应，加强疗效。另外，曾小香体会到，百会为止晕要穴，有开窍醒神、升阳熄风等作用，是用于治疗眩晕的特定穴，以其有温热感逐渐扩散至全头、热力内渗至全头时效果尤佳。

五、辨证分型 重针刺浅深

王进运用浅深刺法，针刺颈夹脊穴为主治疗颈型、神经根型、椎动脉型颈椎病，疗效显著。

取穴：主穴取颈夹脊。颈型配肩井（双）；神经根型，肩胛上背酸痛配肩井、天宗、臂中；手臂麻木配曲池、外关、合谷、后溪；椎动脉型配风池、百会。

操作：颈夹脊：颈型浅刺0.5~1寸，斜刺，针尖指向脊柱，针感为局部酸胀为佳；椎动脉型刺1~1.5寸，斜刺，针尖指向横突孔，针感以酸胀传至头顶为佳；神经根型深刺1.5~2寸，斜刺，针尖指向椎间孔，针感以酸麻放射至手臂为佳。肩井：颈型浅刺0.5~0.8寸，直刺，针感为局部酸胀；神经根型刺0.8~1.5寸，直刺，针感为酸胀放射至肩部。风池、百会、天宗、臂中、曲池、外关、合谷、后溪均常规针刺，施以捻转补泻手法。在治疗早期以泻法为主，中期以补法为主，后期全用补法。每日治疗1次，每次留针30min，10次为1个疗程，疗程间休息3天。

王进根据此病临床症状进行辨证分析，即颈型病变在卫、肌肉，属浅层；椎动脉型病位在血、脉，属中层；神经根型病位在骨，属深层。根据《调经论》所云：“病在脉调之血，病在血调之络，病

在肉调之分肉，病在骨调之骨”。采用浅、中、深三层针刺，使针达病所，更好发挥针灸疏经通络，行气活血软筋的作用。从而使治疗方法针对其病机，故收奇效。

六、远近配穴 雀啄刺

陈粉扣采用雀啄刺法、温针治疗神经根型颈椎病，获理想疗效。

取穴：腕骨、阳陵泉、颈夹脊穴 C_4 、 C_5 或 C_5 、 C_6 。

操作：患者取俯伏坐位或侧卧位，两臂自然置于床上，皮肤常规消毒后，取 1.5 ~ 2.0 寸毫针先刺远道穴位腕骨、阳陵泉，缓慢进针得气后行雀啄刺法，即用右手持针，用无名指紧贴在穴位一旁以腕关节上下快速运动，带动刺手拇、食、中指，达到在穴位上下小幅度地提插，幅度值 1 ~ 2mm，提插频率在 180 ~ 220 次/min。每 5min 行雀啄刺法 1 次，行针时患者感酸胀，术者感到针下沉紧而重，同时令患者活动颈项 3 ~ 5min；后刺颈夹脊穴，缓慢进针得气后行雀啄刺法（方法同上）。留针时，在颈部施温针灸，用艾条一段长约 2cm 左右，插在针柄上，点燃施灸，每施 1 壮后，行雀啄刺法 1 次，共施 3 壮。留针 30 ~ 40min。每天 1 次，10 天为 1 个疗程，可酌情休息 2 ~ 3 日后进入下 1 个疗程。

雀啄刺法是简便易行、行之有效的辅助治疗手法之一，而临床上治疗颈椎病往往只注重常规提插、捻转等刺法。陈粉扣认为雀啄刺法虽提插，但幅度小、频率快、针感强烈，可激发经气传感，使针感由浅入深向四周放散，气至病所，故运用此法治疗本病达到运行气血，加快经气的运行作用。一般情况下，频率越快，疗效越高，得气好而且持久。

腕骨穴系手太阳小肠经腧穴，为原穴，阳陵泉穴是足少阳胆经穴位，既是合穴，又是八脉交会穴之筋会，与腕骨穴合用，共同起疏导经气，舒筋活络的作用。颈夹脊穴是针灸临床上治疗颈椎病常用的穴位，能畅通督脉及太阳经气，调和阴阳。

丁某某，男，54 岁，会计，2001 年 7 月 26 日初诊。因“右颈项强痛并放射至右侧上肢 9 月，加剧 10 天”就诊于本科。患者诉每遇阴雨寒冷天症状出现或加重，发作时伴有右侧肢冷、指麻、肌重无力。检查： C_3 ~ C_6 椎体棘突旁右侧 0.5cm 有压痛，臂丛神经牵拉

试验 (+), 压顶试验及叩顶试验 (+), 颈部活动受限, 颈椎 X 线 (或 CT) 检查示: C₄ ~ C₆ 椎体前缘骨质增生, C₅、C₆ 椎间孔变窄。诊断为: 颈椎病 (神经根型), 采用上述方法治疗, 每天 1 次, 10 天为 1 个疗程, 第 1 个疗程后, 患者临床症状全部消失, 颈项活动自如, 半年后随访无复发。

七、后溪 - 颈夹脊 重在于通

毕宇峰针对颈椎病的特点, 采用针刺后溪穴为主, 配合针刺颈夹脊穴治疗该病, 取得了满意的疗效。

取穴: 后溪、颈夹脊穴。

操作: 取后溪穴, 用 28 号 1 寸针, 行强刺激手法, 使患者痛处出现麻酸痛感。行针时患者因针感强烈可有弯腰弓背的痛苦状为佳。兼取颈椎棘突有压痛处的夹脊穴或压痛不明显时, 参照 X 光片取 C₃ ~ C₇ 椎夹脊穴为配穴, 用 1 寸 30 号针, 向椎体方向 (向轴心) 刺入, 行平补平泻手法, 使针感上传风池, 下达肩胛为佳。每隔 10min 行针 1 次, 每次留针 30min, 10 次为 1 个疗程, 隔日针刺。治疗期间嘱患者加强颈部功能锻炼, 如转颈引项运动等。

后溪为手太阳小肠经的输穴, 取之可治椎节痛痹。此穴又是八脉交会穴, 后溪通过本经交会于督脉之大椎, 使二经脉之气相通。颈夹脊穴, 可调整局部经脉气血, 又可通过局部的针刺治疗, 缓解病变局部肌肉紧张状态, 改善病变部位的血液循环, 收到通畅气血, 消瘀散结的功效。

针治本病, 重在于通。后溪穴经大椎穴通督脉, 所配夹脊穴, 其穴近督脉, 且针刺方向向轴而刺, 使其与督脉经气相通, 二者相辅相成, 可调动督脉之经气, 振奋全身阳气, 使经脉通畅, 以祛邪解痉通瘀强身; 又可通过远端与局部的配合, 通调局部气机, 调整机体阴阳平衡, 使经络气血通畅, 达到祛寒除湿, 扶正祛邪之目的。

李某, 男, 47 岁, 司机。于 1998 年 3 月就诊。主诉: 颈项部疼痛沉困不适 3 月余, 伴眩晕、恶心 1 周。自述因长途行车, 突感风寒, 初时感颈项困重、头闷, 后渐加重。患者就诊时, 颈部强痛, 不能转动, 动则恶心、呕吐。曾在外院就治, 按梅尼埃综合征给输液等治疗无效而来针灸科求治。查体: C₄、C₅ 椎体棘突压痛 (++) , 颈

部活动完全受限，椎轴叩击痛（+）。经拍颈椎正侧位X线光片示：颈椎生理弯曲消失，椎体反曲，C₄~C₅椎体不稳。以“颈椎病”之诊断收入院。此患者入院后应用本法治疗2次，即感颈部可轻度活动，恶心、呕吐症状消失。经1个疗程治疗后，颈项强痛症状消失，颈部活动自如，仅感长时间低头时偶有头昏感觉，再巩固治疗1个疗程后，诸症均消失，复查颈椎X线片示：颈椎生理曲度正常。痊愈出院。

八、局部取穴为主 短刺 电针

神经根型颈椎病是颈椎病中最常见的证型，以颈部脊神经根受压出现神经根激惹症状为主要临床表现，欧阳八四采用短刺加电针治疗本病，取效满意。

取穴：以相应节段的颈椎华佗夹脊穴为主，头痛者配风池，颈项僵硬疼痛者配肩井，项背痛者配曲垣，颈肩疼痛者配肩髃、肩髃，肢麻者配曲池、外关。

操作：采用短刺法，得气后在夹脊穴上接通针灸治疗仪，以连续波刺激，电流频率约100~150次/min，电流输出大小以患者本人感觉舒适为宜，留针30min，每日或隔日1次，10次为1个疗程，2个疗程间休息3~5天。

颈椎乃督脉所过，故易致督阳痹阻，气血失和，累及手之三阳或手之三阴经，故痹痛；邪气深入，营卫不畅，致经络空虚，肌肤不荣，故不仁。治拟行气活血，宣痹通络为先，根据病变部位及经脉循行，采用局部与远道相结合的取穴方法，以疏通经络气血之阻滞，使经气流畅而痛止。尤其是短刺华佗夹脊穴，它体现了中医“直达病所”的理论，刺激了相应的神经根，使受压的神经根相应节段的放射部位得气，通以电针，既产生了电的兴奋作用，又具有针刺的通调作用，减少了用穴，还能客观地掌握刺激量，消除神经根部的水肿，从而改善了局部的微循环，使局部临床症状减轻或消失。

张某，女，43岁，教师，1989年4月21日就诊。主诉左侧颈项及肩部疼痛3年，近1月来加重，伴左上肢麻木。患者诉3年前就开始有颈肩部疼痛，活动不利，同时伴见左上肢麻木感，每当伏案工作时间稍久症状就明显加重，曾用中西药物治疗而未收效，1月

病情复发加剧。查之颈项强直， C_4 、 C_5 、 C_6 棘突左旁一横指有明显压痛，并有触电感向左拇指放射，左上肢皮肤感觉迟钝，叩顶试验（+），臂丛牵拉试验（+），椎间孔挤压试验（+）。X片示 C_5 、 C_6 椎间隙狭窄，生理弧度消失、变直， $C_3 \sim C_6$ 椎体前缘均呈不同程度的骨质增生。诊断：颈椎病（神经根型），按上法治疗，取穴左侧 C_5 、 C_6 夹脊穴及肩髃、曲池、外关、合谷，1次后诸症明显减轻，5次后伏案工作稍久不觉颈肩酸痛，10次后，症状与体征全部消失，后又巩固治疗5次，随访半年未发。

九、针刺夹脊 丹参穴位注射

朱建国运用针刺颈夹脊穴与穴位注射治疗颈椎病，取得了满意的疗效。

取穴： $C_2 \sim C_7$ 夹脊穴。

操作：患者取俯卧位，皮肤常规消毒，用30号2寸毫针刺双侧颈夹脊穴，快速进针，以捻转补泻手法为主，斜向脊柱进针1.2寸左右，得气后接通G6805-III型电针治疗仪，用连续波，以局部肌肉跳动舒适为宜，持续30min。

穴位注射：①风池、定喘、肩中俞、曲池；②天柱、肩外俞、四渎。以上穴位取单侧，两组穴位用复方丹参注射液交替注射，每穴注入1.5~2ml，注射后揉按局部，待酸胀感消退。

以上方法每天1次，10次为1个疗程，连续治疗1~2个疗程。治疗期间及治疗后，每天做2次颈椎功能操。

颈椎病的发病原因复杂，临床中发现，由于长期伏案、持续低头等引起颈及周围肌肉韧带紧张、僵硬，姿势不当、扭伤、落枕及受寒等则引发加重，久则导致颈椎骨质退变增生，椎间隙狭窄，颈椎生理曲度改变，使颈椎间神经血管的压力变化，引发多种类型的颈椎病。朱建国应用针刺颈夹脊穴与穴位注射，在针刺和药物的双重作用下，能行气活血、疏通经络，改善椎动脉供血和颈部肌肉韧带的微循环障碍，消除或减轻病变颈椎附近代谢产物对神经、血管的刺激。

王某，男，49岁。1999年4月3日初诊。患者近3年来颈椎僵硬不适，偏头痛，头晕眼花，经推拿按摩后症状有所缓解。近1月

来症状加重，右上肢酸痛，手指麻木，无力，伴轻度胸闷。X线片示颈椎病，多普乐示椎底动脉供血不足。采用针刺颈夹脊穴和穴位注射。治疗当天即觉症状减轻，5次后症状消退。继治10次。治疗期间及治疗后做颈椎功能操，每日2次，每次10min。随访3年未有复发。

十、颈四穴 电针

吴际生运用针刺颈四穴治疗颈椎病，疗效满意。

取穴：双侧风池和第六颈椎旁开1寸处。

操作：选取双侧风池穴和第6颈椎旁开1寸处，用30号1.5寸毫针。风池穴针尖朝向鼻尖方向，进针0.8~1.0寸，用捻转、轻提插手法，使穴位局部出现酸、胀、麻针感，向头顶放射。第6颈椎旁开1寸处，针尖偏向内侧，进针1.0~1.5寸，用捻转、提插手法，局部产生酸、胀、麻针感，向肩、手传导。针后用G6805-Ⅲ型电针仪（福建省医疗器械厂生产）加电，同侧用阴阳极接上，选连续波。椎动脉及交感神经型电流量以微弱电流为佳，神经根型以能耐受为度。留针30min，每天1次。6天为1个疗程，1个疗程结束停1天，再行第二个疗程。

风池穴穴下有枕小神经、项肌、枕大神经、枕动脉及椎动脉等，第6颈椎旁开1寸处有椎骨下方发出的脊神经及相应的动静脉丛分布。针刺四穴具有通经活络、活血化瘀、祛寒止痛之功能，能促进神经根、动静脉功能，促进局部及头部的血液循环，改善代谢和营养血管神经等。另外，经过电针的刺激，肌肉抖动，使错位紧张痉挛的肌肉得以放松，使筋络顺接，气血流畅，从而起到良好的治疗作用。

十一、针刺刮痧 两法并用

邢健莉应用针刺配合刮痧治疗颈椎病，疗效肯定。

针刺：首取大椎，再依次向上取C₆~C₄椎棘突下缘旁开0.5寸处（双侧），以75%酒精常规消毒后，以毫针直刺1.2~1.5寸，进针时采用震颤进针法，留针20~30min，每天1次。

刮痧：将项部督脉与膀胱经之间夹脊穴所在部位常规消毒，涂

抹少量香油或凡士林均可，用刮痧板沿项部两侧夹脊穴所在部位自上而下刮痧，一般采用腕力，并不断询问受术者有无疼痛以调节刮力的轻重。在同一部位上必须刮至出现斑点，再刮拭其他地方。施术部位刮拭后会出现紫色出血点，病情轻者为红色，重者为紫色，严重者为紫块。每天1次。第2次刮拭需等患处无疼痛时再进行。

针刺具有舒筋活络、活血化瘀、消肿散寒止痛之功，通过针刺能解除局部痉挛，促进局部血液循环，增加营养代谢，松解粘连。刮痧治疗对邻近的脊柱及其周围组织具有疏通壅滞之经脉，缓解拘挛之经筋，调节失衡之阴阳的作用，并且通过刺激脊神经后支，调整其神经功能，消除或缓解临床症状。两者配合治疗，从而可以疏经络、行气血、协调阴阳，共收扶正祛邪、标本同治之功。

十二、针推牵 综合治疗

李娟运用牵引、推拿、针灸等综合疗法治疗神经根型颈椎病，效果良好。

牵引：选取中国航空公司生产的颈椎电子动态牵引器，牵引重量视患者的个体差异而定，一般首次牵引重量不超过7kg，最大重量不超过14kg，每次20min，10次为1个疗程。

推拿：患者侧卧，术者以推、揉、滚法，指压患者两侧斜方肌、肩胛提肌及头夹肌，再点按百会、风池，拿肩井，推大椎，颈部侧扳，最后牵抖上肢，手法不要过重，以免造成局部损伤。每天1次，10次为1个疗程。

针灸：取穴：以天柱、大椎、后溪、颈椎夹脊、颈项局部取穴为主，临证加减。操作：大椎穴直刺2寸，使针感向肩臂部传导；夹脊穴直刺1寸，施平补平泻，使针感向项、肩、臂部传导。得气后留针30min，中间行针3次，10次为1个疗程。

神经根型颈椎病属于中医学筋痹、血痹范围。李娟在治疗时先牵引颈部将椎间隙椎间孔拉大，椎间盘减压，关节突及周围韧带伸直，从而松解粘连和纠正小关节错位，椎体滑移，调节和恢复颈椎的解剖生理曲度和生物学平衡。而手法按摩能够解除痉挛，改善血液循环，分离粘连，促进组织代谢，消除无菌性炎症。另外，大椎是督脉穴，为诸阳之会，针灸能激发诸阳经经气，通经活络；后

溪、天柱分别为手足太阳经，后溪又为八脉交会穴之一，与督脉相通，二穴相配，调太阳、督脉经气，通经止痛；颈椎夹脊穴具有疏理局部气血而止痛的作用。诸穴相配共奏祛风散寒、疏筋活络、理气止痛之功。三种方法协同作用，能更好、更快地解除患者痛苦。

患男，48岁，突尼斯人，2004年4月15日初诊。患者头痛，颈肩疼痛，夜不能寐，上肢麻木，严重影响日常工作，经西医治疗效不佳，求助中医。检查：椎间孔挤压试验阳性，臂丛神经牵拉试验阳性，X线颈椎曲度变直、椎间隙无明显改变，C₃~C₆椎骨质增生。经用上述疗法治疗2个疗程后，颈肩部疼痛消失，功能恢复正常，随诊未见复发。

十三、定喘-大椎 三针齐刺

王勇针对青少年颈椎病的特点，在定喘、大椎上用齐刺法治疗，取得良好疗效。

取穴：大椎、定喘为主穴。有肩部酸痛者，加肩井、肩中俞；有颈部不适者，加风池、C₃或C₄夹脊穴。

操作：常规消毒。先针大椎穴得气，再用30号2寸毫针在定喘穴上向督脉方向，与皮肤成70°~80°刺入1.5寸，施提插捻转手法，使酸胀麻感弥漫局部区域。若有肩部酸痛者，则在肩井、肩中俞上行“左右鸡足”的合谷刺；若有颈部不适者，则先针风池，再用30号2寸毫针深刺C₃或C₄夹脊穴至1.5寸，施提插手法。间歇期留针30min。

由于现在学生学习负担重，长期低头学习，故青少年颈椎病日趋增多。针刺疗法可明显改善症状，尤其对大椎穴处酸胀麻木，牵滞感等疗效较好。在定喘、大椎上用三针齐刺法，属于《灵枢·官针》“齐刺者，直入一、傍入二，以治寒气小深者，或曰三针，三刺者，治痹气小深者也”。对肩部肌肉的酸痛结节，属于中医“肌痹”范畴。故治以一针多向刺的合谷刺。《灵枢·官针》载：“合谷刺者，左右鸡足，针于分肉之间，以取肌痹”。C₃或C₄夹脊为经验穴，深刺后缓慢提插，若出现针感向肩胛部传导现象，对缓解颈部不适有显效。

十四、独取大椎 梅花针叩刺

陈焕农采用梅花针加拔罐法治疗根痛型颈椎病，效果满意。

操作：患者伏案式坐位，用梅花针叩打大椎。手法轻重适度，以局部出现轻微渗血为度，然后在出血部位拔火罐，留 20 ~ 30min。此时火罐内可见有少量渗血（约 2 ~ 3ml）。然后起罐，用酒精棉球将局部擦拭干净，隔 2 天治疗 1 次；10 次为 1 个疗程；一般需 1 ~ 2 个疗程。

根痛型颈椎病的病变实质是颈椎骨关节变化而累及其周围软组织，压迫或刺激颈神经、臂丛神经而出现的一系列临床证候群。中医称之为“痹痛型”。中医学认为“痹证”及风寒湿三气杂至，合而为痹，致使经脉气血运行受阻，不通则痛。运用梅花针叩刺可改善局部微循环。火罐的作用《本草纲目拾遗》中提到：“罐得火气，合于内，即牢不可脱……肉上起红晕。罐中有气水出，风寒尽出。”两种方法合用可增加周围软组织的营养供应，以解除痉挛，消除炎症，减轻或解除神经根的刺激症状，使其恢复正常。

十五、经验取穴 抬肩通络法

王家瑞采用抬肩通络法治疗颈椎病患者，取得满意疗效。

抬肩通络法包括快针与体针。

快针：取抬肩（颈横纹与完骨穴垂直下交点）、颈明（抬肩穴直下约 2 ~ 3 寸）。取平卧头侧位，直刺约 0.5 ~ 0.7 寸，提插泻法（可做 3 ~ 4 次），当电流样感觉通到手指时，有抬肩的动作出现。

体针：①肩髃、臂臑、手五里、曲池、手三里。②四神聪、百会、风池、上星、本神。③颈椎夹脊穴。以上各穴根据病情配合应用，平补平泻，留针 30min，在疼痛明显处加电针。

抬肩穴、颈明穴为王家瑞在临床应用的经外奇穴。抬肩穴与颈明穴有强大的通络、活血、止痛的作用，可以纠正颈椎关节半脱位、移位，解除对椎动脉及交感神经的压迫刺激，改善脊髓的血液循环，消肿止痛，从而解除对脊髓的压迫状态。颈臂穴可加强上二穴的作用。三穴并用可调整颈椎的纵向排列，恢复其弹性，特点是操作安全，无风险。

屈某某，女，58岁，就诊时间：1996年8月14日。患者双下肢活动不利，以右下肢为重已半年；近半月因紧张、着凉，突然引起眩晕，视物旋转、晃动，以右转头为甚，伴恶心，呕吐，颈项僵硬，活动受限，行走不稳，心慌心悸，双上肢麻木无力，手不能握物，便秘，夜尿多，舌红少苔，脉弦，血压：135/85mmHg，颈椎CT平扫示：颈椎曲度变直，C₇后纵韧带骨化，继发椎管狭窄，颈椎前缘骨质增生。查体：双上肢握力减弱，以右后为重，C₃~C₇棘突双侧压痛，颈部肌紧张，活动受限，眼球水平震颤（+）。西医诊为：颈椎病混合型（含脊髓型、椎动脉型）。中医诊为：项痹。辨证：寒邪痹阻督脉、手足太阳经脉，合并脾肾阳虚，脾失运化，痰阻清窍，髓海失职。治疗采用抬肩通络法加消肿养髓汤加减。1个疗程而愈，随访2年未复发。

十六、颈夹脊穴埋线 作用持久

刘本立采用穴位埋线疗法治疗神经根型颈椎病，疗效较好。

取穴：C₃~C₇夹脊（棘突旁开1寸处）、肩井、手三里，均为患侧。

操作：患者呈俯伏坐位，面部靠在垫高的枕头上，项部保持平行状，根据X线片所示及临床检查压痛点，取相应的颈椎夹脊（旁开1寸），标定穴位后，常规消毒，用2%利多卡因在穴位下2寸处进针，当针尖到达病变处作穴位局部浸润麻醉（注意麻醉药要均匀），然后取0~1号医用羊肠线3~4cm（双线），用箭头式埋线针将羊肠线以25°角向枕部方向埋入肌肉层病变处，深度约0.2寸。患者可感觉到较强针感向头部或肩臂部放射，退针后针眼处用碘酒消毒，创可贴外敷固定3~5天。分别隔15天再埋第二、三次，共治疗3次。埋线1周内要求不洗澡，不作剧烈运动。

中医认为本病是因为肝肾不足，气血亏虚，督脉及膀胱经脉空虚失养所致。采用医用羊肠线埋植在患侧颈椎夹脊（病变关节与压痛点）及颈椎神经所经过的穴位处，羊肠线为双线，长约3~4cm，深入肌层0.2寸，在穴位处经过1个月时间的软化、分解、液化、吸收的过程中，逐渐形成保护层，起到缓解颈椎肌群的紧张状态，促进了血液循环和局部无菌性炎症的吸收，改善了脊髓、神经根、

颈椎周围组织的自由基代谢紊乱,使病变组织得到充分营养,达到了消除颈项及肢体疼痛、麻木的目的。

十七、针药并用 动引其气

于泽来采用柴葛解肌汤配合针灸治疗神经根型颈椎病,疗效满意。

取穴:以循经远端、左右交替取穴为主。选取手太阳经之后溪、前谷;足太阳经之束骨、京骨;其他经取曲池、外关、合谷等。

操作:①右后溪、前谷倒马,与左束骨、京骨倒马牵引;②左后溪、前谷倒马,与右束骨、京骨倒马牵引;③左束骨、京骨倒马,与右曲池或外关或合谷牵引;④右束骨、京骨倒马,与左曲池或外关或合谷牵引。患者坐位或卧位,每次取1组穴,最多不超过4穴,常规消毒,贴骨取穴,贴骨进针,不求补泻,进针后嘱患者颈部做前后屈伸、左右侧屈、左右侧旋活动(动引其气)。每天1次,每次30min,5次为1个疗程,其间间隔2天。

中药:采用柴葛解肌汤加减治疗。处方:柴胡、枳壳、桔梗、红花各6g,葛根20g,黄芩、白芷各10g,羌活、白芍各15g,桃仁9g,当归、牛膝各8g,甘草4g。临证时可随症加减。每天1剂,水煎,温服,7天为1个疗程。

现代医学认为,神经根型颈椎病主要原因是颈肩背部的急慢性损伤,导致颈椎退行性病变,破坏了颈椎的平衡系统,造成椎间盘及附件的损害,肌肉、神经根、血管等受到刺激而引起一系列症状、体征。治疗上以恢复平衡系统、缓解刺激为主。本病属中医学骨痹范畴。病因为正气虚损,气血失调,以致风寒湿邪侵袭,阻滞于经络筋骨肌肤所致。病机为“不通则痛、不荣则痛、不松则痛、不动则痛”。治疗原则重在“通、荣、松、动”,以活血化瘀、补益气血、解痉止痛、动引其气为主。柴葛解肌汤中重用葛根以解肌、开腠理、疗诸痹,加强利水渗湿作用。盖肝主筋,颈项为诸筋通路,诸筋病不通、不荣、不松,故配以柴胡、桃仁、红花、当归、牛膝、白芍等入肝经之品,肝经和,则诸筋和,和则通、则荣、则松;枳壳行气宽中除胀;桔梗补血气、除寒热风痹、破血、去积气、消积聚痰涎;牛膝疗寒湿痿痹、四肢拘挛;羌活疗项背强几几、后头痛

连项、湿盛。诸药合用，共奏理气活血、益气行血、舒筋通络、祛湿解肌之功，治诸筋不和。于泽来在针灸治疗上不循《灵枢·经筋》“以痛为腧”的取穴原则，而以《标幽赋》“交经缪刺，左有病而右畔取；泻络远针，头有病而脚上针”为法，而且不拘泥于传统针法，选择倒马针法、动气针法、牵引针法、消骨针法等特殊针法，仅用正刺、斜刺、浅刺、皮下刺以及上转、下转、留针等方法，不刻意追求补泻，操作简单，而且取穴少，效力专。

十八、针推刮 分步施治

刘畅采用针刺、推拿、刮痧三种疗法，分步骤综合治疗颈椎病，获较满意疗效。

针刺主穴：颈椎夹脊穴。配穴：临床随症加减。头晕头痛加四神聪、风池；上臂麻木疼痛加曲池、肩髃等。

推拿：视病人的年龄及身体强弱推拿患侧，一般采用较轻柔的擦、揉、滚法。

刮痧：在督脉的颈椎段和病变的颈椎夹脊处使用刮痧法，以补法为主。

操作：首先采用刮痧疗法，从后发际向下刮疹，可延续到两肩胛处。刮痧后施行针刺，每次颈椎夹脊穴依压痛的轻重程度取4个（双侧8个），夹脊穴针刺呈45°角深刺至椎骨，患者有麻胀触电感则已，不施行手法，留针20min。出针后医生在患处采用轻揉的揉、滚、擦法，患肢亦可采用擦法和抖法，推拿15min，每个病人的治疗时间约40min。每日针刺推拿1次，10次为1个疗程。刮痧法大约每3天施用1次，当病人患部不再出疹可间歇6天后再用，每次刮痧后嘱患者饮用一大杯白开水。

颈椎病是因颈部气血阻塞、气滞血瘀而成，中医称其为痹证。颈椎病的诱发因素很多，以劳累多见。本法使用了3个步骤3个层次的治疗方法，其目的是：①刮痧止痛。刮痧法是中国传统的治疗方法，它可以解决局部相对表浅部位的气滞血瘀，迅速消除局部疼痛。从经络学的角度看，它能使皮部、经筋、络脉被阻滞的经络再通，通则不痛。②针刺通经。针刺通过经络的传导可以解决较深部位的疾病，它能使经脉疏通，气血恢复正常运行，它的疗效持续时

间长,和刮痧疗法相比较,它能起到治本的作用。③推拿调和气血。推拿是为了更好的协调针刺和刮痧的作用,调和已被疏通的气血,解除因疼痛或施行局部治疗所带来的局部紧张,达到理筋调气的作用。

代某,女,46岁,职员。初诊日期:1994年3月22日。主诉:颈痛4年,每遇劳累则症状加重。近日劳累数天,颈部疼痛沉重,患者形容象压了一块石头,伴有头晕,时有呕吐。夜不能寐,自服多种中西药物,症状未见改善。查:患者C₄~C₅椎旁压痛阳性,后颈部有一明显的肌肉痉挛包块。X线片表示:C₄~C₅椎间隙变窄,椎后缘骨质增生。使用三步法,治疗一次后症状明显改善,夜能安卧,无头晕呕吐,颈痛基本消失,肌肉痉挛的包块明显缩小。又治疗4次,症状体征基本消失,后颈部平坦,为巩固疗效,共针10次。随访半年,未见复发。

李某,女,57岁,高级工程师。初诊时间:1994年3月13日。主诉:患颈椎病8年。每当读书制图即觉颈部不适,已使用过多种疗法,效果皆不明显。该患者的疼痛特征是颈部每遇劳累则酸胀重,疼痛不剧烈,以不适感为主。查患者较瘦弱,颈部平坦。X线征表示:C₅、C₆有骨质增生,颈椎生理弯曲有明显改变。使用上法,当时自觉良好,但次日晨起颈部晨僵感加重,活动困难,来院二次治疗。治疗后患者因害怕而停针,1个月后患者又来院告之,患部的疼痛在停针2天后消失,1周后所有的症状消失,1个月内能正常工作。随访半年,未见复发。

十九、疏调太阳 行气活血

颈性头痛即指由于颈部骨骼、肌肉、关节、神经、筋膜等组织病变所引起的头痛,为临床常见病症之一。其头痛特点为前头部、顶枕部等处的胀痛、紧缩痛或沉重感,可向项背部或肩部发散,疼痛为持续性,常由于体位及气候变化、疲劳、兴奋等因素而诱发或加重。蔡朗采用疏调太阳法为主,治疗颈性头痛,取得了较好的疗效。

取穴:本病辨证当属太阳经脉不利,故拟疏调太阳、行气活血为法。主穴:天柱、颈夹脊、玉枕、百会、项肩穴(大椎旁开3

寸)、后溪、申脉。配穴:伴肩痛者,加秉风、肩髃、臑会;伴手臂麻木者,加小海、支正;伴眩晕、耳鸣者,加风池、听宫;兼颞部疼痛者,加悬颅、悬厘;兼额部疼痛者,加攒竹。

操作:患者取坐位或侧卧位,嘱其全身放松,常规消毒后,用30号1寸或1.5寸毫针在所选穴位上针刺。头、颈部穴位行平补平泻法,得气即止,四肢远端穴位一般在得气后行捻转泻法,年老体弱或特殊敏感者行平补平泻法。留针20min,隔日治疗1次,15次为1个疗程。

颈性头痛属中医学“脑风”、“头痛”范围。本病的发生多因颈项部筋骨劳损、外伤,或遭外邪侵袭,致太阳经脉痹阻,气血不畅,不通而痛所致。故治疗主以疏调太阳为法,取天柱、玉枕、后溪、申脉等太阳经诸穴,且远端穴位施以泻法,意在驱除邪气,疏通经络,调和气血;百会为督脉、足太阳之会,善治头顶疼痛;颈夹脊位于项后相应椎间隙旁5分处,其可祛风邪、利颈项,为治疗颈项疾患的有效穴位。从临床观察:绝大多数颈性头痛患者,均于大椎穴旁开约3寸斜方肌处,有明显的拘挛、压痛,针后能有效地缓解症状,故自设项肩穴,与上述诸穴合用,共奏良效。

另外,在此方法的治疗中,尚需注意以下几个问题:①针刺时要注意颈部的舒适及松弛,以背靠式坐位为佳,或侧卧位,头部须垫起,保持颈椎的平直、舒展,最好不取俯卧位,避免由于姿势的不适而加重症状。②颈部穴位,尤其是上颈部穴位,针刺时手法宜轻不宜重,否则不但达不到治疗效果,反可加重症状。③针刺留针时,须嘱患者颈肩部尽量放松,头微后仰,避免由于针刺造成的紧张,致使局部肌肉进一步拘挛,造成新的病理损害。

二十、夹脊穴 配纳络取穴

龚丹采用针刺夹脊穴加纳络取穴法治疗神经根型颈椎病,疗效满意。

取穴:以颈夹脊3~7相应病变椎体处为主穴,有条件的根据X线片或CT提示病变部位的夹脊穴。配合纳络取穴法取值时经和对称经上的络穴。例如:9~11点症状最明显时来诊,取值时经上络穴公孙或加上对称经上的络穴外关一起用。

操作：患者俯卧或坐位，额部放低，充分暴露颈部。选取相应病变压痛点夹脊穴1~2对，皮肤常规消毒，取28号1.5寸针，对准夹脊穴垂直刺入1~1.5寸，得气后针感传至患侧肩背、前臂、手指时立即出针，不留针。出针后根据时辰，选开穴时辰内“时穴”，常规消毒皮肤，取1~2寸毫针刺入穴位，针尖指向病所，采用导气法，使针感传向病所，同时让患者活动颈部，留针10~15min，每5min运针1次，每天1次，10次为1个疗程。

颈椎病属中医的骨痹范围，位当督脉之通途，易致督阳痹阻。华佗夹脊主治相应部位的疾患。取压痛点的颈夹脊穴，使针刺效应直接作用病变局部，具有通经活络、舒筋活血、改善局部微循环、调节神经血管的功能、疏通经脉而达到通则不痛的目的。而子午流注针法中的纳络取穴法属时间医学范畴，是以一天十二时辰配合脏腑经络按时开穴，临床上用于治疗痛证的一种方法。所取位于肘膝关节以下的络穴，远离患处，配以病变部位局部取穴，临床取得了满意疗效。

二十一、综合治疗 通络止痛

张应泰临床数十年，经验丰富，医技精湛，对颈椎病研究出一套独特的治疗方法。

取穴：颈部夹脊穴（ $C_1 \sim C_7$ ）及大杼。

操作：快速进针1~1.5寸，提插捻转，找到针感即起针，不留针。10次为1个疗程，疗程间休息3天。

中药：制马钱子丸（自拟方）：制马钱子90g，葛根240g，骨碎补240g，三七90g，续断60g，山药60g，补骨脂60g，地龙60g，乳香45g，没药45g，桃仁45g，延胡索45g，川楝子45g，片姜黄45g，小茴香24g，土鳖虫24g。

上药共为细末，炼蜜为丸，每丸9g，每次1丸，每日2次，分早晚温开水送服（注：若个别人服用该药后出现恶心、头晕、舌强、手足麻等反应，可减量服用，每服1/3丸，不必停药）。

锻炼：①前屈后伸；②左右侧屈；③顺时针环转；④逆时针环转；⑤顺、逆时针交替环转；⑥左侧后伸（右甩下巴）；⑦右侧后伸（左甩下巴）；⑧左、右交替侧后伸。以上动作，一次每个做20~30

次，每天2~3次。要求由少渐多、循序渐进，应取坐位并手扶器物（如桌子）锻炼，以防跌倒。

护理：平时要求尽量少低头；睡觉时选用小圆枕头并枕于枕部（或用一个啤酒瓶包裹以适量绵软毛巾代替枕头亦可）；注意保暖，避免风寒侵袭。

颈椎病一般既有颈部软组织劳损，又有颈椎骨质退变，颈部夹脊穴是华佗夹脊穴的扩展，大杼穴则是八会穴中的骨会，故针之以疏通颈项部经络，并行气活血，达到“血活则经脉流动，营复阴阳，筋骨劲强，关节清利”的目的。

张应泰运用针灸的独特之处即在于：取穴少而精，快速进针，找到针感后不留针，但特别强调针感。其治法源于《内经》，即《灵枢·九针十二原》：“刺之而气不至，无问其数，刺之而气至，乃去之无复刺，气至也，如风吹云，呜呼若见苍天”、“刺之要，气至而有效”。

制马钱子丸为张应泰潜心钻研的自拟方，具有活血通经，通络止痛，补益肝肾，强筋健骨之功。颈椎病多因长期劳损致颈项部气滞血瘀并气血不足，加之风寒侵袭，寒湿阻滞所致，故以制马钱子丸从内进行调理。

颈椎操锻炼可通过患者的自主活动，恢复并增强颈部的正常活动功能，同时有助于颈椎曲度的恢复和调整。但要注意循序渐进，持之以恒。对于椎动脉型颈椎病，则不宜做颈部环转动作，其他锻炼动作也要注意动作缓和，幅度适可而止，以患者能够耐受为度。

张某，女，43岁，2003年3月15日初诊。主诉左上肢疼痛、麻木3个月，加重2周，并且颈项部疼痛、板滞，受凉或劳累则加重，有长期伏案写作史。查体：C₄、C₅棘突旁压痛，左臂丛神经牵拉试验阳性。X线片示：颈椎生理弧度消失，C₄、C₅部略有反张，第四颈椎间孔变窄。诊断为神经根型颈椎病。治疗如下：①针刺C₂~C₆椎旁夹脊穴及大杼穴（双侧）；②内服制马钱子丸，每次1丸，每天2次；③颈椎操锻炼，每天2次；④护理：少低头；避风寒；枕小圆枕头。针3次后患者即有轻松感，1个疗程后诸症明显缓解，休息3天后，又治疗了第二个疗程，患者临床症状全部消失，左臂丛神经牵拉试验阴性，X线片复查，颈部反张消失，曲度略有

恢复。临床治愈。

二十二、治分六步 通则不痛

郭剑华在临床上以六步法综合治疗颈椎病，收到较为满意的疗效。

(1) 牵引活血解痉法 此法是治疗的第一步。患者解开领扣，静坐于牵引椅上，全身放松，呼吸调匀，头部略前倾，套上颈牵引托行颈部牵引，牵引第1、2次时重量为3~5kg，以后逐步加重牵引量，最多不超过10kg，每日1~2次，每次20~30min。

(2) 针刺通络镇痛法 牵引完成后，患者坐位于治疗椅，裸露颈部及患肢，根据疼痛点及放射走向选穴。各型均可选颈椎两旁的疼痛点、圆形或条索状阳性反应点，以及风池、大椎、翳风、肩井、曲池、中渚、合谷（以上主穴可分组交替使用）。神经根型可配患侧大杼、肩髃、肩贞、抬肩、手三里、列缺等穴；椎动脉型可配角孙、百会、太阳、印堂、内关、神门、太冲、三阴交、足三里等穴；交感神经型可配太阳、睛明（可深刺1~1.5寸，进针和留针时不捻针，出针后应立即紧压进针孔1min左右，以防出血）、球后（方法同睛明）、内关、足三里、三阴交、太冲等穴。以上各型均采用平补平泻法，留针15~20min，每隔5min催针1次。

(3) TDP温经散寒法 在针刺过程中，同时用TDP辐射颈部，辐射头与皮肤之间距离约30~40cm，以患者感温热舒适为度，时间与针刺相同。

(4) 按摩松粘纠偏法 完成前三法后，要求患者在入静的状态下接受按摩，细心体会医生之手法。医者应全神贯注，从丹田运气并催力到双臂，通过肘部到双手，为患者施以下手法。

①揉捏法：医者站立于患者身后或患侧，用双手或单手揉捏患者的颈肌、胸锁乳突肌、斜方肌、背部及患肢肌肉，边揉边拿捏，力量要适度，以患者能忍受为佳。从上到下完成2~3遍。

②点按法：医者用拇指指腹或以食指重叠在中指上，用中指指腹点按颈椎华佗夹脊穴、风池、肩井、肩髃、缺盆、天宗、曲池、合谷等穴。在点按过程中可用拇指桡侧在各穴左右拨动数次。以上手法行2~3遍。力量由轻到重，渗透力要强，以患者感酸胀为度。

③揉推法：用手背及小鱼际部位，通过作腕关节内外旋动作，边揉边用力推动向前。也可用手半握拳，以食、中、无名、小指的指关节，掌指关节为着力点，手腕作屈伸动作，在颈肩部、背部及上肢内外侧作揉动推进动作，每次3遍，要有节奏感、深透感，频率不宜太快。

以上3法适用于各型颈椎病。

④椎间关节松解法：医者以一手拇指顶患侧颈椎棘突旁，另一手扶抱患者头部，从颈2~7椎作头前屈旋转和侧向活动的推扳手法。此法适宜神经根型、椎动脉型、交感神经型颈项强硬、活动受限明显者。

⑤抖动肩关节法：医者一手按患肢肩峰部加以固定，另一手握患肢手指，向下牵直，并轻轻作上下或前后抖动。此法适用于上肢疼痛、手麻木、肩关节活动受限者。

⑥推前额法：首先医者面对患者站立，用双手拇指指腹从印堂用力推至上星，再向两侧分推至角孙穴，并停留在该穴上揉按半分钟左右。可分推3~5遍。然后医者用拇指指腹从太阳穴向上推至头维穴，再从印堂经攒竹、眉中分推至太阳穴3~5遍。此法适用于椎动脉型、交感神经型头晕、头痛、耳鸣者。

⑦仰卧手牵旋转法：患者仰卧位，头部探出床边，医者坐在患者头前方，左（右）手置于枕后部，右（左）手置于颌下，牵引颈部并轻轻摇晃，使颈肌放松，然后在牵引下，双手逐渐用力，使患者头部右（左）旋转到最大限度。此法适用于年老、体弱及椎动脉型颈椎病。

（5）练功巩固疗效法 此法始终贯穿于治疗、康复的全过程。可根据病情、体质、年龄选择以下练功方法。

①望月法 患者站立，双足分开与肩等宽，脚尖向前，双手叉腰，呼吸调匀，深呼气时慢慢抬头仰望天空（头颈部尽量后伸至最大限度），吸气时慢慢还原。重复做5~10遍。

②探海法 姿势同前法，在深吸气时头颈伸向下方，尽量低头望地下，呼气时慢慢抬起使头颈部回到原位。重复做5~10遍。

③环顾法 在深吸气时头部慢慢向左（右）转动，眼尽量向左（右）侧看，呼气时头部回原位。重复做10次。

④旋转法 患者头颈向左环绕一周，再向右环绕一周，可反复旋转5~6遍。开始练此功法时有头晕感，可视其情况慢慢增加次数和加大旋转幅度。

⑤摩颈法 患者用两手掌分别摩擦颈部两侧肌肉，以颈部发热为度。每次可做1~2min。

以上练功法每天晨起和晚睡前各完成1次，也可视其情况选择2~3种。次数由少到多，逐渐加大练功量。

(6) 中药补益肝肾法 在非药物治疗同时，可视其病情，适当选用补肝益肾的中成药。临床中郭剑华常用养筋丸，以强壮筋骨，祛风通络，适用于神经根型、椎动脉型、交感神经型，选用地黄丸类及复方丹参片等，以补肝益肾，活血通络。对巩固疗效、恢复功能、防止复发有积极意义。

颈椎病临床症状复杂。在治疗中，郭剑华将颈牵引放在第一位，通过牵引可缓解颈肩部肌肉痉挛，加大椎间隙，加速血液循环，缓解症状。在临床中郭剑华发现大多数患者能接受牵引治疗。牵引完成后，多数患者在颈肩部、枕部、背部有酸胀、麻木等不适感，此时再进行针刺并同时用TDP辐射颈肩部，利用TDP温经散寒、活血化瘀的作用，加强针刺的疗效，促进血循，加快局部水肿和无菌性炎症的吸收，达到“通则不痛”之目的，相似于温针灸法。

二十三、辨经取穴 通经活络

张铁英运用辨经取穴治疗各类神经根型颈椎病，疗效显著。

(1) 手阳明大肠经 痛以外廉，前臂骨上廉为主，痛及拇、食指。取穴：肩贞、臑会、肘髁、曲池、手三里、合谷，其中主穴为手三里，该穴具有疏风通络之功，长于治疗经络病，其针感特别强烈，且胜于曲池，《针灸大成》卷六云：“手三里主手臂不仁，肘挛不伸，中风口噤，手足不随。”手三里与他穴配合，具有很好的通络止痛活血之功。

(2) 手太阳小肠经 证见肩胛痛，外后廉、臂骨下廉，痛及小指。取穴：天宗、肩贞、养老、后溪，其中天宗为主穴，《甲乙经》卷十云：“肩重，肘臂痛，不可举，天宗主之。”《针灸大成》卷六：“天宗主肩臂酸痛，肘外后廉痛，颊颌肿。”该穴具有散风疏筋，清

热消肿之功，针刺采用直刺，或针尖稍向上斜刺，寻到得气之感后针刺感应相当强烈，能穿过肩胛，传导到小指，故对臂痛及上肢麻痹疗效较佳。

(3) 手少阳三焦经 痛以循外及肘部，出臂外两骨之间为主，痛及中指、无名指。取穴：臑会、消冻、外关、中渚。其中主穴为消冻，《针灸铜人》云：“消冻治寒热风痹，项痛，肩臂急，针入六分，可灸三壮。”该穴针刺时针尖向肘关节处，先泻后补，得气后可出现强烈的酸麻之感，并传向手指。诸穴共用，可增强主穴的疏风通络止痹痛作用。

(4) 手少阴心经 证见内后廉，臂内侧后缘，小指痛。取穴：极泉、青灵、灵道、神门。此经病证主穴为极泉，《针灸大成》卷六云：“极泉主臂肘厥寒，四肢不收。”该穴对肩臂疼痛，四肢不举疗效较好，直刺后，亦可出现经络感传之象，与他穴配合可有奇效。

(5) 足太阳膀胱经 颈部、枕部疼痛，由枕部向顶部、颞部放射，甚达眼眶。取穴：天柱、风池、大杼、百会，其中天柱为主穴，《灵枢·厥病》篇：“厥头痛，项先痛，腰脊为应，先取天柱，后取足太阳。”《针灸甲乙经》卷十：“眩，头痛重，目如脱，项如拔，项直不可顾，天柱主之。”《针灸大成》卷六：“天柱主脑重，如脱，顶如拔，项强不可回顾。”在此天柱与他穴共用可使经络通，疼痛止。

临床中有部分病人为两经并证或多经并证，因而灵活选穴，以上各穴针刺时均采用相应手法，以取得酸麻胀等针感为度。

颈椎病是指因颈椎间盘退化，继发上、下椎骨骨质增生，压迫神经根、脊髓或影响椎动脉供血所引起的一系列症状，而神经根型颈椎病又是最为常见的一种类型，本病归于中医的痹证范围，而与“筋痹”、“骨痹”更为接近。该病多由内、外因致颈项肩背部的经脉阻滞、气血运行不畅、瘀滞不行而致，故针刺时以疏通经络、行气活血为主。各经主穴分别为手三里、天宗、消冻、极泉、天柱，辅以他穴治疗。此五穴均为各经气运行中，脉气流注的关键位置，在症状表现上该穴往往有明显压痛，因而为气血阻滞的关键位置，针之、针感极强。往往有酸麻样针感沿经传导，因此该五穴的选择极为关键，一定要选穴准，力求得到针感为疗效关键，其中消冻穴一般在临床上应用较少，张铁英体会，该穴临床应用价值较高，该穴深部即为桡神

经总干，针之，能够调节恢复神经功能，起到“通经活络”祛瘀活血的作用，经过治疗，经络通，气血行，疼痛麻痹自止。

二十四、随症取穴 刺络配角法

张天英应用刺络出血加角法治疗颈椎病，其效甚验。

刺络出血加角法：颈椎病合并高血压，取穴大椎、双曲池、双耳尖点刺出血后（除耳尖外）都加角法，施于督脉、膀胱经（心俞穴以上），呈三条直线角法。

颈性眩晕（椎动脉型），取穴大椎、双风池，同上进行刺络加角法。每次15min，每天1次。5~6次为1个疗程，（若6次后症状消失，则不再用此法，尚有部分症状者可加用2次）。

头颈部推拿加点穴疗法：先取俯卧位，在颈背先以滚推手法，让肌肉放松后用大拇指和中指从双风池穴棘突两侧上下滑动10次，再用滚、按、揉法施于颈肩背肌群（头夹肌、菱形肌、斜方肌、冈上肌、冈下肌）。然后取仰卧位，揉捏肩井穴、锁骨上窝，在胸锁乳突肌滚、推、拿后，作颈部侧扳法（眩晕型不作此法）。再取坐位，做头部点推按摩，对头痛者取印堂、太阳、攒竹、头维、百会、睛明、上星、率谷、风池等穴，以推拿手法加摩推双侧血管舒缩区、晕听区、枕骨粗隆平衡区，双手叩点整个头面（顺排从前叩到后发际）结束。每天1次，12次为1个疗程，坚持3个疗程，且嘱患者在工间（或课间）自做颈椎操，以利巩固。

中医对颈项病的认识《素问·至真要大论》述：“诸痉项强皆属于湿。”因为寒湿则筋脉凝泣，热湿则筋脉胀，故皆能发痛与项强症。中医又认为颈项腰背的疾病发生均与肾虚、血虚有关。从临床实践出发进行分型治疗，用刺络出血加角法治疗颈椎病高血压（交感神经型）、颈性眩晕（椎动脉型）是根据祖国传统医学的理论，认为这类病理变化属经络气血运行不畅，导致气滞不煦，血壅不濡，津液涩等出现疼痛（不通则痛），血壅不濡而眩。该类病可分虚实二证，其虚中有实，实中有虚。张天英用刺络出血，泻其颈性高血压之邪，加用角法增加刺激量，恰到好处。眩晕型（缺血型）按证是属血虚。但因颈椎骨变窄，压迫导致气血瘀阻而痹。用刺络出血法，旨在去瘀生新，增加血管壁的通透性。加用角法，温经散寒，以疏

通少阳经气之正常功能。

马某某，男，44岁。1993年5月7日来针灸科求医。主诉：颈项不适，颈背如压磨状，头痛。曾服用过镇脑灵，但只要不吃药，症状明显加重。查体：枕后痛，手触头部有血管怒张（右侧血管舒缩区、双太阳穴），神倦疲乏，颈部头夹肌、斜方肌、菱形肌、冈上肌、冈下肌均有压痛，面潮红，心电图正常。X线摄片C₅，C₆，C₇均有轻度增生。诊断：颈椎病、高血压。治疗按上述方法，2个疗程后症状基本消失，为巩固起见，又做1个疗程按摩推拿，至今未发。

白某某，男54岁。1994年3月4日来针灸科求医，主诉：近来不能低头工作，颈部不能侧，动则发晕。查体：血压105/60mmHg，X线片显示颈椎C₄，C₅，C₆，C₇椎体唇样增生，椎间隙变窄，脑血流图异常：椎-基底动脉供血不足。诊断：颈性眩晕（椎动脉型）。治疗按上述方法。3个疗程痊愈，4年内未见复发。

二十五、电针刺络拔罐 三法并用

吴九伟采用电针加刺络拔罐的方法治疗颈椎病，疗效颇佳。

取穴：为颈夹脊、风池、肩井（均双侧），并随症加减。头胀痛或偏头痛：加头维、率谷（患侧）；臂痛、麻木加天宗、肩髃、曲池。

操作：病人取正坐位，取30号1.5寸不锈钢毫针，根据摄片所示的病变位置，取颈夹脊C₂~C₇节段，针刺方向朝下，稍偏向内，进针1~1.2寸，用提插捻转泻法，使病人感到有明显的局部酸胀感；风池针刺方向朝同侧的嘴角，进针1寸许，捻转泻法，要求针感向头顶放散；肩井穴针向脊柱方向斜刺，进针约1寸左右，捻转泻法，以得气为度；头维、率谷，沿皮向后平刺；天宗穴直刺，进针约1寸左右。针刺得气后，接通G6805电针仪，电流强度以病人能耐受为度，留针30min。

刺络拔罐：在电针治疗后，加用刺络拔罐法。取穴：阿是穴（通常在脊柱两侧或肩胛骨内上角寻找压痛点）。将对皮肤局部消毒后，用七星针由中度到重度快速叩刺3~5s，使皮肤出现细小的血珠。叩刺结束后，选用大小合适的真空抽气罐吸拔叩刺部位。留罐3~5min，可拔出瘀血5~20ml。起罐后，用消毒干棉球擦净瘀血。每

周治疗2次,10次为1个疗程。

患者张某,男,46岁,财会人员。1999年11月15日初诊。颈项板滞伴头晕、胸闷不适1月余。患者2年前即经常在工作后感到颈项板滞,偶伴有左手无名指麻木。曾在某医院就诊,颈椎正侧位X线摄片示:颈椎生理曲度改变, $C_5 \sim C_6$ 椎体唇样骨质增生。诊断为神经根型颈椎病,经针灸及中药治疗后缓解。今年10月起颈项板滞又起,并伴头晕、胸闷不适。曾做心电图检查,未发现明显异常。经彩色多普勒超声证实,椎动脉供血不足。就诊时患者诉颈项板滞连及肩背部,并有束紧感,偶有左上肢麻木。检查: $C_5 \sim C_6$ 旁、肩内俞、厥阴俞压痛明显,臂丛神经牵拉试验(+),旋颈试验(+).诊断:混合型(神经根型+椎动脉型)颈椎病。治疗当疏筋活血,通络止痛。电针合刺络拔罐,取穴:颈夹脊($C_5 \sim C_6$)、肩井、百会、天宗、曲池,肩内俞刺络拔罐,当即拔出瘀血约10ml。患者即感颈项板滞感减轻,治疗3次后,头晕等症状明显减轻,手指麻木消失。连续治疗7次,诸症消失,临床治愈。嘱患者注意劳逸结合,经常活动颈椎,若感不适时可佩戴颈托。1年以后再遇患者时,述由于平时注意预防,劳逸结合,疾病未见复发。

参 考 文 献

- [1] 黄丽萍,张冷.“关刺”疗法用于治疗颈椎病的体会.临床军医杂志,2004,32(2):116~117
- [2] 李智.“小醒脑”针法配合推拿治疗颈性眩晕临床观察.河北中医,2004,26(2):124~125
- [3] 王常印.电针夹脊穴治疗神经根型颈椎病144例.针灸临床杂志,1998,14(5):23~24
- [4] 曾小香.隔姜灸治疗颈性眩晕40例疗效观察.新中医,2004,36(8):52~53
- [5] 王进,高晓红.浅深刺法治疗颈椎病108例.上海针灸杂志,1997,16(1):16
- [6] 陈粉扣,陈宁.雀啄刺法、温针治疗神经根型颈椎病66例.针灸临床杂志,2003,19(2):38~39
- [7] 毕宇峰,张俊莉.针刺后溪穴配合颈夹脊治疗颈椎病86例.陕西中医,

2004, 25 (3): 262 ~ 263

- [8] 欧阳八四. 短刺加电针夹脊穴治疗神经根型颈椎病 48 例临床观察. 辽宁中医杂志, 2005, 32 (7): 715
- [9] 朱建国. 针刺颈夹脊穴结合穴位注射治疗颈椎病 264 例. 江苏中医药, 2003, 24 (11): 47
- [10] 吴际生. 针刺颈四穴治疗颈椎病 64 例. 河北中医, 2002, 24 (4): 301
- [11] 邢健莉. 针刺配合刮痧治疗颈椎病 76 例. 河北中医, 2003, 25 (3): 212 ~ 213
- [12] 李娟. 综合疗法治疗神经根型颈椎病 80 例疗效观察. 江西中医药, 2005, (9): 60
- [13] 王勇. 定喘大椎穴齐刺治疗青少年颈椎病. 中医药信息, 2003, 20 (3): 49
- [14] 陈焕农. 梅花针加拔罐法治疗神经根型颈椎病 186 例报告. 安徽医学, 1997, 18 (5): 56
- [15] 王家瑞. 抬肩通络法治疗 43 例颈椎病疗效观察. 针刺研究, 1999, 24 (4): 253 ~ 254
- [16] 刘本立, 李健. 穴位埋线治疗神经根型颈椎病 170 例临床观察. 湖南中医杂志, 2003, 19 (3): 25
- [17] 于泽来, 林一峰, 王伟, 等. 针药结合治疗神经根型颈椎病 50 例疗效观察. 新中医, 2005, 37 (11): 63 ~ 64
- [18] 刘畅. 针推刮综合治疗颈椎病 68 例临床观察. 中国针灸, 1997, (1): 31 ~ 32
- [19] 蔡朗, 唐玉秀. 针刺治疗颈性头痛 117 例临床观察. 中国针灸, 1997, (8): 464
- [20] 龚丹. 针刺夹脊穴加“纳络取穴法”治疗神经根型颈椎病 46 例. 中国针灸, 1998, (7): 445
- [21] 景书州. 张应泰治疗颈椎病经验介绍. 甘肃中医, 2005, 18 (9): 14 ~ 15
- [22] 郭剑华. 六步法治疗颈椎病 147 例临床观察. 江苏中医, 1998, 19 (1): 30 ~ 31
- [23] 张铁英, 孙琳, 黄梅颖. 辨经取穴治疗神经根型颈椎病 360 例疗效观察. 针灸临床杂志, 2005, 21 (5): 18 ~ 19
- [24] 张天英. 刺络出血加角法治疗颈椎病临床观察. 按摩与导引, 1998, (1): 38 ~ 39
- [25] 吴九伟. 电针加刺络拔罐治疗颈椎病 66 例临床观察. 中西医结合学报, 2003, 1 (3): 214 ~ 215

【落 枕】

落枕是指患者颈项部强痛、活动受限的一种病证。又称“失枕”、“失颈”。主要由项部肌肉感受寒邪或长时间过分牵拉而发生痉挛所致。多见于成年人，中、老年患者落枕往往是颈椎病变的反映，且易反复发作。西医学的颈肌劳损、颈肌风湿病、颈部扭挫伤、颈椎退行性变以及颈椎小关节滑膜嵌顿、半脱位或肌肉筋膜的炎症等疾病所引起的颈项强痛、活动障碍，可参考本节治疗。

中医学认为，本病多由睡眠姿势不当，或枕头高低不适，引起颈部气血不和，筋脉拘急而致病。也可由颈部扭伤或风寒侵袭项背，局部经气不调而致。

本病收录了18位针灸医家的临床治验，从取穴来看：有的取悬钟，有的取犊鼻，有的取落枕穴，有的取后溪，有的取外关，有的取天宗；从针刺方法来看：有的采用赤凤迎源，有的采用重刺激，有的采用巨刺，有的采用温针加走罐，有的采用耳针，有的采用快针加拔罐，有的采用刮痧术等。

针灸治疗落枕疗效快而显著。治疗的关键在于局部取穴，强调“以痛为腧”，远端穴位要强刺激，并令患者配合颈项部运动。注意保持正确的睡眠姿势；枕头高低适中，枕于颈项部；

避免风寒等外邪的侵袭。

一、独取悬钟 赤凤迎源

曾奕在临床上采用复式针刺手法中的赤凤迎源针法针刺悬钟穴治疗落枕，取得了较好疗效。

取穴：双侧悬钟。

操作：患者取仰卧位，局部穴位用75%酒精棉球常规消毒，选用30号1.5寸毫针，用夹持进针法，将针刺入皮肤后行赤凤迎源针法。先进针刺入穴位深层，得气后，再上提至穴位浅层，候针自摇，再进针插入穴位中层，然后用拇、食指边提插，边捻转。要求每捻1次，离针柄1次，结合一捻一放，两指展开，形如赤凤展翅飞旋之状，要求针感向上传导。每天针刺1次，留针30min，期间可用赤凤迎源法行针2次，以加强针感。

赤凤迎源最早见于明代徐凤所著《金针赋》中，书中描述：“赤凤迎源，展翅之仪，入针至地，提针至天，候针自摇，复进其元，上下左右，四周飞旋”。使用此法可疏通经络，作为通经接气的催气手法，以促使针感通过关而达病所，临床可用于各种疼痛病证。悬钟具有强筋健骨、通经活络、柔筋止痛的作用，尤其对足少阳胆经及经筋所辖区域内的疼痛有较显著疗效，是临床上治疗落枕的常用穴，而取双侧悬钟则可加强治疗效果。因此在治疗落枕针刺悬钟时应用赤凤迎源针法可通行经气，使针感循经向上传导，从而大大加强悬钟柔筋止痛的治疗效果，达到事半功倍的目的。

韩某，女，43岁，2000年3月8日初诊。主诉：左侧颈部疼痛1天。缘于1天前晨起时无明显诱因感颈部肌肉痉挛、紧张，疼痛较剧，活动受限，余无异常。X线片检查未见明显异常。按上述方法用赤凤迎源针法针刺悬钟穴，症状明显减轻。次日再行治疗1次后症状完全消失。

二、单刺犊鼻 驱风止痛

王远华在临床诊治膝关节病变时，偶然发现膻穴犊鼻有治疗落枕的作用，后经临床验证，效果甚佳。

取穴：犊鼻。

操作：患者取坐位姿势，取 2.5 寸毫针刺入患侧犊鼻穴内，寻得针感后，行平补平泻手法，运针 1min，边运针边嘱患者活动颈项部，留针 10min 后起针。每日针刺 1 次，3 次为 1 个疗程。

犊鼻穴属足阳明胃经，该经上起于头，下行于足，经过颈项，“经脉所过，主治所及”，故而有效。另据《灵光赋》“犊鼻善治风邪痛”的记述，说明犊鼻穴有驱风止痛的功效，而落枕病之发生又多与睡觉姿势不当，加之患部感受风寒所致，故针犊鼻穴治本病有良效。

杨某，女，48 岁，老师，1993 年 6 月 3 日就诊。主诉：颈项强痛 2 日余。患者自 2 日前早晨起床时即觉颈项疼痛，强硬不适，曾服三七片、舒筋活血片，外用正红花油涂擦等方法，见效不显。检查：患者左侧颈后肌肉发硬，有压痛，患者不能向右侧歪头与转动。颈椎 X 线片未见异常。诊断：落枕。王远华采用上法治疗，几分钟后，患者即诉颈疼明显减轻，颈部活动范围也明显增大，次日复治 1 次告愈。

三、落枕穴 重刺激

吴奇方采用巨刺法针刺落枕穴治疗落枕，取得较为满意的效果。

取穴：落枕（位置在手背 2，3 掌骨间，掌指关节后 5 分。第二伸指肌腱桡侧），左侧痛取右落枕穴，右痛取左，双侧痛取双侧落枕。

操作：患者取坐位，将手平放于桌上，掌心向下，用 28 号 1 寸毫针刺入落枕穴 5~8 分，针尖需斜向上。重度捻转，泻法，使针感向上臂放散，以感传达肩部、颈项部为佳。同时让患者前后左右慢慢活动颈项部，范围由小到大，直至疼止。每 10min 行捻转手法 1 次。每次留针 30~40min，每天 1 次。

落枕多因睡眠时风寒侵袭颈项肩部经络，或睡眠时体位不适，或颈部强度用力，致使气血不和，筋脉拘急所致。落枕穴是治疗落枕的经验穴，针刺可以疏通经络，推动气血运行。活动头项部，可使斜方肌的痉挛消除，改善血液循环，起到镇痉止痛之效。

王某某，男，28 岁，1994 年 8 月 29 日诊。晨起左颈项疼痛，连及左肩部活动受限，头部向右转动则左侧颈项痛甚，取右手落枕

穴，针尖向上斜刺 5 分，针感传到肩颈部，慢慢活动头项，30min 而愈。

四、巨刺后溪 散瘀止痛

谈晓玲采用巨刺法治疗落枕，疗效显著。

取穴：后溪。

操作：用巨刺法治疗，即左侧痛取右侧后溪穴，右侧痛取左侧后溪穴，双侧痛取双侧后溪穴。患者取坐位，将手握拳置于桌上，掌心向下，皮肤常规消毒，选用 30 号，1.5 寸毫针由后溪穴向腕关节方向呈 60°角刺入 1.5 寸，施以捻转手法，用泻法，使得气强烈，辅以提插手法使针感向上臂放散以感传到肩部、颈部为佳，同时嘱病人向受限方向活动颈部，其幅度和速度不宜过大过快，留针 15min，其间行针 2 次，起针后再嘱病人活动颈部 3min。

膻穴有通经活络，散瘀止痛之效。“膻主体重节痛”。凡风寒湿留滞，经气不畅所致的一切疼痛均可取之。督脉经和足太阳膀胱经循行于颈部，而手太阳小肠经和足太阳膀胱经又存在着流注关系，所谓“经脉所过，主治所及。”故本法选用位于手部的手太阳经输穴、八脉交会穴通于督脉的后溪穴可起到舒经通络止痛解痉的作用，针刺时配合患者进行颈部活动可达事半功倍之效。巨刺起源于《内经》，是一种左病右取，右病左取，在健侧肢体上取穴治疗的针刺方法，能更好地改善患者的血液循环，并能调摄全身气血达到阴阳平衡的整体治疗目的，促进患侧的康复。

五、外关巨刺拔罐 立竿见影

张书彪在临床上观察到巨刺外关穴加痛区拔罐治疗落枕有立竿见影之效。

取穴：外关。

操作：取 28 号 1.5 寸毫针，常规消毒穴位皮肤，以 80°角向上刺入外关 0.8~1.2 寸，得气后让患者活动颈部，留针 5~10min，中间以捻转泻法行针 2~3 次，针后在病变部位（压痛最敏感处）拔火罐 10~15min 即可。

外关穴属手少阳三焦经穴位，其经络线循行通过颈肩部，根据

经脉所过主治所及原理及《素问·调经论》“巨刺者，刺经脉，左痛刺右，右痛刺左”的理论，张书彪选用巨刺外关穴治疗落枕，配合痛区拔罐可起到疏通经络、活血镇痛之效。经多年来临床使用观察，多数落枕患者一次即可治愈，个别患者需要2~3次治疗，鲜有不效者。

郭某，女，31岁，2001年3月23日初诊，病史：患者晨起时突然感到颈部左侧剧烈疼痛，颈功能活动障碍，尤其是颈部左旋及后仰者更甚，即到针灸科求治。查其颈部左侧C₅椎旁明显压痛，颈部呈右斜位，诊为落枕。令患者取坐位，如上法针其右侧外关穴，下针得气后施以捻转泻法，针感循经上传至肘部，患者立即感觉疼痛缓解，颈功能活动明显改善，留针5min，尔后在痛区拔罐10min，治疗完毕患者基本恢复正常，次日复诊已痊愈。

六、手三针治落枕 针到即愈

杨立柱采用自拟“手三针”治疗落枕，治疗效果满意。

操作：①落枕（手背第二、第三掌骨间，手掌指关节），向上斜刺0.5寸；②中渚，直刺0.4~0.5寸；③外关，直刺0.5~1寸（或透内关）。取患侧穴，均用泻法，用捻转泻法。边进针边嘱患者活动颈部，大多数患者经针刺落枕穴即可收效，如疗效不佳，再刺中渚和外关。留针10~20min，3~5min捻转1次。隔日针1次。

《内经灵枢·经筋》篇云：“足太阳之筋，起于小趾，……与膈中并上结于臀，上挟背上项；”“手太阳之筋，起于小指之上……上绕肩胛，循筋出走太阳之前，结于耳后完骨”。“手少阳之筋，起于小指次指之端……上肩，走颈，合于手太阳。”“手阳明之筋，起于大指次指之端……直上，从肩，上颈。”因此落枕之后，与以上四条经络有关，但以手、足太阳经及手少阳经受累为主。其病因病机不外感受风寒，转头失当、气血失宣、络脉受阻，以致项强牵制，强行活动，痛苦难忍。外关为手少阳之三焦经之络穴，中渚为手少阳经之输穴，落枕穴是经外奇穴，对落枕有特殊疗效的穴位。有大部分落枕患者仅此一穴针刺，头颈部活动即感灵活。临床上只要症状单纯的急性病患者（3天内），1天内效果更好，往往1针见效。

男，20岁，1992年8月30日诊。晚上睡眠欠佳，加之枕头不

适，一觉睡到晨8时许，起床时即感颈部活动不灵，有牵拉感，不能抬头仰视及左旋盼顾，用力右旋则左侧颈部疼痛难忍即来求诊。检查：头部右旋受限， $C_3 \sim C_5$ 左侧肌肉有压痛，左上肢活动无异常，舌苔薄白脉浮数，诊为落枕。即按上法治疗，先针左落枕穴，进针即感颈部活动自如，再针外关、中渚，1次告愈。

女，45岁，1997年9月5日诊。因晚上睡眠不慎，早上起来感颈部不适、活动不利，左右转动均受阻，两肩部有牵拉感，已8天。曾经针、药治疗，未好转。检查： $C_2 \sim C_3$ 两侧颈肌有压痛，微红肿。脉细，舌苔薄。诊断为落枕。处理：针刺落枕、中渚、外关3穴，双侧泻法，隔日1次。结果：1次好转，3次痊愈。随访2个月，颈部正常。

七、温针走罐 祛风通络

杨冰采用温针加走罐治疗落枕，取得满意疗效。

取穴：风池（双），阿是穴（取最明显压痛点），落枕（双）。

操作：患者取坐位，双手自然放在双膝上。选30号1.5寸毫针，常规消毒。先针落枕穴，向掌心方向斜刺0.8~1.2寸，得气后，采用强刺激捻转泻法，同时让患者轻轻转动颈项，幅度由小到大，活动2~3min，留针20min。风池针尖微下，向鼻尖斜刺0.8~1.2寸。阿是穴视其痛点不同，选择进针角度、深度。患侧风池、阿是穴进针后行捻转泻法，得气后留针不动。随后在针柄部插上一节（约2cm长）药用艾条，点燃加温。视患者耐受度连灸2~3壮，待艾燃尽，退去残灰，稍加行针后出针。针后在患部施用走罐，先在患部涂少许凡士林，以玻璃罐闪火法拔罐，顺项肩来回推动3~5min，留罐于痛点，再5min后起罐。经上述治疗，多数患者1次治愈。若仍有不适者，次日可再作1次治疗。

温针具有针刺、艾灸双重作用。燃艾于针尾，借艾灸之热力，增强了温经散寒、祛风通络、调和气血、除湿利关节的作用。更配以走罐，由于局部充血、瘀血、毛细血管破裂，出现罐斑，使机体产生郁血重吸收现象，这一过程，使火罐对穴位的刺激作用得以持续，温经通络、祛寒逐湿、行气活血止痛之功益彰。

陈某某，男，35岁，司机。2000年10月5日就诊。自述：昨

晚11时许,等客时在车内打盹,醒后自觉颈项活动略有不适,未作处理。今晨起即感颈后部强直疼痛,不得俯仰转侧,并向右肩扩散。查:颈后右侧肌肉痉挛强直,压痛明显。诊为落枕。经以上方法治疗,1次治愈。

八、针刺天宗 舒经活络

王占慧在临床中应用针刺天宗穴治疗落枕,疗效可靠。

取穴:天宗。

操作:用75%酒精常规皮肤消毒后,用30号,2.5寸毫针刺入穴位,针尖向上斜刺0.5~1寸,采用手法捻转,进针用泻法,使针感向肩及上臂传导。当患者感到酸麻胀时留针25~30min,留针期间每隔5min捻针1次。在针刺中令患者不断活动头颈部,起针后医者用手再拍打颈肩部5~10min。

天宗穴在冈下肌中,有旋肩胛动静脉的肌支,布有肩胛上神经。而天宗主要功用有舒筋活络,行气宽胸的作用,针刺天宗穴能激发手太阳小肠经的经气传导,更进一步发挥天宗穴的舒筋活络作用,疏通了闭塞的经络,经络通疼痛止。

患者,男,45岁。因饮酒过量卧床而眠,醒来时感到头颈僵硬酸痛难忍,活动受限。经查颈肩部压痛明显。但局部皮肤无红肿现象,诊为落枕。当即针刺天宗穴,边针边嘱患者活动头颈,经治疗25min后患者头颈活动自如,压痛消失。

九、手足配穴 后溪-束骨

落枕的主要临床表现为颈部酸痛不适,俯仰转动不灵;重者疼痛延及患侧肩背及上肢,头向一侧歪斜。吕景山遵《灵枢·杂病》篇:“项痛不可俯仰,刺足太阳;不可以顾,刺手太阳也”之旨,辨证施治。即项痛不可以左右顾者,取后溪为治。项痛仰头低头困难者,取束骨穴为治。

后溪为手太阳小肠经输穴,乃小肠经气所注,为俞(木)穴,又是八脉交会穴之一,通于督脉,与阳跷脉申脉穴相沟通。有宣通阳气,宁心安神,清利湿热,通络止痛之功。束骨为足太阳膀胱经输穴,是膀胱经气所注,为俞(木)穴,有宣通本经阳气,祛风散

寒，发汗解表，通络止痛之效；二穴伍用，一手一足，一上一下，同经相应，同气相求，相互促进。若因受风而致者，加风池、天柱，亦可取大椎火罐。吕景山每遇此类病症，均守方为治，一般针治1~2次即愈。

某男，中年。因夜卧受寒，翌日晨起，即现颈项强痛，以致不能低头、仰头，亦不能向左回顾。检查：舌质淡，苔薄白，脉弦细，向左侧转头时，右侧天柱穴周围有明显的自发痛、压痛。脉症合参，证属足太阳被寒邪所袭，经气不利，经筋受损。治宜疏散太阳寒邪，通经活络止痛。取穴：后溪、束骨。针刺用泻法。边行针边令患者活动颈项，活动范围由小到大，切勿用力过猛，以免经筋再度受损。先刺后溪，行针1min后，左右回顾疼痛减轻，惟仰头时痛减感如故。继针束骨，顿时疼痛缓解。留针30min，每10min行针1次，起针时病情明显好转。翌日又针1次，痛止病除，活动自如。

十、耳穴针刺压丸 祛痛快

刘士佩在临床上采用耳穴治疗本症效果满意。

取穴：颈、肩、枕、神门。如颈部感受风寒者加肾上腺、皮质下；气血失调者加心、耳尖（放血）；少阳经络受阻者加肝。

操作：取患者耳廓颈区阳性反应点（红晕或结节处），或压痛点。对耳廓常规消毒，取0.5寸28号毫针，左手捏托耳穴，右手拇食二指持针准确刺入所取穴位或阳性反应物，捻转进针，以针入皮内耳软骨，不穿透耳廓背面皮肤为度。耳廓感酸、胀、麻、痛、热时令患者活动颈肩部，留针20~30min。

耳穴压丸：对耳廓按常规消毒，将医用橡皮膏或活血止痛膏剪成0.6mm×0.6mm大小斜方块，将炮制过的王不留行籽置于方块中心，每个小方块放入1~2粒，然后将其贴在所取耳穴上，按压1~3min，患者自觉酸、胀、麻、热、痛时，令其活动颈肩部。隔日换药1次，每天令患者自己按压所贴耳穴3~5次，每次1~3min。耳穴压丸3~5次为1个疗程。

陈某，女，35岁，干部。由于睡眠不慎，次日晨起即觉左侧颈肩疼痛，活动受限，头颈偏向左侧。查颈肌紧张，胸锁乳突肌后缘压痛（++），耳穴颈区外缘呈点状充血，压痛（+++）。针刺左

耳廓部颈区阳性反应点，肝、枕、肩、神门，即感耳部热至颈区，头颈活动当即自如，留针 10min 后出针，病愈。

十一、顽固性落枕 针罐推

落枕是针灸科常见病。顽固性落枕是指发病后经治疗 1~2 周末愈者或经治疗已愈后多次复发的反复性落枕。万兆和采用针刺加电疗、拔罐、推拿综合治疗，取得较好效果。

电针：主穴：后溪（直刺 1~1.2 寸），百劳（斜刺，针尖向督脉方向呈 45°角刺入 1~1.2 寸）。配穴：天宗、肩中俞、肩井（直刺 0.5~0.8 寸，均取患侧）。手法：用提插捻转法，主穴用泻法，配穴平补平泻。待得气后用 DG-1 型治疗仪，正负两极分别夹住针柄，选用频率为 60~80 次/min 连续波刺激，量以患者局部肌肉轻微跳动、感觉舒适为宜，留针 20 min。

拔罐：起针后，嘱患者头部前屈后伸及左右慢慢旋转数次，以最大幅度为限。在原施针穴位上选用所需的中、小号口径竹罐，用投火法拔罐，留 5~10min 起罐，用干棉球擦去吸出的瘀血黏液。

推拿：病者正坐位，医者站于患者背后，左手扶患者头顶部，右手对颈部及所牵引的肩胛背肌施按、揉法约 5min，手法先轻后重。用单手按拿法，从风池穴沿颈项椎肌及两侧胸锁乳突肌向下至大椎两旁往返推拿理筋约 5min。左手托患者下颌，右手托枕后向上缓提，左右慢慢拨动，前俯后仰，幅度由小到大，反复 3~5 次，最后双手按拿肩井穴数次，手掌轻轻拍打若干次即可。

中医学认为“不通则痛，通则不痛”。后溪为手太阳经输穴，又为八脉交会穴之一，通于督脉，能直达病所；百劳位于病变所在，属经外奇穴，针尖向督脉方向透刺而补阳（督为阳脉之海）。两穴用泻法，具有通经活络、调和气血之功。天宗、肩中俞、肩井用平补平泻法，以舒筋活血、祛风散寒。针刺得气后加微量电流刺激，能促进局部的血液循环。针后拔罐吸出瘀血黏液，有助祛瘀生新，扶正祛邪。加之局部推拿，理筋通络，松解粘连，更进一步改善血液循环，营卫气血运行通畅，则肌肉痉挛得到解除。以上 3 法合用，相得益彰，故能取效。

十二、液门透中渚 左右捻转

落枕，又名失枕。临床表现颈项强痛，活动受限，局部肌肉紧张或轻度挛缩，或有触痛，多因睡眠姿势不当，颈项部肌肉牵掣过久，或感受风寒后引起，常于起床时突然发现。依经络辨证，左右回顾困难者，病位多属少阳；前俯或后仰不便者，系督脉或任脉受累。

陈克勤在针刺感传研究过程中，发现针刺液门透中渚穴时，其针感可沿上肢肘臂外侧放射至肩、头顶部，因此，便依经之所过，穴之所治，“刺之要，气至而有效”的理论，针刺该穴治疗落枕，疗效显著。绝大多数针1次可愈。

操作：取患侧或双侧穴位，宜握拳俯掌位取之。针由液门穴刺入，沿第四、第五掌骨，深刺1~1.2寸。得气后，嘱患者仿气功之缓慢匀调的腹式呼吸或随其自然呼吸，将针左右捻转，同时令患者左右前后活动头颈，以使与针之捻转相配合。每次捻转时间以1min为一度，间隔3~5min，再施手法。一般3~5次即可。

若针治1次效不著，前俯后仰痛甚者，可取人中或承浆，直刺1~3分，捻转0.5~1min，留针10min，其间再捻转2~3次。左右回顾痛甚者，取同侧或双侧风池穴，手法如上。当捻转时，如能气至痛处，可立效。

权某，男，35岁。夜卧因枕头不适，于晨起床后，即觉颈部左侧疼痛、僵硬，致颈项向健侧倾斜，左右活动极难，头前俯后仰亦觉不便。午后即针左侧液门透中渚穴，针入痛大减，头项即能左右前后活动，捻转30s时，疼痛基本消失，惟稍觉局部强硬不适，继之留针2min，起针。第二天，头项活动自如，一切复常。

十三、辨经取穴 快针拔罐

倪卫民跟随上海名老中医陈作霖教授拜师学习，根据陈老的临床经验，以辨经取穴法治疗落枕，疗效显著。

取穴：查找阳性反应点（肌紧张点或压痛点），辨明循行所过的经脉，取该经脉的远道穴作为治疗主穴：①阳性反应点在颈侧胸锁乳突肌部位，属于阳明经，取三间穴；②阳性反应点在脊柱与肩胛

骨之间的斜方肌部位，属手太阳经，取后溪穴；③阳性反应点在一侧肩胛冈上缘，属手少阳经，取中渚穴；④阳性反应点在椎体棘突处，属督脉，取人中穴。

操作：上述腧穴除人中采用向上斜刺法，其余腧穴均采用直刺法，均行捻转泻法，使针刺部位有酸胀重麻疼等感觉，如有针感循经传导则更佳。行针约1min，同时配合颈部活动，间隔10min后再行针1次并起针。如经2次行针后患处仍有较明显的肌紧张或压痛点，可再行局部针刺，得气后即出针并拔罐，每天1次，3次为1个疗程。

中医认为落枕是外感风寒之邪侵袭颈项，使局部气滞血瘀，经气不通而痛。《诸病源候论·失枕》云：“头颈有风，在于筋脉间，因卧而气血虚者，值风发动，故失枕。”治疗落枕现代临床多用经验穴（落枕穴）或某一单穴，但疗效时好时差。早在《灵枢·杂病》中就有辨经治疗的记载：“项痛不可俯仰，刺足太阳；不可以顾，刺手太阳。”本法以“经脉所过，主治所及”为指导原则，辨明病变部位，对应选穴，使气至病所，舒经通络；辅以颈部活动，快针加拔罐，活血化瘀，改善局部血液循环，缓解肌肉痉挛，通经止痛。

余某，男，30岁，工人。初诊日期：1998年1月12日。因睡姿不当而致左侧颈项部疼痛，次日前来就诊。诉颈部活动受限，转侧不利。查体：头略向左偏斜，左侧肩井穴部位有压痛。舌淡苔薄，脉滑。治以舒经通络。取穴：中渚。操作：以毫针直刺0.5~1寸，得气后行捻转泻法1min，配合颈部活动，10min后再行针1次并起针。行针后，患者立感颈部轻松，活动受限明显减轻。第二次行针后颈项活动自如，肩井穴压痛不明显，临床治愈。

十四、落枕—阿是穴 阻力针刺配推拿

陶明忠采用阻力针刺法结合推拿治疗落枕患者，取得满意效果。

取穴：落枕、阿是穴。

操作：针刺落枕穴为常规针刺，阿是穴采用阻力针法，均留针，针刺阿是穴，选择颈部疼痛剧烈姿势，找其压痛点进行针刺，进针三分，做雀啄手法；同时令患者活动颈部受伤部位，待疼痛减轻，活动较自如，即停止手法出针。如病人颈侧屈疼痛难忍，先针落枕

穴，减轻疼痛并转移病人注意力，然后即让病人侧屈，找出颈部疼痛最敏感处进针，先进针三分，做雀啄手法，并令病人反复侧屈，先慢后快，直到疼痛自感减轻、酸胀感减轻或消失后，停止手法出针。

推拿：针刺治疗后，疼痛缓解，颈部活动明显改善，但仍存在颈椎后关节紊乱和受损肌群的进一步恢复，此时在颈部肌肉痉挛松懈情况下，进行推拿和颈部斜扳法，以促进受损肌群恢复和纠正颈椎后关节紊乱。具体操作：先用滚法在患侧颈肩部治疗5遍。用拇指揉法在项颈部治疗5遍，拿头部肌群5遍，拇指点按两侧肩井穴、风池穴各1min，再用弹拨手法施于患侧肌肉痉挛处，使头部肌肉放松，然后用头部斜扳法纠正关节紊乱，进行复位后，再用揉法和拿法从上而下理顺颈部诸肌，以患侧拇指关节牵拉活血法结束治疗。

胡某，男，34岁，1989年9月5日来厂卫生处康复理疗室就诊。病史颈部疼痛难忍，颈活动严重受限，侧屈，旋转，前屈后仰均受限，尤以左侧屈更甚，查体可见， $C_3 \sim C_5$ 左侧棘突旁压痛，以 C_3 明显。可触及明显筋束和 C_3 棘突左移，击顶试验（±），椎A扭曲（-），臂丛牵拉（-），诊断落枕。治疗选取落枕穴、阿是穴，阿是穴采用阻力针刺法，以病人侧屈疼痛明显姿式，找准压痛点针刺，边行雀啄手法边令病人反复侧屈，直至疼痛消失出针，继之用推拿手法治疗，斜扳复位后结束治疗，病人1次治愈。

十五、针罐并用

田海燕采用手针加火罐治疗落枕，疗效满意。

取穴：手针落枕（手背第二、第三掌骨间，掌指关节后0.5寸）。

操作：病人坐位，手放病床上，取双侧“落枕”穴，皮肤消毒，用1.5寸毫针直刺0.5~1寸深。得气后施以泻法，行针20s后留针，同时暴露患侧颈背部拔以火罐，并嘱病人左右转动前后俯仰颈部，直到疼痛减轻或消失。每次留针30min，拔火罐20min，每天1次，连续治疗4天。

落枕多由睡眠姿势不当，或风寒侵袭颈背部致使局部气滞血瘀，经气不调。多在晨起后一侧项背酸痛不适，颈部活动受限。“落枕

穴”为经外奇穴，加之患部拔罐治疗，可起祛风散寒，活血化瘀，舒筋活络之功。实践证明，手针加火罐方法简便，经济实用，且见效快，只需1~4天治疗，治愈率高，是较为理想的治疗手法。

陈某某，男，28岁，厨师。1997年3月19日晚睡眠时姿势不当，致使落枕，第2天大早急来针灸科诊治。病人左侧项背牵拉痛，颈部不能俯仰及左右转侧，表情痛苦。查体：左侧颈背部稍有肿胀，活动不利。在左侧颈背部施以拔罐，同时刺“落枕穴”，行针20s，即嘱活动颈部，留针30min，拔罐20min后，颈部活动正常，肿胀消失。

十六、多法并用 法分五步

杜梦玄综合运用针刺、推拿、火罐，贴麝香镇痛膏等多种治疗手段，按五步法治疗落枕，取得了一次性治愈的满意疗效。

取穴：主穴列缺；随症加减：肩中俞、肩外俞、肩井、阿是（任取一穴）。

操作：第一步，患者坐位，取患侧列缺，用32号1.5寸毫针向肘部方向快速斜刺0.3~0.5寸，行捻转提插较强刺激，并嘱患者活动颈部约1min。第二步，紧接上步，左右手配合，一只手捻转行针，另一只手在颈项部从风池至肩井一线用推揉手法，并嘱患者继续摇动颈部，再揉按风池，肩中俞、肩外俞、肩井等穴，找出压痛敏感点，并重点揉按此敏感点，治疗约5min左右。第三步，在敏感点上用32号1.5寸毫针刺入1针，留针10min。第四步，拔出敏感点中的毫针，再在此点上拔火罐1个，留罐5~10min，并继续捻转列缺穴上毫针，随后拔出。第五步，为加强疗效，在敏感点部位贴上麝香镇痛膏1次。

落枕又名失枕，失颈，是指睡眠醒来时突觉项强痛，颈肌僵硬活动受限的一类病证。系因颈部姿势不当，风寒外邪侵袭以及外伤扭伤等引起，导致患部经气受限，血脉不通。临床上表现为颈项部疼痛、压痛，特殊的牵强姿势以及活动障碍，治疗上以疏通患部经气为原则。

操作第一步取列缺穴是根据《四总穴歌》“头项寻列缺”属常规经验取穴，同时可提高痛阈值，使活动幅度增加，因而往往一针

即可见到明显效果。第二步在颈项部从风池至肩井一线用推按揉的手法治疗既有针刺辅助手法中的循法作用，诱导患者气至病所，又有推拿手法中舒筋活血，疏经通络作用，并可较精确地找到压痛敏感点部位。第三步在敏感点上补入一针，第四步中拔火罐以加强局部调气活血，舒筋散寒之效。另外临床落枕经针灸后部分病人尚存有轻度不适，杜梦玄从痊愈考虑，加上第五步贴麝香镇痛膏外敷治疗。

本法综合运用了针刺、推拿、火罐、膏药等多种疗法于一体，各步治疗环环相扣，相得益彰，相比单独用针灸或推拿治疗具有取穴少，见效快，治疗更彻底，效果更为显著等优点。

董某，女，45岁，护士，本院职工，患者两天前因头部姿势不良，晨起突觉头项强痛，活动受限，后经贴麝香镇痛膏后略有好转，但强痛仍较明显，症见头向左侧歪斜，查体：以左肩外俞压痛明显，向右屈前屈活动明显受限。诊断：落枕。治疗按上法第一步第二步治疗症状明显减轻，经加用第三步第四步治疗，强痛基本消失，仅有轻度不适，再予贴麝香镇痛膏后于第二天已无任何不适。

十七、自配刮痧油 泻补结合

肖强兵运用刮痧术治疗落枕，收到较好效果。

刮痧油制备：紫草、川芎各 150g，当归、羌活各 120g，红花 100g，干姜、樟脑各 90g，白芷、薄荷脑、血竭各 50g，色拉油 1500ml。

将川芎、当归、羌活、干姜、白芷洗净晒干并整理呈长条状。红花、紫草（另包）置于 1500ml 色拉油中，浸泡 24h 后取出。上药以武火熬炼 30min 至药物呈金黄色时，改用文火，此时先下红花，再入紫草，熬炼约 15min，待油液呈棕红色时过 100 目筛。将樟脑、薄荷脑置乳钵内研匀，用 95% 酒精调成糊状，待油液至温热（约 30~40℃）时，再将樟脑薄荷脑及血竭粉倒入搅拌均匀，冷却后分装于 500ml 灭菌瓶中，密封备用。

操作：先将刮痧油均匀涂抹于患者颈项部，医者右手持水牛角刮痧板从上而下，由颈项正中向棘旁顺次刮拭。用力应均匀、适中，刮拭面尽量拉大。数分钟后，病灶体表出现紫红色斑点或密集的紫

红疙瘩，即为出痧。30min 后病变处疼痛明显减轻，颈项活动明显改善或接近正常，即可停刮；如无改善可在痛点泻刮 30 次左右，即可收到明显效果。

注意事项：①治疗前 15min，嘱患者饮姜汤 50 ~ 100ml，利于治疗药物吸收；②首先刮拭大椎穴及太阳膀胱经的魄户、膏肓、神堂穴，然后再按病证刮拭其他经络穴位；③刮拭时用力应适度，泻补结合，过重会损伤皮肤，过轻则难以出痧；④治疗后嘱患者即饮 350ml 温开水，使腠理开泄，病邪从汗而解；⑤治疗后 1h 内不能用冷水洗脸及手足，2 天内不宜洗澡，避免感染；⑥再次治疗宜在 5 ~ 7 天后进行，可视病情及患处皮肤修复情况而定。

落枕多因素体气血亏虚，血脉不畅，加之外感风寒湿邪而致。寒凝收引，血脉不通则肌肉痉挛疼痛。刮疹施以补泻（轻刮为补，重刮为泻），可取通经活血，扶正祛邪之效。刮痧术主要刺激皮肤，使皮下充血，毛细血管扩张，秽浊之气由里出表，体内邪气得以宣泄，从而邪解。

刮疹油所含药物，直接作用于患处，循经疏理，通血脉散风寒，可使邪从汗解。现代研究表明，刮疹术能使局部微血管和毛细血管扩张，血容量和血流量增加，有利于致炎物质吸收和消散，从而产生自然生理循环的效应。

徐某，男，52 岁，干部，1999 年 8 月 2 日初诊。患者午睡当风，醒后颈项强直疼痛，转侧不利，牵引背部，舌薄白，脉浮紧。拟用刮疹术治疗。泻法刮拭大椎、大抒、膏肓、神堂，出现紫红色疙瘩时，配合刮拭阿是穴、风池、后溪、落枕、绝骨、肩井、缺盆，刮拭后立即饮用热开水 250ml，即获痊愈。

十八、意气针灸 远端针刺拔罐

秦玉革采取以“意气针灸疗法”加拔罐的综合方法治疗重症落枕，取得满意疗效。

（1）意气针刺泻法

以 1 ~ 2 个最痛点为阿是穴，用 30 号，1.5 寸毫针令患者吸气时快速直刺 0.8 寸左右并摇大针孔，然后以指捏针但不做任何提插捻转等手法，全神贯注于针下做以意行气的泻法观想：想象针下的病

气如水一般被从针孔抽到体外。约 10min，退针至皮下，让患者活动颈部以观察颈痛减轻的程度，明显减轻或消失者令呼气时出针，不揉针孔；若减轻不明显者可再刺入行如上泻法 10 ~ 15min。所用意念观想一定要以出气为主，否则可能成为“以意行气的补法”。每天 1 次。

（2）拔罐及远端针刺

在针孔上及附近拔罐 10min；颈痛消失者可不拔罐及远端针刺，此后二步治法。以 30 号，1.5 寸毫针斜向肘部针入养老穴，大幅度提插捻转约 20s，以强烈的酸胀感为佳，每隔 5 ~ 10min 行针 1 次，同时嘱患者活动颈部，30min 后起针。

落枕因垫枕、睡姿不良或外感风寒而致颈项软组织痉挛，造成痛处气血瘀滞，实则急当泻之。而秦玉革所用“意气针灸疗法”是十余年前根据东方古文化及《灵枢·九针十二原》“迎之随之，以意和之，针道毕矣”等悟出，此法不但有强大的补泻作用，而且另一特点是仅有刺入一针的微痛，不要求提插捻转的酸胀等针感，所以没有因刺激痛处而反加重伤处软组织痉挛的缺点，因此秦玉革敢直刺痛处先猛泻其病气，病气大衰则其痛必缓解或消失，加拔罐以活血通经止痛，然后再辅以针刺养老，效果则更佳。此时大多数患者已能忍受颈部活动时出现的疼痛，在活动中使可能紊乱的颈椎小关节得以恢复，使颈痛进一步缓解。

患者，男，31 岁。3 天前晨起时颈痛且渐加重，颈项部活动严重受限，头部明显歪向右侧，右侧颈肌痉挛，在 C₇ 旁触及肌肿块和压痛点，诊断为落枕。针此痛点 1 针，行如上泻法时可明显感到一股寒气从针孔源源而出，约 15min 后颈痛及压痛均消失，颈部功能活动完全恢复正常。虑其寒重而拔罐数个，罐内果然皆现紫黑之色。1 个月内随访未发作。

参 考 文 献

- [1] 曾奕. 赤凤迎源针法治疗落枕 48 例疗效观察. 新中医, 2002, 34 (9): 50
- [2] 王远华. 单刺颊鼻穴治疗落枕 100 例. 四川中医, 1999, 17 (1): 56
- [3] 吴奇方. 毫针巨刺治疗落枕 100 例的疗效观察. 江西中医药, 1995,

增刊: 56 ~ 57

- [4] 谈晓玲. 巨刺法治疗落枕的临床疗效观察. 四川中医, 2000, 18 (12): 52
- [5] 张书彪, 段艳丽. 巨刺外关穴加拔罐治疗落枕. 中医外治杂志, 2002, 11 (4): 42 ~ 43
- [6] 杨立柱. 手三针治疗落枕 120 例疗效分析. 现代中西医结合杂志, 2002, 11 (16): 1593 ~ 1594
- [7] 杨冰. 温针加走罐治疗落枕 76 例. 四川中医, 2001, 19 (3): 74
- [8] 王占慧. 针刺天宗穴治疗落枕 45 例. 上海针灸杂志, 2006, 25 (12): 39
- [9] 胡熙明. 针灸临证指南. 人民卫生出版社, 1991, 511
- [10] 胡熙明. 针灸临证指南. 人民卫生出版社, 1991, 514
- [11] 万兆和. 综合疗法治疗顽固性落枕 97 例. 河北中医, 2000, 22 (9): 693
- [12] 胡熙明. 针灸临证指南. 人民卫生出版社, 1991, 514
- [13] 倪卫民, 黄元芳. 辨经取穴治疗落枕 96 例. 江苏中医, 2000, 21 (6): 37
- [14] 陶明忠. 阻力针刺法结合推拿治疗落枕 68 例报告, 1994, (3): 26
- [15] 田海燕. 针、罐治疗落枕 80 例. 江西中医药, 1997, 28 (5): 38
- [16] 杜梦玄. 五步法一次性治愈落枕 78 例体会. 针灸临床杂志, 2002, 18 (10): 38
- [17] 肖强兵, 邹季, 王善文. 刮痧术治疗落枕 50 例. 湖北中医杂志, 2001, 23 (4): 46
- [18] 秦玉革. 意气针灸疗法加拔罐治疗重症落枕 175 例. 上海针灸杂志, 2006, 25 (4): 42

【肌性斜颈】

肌性斜颈是指以头向患侧斜、前倾，颜面旋向健侧为其特点。临床上，斜颈除极个别为脊柱畸形引起的骨性斜颈，视力障碍的代偿姿势性斜颈和颈部肌麻痹导致的神经性者外，一般系指一侧胸锁乳突肌挛缩造成的肌性斜颈。其病理主要是患侧胸锁乳突肌发生纤维性挛缩，起初可见纤维细胞增生和肌纤维变性，最终全部为结缔组织代替。其病因尚未完全肯定。

本篇共收录了 10 位针灸医家的临床治验。有的采用循经取穴与病位取穴相结合的方法治疗；有的采用缓刺不留针，配合按摩；有的以针刺为主，配中药外敷；有的独取太溪；有的采用电头皮针配体针等。

一、重取穴 通少阳 - 阳明经气

李延芳认为本病多由产伤及宫内发育不良导致病变局部气血郁滞，经脉瘀阻，而致旧血不去，新血不能濡养而造成胸锁乳突肌缺血、缺氧、肌肉挛缩。临床上常用针刺治疗肌性斜颈，疗效肯定。

取穴：主穴：翳风、完骨、扶突、气舍、外关、曲池、合谷。配穴：天窗、天牖、水突、阿是穴。每次治疗时从主穴和配穴中选 6 ~ 8 个穴位，10 次为 1 个疗程。

操作：用针刺快速轻柔点刺法。所选穴位常规消毒。然后用32号1寸毫针快速轻柔点刺，得气为度，不留针。

李廷芳认为小儿斜颈，病变在颈部，累及少阳、阳明二经。病因为产伤及宫内发育不良而致经脉阻滞，气血郁滞，瘀血不去，则新血不能濡养而致胸锁乳突肌缺血、缺氧，肌肉挛缩而致本病。

对于本病的治疗，根据病因及病变部位，采用循经取穴及病位取穴相结合的方法。以理气活血，疏通经络为准则。故取翳风、完骨、扶突、外关、曲池、合谷等穴，以疏通少阳、阳明之经气，使气血流畅，瘀去新生，改善局部血液循环，使挛缩舒展，硬块及条索变软消失。

患儿，男，5个月。于1998年8月就诊。患儿因难产而致右侧肌性斜颈。沿右侧胸锁乳突肌方向，可明显触及条索状硬块。查体：体温、血压、脉搏均正常。神志清醒，发育良好，二便正常，食眠均可。用针刺快速轻柔点刺法。选穴：翳风、完骨、外关、合谷、天窗、水突、阿是穴，不留针。针刺1个疗程后，颈部条索状硬块消失，活动自如，而告治愈。随诊至今，未见复发。

二、缓刺不留针 配按摩

王耀民近年来采用针刺加按摩的方法，治疗小儿斜颈，疗效满意。

取穴：大椎、肩井、颈阿是、天宗、大杼、阳陵泉、绝骨。

操作：抱紧患儿，固定患侧头颈部，穴位常规消毒后，用30号1寸毫针快速针刺上穴，得气后出针，行平补平泻手法。

按摩：患儿取仰卧位，医者用拇指、食指和中指轻轻揉捏患侧胸锁乳突肌，手法由轻渐重，对硬结较大处，可在胸锁乳突肌纤维方向垂直自上而下弹拨，并配合指揉反复数次，每次按摩10min。每天1次，先针刺后按摩，6次为1个疗程，休息1天，再进行下1个疗程。

中医认为本病属“颈筋硬结”、“斜颈”等范畴。其病因病机主要是禀赋不足，气血不和，痰瘀交阻，脉络不通，经筋结聚。王耀民选用筋会阳陵泉，髓会绝骨，骨会大杼，诸阳之会大椎穴，意在通阳舒筋，壮骨益髓，此为治本之法，亦针肩井、天宗、颈部硬结

阿是穴，以通调气血，化瘀散结。

盖小儿稚阴稚阳之体，皮肤娇嫩，形气未充，缓刺留针虑其伤正留邪，故宜得气即速出针，手法用平补平泻以调之。按摩揉捏弹拨之术，可缓解肌肉痉挛，促进血液循环和营养代谢，降低神经末梢兴奋性，增强消炎止痛散结功能。

患儿，男，出生31天。1998年5月6日就诊。其母代述：小儿出生后半月发现右颈部有一肿块，头向右侧歪斜，遂往省儿童医院诊治，被诊为肌性斜颈，建议采用针灸按摩治疗。患儿满月后来针灸科求治。体查：发育尚好，头颈略向右偏斜，右胸锁乳突肌中部可触及1.5cm×2.0cm大小硬块，如软骨。诊为“颈筋硬结”，拟舒筋通络，消瘀散结，壮骨益髓之法，针刺按摩并用，15次后诸证全消，病告痊愈。

三、针刺为主 配中药外敷

吴永刚采用针刺配合中药外敷的方法治疗痉挛性斜颈，疗效满意。

取穴：天柱、大杼、昆仑、外关、中渚，均为双侧。

操作：用30号1.5寸不锈钢毫针，直刺，进针得气后行针2~3min，用泻法，以患者能忍受为度。每隔10min行针1次，留针30min。每天1次，10次为1个疗程，休息2~3天进行下1个疗程。

中药外敷：葛根100g，桂枝50g，白芍100g，穿山甲25g，威灵仙25g，天麻25g，木瓜25g。以上诸药煎汤浓缩，用纱布浸汁敷于患处。同时配合TDP照射，其热度以患者能忍受为度，每次30min，每天1次，10天为1个疗程。疗程间休息2~3天。

中医认为本病属证证范畴。多由外邪侵袭，阻滞经络，筋脉强急所致。宗以解肌祛邪，通经活络，舒筋缓急之法。针刺所选天柱、大杼、昆仑为足太阳膀胱经穴，邪病所客之处正为该经所过。天柱、大杼局部取穴可祛邪舒筋缓解拘挛，昆仑为该经五输穴之经穴，具有疏通经气、缓急之效。中渚、外关为手少阳三焦经的输穴和络穴。三焦经“上肩而交出足少阳之后”，亦为邪气所客之处。故针刺二穴通经活络，可收祛邪缓急之功。

选用葛根汤加减。其中葛根、桂枝、白芍祛邪解肌，生津缓急，

山龙、灵仙、天麻、木瓜相伍有通经络舒筋缓急之功。加之煎汤局部外敷透入给药更增其效。

裴某，女，42岁，工人。于1992年9月16日入院。主诉：3个月前无明显诱因出现头部不自主摇动，逐渐向右侧倾斜。曾于哈医大一院确诊为痉挛性斜颈，住院治疗效果不明显。出院后症状逐渐加重，每日以手扶头。稍事活动则心悸，气短，夜寐不安，生活难以自理。遂入院要求中医治疗。查体一般状态可，头向右侧倾斜，强迫体位，左侧胸锁乳突肌肥大，其他阳性体征未见。舌淡，苔薄白，脉弦。治疗：用上述方法治疗1个疗程后，头部无需手把持可轻微向患侧活动。2个疗程后自觉左侧颈部较前柔软。3个疗程完毕，左侧肥大胸锁乳突肌消失，颈部无倾斜，活动自如而出院。

四、独取太溪 气至有效

李峥采用针刺双侧太溪穴治疗外伤后痉挛性斜颈，疗效明显。

取穴：双侧太溪（内踝之后，跟骨之上的凹陷处）。

操作：常规消毒，用32号1寸不锈钢毫针，按天、地、人三部直刺进针，重而疾入直插至地部，提、插、捻、转，待出现“如鱼吞钩饵之沉浮”的得气征象后，立即出针。两侧同样。

外伤后痉挛性斜颈为颈部筋之挛缩，属伤筋范畴。肾通过髓可以与肝取得联系，而肝可以生筋，故取肾经原穴太溪，最终可以治疗伤筋。李峥按照《灵枢·本输》“太溪，内踝之后，跟骨之上，陷中者也”，刺之则可获得有如鱼吞钩饵之得气反应。本病属于骨伤科较难治疾病，仅取太溪一穴即能奏效正所谓“先得其道，稀而疏之”（《灵枢·官能》）。

患者李某，女，23岁，美容师，2004年7月9日13点来诊。患者3周前下楼时不慎摔倒，当时未感身体异常。3h后突感颈痛，头向左前下方倾斜时疼痛减轻。患者立即到某医院就诊，经X片诊断认为是寰枢椎半脱位，给予手法治疗后，颈托固定。之后，患者病情时好时坏，每于精神紧张时痉挛发作。今日来诊时，查其左侧胸锁乳突肌痉挛紧张。3周前在某医院所拍X光片显示，两侧寰齿侧间隙有差距，但差距小于2mm，属于正常解剖变异范围之内。故觉“寰枢椎半脱位”之诊断欠妥。应诊断为外伤后痉挛性斜颈。立即给

予针刺双侧太溪穴治疗，双侧均很快得气，出针后患者左侧胸锁乳突肌痉挛紧张消失，头旋转活动自由。翌日再针1次，痊愈。随访1个月无复发。

五、针刺治疗 祛邪缓急

儿童急性斜颈是一种颈椎间盘的早期疾患，其病因尚未明了，一般认为与风湿有关。主要表现为头部突然向一侧倾斜，逐渐加重，单侧肩颈部肌肉强直痉挛，颈椎活动受限。王志军近年来针灸治疗本病，疗效满意。

取穴：患侧风池、天柱、后溪、悬钟。

操作：令患者侧卧位，用30号1寸不锈钢毫针进针约0.3~0.5寸深，采用捻转手法。

斜颈多因肝肾阴虚，筋脉失其濡润，气血运行不畅，而使肌肉筋脉挛急所致。后溪为手太阳小肠经之输穴，八脉交会穴之一，通于督脉，经脉经肩颈上面颊，故主臂痛项强。风池、悬钟属足少阳胆经，对头项强痛均有显效。天柱为足太阳膀胱经穴。诸穴位相互配用以疏通经络，调和气血，而收祛邪缓急之功。

王某，男，7岁，学生，1993年3月19日就诊。家长代诉：1个星期前发现患儿出现斜颈，头向左侧倾斜，学习注意力分散，症状逐渐加重。经本院神经科确诊为，“儿童急性斜颈”，建议针灸治疗。检查：患儿精神尚好，发育良好，头向左侧倾斜约40°，不能左右转动头部，颈椎活动受限。经用上述疗法治疗1个疗程痊愈，至今未发。

六、针刺推拿 软坚散结

焦红波采用针刺推拿交替治疗小儿肌性斜颈，取得了显著疗效。

针刺：取哑门、风池、天柱、肩中俞、天宗、列缺、阳陵泉等穴，快速进针，平补平泻，不留针。

推拿：患儿取仰卧位，医者用分筋理筋法施术于患侧胸锁乳突肌挛缩处推拿6次，医者一手扶住患侧肩部，另一手扶住头顶，使患儿头部渐渐向健侧倾斜，逐渐拉长患侧的胸锁乳突肌；然后，医者用双手托住患儿头部轻轻向上牵引3次，按摩肩中俞、大杼、天

宗、阳陵泉等穴；最后用轻微的手法松解胸锁乳突肌。针刺与推拿交替治疗，即第一次针刺，第二次推拿，第三次针刺，以此类推，每天1次，7次为1个疗程。如果患儿斜颈未愈，休息7天后再继续治疗。

小儿肌性斜颈为临床少见病。多数学者认为分娩时胎儿头位不正，阻碍一侧胸锁乳突肌血液运行，引起该肌肉缺血性改变所致。解除患儿胸锁乳突肌的挛缩是治疗小儿肌性斜颈的关键，针刺哑门、风池、肩中、列缺、阳陵泉、悬钟能激发头颈部的经气，调和气血，祛瘀活血，疏通经络。推拿胸锁乳突肌挛缩处条索状包块及有关部位，使用一定的手法，舒筋活血、软坚散结。针刺推拿交替治疗小儿肌性斜颈，使颈部气血运行通畅，胸锁乳突肌挛缩解除，头颈歪斜纠正。

王某，男，6个月。1996年6月2日因头颈歪斜前来就诊。患儿自出生后发现头颈歪斜，2个月前曾在某某医院治疗未见效。患儿足月产钳助产，出生时体重3.6kg。检查：患儿发育中等，头向左侧歪斜不能向右侧转，左侧胸锁乳突肌条索状包块约3cm×2.5cm，局部不充血，无触痛。临床诊断为小儿肌性斜颈。给予针刺推拿治疗。针刺取哑门、风池、肩中俞、天宗、列缺、阴陵泉、悬钟针刺治疗，快速进针点刺，平补平泻，不留针。第二天来诊时，患儿头颈歪斜稍有减轻。给予推拿治疗。患者家长抱患儿，取仰卧位，医者用分筋理筋法推拿患儿胸锁乳突肌挛缩处6次。医者一手扶患儿右肩部，另一手扶患儿头顶，使患儿头部渐渐向右侧肩部倾斜，逐渐拉长患侧胸锁乳突肌。然后用双手托患儿下颌和枕部轻轻向上牵引3次。按肩中俞、大杼、天宗各3次。最后，再用松解手法轻轻按摩患侧胸锁乳突肌。经针刺治疗4次，推拿治疗3次，患儿头颈歪斜纠正，左侧胸锁乳突肌条索状包块全部消失。休息1周后，患儿头颈活动自如而痊愈。1年后随访未复发。

七、头穴体穴 电针治疗

王卫东应用电头皮针配体部腧穴电针疗法治疗痉挛性斜颈，疗效较好。

取穴：“头皮针”取运动区、舞蹈震颤区；平衡区、顶中线；顶

颞后斜线, 顶颞前斜线; 颞前线、颞后线。体部腧穴取大杼、风府、风池、阳陵泉、足三里、天鼎、扶突、合谷、天窗、天容、天牖、臂臑等穴。

操作: 头皮针用 1 寸不锈钢毫针与头皮呈 $15^{\circ} \sim 30^{\circ}$ 夹角, 将针快速刺入头皮下, 当针尖达帽状腱膜层时, 指下捻转进针约 25mm 留针; 左右侧交替, 每个刺激区域相接续刺 1 ~ 5 根针。每次取 8 ~ 10 个体部腧穴, 均为双侧配对使用; 针刺角度、方向、深度根据治疗部位具体灵活掌握; 针刺“得气”后强刺激后留针, 与头皮针同时接以 G6805 型电针治疗仪, 频率选用 300 ~ 500 次/min, 通电 30 ~ 60min, 均以强刺激, 以病人能耐受最大强度为限。12 次为 1 个疗程, 每疗程休息 3 ~ 7 天。

人头部为十四经循行交会、汇聚之处, 刺激头穴、头区可以通过调节气血、阴阳起到治疗作用。神经生理解剖学认为, 颅内外末梢循环之间存在大量吻合支, 可以相互补充; 头皮针是在头部的经穴或特定的刺激区域(经络循行其间, 如督脉对颈部疾病有特异性)内沿皮透刺; 电针是在针刺的基础上加以脉冲电, 选取头部反射区及体部有关腧穴强刺激, 采用透穴起到一经带多经, 一穴带多穴的正合作用, 从而调整机体内部的不平衡而达到治疗作用。

患者, 男, 欧洲白人, 42 岁, 翻译。头部不自主向右侧倾斜摆动及扭转 18 个月, 情绪激动时加重, 睡眠中消失, 经美国、德国医生检查为痉挛性斜颈, 服用多种药物治疗无效。于 1993 年 5 月 5 日来诊。

检查: 见病人头部不自主地向右侧方向频繁摆动呈 $45^{\circ} \sim 60^{\circ}$ 角(小动度摆动), 频率 40 ~ 50 次/min, 其间有时突然向右后上方极度强烈扭转 $90^{\circ} \sim 100^{\circ}$ 角(大动度扭转), 频率 16 ~ 22 次/min。大动度扭转和小动度摆动的频率, 合约 70 次/min。病人表情相当痛苦, 不能保持正常姿式与人交谈和写字。血压 140/100mmHg; 眼底动脉硬化 I 级; 双肱二头肌、双肱三头肌腱反射对称引出; 无感觉障碍; 左侧胸锁乳突肌呈梭状肥大; 肌张力高; 未见肌肉萎缩; 两侧斜方肌肌力相等。颈椎正、侧及双斜位 X 光摄片均未见明显增生; CT 检查正常。诊断: 痉挛性斜颈。

采用电头皮针配体部腧穴电针方法治疗 3 次后, 该患者感到胸

锁乳突肌、颈部肌肉痉挛明显缓解，肌张力有所降低，大动度扭转与小动度摆动的频率显著减少；治疗6次后，大动度扭转发作仅5~6次/min，小动度摆动16~22次/min；待到12次治疗后大动度扭转仅1~2次/min，小动度摆动也只有10~12次/min；病人可从事写作工作。经18次治疗后，大动度扭转0~1次/min，小动度摆动5~6次/min；24次治疗后，大动度扭转发作消失，小动度摆动仍有2~3次/min；经3个疗程36次治疗后，大动度扭转及小动度摆动全部消失。治疗期间病人没有晕针等不良反应，6~9个月后随访未复发。

八、阿是穴分刺 直捣病所

谢会平运用分刺法治疗小儿先天性斜颈，疗效明显。

取穴：阿是穴。

操作：患儿取仰卧位，术者位于患者头顶部，以胸锁乳突肌挛缩触之最明显处为阿是穴。常规消毒，取28号，1.5寸毫针，由乳突向锁骨侧用分刺法刺进阿是穴，留针5min，出针术毕。2天1次，4次为1个疗程。

先天性斜颈的病理是患侧胸锁乳突肌发现纤维性挛缩，起初可见纤维细胞增生和肌纤维变性，最终为结缔组织所代替。其病因尚未完全肯定，多数认为与分娩时患儿胸锁乳突肌受产道或产钳挤压损伤致出血，而血肿机化挛缩；或者分娩时胎儿头位不正，阻碍一侧胸锁乳突肌血运供给，引起该肌缺血改变所致。中医认为，本病属痉证范畴，系由小儿颈部经筋受损，风寒湿邪侵袭经络，致气血运行不畅，脉络受阻，筋脉失养所致。

《素问·调经论篇》“病在肉，调之分肉”。《灵枢·官针》“分刺者，刺分肉之间也”。因此，谢会平于血管神经丰富且解剖关系复杂的胸锁乳突肌上取阿是穴行分刺法，直达病变的肌肉组织而收效。

九、穴位注射 舒筋活血

查贵胜采用按摩及丹参液注射治疗肌性斜颈，收到好的效果。

丹参注射：将小儿仰卧于治疗床上，颈、肩垫一枕头，头偏向健侧，颈呈过伸位，充分显露血肿包块。助手固定头部避免头活动

及压迫气管造成窒息。常规消毒后。术者取丹参液 2ml，行胸锁乳突肌血肿内注射，每周 1 次，3~5 次为 1 个疗程，一般使用 2 个疗程。每次注射后观察 10~20min，无不良反应方能离去。

推拿：按摩松解法：抱住患儿或仰卧位，术者面对患儿，用拇指轻轻揉按血肿及肿块 3~5min，以活血散瘀、消肿止痛。用拇食指指腹捏拿胸锁乳突肌肌腹 3~5min，以松解胸锁乳突肌。用拇食指捏拿弹拨胸锁乳突肌 5~8min，以拉开粘连，松解挛缩。双手抱头扳正头颈并旋转活动，起防止偏斜和术后放松局部肌肉的作用。用拇食指按揉胸锁乳突肌胸骨头及锁骨头 5~8min，以松解挛缩。

以上操作时，医者均以滑石粉作介质，避免对患儿皮肤刺激过大，手法用力应轻柔缓和以患儿不哭为度。

丹参注射液具有活血散瘀、通脉养心的作用，可扩张血管，增加血流量，减少血液黏稠度，溶解纤维蛋白，调节毛细血管通透性，增加网状内皮系统的作用，此药治疗胸锁乳突肌血肿挛缩、畸形，可促使血肿消失，包块消退，从而达到矫正畸形的目的，按摩能舒筋活血，疏通局部血液供给，缓解肌肉痉挛，促使肿物消散。弹拨患侧胸锁乳突肌，能改善和恢复颈部活动功能，使两侧肌力平稳。

杨某，女，1 个月。（母亲代诉），患儿头向右侧偏 1 月余，活动不便，右侧摸及患儿哭闹，经外院诊所诊治未说明原因，于 1994 年 1 月来针灸科就诊。检查：右侧颈部扣及肿块，压痛，头向左侧转受限。诊断：肌性斜颈。经上述两种方法治疗 1 个疗程，效果明显，继续治疗 1 个疗程，患儿右侧肿块消失，活动自如，随访 2 年患儿头部活动正常。

陈某，男，2 岁。（母诉）患儿在出生 1 月发现左侧颈部皮肤糜烂，触及右侧颈部则哭闹，经当地医生诊治，告知此是腹中带来无法治疗，患儿逐渐长大，头偏也加剧，于 1995 年 2 月来针灸科就诊。检查：头偏向左侧，左侧颈部挛缩，胸锁乳突肌呈条索状发硬，压痛，颜面耳、眼比健侧小。诊断：肌性斜颈。经上述方法治疗 2 个疗程疗效显著。继续治疗 1 个疗程，颈部活动近正常，颜面基本恢复正常。

参考文献

- [1] 白金尚, 耿惠, 李延芳. 针刺治疗小儿先天性斜颈经验. 中国全科医学, 2000, 3 (1): 76
- [2] 王耀民, 何立, 李梅. 针刺按摩治疗小儿斜颈 35 例. 江苏中医药, 2002, 23 (9): 33
- [3] 吴永刚, 韩晶, 吴勃力. 针刺配合中药外敷治疗痉挛性斜颈 31 例疗效观察. 中国针灸, 1994, (2): 21 ~ 22
- [4] 李峥, 朱蜀云, 李翔. 针刺太溪穴治疗外伤后痉挛性斜颈 15 例中国中医药信息杂志, 2005, (2): 60
- [5] 王志军. 针刺治疗儿童急性斜颈 12 例. 中国针灸, 1995, (2): 18
- [6] 焦红波, 王德寿. 针刺推拿治疗小儿肌性斜颈 50 例疗效观察. 中医外治杂志, 2004, 13 (2): 20
- [7] 王卫东, 于敏华, 李守叶. 头皮针配体部腧穴电针治疗痉挛性斜颈. 吉林中医药, 1994, (6): 26
- [8] 谢会平, 文拔川. 分刺法治疗小儿先天性斜颈观察. 辽宁中医杂志, 2003, 30 (2): 144
- [9] 查贵胜, 王佳琼. 按摩手法合丹参液注射治疗肌性斜颈. 按摩与导引, 1999, 15 (1): 25

【肩关节周围炎】

肩关节周围炎简称肩周炎，是指肩部酸重疼痛及肩关节活动受限、强直的临床综合征。属于中医学的“肩痹”范畴。中医学根据其发病原因、临床表现和发病年龄等特点而有“漏肩风”、“肩凝症”、“冻结肩”、“五十肩”之称。女性发病率高于男性。

本病的发生与慢性劳损有关，患者可有外伤史。主要病理系慢性退行性改变，多继发于肱二头肌腱腱鞘炎、冈上肌腱炎或肩峰下滑囊炎。某些患者的发病与感染性病灶或内分泌功能有关。

中医认为，本病的病变部位在肩部的经脉和经筋。五旬之人，正气不足，营卫渐虚，若局部感受风寒，或劳累闪挫，或习惯偏侧而卧，筋脉受到长期压迫，遂致气血阻滞而成肩痹。肩痛日久，局部气血运行不畅，气血瘀滞，以致患处肿胀粘连，最终关节僵直，肩臂不能举动。

本篇收录了20位针灸医家的临床治验。有的采用透刺、巨刺法治疗；有的采用多针透刺；有的采用独取阳陵泉，互动式针刺；有的采用左右配穴，埋针法、电针法治疗；有的采用循经远取，针罐并用；有的采用傍针刺法；有的采用耳针治疗；有的采用分步针刺，透穴丛刺

并用等。

针灸治疗肩周炎有较好的疗效。但必须明确诊断,排除肩关节结核、肿瘤、骨折、脱臼等其他疾病,并与颈椎病、内脏病等引起的牵涉痛相区别。把握针灸治疗时机,病程越短效果越好。对组织产生粘连、肌肉萎缩者,应结合推拿治疗,以提高疗效。自主锻炼和被动锻炼是配合针灸治疗、早日恢复肩关节功能不可缺少的环节。必须强调适当进行肩部功能练习,每日做2~3次爬墙活动。

一、透刺-巨刺 通则不痛

朱俊珂近年来,采用长短针配合加刺络拔罐治疗肩周炎,每获良效。

取穴:肩髃、肩髃、肩贞、肩内陵、肩外陵、臂臑、曲池、合谷、条口、承山。

操作:让患者取端坐体位,暴露小腿用巨刺,左肩关节疼痛取右侧穴,右肩关节疼痛取左侧穴。皮肤常规消毒后,用29号,3寸毫针从条口向承山方向透刺,进针约2.5寸,捻转提插强刺激,患者感觉腓肠肌或整个小腿均有酸麻胀感与此同时嘱患者活动患侧肩关节,尽量寻找疼痛体位并故意造成疼痛。留针5~10min后起针。然后让患者取侧卧位,患侧朝上,垂肩曲肘,用同号针自肩髃穴进针向下经过肌层刺到臂臑穴,提插捻转用泻法,以肩关节有较强的酸麻胀感为度,得气后出针,再用同号针取肩贞穴向肩内陵穴透刺,使患肢局部有较强的酸麻胀感并向前和手指放散。进针时针尖稍向外斜,以免误入胸腔,引起气胸,得气后出针。再用30号,1.5寸毫针常规消毒后直刺肩髃、肩髃、肩外陵、臂臑、曲池、合谷,弱刺激,留针20~30min。起针后寻找最疼痛部位用三棱针点刺3~5下,加大号玻璃罐拔之,出血量5~10ml。针刺每天1次,10次为1个疗程。刺络拔罐每周2次,疗程间休息3~5天。

用长针透刺,一针达二穴,强刺激,能疏通经络,再用短针弱刺激。调和气血,强弱刺激配合,共同起到改善局部血液循环,加速炎性渗出物吸收,降低神经兴奋性,从而达到消炎止痛、促进功能恢复的目的。条口透承山为治疗肩周炎之经验穴,能散寒通经舒筋。肩髃、臂臑为手阳明大肠经穴,二穴相透,能疏通经络,止痛

荣筋。肩髃为治疗肩关节局部疾病的主穴。肩贞是小肠经穴，因本经脉循行上臂外侧后缘，出于肩关节，绕行肩胛部，故为治疗本病的要穴。肩内陵、肩外陵为经外奇穴，肩贞透肩内陵，主治肩臂痛，臂不能举。曲池为手阳明经合穴、合谷为手阳明经原穴，原合相配能激发人体真元之气，抵抗病邪侵袭，共奏扶正祛邪之效。疼痛点刺络拔罐意在祛除瘀阻，畅通经脉，使其通则不痛。

吴某某，女，64岁，2002年9月就诊。主诉有受凉史，夜间疼痛加重，并严重影响睡眠，左肩发凉，手不能负重，穿脱衣服、洗脸、梳头困难。曾服中西药物及外贴膏药未见好转。查：左上肢外展、上举、内旋、外旋均受限、左肩峰周围有明显压痛点；舌质黯、脉弦。诊断为肩周炎。用上述方法治疗1个疗程后，肩臂疼痛明显减轻，夜能眠、穿脱衣服、洗脸能完成，但较吃力。又继续治疗1个疗程后，疼痛完全消失，肩关节功能恢复正常，随访2个月未复发。

二、肩髃 - 肩前 - 肩后 多针透刺

刘卫仁采用一穴多针治疗肩周炎，疗效显著。

取穴：肩髃、肩前和肩后。

操作：皮肤常规消毒后，选用28号3寸不锈钢毫针。肩髃穴向臂臑穴方向直刺2.5~2.8寸（针身应贴近肱骨骨面向下透刺）为第一针，行提插捻转泻法，针感向前臂和手指放射，再向前斜刺为第二针，针尖达到肩内陵；针尖斜刺向后穿过肩髃穴为第三针，两针均行提插捻转泻法，使整个肩部出现较强的酸麻重胀感。肩前穴向肩后穴方向直刺1.5寸为第一针，沿着肱骨向上斜刺1.5寸，针尖达到肱骨结节前下缘为第二针，向下斜刺1.5寸为第三针，3针均行提插捻转泻法。肩后穴向肩前穴直刺1.5寸为第一针，沿着肱骨后面向上斜刺1.5寸为第二针，针尖达到肩胛冈下缘；沿着肱骨向下斜刺1.5寸为第三针，3针均行提插捻转泻法。3穴9针操作完毕，留针观察15min，患者如无不良反应，可按上述方面再运针1次后出针，然后在痛点部位加拔火罐，留罐10min，每天1次，10次为1个疗程。

根据肩周炎病变范围广，病程缓慢缠绵的病理特点采用肩髃向

下、向前、向后3针透刺，肩前、肩后对刺和各向上、向下3针透刺形成网状针刺，所有病灶都能贯通，较大限度地改善了病变部位的血液循环状况，有利于局部新陈代谢和致痛物质的清除，促进炎性物质的吸收，加快关节功能恢复，从而使肩部气血调和，经脉通利，通则不痛。

吴某，女，47岁，职员，于2004年5月11日初诊，自述右肩疼痛，活动受限，反复发作2年余，近二月来因打乒乓球症状加剧，夜不能寝，服中西药及做理疗效果不显。检查：右肩活动明显受限，外展、前屈上举、内旋、后伸均受阻，且疼痛难忍，肩关节周围软组织压痛明显，三角肌轻度萎缩，在肩内陵、肩后穴周围能触到条索状阳性反应物。经一穴多针透刺治疗4次，疼痛明显减轻，能安稳入睡，前屈、外展、后伸明显改善。经治疗15次后痊愈，嘱其自行肩部功能锻炼，随访1年余无复发。

三、独取阳陵泉 互动式针刺

廖辉近年来采用互动式针刺法治疗肩周炎，取得肯定疗效。

取穴：阳陵泉。

操作：病人取直立位，全身放松，用直径29号，2寸毫针在患侧阳陵泉进针，得气后采用提插泻法，针刺同时令患者活动患肩，作外展、上举、内收、前屈、后伸等动作。患者在活动过程中，肩部疼痛可能会加重，但随着医者继续行针，所施手法由弱渐强，患者的痛阈可不断提高，从而疼痛会逐渐减轻，活动范围及力量也会逐渐加大。行针5~7min后，留针10min（此时患者停止活动，缓解疲劳，可由站位改为坐位，防止晕针），然后再施以手法5~7min（方法同前），再留针10min，约30~35min后起针。1次/天，每周5次，1周为1个疗程。

阳陵泉为足少阳胆经之穴。少阳主枢，乃诸筋之会穴，故针刺阳陵泉，意在舒缓筋脉，解除痉挛，缓解疼痛，舒展关节，加之同时活动患侧肩臂能够帮助其松解粘连，两者配合，可达到舒缓筋脉，缓急止痛，舒展关节，缩短疗程，提高疗效的目的。

唐某，男，53岁，工人。2002年3月13日初诊。主诉：右肩臂疼痛1年，伴活动不便9个月，加重2周。1年前无明显诱因出现

右肩臂疼痛，活动时加重。因症状时轻时重，故未予重视。9个月来，症状明显加重，右肩臂疼痛，不能侧卧，夜间常因疼痛致醒，同时伴见右肩臂活动受限，不能梳头、穿衣。曾在外院就诊，确诊为肩周炎，予消炎痛、芬必得等药物治疗。服药时症状减轻，但停药后症状依旧，因上述药物对胃肠道刺激明显，故近两月在本院门诊改以中药及针灸治疗（药物及穴位不详）。右肩臂疼痛及活动受限有所改善。因春节劳累及天气变化，右肩臂再次出现剧烈疼痛，难以忍受，遂来本科就诊。首诊：右肩臂疼痛，入夜疼痛更甚，活动受限。肩臂外观无异常，肩关节周围压痛明显，肩关节运动受限，仅能外展 50° ，内旋 60° ，上举 80° ，外旋 30° 。诊断：右肩周炎，采用互动式针刺法治疗。经6次治疗后，患者肩关节疼痛消失，关节活动恢复正常，右臂能外展 90° ，内旋 90° ，上举 180° ，外旋 80° ，巩固治疗3次。随访半年未复发。

四、肩髃穴 三透法

肩周炎是肩部关节囊和周围软组织的一种退行性炎症。张学武近年来应用“三透法”治疗该病，疗效满意。

取穴：肩髃。

操作：三透法：①直刺：臂外展，沿肩峰与肱骨大结节之间对准极泉，深刺1.5~2寸，酸胀感扩散至整个关节腔。②斜刺：向肩前穴方向透刺，进针2~3寸，酸胀感扩散至肩关节周围，或有麻电感觉往臂部放散。③横刺：上肢外展牵制时，可向三角肌方向透刺，深2~3寸，臂部酸胀。留针30min，中间隔5min透刺1次。对晚期患者，在取针后再配合手法松解，每个压痛点手法松解约2min，每次选用3~5个压痛点。以捏、揉、拿、点、拨手法交替使用，由轻到重，逐渐加力，使压痛点达到酸、胀、热感。上述治疗，每天1次，10次为1个疗程。

“三透法”属于多向透穴法，具有取穴少、刺激强、感应大、病人痛苦小等特点。对早期肩周炎，疏通气血、舒筋活络有较好疗效；晚期肩部粘连形成，运动受限，配合手法松解，“摩其壅聚，以散瘀之肿”，从而达到疏通经络，宣畅气血之目的。此法是张学武数年临床实践摸索出来的，对疼痛剧烈、活动受限、肌肉萎缩者通过5~6

次治疗，症状可明显好转。

刘某，男，52岁，教师，1995年4月17日诊。主诉2个月前因受凉右肩疼痛不能上举，外展困难，经服药治疗无效。查：右肩关节有明显压痛，上肢抬到与肩平，不能摸到对肩，外展 60° 。诊为肩周炎（晚期）。按上法治疗。1个疗程后，疼痛明显减轻，患者上举达 120° ，外展达 65° ，后伸 20° 。2个疗程后，疼痛消失，活动功能自如，完全治愈。

五、巨刺 配运动疗法

王凤采用巨刺的方法，治疗肩关节周围炎，疗效满意。

操作：左右交叉取穴伴运动疗法，选择与患部相对应的腧穴。如左肩疼痛，取右肩的相对应腧穴，肩前痛可取肩髃、肩前穴。固定穴位后，先用轻刺激手法，垂直刺入0.6~1.0寸深，待病人感到产生酸重感后，再用重刺激手法。并令患者运动患部关节，幅度由小变大，每次留针30min，10次为1个疗程。

巨刺法始见于《灵枢·官针篇》“巨刺者左取右，右取左。”是一种交叉取穴施治的方法。《素问·调经论》：“病在中，而右脉病者，巨刺之。”左取右，右取左，交叉取穴针刺，优于患侧局部用针，可以提高患痛阈，减少患肩局部刺激。在针刺过程中，让病人主动做前后、内外活动患肢非常重要，随着疼痛的减轻，活动范围可逐渐增大，大大超过治疗前的活动范围。

王某，女，52岁。发病2月余，右肩关节疼痛，夜间痛甚，恶寒冷，无扭伤史，有受寒史，曾服药及理疗等无效。1周来疼痛加重，右上肢不能活动，夜间时常痛醒，故前来求治。检查：病人痛苦面容，右肩关节前屈上举 90° ，外展 60° ，后伸小于 10° ，旋前旋后均受限，触诊整个肩部发凉，肩关节周围均有明显压痛。X线报告：右肩关节无异常。舌淡苔白，脉弦。选取左侧肩髃、肩前、肩后。针刺时使活动右肩关节、幅度由小变大，经治疗1次后患者疼痛大减，共治疗5次，痊愈停止治疗。

六、左右配穴 埋针电针

肩周炎是关节囊和关节周围软组织的一种退行性、炎症性疾病，

以肩臂疼痛，活动受限为主要表现，常发生于中年以后，且以女性略多。符少杨采用埋针、电针治疗本病，取得较满意的疗效。

埋针：取患侧痛点为主，无痛点取肩髃、肩井、风池、肩贞、臂臑，每次取三穴，肌肉萎缩者配合同侧手三里、足三里，用颗粒型皮内针，常规消毒后埋置，外用医用小方形（1.0cm×1.0cm）胶布固定，3天后交换穴位。

电针：取健侧肩三针（肩及其前后各旁开1寸）、曲池、外关为主，颈部放射者加肩井、风池；肌肉萎缩者加手三里、足三里，取1~2寸针灸针，常规消毒后针刺得气，然后用G6805-1治疗仪通断续波20min，出针。每天1次，7天为1个疗程，疗程间隔3~5天。

符少杨根据对症选穴，左右配穴法为原则，予患侧埋针，健侧电针治疗。埋针法是我国古代“浮刺”、“毛刺”针法发展而来，《灵枢·官针》：“浮刺者，傍入而浮之，以治肌急而寒者也”，皮内埋针可以疏通经络，调和气血，促进机体恢复正常，从而达到防治疾病的目的。肩关节周围为阳明经之所过，所以健侧取手阳明经穴肩髃、曲池为主以疏导阳明，祛风解表，通络止痛，取肩三针以加强局部活血化瘀止痛之力，外关为手少阳三焦之经穴，取之可散风解表，与曲池配合可以疏导阳明、少阳经气，清化湿热以加强疗效。颈部放射痛者加肩井、风池，加强祛风通络，调和气血；肌肉萎缩者加手、足阳明经之强壮穴手三里、足三里，可以补益气血。由于经络分布是对称的，且具有循行交叉的特点，左右同用，可以加强其协调作用，从而达到疏通经脉，调和气血，活血化瘀。

陈某某，女，45岁，1999年7月6日就诊。患者左侧肩关节疼痛1个月，活动受限，夜间尤甚。无外伤史。曾服药、封闭、电兴奋等治疗，疗效不明显。体查：右肩外观无异常，活动明显受限，上臂前举60°，后伸30°，外展50°，肩峰下滑囊、肱二头肌腱长头附着点有明显压痛，舌质黯红，苔微黄腻，脉滑弦。X片示：肩关节未见异常。诊断：肩周炎。采用上述治疗方法治疗1个疗程后，疼痛明显减轻，活动明显改善，再治疗1个疗程后完全康复，肩关节活动自如，无疼痛，随访1年未复发。

七、循经远取 针罐并用

肩周炎好发于 50 岁左右的中老年人，也称五十肩，为临床常见病，多发病，高崇群采用循经远道取穴的针刺疗法，并配合拔火罐治疗本病取得满意疗效。

取穴：根据肩部疼痛的部位及痛点的分布，循经取穴，即痛点在臂内侧上段、肩腋前沿的取太渊；在肩峰及臂前廉的取合谷；左肩肘臂外侧及肩胛疼痛的取中渚；在肩胛上段前沿肩胛骨中央或肩胛部外下缘等处取后溪；对多个痛点的患者针刺取穴亦相应采用多个穴位。并可循经选 1~2 个穴位为配穴。

操作：常规消毒后，采用 28 号 1 寸不锈钢针快速刺入所取穴位，以明显得气感为宜，疼痛重者用泻法，较轻者平补平泻，每隔 5~10min 行针 1 次，留针 30min，每天 1 次，10 次为 1 个疗程。起针后再在肩关节周围拔火罐，拔罐部位主要以痛点为主，根据个体胖瘦差异及部位选择合适的罐型，用闪火法，留罐 15~20min，隔日 1 次，也可在痛点与痛点周围每日交替进行。同时嘱患者回去进行功能锻炼。

中医学认为其病机不外乎瘀血内阻，筋失濡养及寒凝气滞使局部经络气血运行不畅所致，高崇群在临床中体会到，仅针刺肩关节局部，虽亦能局部舒筋活络，但却不能令邪有出处，结果疗效差、疗程长，增加了患者的痛苦，而根据经脉所通，主治所及的经络原理采用循经远道取穴，不仅能舒筋活络，还能引邪外出，促进了局部炎症的吸收，再配合局部拔火罐，以温经散寒，活血化瘀，二法共用，收到满意疗效。

毕某某，女，51 岁，教师，1998 年 3 月 10 日就诊，主诉：右肩部疼痛，活动受限已月余，近日因教学任务繁重而明显加重，抬臂，持物均感困难。查：右肩关节压痛明显，痛点主要以肩腋前沿和肩峰端明显，肩关节活动受限，后伸 25°，外展 60°，内旋后伸右拇指仅抵于第一腰椎棘突点处。诊断为右肩周炎。治疗取穴以太渊、合谷为主穴，天府、尺泽、臂臑、曲池为配穴，前 3 天用泻法，后 7 天平补平泻，并在上述痛点处拔火罐，隔日 1 次。1 个疗程后，上述症状消失，肩关节活动恢复正常。

八、肩内陵为主 傍针刺

史永奋用经外奇穴肩内陵穴运用《黄帝内经》傍针刺法为主治疗以肩关节后伸内旋功能障碍为主的肩周炎患者,取得较好的疗效。

取穴:主穴肩内陵。配穴肩髃、肩髃、肩内陵、臂臑、曲池。

操作:选用32号1.5寸毫针,穴位皮肤常规消毒后,快速进针,肩内陵穴用傍针刺法,即在肩内陵穴上方一寸处斜刺,针尖朝向肩内陵穴。其他穴位常规针刺,各穴得气后用提插捻转泻法,然后接KWD-808Ⅱ型电针治疗仪,连续波,频率3Hz,强度以病人能忍受为度,时间20min,起针后拔罐10min。隔日1次,10次为1个疗程,休息7天后进行第2疗程。同时嘱患者每日做肩关节功能锻炼。

针灸对本病的治疗效果是较满意的,不同的医师采用了各种方法均取得了很好的疗效。但史永奋在临床上观察到有一部分患者主要是肩关节内侧病变,如肩胛下肌、肱二头肌、大圆肌等肌腱损伤,导致肩关节前内侧疼痛,持续时间较长,肩关节后伸内旋功能障碍较严重,用常规方法治疗,虽然上举外展功能可改善,但肩前疼痛、后伸内旋受限等症状改善不明显,并且肩关节前部穴位较少,只有经外奇穴肩内陵(肩前)穴一个。故考虑运用《灵枢》中“十二刺”之一“傍针刺”方法来加强肩内陵穴的治疗效果。傍针刺肩内陵穴可以明显增加病人肩关节活动度,特别是后伸内旋功能,松解肩关节粘连,缓解患肩的疼痛和拘挛,临床上收到很好的效果。

刘某,女,48岁,右肩关节酸痛2个月,疼痛日轻夜重,夜间痛醒,右肩活动障碍,上举120°,外展70°,后伸20°,后伸内旋时右手拇指与左肩胛角的距离为25cm。针刺取穴:肩髃、肩髃、肩内陵(傍针刺)、臂臑、曲池。用32号1.5寸毫针进针得气后接电针治疗仪,20min后起针,拔罐10min,嘱每日作爬墙、推磨、后拍等功能锻炼。隔日治疗1次,10次后,患者诉肩关节疼痛减轻,活动改善,休息7天后作第二疗程,结束后,肩关节疼痛明显减轻,肩关节功能明显改善,已能上举,外展85°,后伸40°,后伸内旋时右手拇指与左肩胛角的距离为5cm,嘱继续功能锻炼。

九、主配穴并用 针刺耳压

吴军采用针刺加耳穴疗法治肩周炎，效果显著。

取穴：①体穴：主穴取条口透承山，配穴取肩臂痛点配合谷、肩髃、肩髃、肩贞、肩俞或列缺穴。②耳穴：主穴肩（双）、神门（双）、耳背肩部（双），配穴：肾、肝、脾、肾上腺、内分泌。

操作：①用2寸毫针由条口穴向承山穴透刺并强刺激，边捻边嘱患者活动患肢，后依据症状加配穴。得气后留针30min可配合TDP每天1次，10日为1个疗程。②体针取出后用棉球（75%酒精浸泡过）常规消毒耳穴处，用王不留行籽贴肩（双）、神门（双）、耳背部肩部（双），依次配肾、肝、脾、肾上腺、内分泌穴，每2天1次，10次为1个疗程。

条口透承山为治疗肩凝症之经验穴，可理气活血、舒筋活络、缓解肩周炎之肌肉疼痛和痉挛，配穴可以通络活血，通利关节，耳穴属全息穴范畴，《内经》中载“耳者宗脉之所聚也”。《卫生宝鉴》载有“五脏六腑、十二经脉有络于耳者”，故耳穴疗法可温通经络，理气活血，散瘀止痛，两者结合达到治疗目的。

刘某，女，45岁，干部。1999年11月3日就诊，主诉：左肩关节疼痛8个月余，当劳累或受凉后症状加重，夜间凌晨尤甚，影响睡眠，穿衣、梳头、写字均受限，检查示肩关节活动范围减少20°、15°、55°、25°，后伸、外展、内旋活动受限，肩关节周围压痛明显。血沉和X线片检查均无异常现象，诊断为肩周炎，给予体针、耳穴治疗6次，症状消失，运动功能恢复正常，随访2年未见复发。

十、随症选穴 针刺穴注

于金栋在临床中，运用针刺结合穴位注射治疗肩周炎，疗效显著。

取穴：以肩髃、肩髃、肩内陵、肩贞、阿是穴为主穴。上肩痛配臂臑、曲池；肩胛痛配肩井、天宗；肩部活动障碍、肌肉萎缩配条口透承山。

操作：采用30号不锈钢毫针，采用平补平泻法，留针30min，每日针刺1次。起针后行穴位注射，选取阿是穴及治疗本病之主穴

肩髃，对穴位进行常规消毒，用5ml一次性注射器抽取1%利多卡因2ml、复方当归注射液2ml、维生素B₁₂500μg（1ml），混合后，将针直刺入阿是穴、肩髃穴，得气后，回抽无血，各穴缓慢注入2.5ml。隔日治疗1次，10次为1个疗程。

本病多导致周围组织痉挛和粘连，引起疼痛和功能障碍，故本病早期以肩痛为主，后期以功能障碍为主，治疗时根据不同阶段，解决痛的问题和松解其粘连，使经络气血通畅，“通则不痛”。

于金栋在针刺的基础上配合穴位注射。针刺能激发经气，调理气血，疏通经络，达到镇痛和松解其粘连的目的。利多卡因可以阻断神经，加强其镇痛的效果。复方丹参注射液可以舒经活血祛瘀。维生素B₁₂注射液可以营养局部神经肌肉。诸药合用，可以改善局部组织新陈代谢，迅速减轻疼痛和松解局部粘连。

张某，男，54岁。1997年5月6日初诊。右肩关节疼痛年余，时轻时重。近日余因感寒，其痛势加剧，影响睡眠。现右肩周围软组织有明显压痛，关节活动受限，舌质黯红，舌苔白，脉弦紧。用针刺结合穴位注射治疗5次，右肩痛大减，嘱病人适当加强功能锻炼，1个疗程后好转，2个疗程痊愈。随访未复发。

十一、阳明经穴 顺序针刺

王丽运用不同次序针刺治疗肩周炎，取得了一定的疗效。

取穴：肩髃、曲池、合谷、阳陵泉、条口、承山、配以阿是穴等。

操作：首先取患侧下肢条口穴，将皮肤常规消毒后，用30号，3寸毫针刺入，并向承山穴方向透刺，用泻法捻转提插至得气，再刺患侧的阳陵泉，用平补平泻法，最后依次（顺手阳明经）针刺患者患侧合谷、曲池、肩髃，配以阿是穴，一般用平补平泻法，在针刺下肢穴得气后嘱患者活动患侧上肢1min。以上均留针20~30min，留针期间行针2~3次，每天1次，5次为1个疗程。

条口为足阳明胃经穴，为治疗肩周炎之经验穴，手足阳明经之气上下相接。手阳明经气流注入足阳明。《灵枢·经络》篇曰：病在上者取之下”，故先取条口，清泄阳明经气，以祛邪通络，承山为足太阳膀胱经穴，能散寒舒筋止痉。条口透承山，一针达二穴，手阳

明经从手走头，合谷是手阳明大肠经原穴，曲池为手阳明经合穴，先刺原穴，再刺合穴，为激发人体真原之气，使脏腑经气具百川汇合入海之势，以振奋人体正气，抵抗病邪的侵袭。王丽以为，此方法强调针刺次序，先刺条口透承山打通经气，然后刺合谷、曲池、肩髃为循经气流注方向施治，是为扶正以祛邪之法。诸穴合用，上病下治，上补下泻，共达疏筋散寒，通络止痛之功。

十二、透穴丛刺 分步施治

陈能哲在临床上根据其发病表现和病理特点，从针具选用、针刺取穴及手法上进行研究，取穴采取局部和远端相结合，针刺手法采用动刺和留针、局部丛刺和透刺相结合，分步治疗，取得理想疗效。

操作：分3步针刺。①远端透穴：用3~4.5寸28号毫针，取条口透承山、阳陵泉透阴陵泉，同时刺入，双手强刺激2~3min，行针期间患肩做前屈、上举、后伸等动作10min。②局部透刺：用4.5寸28号毫针，侧身使肩关节呈外展位操作，分别取肩髃透极泉，肩髃透臂臑，肩贞透臑俞（取穴不拘泥于原穴定位，可在穴周寻找压痛点、条索状结节等阳性点作为进针点，效果更佳）依次施术，得气后行雀啄法2~3min，行针同时医者小幅度被动活动肩关节，以患者能耐受为度，不留针。③局部丛刺：三角肌肌腹中点刺入一针，沿三角肌呈倒三角形分散刺入数针，针数7~9针为宜，以1.5寸30号毫针刺入0.5~1寸，不行针，留针20min。

陈能哲在临床上针对肩周炎发病特点，采用长短针配合，局部和远端取穴相结合，针刺手法采用动刺和留针相结合，局部围刺和透穴相结合的方法。透刺结合动刺有类似小针刀的疗效，当患者做相应动作时，针体与肌腱或肌肉或其他粘连组织之间产生了一种相向运动，这种运动有可能将粘连剥离。丛刺多用于病在肌肉、肌腱者，尤其适用于病程长，有肌肉、肌腱临床萎缩的患者。以长针透刺，动刺为“通”，旨在松解粘连，舒筋止痛；局部丛刺为“养”，旨在濡养筋脉，活血止痛。多种针法并用，各取其效，“通”、“养”兼施，取得了较好的效果。

十三、局部取穴 温针灸

陈兴华采用温针灸治疗肩周炎，获理想疗效。

取穴：主穴：肩髃、肩内陵（肩前）、肩贞、阿是穴。配穴：上肩痛，配臂臑、曲池；肩胛痛，配肩井、天宗；肩部活动障碍，肌肉萎缩，配条口透承山、手三里等。每次选用4~6个穴位，每天1次。

操作：采用1.5寸不锈钢制毫针，针刺得气后，将一段长约2cm左右的清艾条插在针柄上点燃施灸，烧完后去掉灰烬，再加上一段同样长的清艾条施灸，待艾条烧完后再除去灰烬，将针取出。

肩关节周围炎在中医学中称为“漏肩风”或“肩凝症”。多由年长气虚，营卫不固，或汗出当风，致风寒湿邪闭阻经络，气血运行不畅，外邪凝滞肩部筋脉所致。根据发病机制，本法采用局部三阳经穴位为主，加以温针灸治，能收助阳散寒，温通经络，运行气血之效，使“通则不痛”达到治疗目的。

曾某某，男，53岁，中学教师，于1990年7月15日就诊。自诉右肩臂疼痛1年余，肩关节各方向活动均困难，并逐渐加重，时有颈部和手臂拉痛，影响教学工作，曾经在外院口服中药及多种止痛药，做过肩部穴位封闭治疗均无效。经人介绍前来就诊。症见右肩臂及上臂疼痛难忍，抬举手臂困难。检查见右肩胛部广泛压痛，肩关节各向活动均受限，尤以外展、外旋、后伸为甚。舌质淡暗，苔薄，脉弦细。施以温针灸法，在温针治疗过程中，病人即觉疼痛明显减轻、肩关节活动功能改善，信心大增。坚持2个疗程的温针灸治，病人自觉右肩疼痛消失，肩关节活动基本恢复正常，临床治愈。追踪2年，未见复发。

十四、运动针法 配刺络拔罐

程永采用运动针法配合刺络拔罐法治疗肩周炎，取得较好疗效。

运动针刺：采用一次性无菌1.5~2寸毫针若干，按顺序选取局部阿是穴即经筋结聚部位（肱骨结节间沟、肱骨大小结节、喙突、肩峰下、冈上肌起止点、冈下肌起止点、大小圆肌起止点、肩胛下肌止点等压痛点）为进针点，针至病变部位时，沿同一方向捻针至

最大阻力，或进针后先行强刺激，令患者活动（主动或被动运动）肩关节至最痛的姿势，在最痛的时间行雀啄泻法，再令患者沿肩关节各个方向运动，特别是最痛的方向应多运动，患者感到活动自如时（一般5min左右）出针。若压痛点局限，粘连较明显，则采用多针齐刺法，刺准痛点后，先行肩关节被动运动，后行主动运动，以增强疏经通络和分解粘连的作用。以上各点不必尽取，一般4~6点为宜。隔天1次，7次为1个疗程。

刺络拔罐：选取局部阿是穴消毒后，用梅花针或三棱针刺络拔罐放血，出血量每穴约3~5ml为宜。每次2~3穴，隔天1次，7次为1个疗程。

程永以经筋理论为指导，认为肩周炎的病机实质是“经筋病变”，当经筋结聚部位（即肌肉起止和交汇点）因外伤后遗、积累劳损、气血不足而复感外邪，影响经筋“主束骨而利机关”的功能，即可导致肩关节动态平衡失调而发为本病。运动针法采用毫针单针或多针针刺病变经筋结聚点结合主动和被动运动肩关节，不但加强了疏经通络作用，大大提高痛阈迅速改善局部微循环，而且在运动中利用毫针的弹性剥离作用分解粘连不甚的肩关节，从而达到消除炎性水肿、松解筋结病灶的作用。刺络拔罐法具有祛瘀生新、迅速降低筋膜张力的效果，从而达到止痛的目的。

十五、主穴三个 热补针法

郑魁山在临床采用热补针法治疗肩周炎，取得较好疗效。

取穴：主穴：取患侧肩髃、肩髃、天宗。配穴：若肩肱连动，肩缝处有压痛，后伸困难，取肩缝、尺泽、阴陵泉；肩髃处有压痛，上举困难，取肩髃透极泉、曲池、巨骨、条口透承山；天宗处有压痛，内收困难，取肩贞、后溪、申脉；肩髃处有压痛，外展困难，取臑俞、外关、阳陵泉透阴陵泉。

操作：用热补针法：术者左手拇指或食指紧按穴位，右手将毫针刺入至5分深左右，候其气至，接着左手加重压力，右手捻转5s，候针下沉紧，针尖拉着有感应时，连续重插轻提10s，右手再连续捻转45s，针尖顶着产生感应的部位守气，使针下持续沉紧，然后出针。或再加灸10~20min。针刺配穴，须上肢的针起完后再针刺下

肢，针刺下肢穴位时，边操作边嘱患者做上肢上举、外展、内收等运动，以锻炼肩部，提高疗效。每天1次，10天为1个疗程。

热补针法是郑氏对复式补法烧山火的简化。临床运用时先由左手摸准穴位，随即右手押手关闭，使针感向病所传导，关闭的方向有如《针灸大成》所指出：“凡针下得气，如要使之上，则须关其下；要下，须关其上”。务使针下继续沉紧，产生热感。此外，还宜再次双手传导，即在产生针感的同时，左手加重压力，将针感向病所顶按，针刺手臂穴位时配合将针尖向病所推纳，令感传顺畅。郑老几十年的临床实践证明，热补针法治疗肩周炎具有独特的疗效。

张某某，女，50岁。2005年3月2日初诊。患者2个月前因劳累，又因天气寒冷，致右肩臂疼痛，活动困难，逐渐加剧，以至夜难入睡，经常痛醒，不能提腰带，否则就引起右肩臂剧痛。今检查：右臂上举不能摸及右耳，肩肱连动，外展不能平肩，内收能摸及胸部，后伸不能摸及髂骨，不能叉腰，肩关节周围有压痛，以右肩髃、臂臑穴处压痛最明显。舌质红、苔薄白，脉弦紧。辨证系风寒侵袭，经络瘀阻，损伤经筋，瘀血停留。采用祛风散寒，活血通络舒筋之法治之。取肩髃、臂臑、肩髃、天宗、曲池，用热补针法，起针后用同样手法针右条口透承山，留针20min，在留针期间边操作边让患者活动患臂。每天治疗1次，并嘱患者平时多活动患臂。治疗2次后，右肩臂疼痛减轻，活动范围扩大。至3月12日，针刺达10次时，疼痛基本消失，右臂上举能摸及左耳，外展能平肩，内收能摸及左肩，后伸摸脊能摸及第二腰椎。至3月22日，针刺达20次时，右肩臂疼痛完全消失，活动恢复正常，后伸摸脊能摸及第九胸椎。治愈停针。随访10个月未复发。

十六、循经三步针法 通络止痛

姚军采用传统经络诊察法进行客观地辨经、查经，运用循经三步针法治疗肩周炎患者，效果满意。

操作：分3步进行。

第一步，选病变经络远端腕关节以下五输穴点刺，不留针。手太阳经病变取鱼际、太渊；手阳明经病变取三间、阳溪；手太阳经病变取腕骨、后溪；手少阳经病变取液门、中渚。

以1寸毫针快速刺入所选穴位，进行小幅度提插捻转，针感以患者能耐受为度，同时嘱患者活动患肩，约活动2~3min，肩关节疼痛缓解或暂时消失后即拔针，让病人稍事休息。如为多经病变则增加相应穴位。

第二步，选病变经络病理反应点针刺，选病变经络上2个最明显的病理反应点（腕关节以上、肘关节以下）针刺，采用1.5寸毫针直刺，通电15min。如为多经病变则增加相应穴位。

第三步，病变经络循行肩关节局部穴位刺络放血拔罐，留罐10min。手太阴经病变取肩内陵、中府，手阳明经病变取肩髃、臂臑，手太阳经病变取肩贞、臑俞、天宗，手少阳经病变取肩髃、臑会。

以三棱针快速散刺所选穴位，刺络后拔罐10min。1个疗程10次。

循经三步针法中“点刺远端五输穴”依据于腧穴的远治作用及腧穴的主治规律，即“经络所过，主治所及”。点刺所选五输穴多为输穴、原穴和经穴。输穴可益气化湿，原穴可益气、温阳、通络、祛邪，经穴可温通经络、疏散风寒，3穴合用可宣痹开结，共除肩关节“风寒湿”之痹阻。电针病理反应点可起到运行气血、散结导滞、疏通经络之作用。在疼痛局部刺络拔罐可活血化瘀，祛痰通络，去瘀而生新。《灵枢·本藏》云：“经脉者，所以行血气而营阴阳，濡筋骨，利关节者也”。循经三步针法正是将三步合于一体，发挥了运行气血、协调阴阳、濡养筋骨、滑利关节的作用，从而达到疏通经络、通络止痛的目的，故通则不痛而解肩痛。

孙某某，女，48岁，会计。1999年3月9日初诊。主诉：右肩痛伴不能上举2个月。病史：2月前曾因搬家劳累闪挫，受凉后出现右肩疼痛，夜间较重，常被痛醒，右臂不能上举、后伸，生活和工作不便，遂来针灸门诊就治。查：右肩峰下端、后下方、三角肌外缘、后缘压痛明显拒按，右肩臂外展上举、后伸、后背上抬动作受限。舌黯红、苔白腻，脉滑。西医诊断：右肩周炎。中医诊断：肩痹，属寒湿夹瘀证。辨病经：手阳明大肠经、手少阳三焦经病变。循经诊察：右前臂病理反应点两处，一处在大肠经上表现为结节拒按，一处在三焦经上表现为按压酸胀喜按。循经三步治疗：先取患

侧大肠经、三焦经远端穴三间、阳溪、液门、中渚点刺，配合活动患肩，不留针；再取病理反应点两处针刺，通电 15min；最后以三棱针散刺患侧大肠经、三焦经所在肩关节局部穴位如肩髃、臂臑、肩髃、臑会，点刺后迅即拔罐，留罐 10min。经 2 次治疗后肩痛明显减轻，夜间未被痛醒，肩臂活动功能亦明显改善。治疗 5 次后无明显肩痛，夜间能平稳入睡，肩臂外展、后伸、后背上抬等活动无明显受限。巩固治疗至 10 次（1 个疗程）症状消失，肩臂活动功能基本恢复。随访半年无复发。

十七、肩部三针 讲究手法

肩关节周围炎是肩关节及其周围组织的损伤性、退行性病变。以 50 岁左右为多见，故称“五十肩”，属于中医学痹证的范围。一般称为漏肩风或肩凝症。张正采用针刺并运用自己的经验操作手法治疗，每每取得良效。

取穴：以局部穴位为主，选用肩三针，即肩髃透极泉，肩前穴、肩后穴、曲池、合谷。文献记载，肩前穴在腋前皱襞尽头上 1 寸，肩后穴在腋后皱襞尽头上 1.5 寸，张正所选肩前、肩后并非此二穴位置，而是根据经验所定穴位，亦取肩前、肩后之名，两穴均选在腋前、后皱襞尽头处，其效尤佳。

操作：患者取坐位，将患侧上肢平伸屈肘放于桌上，取毫针直刺肩髃深 1.5~2 寸，直透极泉，其他穴位均用毫针直刺 1~1.5 寸，得气后采用提插捻转泻法，各穴强刺激 1min，使针感向肩周和上肢传导。此时用拇指向前，食指向后将针柄单向捻转至针不能转动为止。此手法可使针下始终留下强刺激的针感，留针 15min。然后拇指向后，食指向前捻转针柄，松弛针感，提插捻转并摇大针孔而依次出针，不揉按针孔，留下合谷穴边捻转边嘱患者活动肩部。出针后，各穴即拔火罐，10min 左右取罐，针孔拔出血液效果更佳。每天 1 次，7 次为 1 个疗程，休息 3 天继续治疗，治疗中宜加强肩部功能锻炼。

胡某，男，62 岁，1980 年 7 月 13 日就诊。患者三月前开始感觉左肩关节疼痛，穿衣困难，服用中药其效不显。近 1 个月，症状加重，肩部微肿，疼痛不止，上举、旋后、外展、后伸等活动障碍，

肩背沉重，天阴尤甚，舌质黯红，苔薄白，脉细弦。即针刺肩髃透极泉，肩前、肩后、曲池、合谷，针毕即拔火罐，每穴针孔均拔出紫黑色血液，取罐后，患者上肢即能举过头、后旋至背，疼痛顿减，欣喜无比。如法针3次，左上肢活动自如，肩部肿消，再无疼痛，随访未再复发。

十八、六经分治 针灸并用

张国瑞将肩痛证按六经分治，以疏通经脉为主，取其相应经脉腧穴，可取得较好疗效。

(1) 手阳明型 肩上、肩外侧疼痛或压痛，亦可扩散到上肢外侧前缘，上肢外展高举时疼痛加重或功能障碍。包括冈上肌腱炎，肩峰下滑囊炎，肩周炎等。

主穴：条口。配穴：曲池、巨骨、肩髃、臂臑。用32号1.5寸毫针，条口：进针0.8~1.2寸。用捻转补泻手法，使整个小腿酸胀。边用手法，边令病人活动患肢。若兼有手太阳型症状者，用30号3寸毫针，取条口透承山，一针兼治两经病。配穴均用32号毫针，行平补平泻手法。

(2) 手少阳型 肩部外侧疼痛或压痛，上肢旋前高举时疼痛明显或功能障碍。包括肩周炎，肩峰下滑囊炎等。

主穴：阳陵泉。配穴：外关、肩髃、下髃会（髃会直下1.5寸）。主穴阳陵泉用32号2寸毫针，稍向前下斜刺1.5寸，行先提插后捻转手法，使针感向下传至足背外侧。若兼有手太阴型者，用30号3寸毫针，取阳陵泉透阴陵泉；肩连颈项者，阳陵泉改用悬钟。配穴用32号1.5寸毫针，行平补平泻手法。其中下髃会用先提插后捻转手法，使针感传至手背或手指。

(3) 手太阳型 肩关节后侧疼痛，常连及肩胛部和上肢外侧后缘，上肢内收高举时疼痛加重或功能障碍。包括肩周炎，冈上肌、冈下肌肌腱炎，肩峰下滑囊炎等。

主穴：承山。配穴：肩外陵、天宗、秉风、后溪。主穴承山用32号2寸毫针，直刺1.5寸深，行先提插后捻转手法，使针感放射至足心或足外侧。若兼有手阳明型症状者，用30号3寸毫针，取承山透条口。

(4) 手太阴型 肩关节前及臂臑内侧前缘疼痛, 有时可摸到条索状反应物, 有压痛。上肢后伸时疼痛加重或功能障碍。包括肱二头肌长头腱鞘炎, 肩周炎等。

主穴: 阴陵泉。配穴: 肩内陵、天府、尺泽。主穴阴陵泉用 32 号 2 寸毫针, 直刺 1.5 寸, 行先提插后捻转手法, 使针感传至足底或足内侧。兼有手少阳型症状者, 用 30 号 3 寸毫针, 取阴陵泉透阳陵泉。配穴用 32 号 1.5 寸毫针, 行平补平泻手法。

(5) 手厥阴型 肩前疼痛或压痛, 上肢向外侧前上方抬举时疼痛明显。肱二头肌抗阻力试验阳性, 喙突部有压痛。包括肱二头肌短头肌腱炎, 肩周炎等。

主穴: 曲泉。配穴: 曲泽、阿是穴。主穴曲泉用 32 号 2 寸毫针, 直刺 1.5 寸, 行捻转提插手法。若兼有手少阳型症状者, 用 30 号 3 寸毫针, 从曲泉透阳关, 行捻转补泻手法。配穴用 32 号 1.5 寸毫针, 行平补平泻手法。

(6) 手少阴型 症见腋窝部疼痛, 或淋巴结肿大疼痛, 肱二头肌后缘疼痛或功能障碍。

主穴: 筑宾。配穴: 下极泉(极泉直下 1.5 寸)和少海。主穴筑宾用 32 号 2 寸毫针, 直刺 1.5 寸, 行先提插后捻转手法, 使针感传至足底。配穴下极泉和少海均用 32 号 1.5 寸毫针, 直刺或稍向桡侧斜刺 1.2 寸深, 行先提插后捻转手法, 使针感达前臂或手指。

以上为六经分治。但在临床上症状表现是复杂多变的, 有的几经同时发病, 更有寒热虚实的区别。临床上必须综合分析, 辨证用穴才能取得理想效果。

偏于风盛者, 散风活络, 加风池、外关, 并予局部加闪罐, 如此反复快速多次, 至皮肤充血红润为度; 偏于寒盛者, 温经散寒止痛, 局部深刺加灸, 加太冲、合谷; 偏于湿盛者, 健脾利湿, 加足三里、阴陵泉; 郁久化热者, 清热泻火, 加大椎、合谷、曲池; 肌肉萎缩功能障碍者, 健脾益肾, 加三阴交、太溪; 局部多针浅刺配合按摩和功能锻炼。

十九、针刺运动疗法 通络止痛

杜永平采用针刺配合运动疗法治疗肩周炎, 取得理想疗效。

(1) 针刺

取穴：肩前、肩贞、肩髃、阳陵泉、阿是穴。

操作：选择取1~3寸28号毫针，针刺以上穴位，手法采用提插或捻转泻法，体质虚弱明显者用平补泻手法，中强刺激，以局部胀困酸痛为度，肩前、肩贞宜向外斜刺，阳陵泉宜深刺，阿是穴以斜刺为主，多用围刺法，针刺后，选择取疼痛最明显处的两针连接G6805-1型电针仪输出的两极，采用密波，频率200次/min左右，强度以患者能耐受为度，20~30min后出针。

(2) 运动疗法

取穴：中平或条口。

操作：选择取4寸长针深刺中平穴或条口透承山穴，采用提插捻转泻法，强刺激2~3min，局部酸胀麻抽为度，针感能上下传导更佳，再被动活动肩关节2~3min。活动时，先对肩关节进行前屈，后伸及外展等活动，然后采用肩关节摇法，向前后各8~10圈，一次活动结束后，再行针及被动活动肩关节如上法1次，最后再如前行针2~3min，在行针的同时嘱患者主动活动肩关节如上法后出针，结束操作，中平或条口针刺可与其他穴位针刺时进行，注意在肩关节活动过程中，以患者能耐受为度，应尽量扩大患者肩关节的活动范围，逐步缩小功能障碍。

以上治疗每天1次，8~10次为1个疗程，疗程之间体息1~2天，一般治疗1~3个疗程，2周以内的患者一般治疗3~5次即可。

肩周炎中医属痹证范畴，称为肩痹。中医理论认为，50岁左右的人，肝肾不足，天癸竭，处于中老年转化阶段，对外邪低御能力差，易患本病，所以又称“五十肩”。中老年人肝肾不足，气血亏虚，筋脉失养，加之汗出当风，睡卧露肩，感受风寒湿邪，或慢性劳损等因素诱发而致。所以，肩周炎往往正虚在先，加之外邪侵袭，凝聚而为痰瘀，成为本虚标实之证。临床表现往往以邪盛为主，而正虚不明显。在治疗时，应以去邪为主，但不能忘记补虚。所以针刺治疗本病，应以祛风散寒，化痰除湿，通络止痛，散瘀解凝为主，体虚明显者兼补肝肾。在治疗过程中，手法也以泻法为主，体虚明显者平补平泻，亦可加刺足三里、三阴交等穴，用补法。针刺疗法：局部取穴肩前、肩贞、肩髃，是谓之“肩三针”，配合阿是穴用泻法

以祛风散寒，化痰除湿，通络止痛，散瘀解凝，循经取穴筋会阳陵泉，为胆经合穴，有通利三焦，除湿通络，化痰散瘀的功效，以加强局部疏筋通络，解凝止痛的作用。针刺运动疗法实质上是针刺疗法与运动疗法相结合的一种治疗方法。中平穴或条口穴为治疗肩周炎的有效经验穴，深刺并用泻法强刺激，加强了针刺疗法疏筋通络，解凝止痛的作用，有利于减轻运动时疼痛。在留针时伸展，增加肩关节活动范围，改善肩凝症状。两次操作后，再让患者自主活动肩关节，以巩固肩关节活动范围，缓解被动活动时所产生的疼痛，增强治疗的信心。在被动活动时，应重点对功能活动障碍比较严重的后伸、外展等作重点运动，可适当配合推拿分筋手法，以增加解凝效果。

王某某，女，51岁，2005年4月15日初诊，右肩关节周围疼痛，功能活动障碍2周，加重2天。2周前，无明显诱因觉右肩部发凉疼痛，初起还可忍受，后逐渐加重，板滞不适，夜间有时因肩关节活动而痛醒，近两天来，右肩关节周围疼痛加重，肩背部板滞僵硬，恶风畏寒，甚至夜间扶枕掖被即出现剧烈疼痛。肩关节前屈、后伸、外展均受限，以外展最为严重，遂来就诊。查体肩关节周围压痛广泛，但范围不明确，无结核，脱位及急性软组织损伤史，舌苔白腻，脉沉细，诊断为肩周炎，炎症期，证属阳虚痰淤，寒湿内侵。以上述方法治疗1次，疼痛明显减轻，功能活动好转，晚间休息未出现疼痛，治疗5次后右肩部疼痛消失，功能障碍解除而愈，随访半年未见复发。

二十、条口透承山 针通两经

肩周炎又称肩凝症，是以单侧或双侧肩关节酸重疼痛，运动受限为主症。李霞采用条口透承山配合运动疗法治疗该病，疗效显著。

针刺：条口穴透承山穴。取双侧，病人采取坐位，两腿屈成直角，用4寸毫针刺入条口，徐徐向承山，频频捻转，在得气的情况下，嘱病人活动患肩。

运动疗法：在针刺行针的同时，不伴功能障碍者，要求患者主动活动患侧肩部，做内收、内旋、外展、上举等动作，如伴功能障碍者，医者在行针时，可让助手在患肩施行推拿、按揉、点压、弹

拨等放松手法,然后被动活动患肩,施以扳法、摇法等手法,每天1次,留针30min,10min行针1次,行针约3min,10次为1个疗程,间隔3天进行下1个疗程。

肩周炎的病机是寒凝气滞、经络气血不通所致,属中医之痹证范畴。肩关节周围为手太阴经脉和手三阳经脉循行所过,若寒邪凝滞、经络不通、气血运行不畅、不通则痛。中医学认为“上病者,下取之”、“同名经相通”,故针刺足阳明胃经穴条口透足太阳膀胱经穴承山,针一穴而通两经,阳明又为多气多血之经,调其经脉,气血运行通畅,则诸经通顺,疼痛减而消,加之配合肩部的主动、被动的运动疗法,尤其是将推拿手法融合于被动的肩部运动,既能提高局部组织的痛阈、松解粘连,改善局部的血液循环,又能减轻患者因惧怕疼痛而不活动肩部的心理,两者相辅相成,故可达到散寒止痛、调和气血、通经活络、滑利关节之功效。

李某,女,43岁,营业员。2002年4月23日来诊。病史:左肩关节疼痛1月,加重伴酸困无力10天来诊。患者1月前因肩部受寒后感左肩关节周围疼痛,尤以夜间痛甚,伴酸困无力,遇寒加重,得热稍舒,曾服“消炎痛”、“阿司匹林”效不佳,特来诊治。查体:左肩髃、肩内陵、肩后穴处压痛明显,活动时疼痛较甚,但活动不受限,舌质淡红,苔薄白,脉滑缓。中医诊断:漏肩风(寒凝气滞),西医诊断:左肩关节周围炎。治则:温经散寒、行气通络。取穴:条口透承山(方法同前),并令患者主动活动左肩,作内收、外展、内旋、上举等动作,经治疗3次患者感左肩部疼痛已明显减轻,共治疗7次即告痊愈。半年后因其他病来诊,问其未再复发。

参 考 文 献

- [1] 朱俊珂. 长短针配合加刺络拔罐治疗肩周炎疗效观察. 针灸临床杂志, 2003, 19(4): 38~39
- [2] 刘卫仁. 多针透刺法治疗肩周炎64例疗效观察. 中国热带医学, 2005, 5(7): 1506
- [3] 廖辉, 李丹萍, 徐杰. 互动式针刺法治疗肩周炎69例临床观察. 天津中医药, 2003, 20(5): 46~47

- [4] 张学武. 肩髃穴“三透法”针刺治疗肩周炎 88 例. 安徽中医学院学报, 1997, 16 (6): 53
- [5] 王凤. 巨刺法治疗肩周炎 52 例临床观察. 甘肃中医, 1997, 10 (2): 36
- [6] 符少杨. 埋针、电针治疗肩周炎 69 例. 针灸临床杂志, 2005, 21 (10) 39 ~40
- [7] 高崇群, 所东, 寇壮铃. 循经远道取穴法配合拔罐治疗肩周炎 30 例. 上海针灸杂志, 2000, 16 (5): 43 ~44
- [8] 史永奋, 王丹华, 张海纓. 运用《黄帝内经》傍针刺法治疗肩周炎疗效观察. 上海针灸杂志, 2004, 20 (3): 40 ~42
- [9] 吴军. 针刺加耳穴疗法治疗肩周炎. 针灸临床杂志, 2002, 18 (11): 28
- [10] 于金栋. 针刺结合穴位注射治疗肩周炎 100 例. 天津中医学院学报, 2000, 19 (1): 33 ~34
- [11] 王丽. 不同次序针刺治疗肩周炎 101 例. 云南中医中药杂志, 2007, 28 (2): 33
- [12] 陈能哲. 分步针刺法治疗原发性肩周炎 169 例. 福建中医药, 2004, 35 (4): 28 ~29
- [13] 陈兴华. 温针灸治疗肩周炎 76 例疗效观察. 针灸临床杂志, 1998, 14 (10): 11 ~12
- [14] 程永, 林贤梅, 成卓, 等. 运动针法配合刺络拔罐治疗肩周炎 40 例疗效观察. 新中医, 2005, 37 (5): 60 ~61
- [15] 赵海红, 王允娜, 孙桂云. 郑魁山热补针法治疗肩周炎的经验. 浙江中医杂志, 2007, 42 (1): 38
- [16] 姚军. 循经三步针法治疗肩周炎 30 例疗效观察. 中国针灸, 2004, 24 (3): 185 ~187
- [17] 胡熙明. 针灸临证指南. 人民卫生出版社, 1991, 518
- [18] 胡熙明. 针灸临证指南. 人民卫生出版社, 1991, 523
- [19] 杜永平. 针刺配合运动疗法治疗肩周炎 38 例. 现代中医药, 2007, 27 (1): 58 ~59
- [20] 李霞, 高军权. 针刺配合运动疗法治疗肩周炎 58 例. 陕西中医学院学报, 2003, 23 (4): 39

【肱骨外上髁炎】

肱骨外上髁炎是以肘部疼痛、关节活动障碍为主症的疾病，俗称“网球肘”。属于中医学“伤筋”、“痹证”的范畴。多因前臂旋转用力不当而引起肱骨外上髁桡侧伸肌腱附着处劳损，是常见的肘部慢性损伤。多见于从事旋转前臂、屈伸肘关节和肘部长期受震荡的劳动者，如网球运动员、打字员、木工、钳工、矿工等。中年人发病率较高，男女之比为3：1，右侧多于左侧。

中医学认为，劳累汗出、营卫不固、寒湿侵袭肘部经络，使气血阻滞不畅；长期从事旋前、伸腕等剧烈活动，使筋脉损伤、瘀血内停等均能导致肘部经气不通，不通则痛。

本篇收录了11位针灸医家的临床治验，从治疗方法上看：有的采用关刺法，有的采用围刺法，有的采用扬刺法，有的采用苍龟探穴法；从取穴上看：有的以阿是穴为主，有的取曲池、手三里，有的采用远端辨证取穴等。针灸治疗本病效果满意，一般2~3次即可见效。治疗期间应避免肘部过度用力，急性发作者应绝对避免肘关节运动。病程较长、局部肌腱或组织发生粘连者可配合推拿，并做适当的活动，有利于康复。

一、阿是穴关刺 活血止痛

蒋湘萍采用关刺加隔姜灸，治疗肱骨外上髁炎，取得满意疗效。

取穴：主穴：为肱骨外上髁至桡骨颈间之敏感压痛点；配穴：患侧曲池、手三里、外关、合谷。

操作：局部常规消毒，用28号1.5寸毫针直刺，深达筋膜，捻转至酸麻胀痛或触电感为度。每10min行针1次，留针30min。

隔姜灸：取大块新鲜生姜切片厚约0.3cm，用三棱针在姜片上均匀地点刺6~8个小孔。出针后将姜片置于痛点处，然后在姜片上放置枣核大小艾炷灸5~8壮，灸至局部皮肤潮湿红润为度。每天1次，7次为1个疗程，疗程间隔3~5天。治疗期间尽量减少患肢活动，避免使患肘劳累。

肱骨外上髁炎主要由于前臂伸肌群处于长期反复强烈的收缩、牵拉导致其附着处发生不同程度的急慢性积累性损伤，属中医学“筋痹”范畴。“关刺”乃“五刺”中之一。《灵枢·官针》篇云：“关刺者，直刺左右尽筋上，以取筋痹……。”此法是刺左右四肢关节附近筋的近端，用以治疗“筋痹”，具有舒筋活络，调和气血，平衡阴阳，扶正祛邪的作用。隔姜灸能够温经行气，活血止痛，用来治疗痹痛，与“关刺”手法相配，相得益彰，故能取效。

曹某，男，35岁，厨师。1992年10月26日初诊。患者于半年前始感左肘酸痛，曾用泼尼松龙局部封闭，疼痛缓解3月余，近2个月来，左肘关节酸痛，且疼痛逐日加重，前臂乏力，旋前疼痛加重，持物困难。查体：左肘关节活动基本正常，皮色不变，左侧肱骨外上髁与桡骨头之间有明显压痛点，抗阻力痛及伸肌群牵拉试验阳性。舌苔薄白，脉弦涩。诊断为肱骨外上髁炎，乃劳伤气血，筋脉不和所致。遂用上法针灸1个疗程后，左肘关节疼痛基本消失，握物有力，继续巩固治疗3次，随访2年未复发。

二、苍龟探穴 重在取穴

网球肘是临床上常见病及多发病，患者以疼痛为主要表现，严重者可影响关节的活动。张爱冰在临床上采用苍龟探穴法针刺治疗网球肘患者，获得满意疗效。

取穴：主穴取患者肱骨外上髁周围压痛点，为阿是穴，取穴要准确，按压局部酸痛明显，可放射至前臂。配穴为患侧曲池穴、手三里穴。

操作：患肢屈肘功能位，选用28号2寸毫针，穴位常规消毒后进针，得气后退至皮下，再分别向前后左右多向斜刺，待获得较强的针感后，留针30min，留针期间行针2次，10次为1个疗程，疗程间休息3天。

网球肘即肱骨外上髁炎，属中医“筋痹”范畴，多因经脉气血瘀阻不畅，筋脉失养而发病。苍龟探穴法属于“飞经走气”四法之一，该法具有取穴少，针感强的特点。在临床运用上，必须遵循《金针赋》所述：“苍龟探穴，如入土之象，一退三进，钻剔四方。”的操作方法，方能取得满意的疗效。

网球肘的疼痛敏感点明显，苍龟探穴法采用一针多向深刺，取阿是穴以痛为腧，直捣病所，从而达到疏经通络、活血止痛的作用，为主穴。曲池、手三里同属手阳明大肠经，两穴下分别有桡返动脉分支、前臂背侧皮神经及桡神经分支，刺激两穴可以消炎止痛、改善局部微循环的作用，为配穴。以上穴位合用可以增强治疗效果，达到通络止痛的目的。

三、曲池—手三里 电针配温针

网球肘又名肱骨外上髁炎，此病常影响工作和睡眠，顾训杰采用电针加温针治疗该病。

取穴：曲池（曲池合谷刺）及手三里。

操作：局部先用75%酒精消毒，用30号，1.5寸毫针取曲池直刺待得气后再距离曲池穴约1寸左右各向曲池方向斜刺1针，同样有得气感，再取手三里直刺得气，然后用音频脉冲分别夹在曲池和手三里上，进行刺激，其强度根据各病者，舒适为度，连续刺激30min，在电针刺激同时，用艾炷约1寸左右分别在曲池和手三里针柄上续灸3壮，每周2次，10次为1个疗程。

现代医学认为网球肘是由于肘关节长期慢性劳损导致局部无菌性炎症，刺激压迫神经末梢和阻碍局部血液循环，从而导致局部代谢障碍而发生。曲池、手三里为手阳明经经穴，阳明经为多气多血

之经，故温针能调养气血，达到温经通络、散寒止痛的目的，是治疗肘臂部筋病的要穴，加上曲池合谷针能改善局部循环，达到通则不痛，配合电针刺激加速通经活血、消炎，从而减轻炎性渗出，消除组织水肿、促进症状缓解。

黄某，男，52岁，汽车修理工，因右肘关节酸胀疼痛1年余，近1周来病情加重，前来就诊。针见右肘关节酸痛，向前臂及手指放射，用力时肘部疼痛加甚，平时右手不能持重物，影响穿衣，睡时常疼痛而醒，给生活、工作带来一定困难。检查右肱骨外上髁压痛明显，前臂旋转及屈腕活动受限，舌淡红，苔薄白，脉弦紧。诊断为右肱骨外上髁炎。给予电针加温针治疗，1个疗程而愈，经随访2年未发。

四、远端辨证选穴 虚补实泻

网球肘属中医伤筋、肩痹范畴，一般起病缓慢，常反复发作，无明显外伤史，多见于从事旋前臂和屈伸肘关节的劳动者。黄选玮的远端辨证选穴经验及自创的患者自我行针术颇具特色，治疗网球肘屡收佳效。

取穴：中渚、三间、列缺。

操作：用75%酒精常规消毒，选用30号，1寸不锈钢毫针以单手进针快速刺入，中渚、列缺二穴均向上斜刺，三间向手心方向透刺。以上诸穴得气后视病情虚实情况而施补泻手法，留针30min，留针期间嘱患者活动腕、掌指关节以自我行针，保持针感并以患者能耐受为度。每天治疗1次，10次为1个疗程。临证在疼痛点拔罐，以皮肤变紫为度，并于局部加用TDP照射30min。

黄选玮打破传统以阿是穴为主治疗网球肘的方法，而以手太阴肺经、手阳明大肠经、手少阳三焦经的五输穴为主治疗。他认为本病多伤于手太阴肺经、手阳明大肠经、手少阳三焦经之经气，造成三经经气运行不畅，故在手少阳三焦经、手阳明大肠经上分别取中渚、三间二穴，针之能使经气通畅，脉络畅通，气血得行，共达通则不痛之效。本病常因感受风寒湿之邪而发，肺主皮毛，司一身之表，外感之邪来犯，首当其冲，故于手太阴肺经上舍输取络之列缺，不但能疏通手太阴经之经气，而且能祛外感风寒湿之邪。共凑舒筋

通络，解痉散寒止痛之功。在痛点拔罐，用 TDP 照射，能增加活血行气，舒筋活络，温经散寒止痛之功，使肘部经络通畅，风寒之邪尽去，达到标本兼治，肘劳自愈之效。

周某某，女，51 岁，已婚，教师。于 2005 年 8 月 10 日前来就诊。自诉 4 天前清晨醒来，突觉右手肘部疼痛，右手屈、伸、旋前、旋后、扫地、拧衣服均困难。黄老师刻诊：右肘关节疼痛，屈、伸、旋前、旋后痛甚，痛引前臂、上臂。肱骨外髁以及肱桡关节间隙处有明显压痛，腕伸肌紧张试验阳性，前臂伸肌腱牵拉试验阳性，X 线无异常发现。舌淡，苔薄白，脉弦而紧。四诊合参，现代医学属于网球肘；中医证属于寒凝经脉，气血阻滞，脉络不通而致伤筋、肩痹，治宜舒筋通络，行气活血，散寒止痛。乃施上法，使风寒湿之邪得祛，经络畅通，气血得行。经 1 次治疗疼痛锐减，关节活动度大有改善，4 次治疗后痊愈。后因家人来诊，自诉其未有不适。

五、局部取穴 青龙摆尾

网球肘多因肘部过劳，风寒积聚，损伤气血，筋脉失和所致。气主骨（关节），血主筋，气血凝滞则拘挛疼痛。李子勇采用青龙摆尾针刺手法治疗网球肘，取得较满意疗效。

取穴：阿是穴、曲池、手三里。

操作：常规消毒后选用 30 号 1~1.5 寸华佗牌不锈钢毫针，将针斜 45°进针，得气后，拇指执针不转，针不进不退，一左一右慢慢摆动针柄，如用手扶船舵或左或右以正航向一样，针感沿前臂传导，然后留针 30min。每天治疗 1 次，5 次为 1 个疗程，休息 2 天后再进行第二个疗程。

冯某，男性，33 岁，右侧肘关节疼痛，活动不利，不能持物，以夜间明显，时好时差，伸肌腱抗阻力试验（+），曾在当地各大医院做 X 光检查、头颅及彩超等检查均未发现异常。取穴：阿是穴、曲池、手三里，用青龙摆尾法针刺 1 个疗程后，症状消失，追踪观察 1 个月未见复发。

六、围针刺拔罐 结合穴注

岳延荣采用围针刺、拔罐法结合穴位注射治疗网球肘，取得较

满意的疗效。

围针刺拔罐：在原发病灶疼痛部位，用酒精消毒后取 30 号毫针在疼痛部位外围 2~3cm 处，针呈 30°~45°角方向斜刺，针尖指向疼痛部位中心区，根据疼痛部位的大小，用 4~8 根针围成圈状，针刺后施行捻转泻法，逐根运针各 5min 后出针。然后在疼痛部位拔罐，因疼痛在关节周围，所以选择适宜型号的火罐以及选择合适的拔罐角度和位置十分重要。每天 1 次，10 次为 1 个疗程。

穴位注射：将患肘曲池穴部位皮肤常规消毒后，用注射器抽取野木瓜注射液 2ml。以注射针直刺穴位，至患者感到酸麻胀感。稍留针片刻，回抽无血即可注入药液。每天 1 次，10 次为 1 个疗程。

中医认为本病主要是由于劳损所致。久作劳损，必有伤于气血，使经脉运行无力，经筋因而瘀阻，加之感受外邪，致使因痹而痛。因此在疼痛局部围针，能改善局部血液循环，促进经脉气血流通。拔罐有消炎作用，吸拔之后使局部血液循环改善，可迅速带走炎性渗出物及致痛因子，消除肿胀和疼痛。吸拔之后局部白细胞数目轻微增多，吞噬功能增强。用于穴位注射的野木瓜注射液有祛风止痛、舒筋活络以及良好的抗炎和消肿作用。针、罐、药结合使用可使疗程缩短，疗效增强。

梁某，女性，22 岁，因打羽毛球而致右肘部疼痛，右肱骨外上髁压痛明显，周围组织肿胀，右前臂外旋时疼痛且活动受限，伸腕肌群紧张试验及伸腕肌抗阻试验阳性。诊为右肱骨外上髁炎，采用上述综合疗法治疗 1 次，疼痛明显减轻，6 次后肿胀及疼痛消失，肘关节功能恢复正常，半年后随访未见复发。

七、以痛为腧 小宽针配火罐

张红英采用小宽针针刺配合拔火罐治疗肱骨外上髁炎，获一定疗效。

取穴：主穴取肱骨外上髁压痛点。配穴取曲池、手三里、天井、肘髁。

操作：针刺主穴时，取曲肘式，先找准压痛点。常规消毒，以 2% 碘酒皮肤消毒，再用 75% 酒精脱碘，消毒后医者用右手拇指和食指捏住针体，控制进针深度，小指顶住针柄，以中指和无名指扶住

针体。针尖与皮肤呈 90° 垂直角，左手拇指按压痛点中心，直接刺入病变部位，达一定深度后来回划割一下，划动度平均1cm左右，以达到划破局部病灶的目的，操作时要轻巧灵活（划割度不宜过大，过大则容易引起局部血肿加剧疼痛，也不可过小，过小则不易划破局部病灶，达不到治疗目的）。出针后用闪火法将玻璃罐扣在针刺的穴位上，约停1min拔出瘀血，穴位出血约1ml时起罐，用消毒纱布拭擦，并敷消毒纱布按揉穴位1min。7天治疗1次，3次为1个疗程。

肱骨外上髁炎主要由慢性劳损引起，如肘腕长时间操劳，劳伤气血，气滞血瘀；或前臂旋转用力不当，前臂伸腕肌的起点扭伤，亦有因风寒痹阻，敛缩脉络、经筋所致。小宽针是在九针的基础上改进的。选择疼痛部位进行针刺拔火罐具有通经活络，舒筋止痛，宣通气血，促进局部血液循环，改善新陈代谢的功能。按经筋之为病，符合局部取穴和“以痛为输”的原则。

八、杨刺阿是 通经活络止痛

肱骨外上髁炎，又称网球肘，是肘关节常见的致痛原因。潘宁运用《内经》扬刺法治疗本病。

取穴：在肱骨外上髁寻找压痛点作为阿是穴；根据放射痛、不适感部位，酌取手阳明经曲池、手三里、上廉、下廉、合谷等1~2穴。

操作：患者坐或卧位，屈肘。取28号，1寸毫针，在阿是穴压痛最明显部位中心进针，进针后，直刺抵骨面，在压痛最明显部位的骨面上提插深刺，在针感强烈的位置留针。然后以阿是穴为中心在其四周斜刺4针，针尖斜向正中1针针尖，针身与皮肤平面约成 15° 角，缓慢捻转推进，使每针的针尖均达到正中1针针尖处骨面。其他穴位常规针刺，得气后行平补平泻手法。留针20min。留针期间，于阿是穴正中1针针柄上置艾条温灸。隔日1次，5次为1个疗程。休息1周，进行下1个疗程。

扬刺是《内经》十二节刺法之一。《灵枢·官针》云：“扬刺者，正内一，旁内四而浮之，以治寒气之博大者。”根据以痛为输的理论，选穴上以肘部阿是穴为主，采用扬刺法以加强通经活络止痛。

又因本病的疼痛不适主要表现在手阳明大肠经上,所以酌配曲池、手三里、上廉、下廉、合谷等穴,是取其“经络所通,主治所在”之意。复加温灸更助散寒通络止痛之功,共奏佳效。肱骨外上髁压痛点,每次针刺前须重新寻找,用拇指指腹顶端均匀用力触压,仔细比较,作好标记,确定压痛部位、压痛最明显部位及其中心。针刺阿是穴须深入到前臂伸肌总腱附着区、肱骨外上髁骨面上。以上是取得疗效的关键。治疗期间及症状消失后1个月,应减少患肢活动,避免用力。

九、梅花针配点穴 止痛

李晓明采用按摩点穴结合梅花针治疗肱骨外上髁炎,获满意效果。

按摩点穴:先点揉患侧曲池、肘髁、尺泽及阿是穴10min,然后嘱患者屈肘约90°,在肱骨外侧前下方医者用拇指或食指端在局部微用力往返拨动桡侧伸腕长短肌之肌腱,再施以被动旋肘法,即医者以一只手持患肘并用拇指指腹轻按压痛点,另一只手持患侧腕部,进行顺时针及逆时针旋肘运动3~5min,继以拔伸、抖动患侧拇指、食指,最后医者以拇指端点按并拨动手三里3次,以患者自觉有电流向前臂放散,传导感觉至拇、食指为佳,此为1次治疗结束。

梅花针:令患侧肘弯曲稍大于90°,桡侧在上,辨明压痛点及压痛区域(约1~2cm)进行常规消毒后,用无菌梅花针垂直向压痛点及压痛区域叩刺。叩刺时要用弹刺、疾刺,不能斜刺、拖刺,频率保持在70~90次/min。叩刺至皮肤明显发红,并有较多渗血出现为止,用消毒棉擦去渗血,治疗结束。

上述治疗隔日进行,5次为1个疗程。

中医认为肱骨外上髁炎的发生是由于筋脉受损,局部组织失养,气血瘀滞而致。针对其病因病机,李晓明用上述方法进行治疗。首先,按摩具有疏筋活络、理气活血、散瘀化滞、消肿止痛功效,李晓明在按摩时除了着力于患处的重点病位,同时还按压点穴,这对周围损伤组织也起到了调节、温养、修复的作用,加之弹拨及被动引伸旋肘手法又能使粘连松解,关节滑利,达到迅速恢复活动功能使疼痛消失的治疗目的,故疗效较好。梅花针由《灵枢·官针》

“半刺”、“浮刺”等浅刺法发展而来，具有疏通经络、调和气血、散瘀消肿、止痛的治疗作用。李晓明用梅花针浅刺直接作用于病痛区域至皮肤发红、渗血，可加快局部血液循环，对消散瘀肿、促进局部新陈代谢、加快组织修复有良好的作用。

王某，男，52岁，2002年5月9日初诊。主诉：右肘关节疼痛1年余，半年前因右肘外侧痛并连及前臂桡侧放射痛，理疗、针灸治疗15次无效，遂接受手术治疗。术后痛更剧，影响饮食、睡眠，西医建议再行手术，患者不接受，遂采用中医治疗。查患者右肘上髁处有一手术疤痕，局部微肿胀，色青紫，肘关节屈伸不利，柯生试验及密耳试验均呈阳性，患处有明显压痛，诊为陈旧性肱骨外上髁炎。用上述方法治疗1次后，顿觉肘部疼痛大减，5次后疼痛消失，共治疗10次痊愈，恢复正常工作，追访1年无复发。

十、针推并用 通则不痛

曹璐敏采用齐刺结合按摩治疗肱骨外上髁炎，疗效显著。

取穴：阿是穴。

操作：患者平躺治疗床，患肘屈曲，找准压痛点，并在其上下各2cm处选取两点作为穴位，对局部皮肤及针具常规消毒，以30号2寸针刺入压痛点，用苍龟探穴法行针，以30号1.5寸针刺入上下两点，行提插捻转泻法，以引病气外出；再将上下两针接通G6805-1型治疗仪，采用疏密波，电量以患者耐受为度，留针30min，痛点之针每隔30min行针1次。

推拿：针刺后进行按摩治疗，患者取坐位或仰卧位，医者立于患侧，先沿肱骨外上髁向前臂用按、揉等手法按摩3~5min，以舒筋活血；再对压痛点按、弹拨3~5min，以松解粘连；继而按住压痛点同时进行屈肘屈腕、前臂旋转等动作各10次；最后以搓、抖等手法放松肘关节5次。上述方法每天1次，10次为1个疗程，疗程间隔3~5天。

肱骨外上髁炎属中医筋痹、肘劳范畴。中医学认为由于素体气血虚弱，复加肘部外伤或感受风寒湿邪，导致局部气血瘀滞经筋，流注于关节引起本病，主要病机为气血瘀滞，日久不愈则导致局部组织粘连，使关节僵硬疼痛、功能障碍或受限，治疗本病应舒筋活

血、化瘀止痛，达到通则不痛的效果。

齐刺法见于《灵枢·官针》：“齐刺者，直入一，傍入二，以治寒气小深者，或曰三刺，三刺者，治痹气小深者也。”本方法主要治疗小范围的痹痛之证，而苍龟探穴法为明代徐凤《金针赋》所载的飞经走气四法之一，有通行经气的作用，主治经络气血壅滞之证，使经气容易扩散。针刺及按摩可提高痛阈，增加疼痛耐受力，降低痛觉的敏感性。针刺对炎症过程的渗出、变质和增生的病理变化呈现一种调整作用，可控制机体的炎症反应。电针采用疏密波能促进代谢，促进气血循环，改善组织营养，消除炎性水肿。而按摩时手法的机械能转化为热能，可使毛细血管扩张，增加局部肌肉的营养供应，促进损害组织的修复，加快血液循环及淋巴循环，加速水肿及病变产物的吸收，促进肿胀挛缩消除，可增加肌肉的伸展性，并使局部组织温度升高，肌肉的黏滞性减小。通过在肘关节局部的综合治疗，可温通经络、行气活血、祛瘀散寒、舒筋散结、滑利关节、松解粘连，使得气血通畅、瘀滞消除，损伤的组织得以修复，充分达到松则通、通则不痛的治疗目的。

程某，男，37岁。2003年4月13日以“右肘关节外侧疼痛3月”之主诉初诊，缘于3月前打网球时间过长引发病证，无明显外伤史，肘关节疼痛遇阴雨天加重。查体：前臂旋前及屈伸肘关节时疼痛加剧，肱骨外上髁处压痛明显，服“布洛芬”等消炎止痛药效果不佳。诊断：肱骨外上髁炎（右），以上述方法治疗1个疗程，症状明显减轻，继续治疗1个疗程痊愈，随访3月未复发。

十一、独取曲池 穴注艾灸

高红采用曲池穴穴位注射加艾条温和灸治疗难治性网球肘，疗效显著。

取穴：患侧曲池。

操作：患者取坐位，患肢置于治疗台上，暴露穴位，常规皮肤消毒后，用2ml一次性注射器6号针头吸取正清风痛宁注射液50mg（1支）后，针头快速刺入穴区，深度为针头的2/3，稍做提插，待患者自感穴区有酸胀感后，回抽针管无回血，即缓慢注入药液，注射完毕后出针，用消毒干棉球按压穴位片刻，然后用点燃的艾条在

曲池穴区温和灸 30min。穴注治疗隔日 1 次，10 次为 1 个疗程。艾条温和灸每天 1 次，10 次为 1 个疗程。

肱骨外上髁炎属中医学痹证范畴，大多因劳累受寒，局部经络气血痹阻不通，营卫不和，血不荣筋所致。所选曲池穴是手阳明经之合穴，位于肱骨外上髁与桡骨关节部之桡侧，具有主治手臂肿痛、肘中痛、肘细无力等症的功能。穴位注射选用的药物正清风痛宁注射液，不但有祛风除湿，活血通络，消肿止痛功效，还具有抗炎、镇痛及较好的免疫调节作用，且毒性及不良反应轻。

“针所不为，灸之所宜”，配合艾条温和灸，促使局部产生温热或灼热的感觉，发挥通经活络，祛寒湿，消肿止痛等作用，促进无菌性炎症吸收，与正清风痛宁注射液合用加强了消炎止痛的作用。

患者，女，51 岁，2004 年 11 月 22 日就诊。右侧肘关节疼痛 10 个月，疼痛时轻时重，并进行性加重，近日因受凉疼痛加重，右侧肘部活动受限，右手持物乏力，提物困难，劳累及阴雨寒凉天加重，曾自贴奇正消毒贴及口服酮洛芬胶囊效果欠佳。查体见右肱骨外上髁压痛明显，前臂内外旋转受限，持物乏力，握拳不紧，前臂伸肌群紧张试验（+），伸肌群抗阻试验（+）。该患者为难治性网球肘，病情反复发作，时轻时重，久治不愈，在本门诊治疗 2 个疗程后，诸症消失，疗效满意，随访至今无复发。

参 考 文 献

- [1] 蒋湘萍. “关刺”并隔姜灸治肱骨外上髁炎 52 例. 新中医, 1998, (1): 28
- [2] 张爱冰. 苍龟探穴法治疗网球肘 38 例临床观察. 针灸临床杂志, 2003, 19 (3): 38
- [3] 顾训杰. 电针结合温针治疗网球肘 40 例. 针灸临床杂志, 1999, 15 (8): 26~27
- [4] 曾权. 黄选玮教授运用远端取穴法治疗网球肘经验. 贵阳中医学院学报, 2006, 28 (2): 14~15
- [5] 李子勇, 老锦雄. 青龙摆尾法治疗网球肘 91 例的临床观察. 按摩与导引, 2006, 22 (3): 9~10
- [6] 岳延荣, 曾展鹏, 劳永生. 围针灸拔罐法结合穴位注射治疗网球肘 31 例.

- 中国民间疗法, 2001, 9 (2): 19
- [7] 张红英. 小宽针治疗肱骨外上髁炎 43 例. 上海针灸杂志, 1996, 15 (3): 242
- [8] 潘宁. 扬刺法治疗肱骨外上髁炎 78 例. 上海针灸杂志, 1997, 16 (5): 19
- [9] 李晓明, 栾永红. 按摩点穴结合梅花针治疗肱骨外上髁炎 38 例. 北京中医药大学学报 (中医临床版), 2005, 12 (3): 27 ~ 28
- [10] 曹璐敏. 齐刺结合按摩治疗肱骨外上髁炎 43 例. 陕西中医, 2005, 26 (6): 571 ~ 572
- [11] 高红, 王昕. 穴位注射配合温和灸治疗网球肘 40 例. 上海针灸杂志, 2005, 24 (12): 27

【腕管综合征】

腕管综合征又称正中神经挤压征、腕管狭窄性腱鞘炎。腕管为一骨性纤维管，其内有正中神经和数条肌腱通过。腕管综合征是由于各种外伤、劳损等导致骨性管道狭窄和软组织慢性炎症性改变，使韧带增厚、肌腱增粗、神经水肿，从而使正中神经受到挤压而引起运动、感觉和植物神经功能紊乱等一系列症候群。

本病多见于中年妇女，主要症状为桡侧3个半手指感觉过敏、刺痛或烧灼样疼痛，夜晚或清晨较明显。劳动后，温度增高时症状加重，疼痛可放射至肘，在冬季患指可有发冷、紫绀等。有时拇指外展、对掌无力，握力减弱，动作不灵活，握物端物时，偶然有突然失手的情况。病程较长且有运动障碍的患者可见大鱼际肌萎缩变平或凹陷。

该病诱因尚不清楚，腕部的创伤，如骨折、脱位、扭伤劳损等，以及腕管内腱鞘囊肿、脂肪瘤、屈拇肌或蚓状肌肌腱过长、类风湿性关节炎、肌腱滑膜炎等常能造成腕管内的容积减少、压力增高，而压迫正中神经。部分患者无外伤史，可为慢性劳损等因素所引起。中年妇女的停经期、妊娠期及哺乳期发病较多，可能与内分泌的改变有关。

本篇收录了9位针灸医家的临床治验，大

多以局部取穴为主，从治疗方法来看：有的以针刺为主，有的采用小铍针治疗，有的采用穴位埋针，有的采用针刺配合穴位注射，有的采用针推并用，均取得了较理想疗效。

一、局部取穴 随症加减

李岩在临床上采用针刺法治疗腕管综合征，收到满意疗效。

取穴：主穴：患侧大陵、阳池、阳谷、经渠、外关透内关。手指发麻加曲池、合谷；手背红肿加中渚、液门；夜寐不安加神门、三阴交；大鱼际萎缩加鱼际。

操作：选用30号2寸毫针，针刺部位常规消毒，快速进针，进针0.5~1.5寸（根据穴位而定），提插捻转至有酸麻胀感，留针30min，每天1次，10次为1个疗程。

本病属于中医学筋痹范畴，多因感受风寒或因劳损及外伤损伤血络，瘀血内停，脉络受阻，气血运行不畅所致，久之气血汇聚，出现红肿痛，压迫神经，引起局部酸痛麻木。大陵、阳池、阳谷、经渠、外关透内关均在腕管周围，局部取穴，能疏通局部经脉，主治腕痛；曲池、合谷有疏散风寒，通经活络之功；中渚、液门有消肿定痛，活血通络之功效；神门、三阴交宁心安神；鱼际通经行气，活血生肌。诸穴合用，共奏通经活络，行气消肿，疏风散寒之功效。

徐某某，女，43岁，1999年4月12日来诊。主诉：右腕关节疼痛半年，加重伴肿胀1周。查：右腕关节周围肿胀压痛，活动受限，伸、屈腕时疼痛加重，患手握拳无力，拇、食指时有麻木。用上法治疗3次，即初见疗效，肿痛及伸、屈腕时疼痛减轻；治疗10次后，肿痛基本消失，握拳有力，手指无麻木；休息5天后，续针刺7次，腕关节肿痛消失，活动自如。随访至今未复发。

二、腕三针 - 内关 - 间使 气至有效

杨振辉采用针刺治疗腕管综合征，取得了良好疗效。

取穴：腕三针、内关、间使。

操作：患者取坐位，患侧屈肘伸腕伸指，掌面向上置于桌面上，腕三针皆沿腕横韧带、腕掌韧带向下平刺，第1针取在桡侧腕屈肌腱外侧，第2针取在腕横纹正中避开肌腱、血管、神经，第3针取

在指浅屈肌腱内侧，针感向肘臂放射。内关、间使两穴针感向肘臂及指端放射。间隔 10min 行针 1 次，留针 40min。配合 TDP 局部照射，每天 1 次，10 次为 1 个疗程。

腕管综合征病理改变的基础是正中神经暂时或永久的压迫性缺血。开始表现为神经的水肿及充血，腕横韧带近侧神经假性神经瘤，其远侧有萎缩变性，久之，因缺血致神经内纤维化，髓鞘消失。针刺通过改善局部供血，从而有效地降低腕管内压，解除正中神经压迫，减轻神经水肿，改善其营养，促进其功能的恢复。

王某某，女，52 岁，钢琴教师。2000 年 10 月就诊。病程近 2 年，起病缓慢，初始仅有右手拇指、食指的感觉异常，渐渐发展至刺痛向前臂放散，晨起患手肿胀及活动笨拙，无法正常练琴。患病后辗转就医多处，因不愿行腕管松解术转来针灸科治疗。针取腕三针、内关、间使，配合 TDP 局部照射，每天 1 次。治疗 3 次后，病情明显减轻；1 个疗程后，仅存拇指、食指的麻木感；休息 10 天后，继续 1 个疗程的治疗，麻木感完全消失，可以正常练琴。

三、据解剖取穴 平刺单向捻转

彭江华在临床上采用平刺单向捻转针灸法治疗腕管综合征，取得满意疗效。

取穴：让患者用力握拳向掌侧屈腕，在腕部掌侧可有三条纵行皮下的隆起，中间者为掌长肌腱，桡侧的为桡侧腕屈肌腱，尺侧的为尺侧腕屈肌腱。在下端腕横纹尺侧腕屈肌腱的内侧缘选一进针点 A_1 ，沿尺侧腕屈肌的内侧缘向远端移动 2cm 左右再定一进针点 A_2 ；在下端腕横纹上的桡侧腕屈肌腱的内侧缘定进针点 B_1 ，再沿桡侧腕屈肌腱向远端移动 2cm 左右定一进针点 B_2 。

操作：在上述 4 点处，选用 28 号 1 寸针灸针，针体与腕平面成 90° 角进针，深度不超过 0.2 寸，然后调转针尖方向，与腕面成 15° 角； A_1 、 B_1 两针点针尖向腕屈肌的远端（指尖方向）平刺约 0.8cm， A_2 、 B_2 两针点针尖对着腕横纹方向平刺约 0.8cm。

医者左右手分别持 A_1 、 A_2 针柄，对着桡侧腕屈肌方向，右手顺时针单向捻转 A_2 针柄，左手逆时针单向捻转 A_1 针柄；快速转动数圈，直至针体有涩滞感为止，然后用小块胶布条缠绕针柄一圈，并

粘贴在掌面，防止针体回转（或让助手固定 A_1 、 A_2 针柄）；接着，医者左右手分别持 B_2 、 B_1 针柄，对着尺侧腕屈肌方向，右手顺时针单向捻转 B_1 针柄，左手逆时针单向捻转 B_2 针柄，快速转动数圈，针体有涩滞感为止，并用胶布条固定在掌面（或由医生双手持针柄固定针体，以防针体回转），留针 20min，针后用温和灸，每穴灸 3min，皮肤微红即可，每日针 1 次，10 次为 1 个疗程。如未愈，续进行第二疗程。

腕管综合征是由于腕部劳损引起腕管狭窄，压迫正中神经而引起手指麻木为主症的一系列顽固性的临床症状。治疗本病的关键在于增大腕管容积，消除腕横韧带对正中神经的压迫和腕横韧带与肌腱的粘连。用平刺单向捻转针灸法治疗本病，主要目的是将针体刺入腕横韧带与腕骨连接处，通过单向捻转，尽量将腕横韧带放松、拉长，增加弹性，使腕管容积增大，解除对正中神经的压迫。腕横韧带厚约 0.1cm，宽约 2cm，4 个进针点分别位于韧带 4 个角，用较粗的 28 号毫针平刺进针，使针体与韧带根部处于同一水平位置，单向捻转可将韧带根部与针体缠绕在一起，通过持续加大幅度单向捻转和固定，可达到将韧带拉长放松的目的。针刺结合艾灸能改善局部血液循环，有助于放松韧带，治疗肌腱滑膜和神经的慢性损伤，使腕管内环境“宽松”，正中神经不受挤压，从而治愈本病。

四、小钹针 以松为主

邵志刚采用小钹针治疗腕部正中神经卡压症（腕管综合征），疗效满意。

器械：仿中医“九针”中的钹针，用 0.1 寸的克氏针稍加磨制，仅保留尖端部分的单边斜刃，刃与针身呈约 45° 角，刃长约 0.1 寸。

操作：①进针点：位于掌长肌腱尺侧缘和远侧腕横纹的交点与环指近端尺侧缘的连线上，距远侧腕横纹 1~1.5cm 处。②麻醉：用 1% 盐酸利多卡因 4ml，兑入 0.05mg 肾上腺素局部麻醉。麻醉层次限于屈肌支持带以浅。注药后往往可诱发出原有神经卡压症状。若局麻药误入腕管内，则原有的麻痛消失而出现正中神经麻醉，应中止治疗。体会组织层次的方法是在针头刺入过程中时时横摆针尖，若

刺入韧带，因阻力增大，针尖摆动会受到限制。③切割：用小铍针从进针点垂直刺入皮下，缓慢进针，并在进针过程中时时横向摆动针尖，体会针尖位置，达腕横韧带时，针尖可沿韧带表面较大幅度摆动，刺入韧带则阻力明显增大。刺破腕横韧带，沿肢体长轴向远近两端抗阻力切割，注意无阻力勿切割。以进针点为中心，针尖纵向摆动式切割长度约3cm，至出现落空感，寻找不到阻挡切割的韧带，即达到切割要求。出针后可向腕管内注入泼尼松龙或曲安奈德1ml。术毕，针眼敷盖消毒敷料或创可贴3天。部分病人在切开韧带时原有症状减轻或消失，继而在手术将结束时缓慢出现正中神经和尺神经的暂时麻醉，前者示卡压解除，后者为麻醉药扩散所致。

中医“九针”中的铍针两边有刃，便于切开浅表痈脓，未见用于深部组织切割的论述。小铍针是去掉铍针针身两边长刃，并改剑头部两边有刃为单边斜刃，靠其背面和两侧的钝性部分，能够在深层组织回旋摆动，清晰感觉所在的组织层次，从而将小铍针集探针和手术刀于一身，可将刀刃准确送达深部组织，有效松解被卡压的正中神经，适合于腕管综合征盲视下切割松解，解决了该病的微创手术难题。

李某，女，55岁，农民。就诊日期：2002年1月24日。主诉：左侧手指麻痛时作1年余。曾辗转多家医院，先后按脑血栓、高脂血症等治疗无效。4个月前按腕管综合征封闭治疗3次，症状缓解，后因田间劳动复发。2个月来麻痛持续，夜间加重，常可痛醒。检查：左手掌面桡侧3个半手指皮肤感觉减退，运动正常；用力指压腕管部，原有麻痛加重，止血带试验(+)，Phalen征(+)；颈椎间孔挤压征(-)，臂丛牵拉征(-)，血压126/78mmHg。诊断：左侧慢性腕管综合征。治疗：用小铍针治疗，操作如上述。切割过程历时约2min，术中患者先出现原有症状明显减轻，继而出现正中神经麻醉，约1h后麻醉消失，刀口微痛，当日夜间未再出现手部不适。6个月随访未见复发，皮肤感觉正常。

五、独取大陵 穴位埋针

腕管综合征是由于正中神经在腕管中受压，而引起以手指麻痛乏力为主的症候群。刘英单纯采用穴位埋针疗法治疗，取得满意

效果。

取穴：患侧大陵。

操作：常规消毒后，用镊子把消过毒的 28 号皮内针取出，取准穴位直接刺入，得气后用胶布固定。夏季留针 1~3 天，冬季留针 3~5 天。告患者不要沾水，注意局部卫生，留针期间不必限制患肢的活动，使患肢在活动中而加强针感。

腕管综合征属中医痹证范畴，多由于寒湿伤筋、跌打劳损、血瘀经络以致气血受阻而发病。大陵穴位于腕部屈面正中，于掌长肌腱与桡侧腕屈肌腱之间，深层为正中神经主干。大陵穴埋针可通过神经末梢的传导至指端，起到疏通经络，行气活血，改善手指神经末梢循环，从而达到治疗目的。

曹某某，男，38 岁，右侧手指麻木，活动受限，骑车不能握把，按压腕部屈面正中时可引起放射性触电感，手指麻木等症状。颈椎 X 片无异常。经大陵穴位埋针 1 次，留针 3 天，自觉症状完全消失，病获痊愈，随访无复发。

六、针药并用 通则不痛

胡乃武采用针药并用治疗腕管综合征，疗效显著。

针刺：普通毫针针刺患侧阳池、内关、合谷三穴，捻转结合提插，平补平泻，得气后留针 15min，其间行针 1~2 次，每天 1 次。

中药外洗：桂枝、白芍、透骨草、红花、威灵仙各 15g，当归、制川乌、细辛各 10g，生地黄 60g，加水 2500ml 浸泡 30min 后微火煎 1h，连滓共置于广口容器中，加入白酒 100ml、米醋 100ml，熏蒸腕掌部，至药汁稍凉始反复浇洗患侧手部及前臂，每次 30~40min，每天 2 次。针药并用 20 天为 1 个疗程。

腕管综合征以指端疼痛、手部感觉异常为主，病位固定，与中医学中的痹证较为相符。中医认为“不通则痛”“不荣则痛”“气虚血少成麻木”。胡乃武认为腕管综合征早期以不通为主，局部经脉不通，气血运行受阻而失养，故出现麻木、疼痛。随着病情发展，局部肌肤失养肌肉萎缩，功能受损，则不通与不荣同时存在，治宜通经与养血并重。针刺患侧阳池、内关、合谷等经穴，可以引动阳气，使经脉通畅。以养血、温经通络之药外洗，可以促进局部气血的推

动与濡养功能。外洗方中 60g 生地黄为主药，配以制川乌，取法于姜春华的地乌蠲痹汤。生地黄甘寒，有滋阴润络、凉血清营、补益肝肾之功，能逐血痹、除寒热积聚除痹；川乌能治诸气、破聚滞气，其性辛热，与生地黄相配共奏蠲痹止痛之效而无辛温伤阴血之弊。桂枝、白芍调和营卫；首乌、当归、红花养血活血；细辛温经；威灵仙走十二经而通络止痛；透骨草善舒筋活络而引诸药直中病所。全方润燥相伍，气血兼顾，无伤正之虞而增通养共施之效，且局部用药，切中要害，重点突出。

七、大陵 - 内关 隔姜灸

腕管综合征是神经受压综合征中最常见的一种，杨永晖采用隔姜灸法治疗该病，效果极为满意。

操作：取新鲜生姜 1 块，切成厚约 0.3cm 的薄片，在中心处用细针穿刺数孔，上置艾炷放在患侧大陵、内关 2 穴上施灸，如病人在施灸过程中局部有热痛感，可将姜片连同艾炷向上略略提起，稍停放下再灸。艾炷燃尽，再另换 1 炷，以灸至局部皮肤潮红湿润为度。每次每穴施灸 6 壮，每天 1 次，5 次为 1 个疗程，间隔 3 天再行第 2 疗程。

腕管综合征是指正中神经在腕管内受到压迫引起手部正中神经支配区的疼痛、麻木及进行性的大鱼际萎缩，属于中医学痹证之范畴。乃因各种原因引起之急、慢性损伤，导致经络气血运行不畅，气血瘀滞，又因复感寒湿之邪，合而成痹。隔姜灸大陵、内关 2 穴，则起温经散寒、除湿通络、活血祛瘀之功效，起到“通则不痛，痛则不通”之治疗目的。

李某，女，47 岁，工人，1996 年 10 月 7 日初诊。主诉：左手指麻木、刺痛 2 月余，入夜受凉或劳累后加重。检左腕关节无肿胀畸形，左桡侧 3 个半手指痛觉减退，拇指外展肌力稍弱，大鱼际未见明显萎缩，屈腕试验及 Tinel 征均阳性，颈椎 X 线检查正常。诊断：左腕管综合征。取左侧大陵、内关 2 穴，采用隔姜灸法，每次 6 壮，3 次后诸症全消。随访 2 年，未见复发。

八、水针配推拿 活血化痰

李霞在门诊治疗中,采用水针结合推拿的方法治疗腕管综合征,效果较好。

水针:嘱患者取舒适坐位,患侧曲肘平放,常规消毒后,用6号注射针头由掌纹处刺入,刺入方向与腕平面呈 60° 角,穿刺腕横韧带如有突破感,则进入腕管内,待回抽无血后,注入醋酸泼尼松龙1ml、2%普鲁卡因1ml、维生素 B_{12} 注射液2ml的混合液,每5日注射1次,3~5次为1个疗程。

推拿:水针治疗后,医者用拇指点按内关、大陵、鱼际等穴,用一指禅推法在前臂至手沿手厥阴心包经往复治疗,重点治疗腕管及大鱼际处,手法先轻后重,再用摇法揉腕关节及指关节,最后用擦法擦腕关节。

中医学将腕管综合征归属痹证,由于急性损伤或慢性劳损致气血流通受阻而引起。治疗时利用手法的机械作用使局部毛细血管扩张,加速血液运行,从而使瘀血消除,组织更快的修复,进而达到舒筋通络,活血化瘀的作用;采用水针疗法能将药物直接作用于局部,具有抗炎和改善局部神经营养代谢,增强局部血液循环。

陈某某,女,31岁,1997年4月16日就诊。自诉其右侧腕部麻木、刺痛近1个月,夜间痛甚。查体:患者右手拇指外展受限,以手压迫腕管掌侧2min后麻木感加重,放松外力压迫后症状即缓解。X光片显示:颈椎无异常改变。诊断为腕管综合征,采用上述方法治疗后,3次即痊愈。

九、针推并用 舒筋通络

彭德忠采用针灸推拿治疗腕管综合征,取得了良好的疗效。

(1) 针灸治疗

取穴:大陵、内关、间使、鱼际、合谷、曲泽。

操作:患者取坐位,患侧屈肘伸腕伸指掌面向上置于治疗桌或床上。选用30号1.5寸长华佗牌一次性无菌针灸针。所选穴位的皮肤常规消毒。先针刺鱼际、合谷、曲泽,以局部出现酸胀为度;然后针刺大陵、内关、间使,要求针感向肘臂或指端放射。间隔15min

行针1次，留针30min。配合TDP局部照射。

(2) 推拿治疗

取穴：大陵、劳宫、合谷、鱼际、内关、间使、曲泽。

手法：按法、揉法、一指禅推法、摇法、拔伸法、捻法、擦法。

操作：患者取坐位，将患手伸出，掌心向上置于治疗桌上且放松。医者先用拇指点按患者大陵、合谷、劳宫、鱼际、内关等穴，以局部出现酸胀为度，每穴30s；再用一指禅推法在前臂至手沿心包经往返治疗3min，重点在大陵及鱼际穴治疗，用小鱼际施法在患者鱼际、手指掌侧及前臂至肘处，往返治疗3min，手法应先轻后重；掌揉前臂及掌指部2min；用捻法在拇指、食指、中指操作2min；拔伸腕关节1min，力量逐渐增加；在拔伸的基础上摇患侧腕关节（掌屈、背伸、外展、内收及环旋各10次）；最后用擦法擦腕掌指部，以局部发热为度。全部按摩完成共15~20min。

以上方法，一般是先推拿治疗后针灸治疗，每周2~3次，10次为1个疗程。

腕管综合征是指正中神经在腕管内受到刺激或压迫所引起的手指感觉异常及麻木、刺痛等神经症状。其病理改变是正中神经暂时或长期的压迫性缺血。主要是因为急性损伤和慢性劳损，致使指屈浅、深肌腱发生非特异性慢性炎性变化。由于肌腱腱鞘的肿胀、膨大，可致腕管相对的变窄，从而导致正中神经在腕管内受到挤压而发生神经压迫症状。通过针灸推拿治疗，可以舒筋通络，活血化瘀，温经散寒，改善局部血供，消除局部炎性反应，从而有效地降低腕管的内压，解除正中神经压迫，改善神经的营养，促进神经功能的恢复，消除神经症状。

患者，女，34岁，办公室秘书，2004年5月10日就诊。病史：2003年11月中旬无任何原因出现右手拇指、食指的感觉异常，一周后出现拇指、食指、中指麻木、刺痛，有时向前臂放射，晨起感手指肿胀及活动笨拙，不能正常工作。经X线摄片检查颈椎及腕关节均无异常改变。西医诊断为腕管综合征，经局部封闭治疗2次，症状明显缓解。3个月前，因使用计算机过度再次出现上述症状，西医要求患者行腕管松解术，患者未同意，经西医推荐转求中医治疗。按上述方法治疗，5次后症状明显减轻；1个疗程后，仅存食指指端

感觉异常。休息1周后，继续治疗5次，所有症状完全消失，患者工作正常。半年后，患者主动电话告之症状未复发。

参 考 文 献

- [1] 李岩. 针刺治疗腕管综合征36例. 中医外治杂志, 2006, 15 (4): 48
- [2] 杨振辉, 司健, 张悦. 针刺治疗腕管综合征12例. 中国针灸, 2004, 24 (6): 407
- [3] 彭江华. 平刺单向捻转针灸法治疗腕管综合征48例. 中国针灸, 2002, 22 (8): 550
- [4] 邵志刚. 小钹针治疗腕部正中神经卡压症31例. 中国针灸, 2004, 24 (1): 73~74
- [5] 刘英, 汤开鉴. 穴位埋针治疗腕管综合征8例. 针灸临床杂志, 1999, 15 (10): 36
- [6] 胡乃武, 刘久英, 王凤敏. 针药并用治疗腕管综合征的临床观察. 中医药学报, 2000, (3): 57~58
- [7] 杨永晖. 隔姜灸治疗腕管综合征32例. 安徽中医临床杂志, 1999, 11 (4): 258
- [8] 李霞, 何平. 水针配合推拿治疗腕管综合征48例. 针灸临床杂志, 1999, 15 (1): 37~38
- [9] 彭德忠, 张先庚. 针灸推拿治疗腕管综合征32例. 四川中医, 2006, 24 (4): 107

【腱鞘囊肿】

腱鞘囊肿是筋膜部位发生的囊性肿物，以腕关节多见，也可发生于手掌指关节和足趾的背面、腘窝等处。属于中医的“筋瘤”、“筋结”等范畴。多见于青壮年女性。病因尚不完全明了，但与外伤、劳损有关。若腱鞘、关节囊受损，引起局部炎性肿胀，腱鞘和关节囊积液、变薄、扩张而逐渐形成囊肿。

中医学认为，本病多由劳作伤筋、经气阻滞、血行不畅、瘀血内停或遭受外伤，经脉受损，气血凝滞而逐渐形成。

本篇收录了7位针灸医家的临床治验，有的采用火针速刺；有的采用局部取穴恢刺；有的齐刺配温针灸；有的采用三棱针点刺；有的采用围针刺加灸；有的循经取穴，配药物外敷等。

针灸治疗本病有良效，可作为首选之法。操作时要注意局部严密消毒，防止感染。挤出囊液后最好在局部置一硬币，然后加压包扎2~3天。如囊肿复发，再予针治，依然有效。治疗期间和治愈之后1个月内应注意局部保暖，避免寒湿的侵入。

一、火针速刺 软坚散结

曹伟民应用火针配合按揉法治疗腱鞘囊肿，

取得显著效果。

操作：患者取适当体位，将囊肿部位皮肤行常规消毒，医者以左手拇指、食指固定囊肿，将内物推至一边，避开血管及肌腱，使囊肿突起，右手持火针在酒精灯上烧红，沿囊肿边缘分别向囊肿中心部迅速刺入4~5针。针要速刺速出。病程1年以上者要留针2~5min。出针后术者再以双手拇指重叠于患者囊肿之上，紧握按压，挤出胶状黏液，即觉囊肿由硬变软之感，局部应显平复。再行患部按揉手法5~10min，按压排尽黏液，用酒精棉球压迫，加压包扎。针后3天内不要沾水，注意局部卫生。1周后再复诊1次，如患处仍有微肿、黏液未排尽或囊肿吸收不好，按上法再重复治疗1次。一般1~3次即临床痊愈。

囊肿形成急慢性不等，但多无症状，偶尔局部酸痛，外形光滑，触之较硬，无压痛，多与皮肤无粘连。多因扭、挫等伤及筋脉，或经久站立，或由于寒湿刺激阻滞经脉，气血运行失畅，筋膜肌腱失其濡养，导致关节囊或腱鞘发生黏液性或胶状变性液渗出而成。用火针刺破囊壁，将囊内胶状黏液挤出，可起到软坚散结的作用，并可加快局部血循环，促进胶状黏液渗出后被周围组织吸收，同时针后按摩亦可助囊液的渗出吸收，肿物逐渐消失。治疗时尤应注意针刺深度，应深达囊肿基底部，以确使囊壁破坏，避免复发。

夏某某，女，41岁，农民。于1990年10月25日初诊。主诉：左足背生包块两年。2年前患者发现左足背一肿块，逐渐长大，行走时感轻微疼痛，5个月前经手术治疗，但术后两月又复发。检查：见左足背有1.5cm×2cm大小包块，按之波动，触之有明显饱胀感。给予火针治疗，配合局部按揉挤尽黏液后，加压包扎。4天后复诊，又给予火针治疗，半月后痊愈。随访3年未复发。

二、局部取穴 恢刺

腱鞘囊肿多发于腕关节、足背、腘窝等处，中医学有筋聚、筋结之称。俞国瑛运用恢刺法治疗该病，临床上取得良好效果。

取穴：取囊肿顶部中点。

操作：先用毛巾热敷囊肿皮肤5min，常规消毒后用28号1.5寸毫针，对准囊肿顶部直刺。针尖刺破囊壁达囊中，呈45°及75°角分

别向四周来回点刺，针刺深度以刺破四周囊壁为度。起针后医者用右手大拇指指腹压在囊肿中央，左手大拇指按在右手大拇指上，两手用力向下按压推动，使囊壁破裂，黏液流散。隔日治疗1次，5次为1个疗程。

李某，男，36岁，1989年4月1日初诊。诉右腕关节扭伤后发现肿块3个月。伴关节酸痛，提物无力。查右腕关节背部有一蚕豆大小肿块，推之移动，诊断为右腕关节腱鞘囊肿。按上法治疗1次后，肿块明显缩小，治疗3次后，症状全部消除。3个月后随访，未见复发。

三、齐刺温针灸 祛瘀散结

张治国采用齐刺法加温针灸治疗腱鞘囊肿，取得满意疗效。

针刺：取囊肿中央部位皮肤为第一针刺点，再分别于囊肿周围选取另两个针刺点，要求三点在一条直线上。将针刺点皮肤常规消毒，选取29号2寸针，先于第1针刺点垂直皮肤刺入，再于另两个针刺点向囊肿中央刺入。3针均以患者有酸胀感为度。

温针灸：在以上所刺中央针柄上端套置一段约2cm长的艾条。于艾条下点燃施灸，艾条燃尽为止。为预防艾条脱落烫伤患者皮肤，需在针刺部位置一张剪好缝的纸板。

以上治疗每天1次，每次留针30min，留针期间不捻针。5次为1个疗程。

《灵枢·官针》记载：“齐刺者，直入一，旁入二，以治寒气小深者，或曰三刺，三刺者，治痹气小深者也”。腱鞘囊肿病变部位在关节腔或腱鞘附近，属气血郁结或寒湿阻滞，气血瘀滞，久之结而成节。张治国采用此法针刺，针可直达病所，能达到祛瘀散结的目的。《素问·调经论》里说：“血气者，喜温而恶寒，寒则泣而不流，温则消而去之。”施温针灸，温经行气活血，使气血运行通畅则节可消。本法治疗腱鞘囊肿简便易行，患者易接受，疗效满意。

四、三棱针点刺 简单效佳

陈剑波采用三棱针点刺治疗腱鞘囊肿，治愈率高。

操作：取囊肿顶部中点，常规消毒，左手拇指、食指夹住囊肿，使之突起固定，右手持三棱针，对准囊肿中心直刺，速进速出，起

针后，术者两手迅速挤压囊肿四周，向针孔方向推动，挤出囊肿中的浅白色黏液，挤净压平，然后用碘酒棉球压住针孔，剪一块如囊肿大小的硬纸片，越硬越好，用消毒纱布包好，紧贴压于患处，再用绷带包扎4~5层，紧紧裹住患处，3天后即可痊愈。

《灵枢·官针》：“病在经络痼痹者，取以锋针。”锋针，即现代之三棱针。三棱针刺法具有祛瘀活血，疏经通络之功效。陈剑波根据“实者泻之”之原则，用三棱针刺法结合硬纸片加压，使囊壁破裂，挤净囊液，硬纸片压迫囊肿，使囊壁重叠愈合，囊液不易再生，囊肿不再复发。

肖某某，男，28岁，1992年9月15日初诊。4个月前发现右腕关节背面如黄豆大小的肿块，开始并不介意，后肿块增大，伴关节酸痛，功能活动受限。曾经外科诊治，诊断为腱鞘囊肿，患者拒绝手术，经人介绍转来针灸科。查右腕关节背面有一话梅大小肿块，患处肤色如常，表面光滑，边缘整齐，推之滑动，并有轻微酸胀感。用上法治疗1次痊愈。

五、局部取穴 围针刺加灸

张京峰采用围针刺加灸法治疗腱鞘囊肿，取得较好疗效。

操作：将患者关节置于囊顶向上部位，由中心向四周对囊肿进行常规消毒，视肿块大小取1~1.5寸毫针沿囊肿边缘等距离斜刺4针，使针尖透至囊肿对侧边缘，针身在肿块内呈“十”字样，中央囊顶处直刺1针，深达囊肿基底部，间歇行针，留针30min，取艾条1支，在留针同时于囊肿处作回旋灸，至局部皮肤潮红为度，起针后用手指压迫，挤出肿块内液体，使之渗于皮肉之间，每天1次，10次为1个疗程。

腱鞘囊肿是筋膜部位发生的囊性肿物，以腕关节多见，也可发于手掌指关节，足趾背面等处，中医属筋瘤、筋结范畴，由长期劳动致关节或肌腱损伤，气滞血瘀于局部而成。采用围针透刺可疏通气血、祛瘀散结，加艾灸局部可软化凝结之黏液，加强活血消肿之功，故使囊肿迅速吸收消散。

刘某，女，14岁，学生，于1997年5月21日就诊。主诉：右手腕背部有1个包块，3个月，开始如蚕豆大，逐渐增大如桃核，局

部隐痛，曾按摩、封闭、外敷膏药均未收效。查：右手腕背面桡骨端处有 $3\text{cm} \times 0.6\text{cm} \times 1.6\text{cm}$ 肿块，质较硬，活动度较小，轻度压痛，舌淡苔薄白，脉细缓，诊断为腱鞘囊肿。予上述疗法治疗 3 次后肿块明显变小变软，经治 1 个疗程，肿块消失，腕部活动功能恢复正常，随访半年无复发。

六、循经取穴 药物外敷

胡伟勇采用循经针刺配合外敷治疗腱鞘囊肿，疗效颇佳。

取穴：囊肿位于手阳明大肠经上的取偏历、合谷；在手少阳三焦经上的取外关、中渚；手太阳小肠经上的取后溪、支正；在足太阳膀胱经上的取委中、承山；足少阳胆经上的取阳陵泉、侠溪；在足阳明胃经上的取三里、内庭。

操作：穴位局部常规消毒后，取 1~1.5 寸毫针直刺，行提插捻转手法，使局部产生酸胀感后，加电针留针 30min，10 次为 1 个疗程。

药物外敷：用 $5\text{cm} \times 7\text{cm}$ 伤湿止痛膏 1 张，膏药中间均匀撒一层樟脑粉末，再敷于囊肿的患处，每天更换 1 次。

根据“经脉所过，主治所及”的原理，取囊肿所在经脉上的穴位进行治疗，具有疏通本经经脉，行气活血，消肿散结的作用，故采用循经取穴针刺治疗腱鞘囊肿。《本草纲目》记载，樟脑能“通关窍，利滞气，治中恶邪气”。具有行气活血，散肿止痛之功，伤湿止痛膏具有祛风除湿，活血化瘀的功效，两药相合能起到相辅相成的作用。

患者，男，43 岁，教师，2001 年 10 月 20 日诊，患者述去年开始出现右手背腕关节处有 1 个蚕豆大小囊肿，并逐渐增大如桃核，局部隐隐胀痛不适，提物无力，影响了手腕的活动功能，给教学工作带来极大的不便。查：右手腕背一核桃大小囊肿，表面皮色正常，质中，活动度尚可。诊断：右腕关节腱鞘囊肿，遂给予上法施治，次日便见囊肿明显缩小，局部疼痛不适感减轻，依上法继续针刺加敷贴，1 个疗程后症状悉除，3 个月后随访未见复发。

七、局部取穴 围刺挑刺

卢劲松采用针刺治疗腱鞘囊肿，取得满意的效果。

操作：对局部按常规消毒，取 28 号毫针 5 支，在囊肿的中心部位垂直刺入 1 针，然后在四周以 45° 向其基底部针刺 4 针，以酸胀为度，每隔 5min 行针 1 次，出针时摇大其针孔，针毕以左手固定囊肿，采用三棱针穿透囊肿，速刺疾出，挤出大量胶冻黏液，在局部施以按揉手法 5min，然后加压包扎 24h，隔日治疗 1 次，5 次为 1 个疗程。

腱鞘囊肿多因外伤、劳损导致经络受阻，气血运行不畅，久而久之，气血凝集形成肿块，出现压迫软组织的酸痛麻木等症状。围刺及手法按揉具有舒经通络之功，三棱针点刺以祛瘀散结；加压包扎，可使囊壁闭缩，囊肿消退。从而达到瘀去而新血生，经脉通畅，活动自如而痛止的目的。

黄某某，女，38 岁，1998 年 8 月 6 日就诊。主诉：右腕背肿块 1 年，局部酸麻。查体：右腕背横纹中央见 1 个直径约 1.2cm 的隆起肿块，触诊质地柔韧，固定不动、表面光滑无结节，压之酸痛，手腕屈伸活动即疼痛。曾局部抽液后注入类固醇药物，疗效欠佳。诊断为腱鞘囊肿。经上述方法治疗 2 次，局部酸麻感消失，肿块完全消失，腕关节活动自如，随访 1 年未见复发。

参 考 文 献

- [1] 曹伟民. 火针配合按揉法治疗腱鞘囊肿 78 例报告. 光明中医杂志, 1995, (1): 21~22
- [2] 俞国瑛. 恢刺法治疗腱鞘囊肿 46 例. 中国针灸, 1996, (10): 40
- [3] 张治国. 齐刺法加温针灸治疗腱鞘囊肿 35 例. 针灸临床杂志, 2005, 21 (7): 31
- [4] 陈剑波, 温成昶. 三棱针治疗腱鞘囊肿 67 例小结. 江西中医药, 1997, 28 (5): 33
- [5] 张京峰. 围针刺加灸治疗腱鞘囊肿 78 例. 中医外治杂志, 1999, 8 (5): 25
- [6] 胡伟勇, 邹定华. 循经针刺配合外敷治疗腱鞘囊肿 45 例. 江西中医药, 2005, 36 (6): 57
- [7] 卢劲松, 张小丽. 针刺治疗腱鞘囊肿 32 例. 针灸临床杂志, 2000, 16 (10): 6

【急性腰扭伤】

急性腰扭伤，为腰部的肌肉、韧带、筋膜等软组织在活动时因用力不当而突然损伤，可伴有椎间小关节的错位及其关节囊嵌顿，致使腰部疼痛并活动受限。本病中医称之为“闪腰岔气”，多发于青壮年体力劳动者，临床上多见于搬运、建筑工人或长期从事弯腰工作、平时缺乏体育锻炼的人。损伤多发生于腰骶、骶髂关节或椎间关节两侧骶棘肌等部位。主要因外部暴力，以致筋脉损伤，瘀血郁滞，气机不通而痛。

本病多有外伤史，受伤时部分患者可感到腰部有“咔咔”响声，伤后立即出现一侧或两侧剧痛。腰痛不能挺直、俯仰屈伸，严重者转侧起坐甚至翻身时均感腰部疼痛异常。疼痛为持续性，活动时加重，休息后也不缓解，咳嗽、喷嚏、大声说话或腹部用力等均可使疼痛加重。患者站立时腰部僵硬，病人常以两手撑腰，行走时多挺直腰部、步态缓慢，卧位时常以手撑腰才能翻身转动。绝大多数患者有明显的局限性压痛点，且由于疼痛可致不同程度的功能受限。本病多无下肢痛，但有可能出现反射性坐骨神经区痛。直腿抬高试验可为阳性。

本篇共收录了 22 位针灸医家的临床治验。有的采用循经远取，互动式针刺进行治疗；有

的独取大肠俞，强刺激；有的采用针刺加刺络拔罐；有的取夹脊穴，长针深刺；有的采用长针深刺命门穴；有的取上髂穴，多发针而深之；有的采用鼻针疗法；有的独取膻中，粗长针针刺；有的采用排针透刺等。

针灸对本病治疗效果较理想，但应注意局部保暖，疼痛缓解后，可加强腰部的功能锻炼，如旋转、屈伸及腰背肌锻炼，应绝对卧硬板床休息，表浅伤筋可腰部垫枕，使腰椎呈过伸体位；深部伤筋以屈膝屈腰体位为好，以减轻疼痛，缓解腰肌痉挛，防止继续扭伤。

一、循经远取 互动式针刺

急性腰扭伤为临床常见病，治疗方法很多，高阳治疗中注重调动患者自身调节阴阳的能力，采用互动式针刺法治疗急性腰扭伤，取得较好疗效。

取穴：外关、悬钟、人中，其中躯体前倾功能受限者取外关，躯体后仰功能受限者取悬钟，以脊中痛为主者取人中。

操作：（1）一侧腰痛为主，躯体前倾功能受限者，取坐位，针刺同侧外关，得气后取捻转泻法 3min。指导患者站位做前倾动作 5min，前倾角度以可耐受为度，前倾频率视病情而定，尽量多活动。行针次数视病情轻重及病情改善情况而定，尽量多行针。如患者活动时疼痛加重，随时增加行针次数。

（2）一侧腰痛为主，躯体后仰功能受限者，患者取站位，针刺同侧悬钟，除做后仰动作外，其他同上。

（3）以脊中痛为主者，患者取站位，针刺人中，行雀啄法 1min 后，嘱患者躯体做前倾、后仰、侧弯等动作，其他同上。

指导患者活动，应由弱渐强，并随时观察患者反应，以防止晕针。针刺外关、悬钟，活动时注意保持针刺肢体的位置基本不变，以防止滞针、弯针。

本病取互动式针刺法治疗，意在调动患者自身治疗疾病的能力。本病为阳经循行部位阴阳失调，导致阳急阴缓，故取阳经穴位治疗。急性腰扭伤多因体位变化或腰部用力不当和外力的作用使一侧腰肌痉挛疼痛为主，导致腰部功能障碍，活动受限。针刺使患处痛阈升高，疼痛减轻，腰部活动范围增大。

二、独取大肠俞 强刺激

叶险峰运用针刺大肠俞治疗急性腰扭伤，收到良好的效果。

取穴：大肠俞。

操作：患者仰卧位。一侧腰（或腿）痛者，取患侧大肠俞，双侧痛取双侧穴位。穴位皮肤常规消毒后，以2.5~3寸毫针，针尖向脊柱方向直刺。进针得气后大幅度捻转、提插强刺激，使患侧有放射至足的触电感和肌肉跳动即可起针。病重者可留针约10min后如上法给予强刺激。每天1次，一般1次即愈。

针刺大肠俞治疗腰扭伤的效果，关键在进针深度和针感。大肠俞穴下有第3腰神经后支，深层为腰丛，其发出的神经分支分布于下腹部、臀部及下肢的肌肉和皮肤，故深刺大肠俞，可使针感直达病所，“气至而有效”。本法可以疏通经络气血，调整机体各系统的功能，达到恢复腰部功能之目的。

李某，男，20岁，学生。就诊前1h在篮球比赛中不慎扭伤腰部，致腰部疼痛难忍，转侧不利，动则疼痛加剧，由同学抬送来院就诊。查患者痛苦面容，左侧腰背肌条索样紧张，以第三、第四腰椎旁压痛明显，腰椎正侧位X线摄片未见骨关节异常。临床诊断为急性腰扭伤，取左侧大肠俞，按上法治疗，即刻腰痛消失，屈伸转侧正常，步行返校。

三、针罐并用 通则不痛

急性腰扭伤是临床常见病、多发病，郭燕采用针刺加刺络拔罐法治疗本病，取得了满意疗效。

取穴：后溪。

操作：患者正坐位，两手平放于桌上，半握拳。常规消毒后，用30号2寸毫针快速直刺后溪穴，针尖向劳宫穴方向透刺，得气后再予以强刺激，行捻转、提插泻法，患者有强烈的针感，然后令患者做弯腰、下蹲动作，鼓励患者最大限度地活动腰部。每隔10min行针1次，留针30min。每天1次，10次为1个疗程。

刺络拔罐：针刺后让患者俯卧于治疗床上，找到压痛点，用三棱针点刺，然后在针孔处迅速以闪火法拔火罐，留罐5~10min。取

罐，擦净瘀血，用消毒棉球按压针孔片刻。每天1次，10次为1个疗程。

后溪穴为手太阳小肠经之输穴，手太阳与足太阳为同名经，两经脉气相通，“输主体重节痛”，同时，后溪穴又为八脉交会穴之一，通于督脉。急性腰扭伤多使督脉及膀胱经气受损，据“经脉所过，主治所及”的原则，针刺后溪穴能使气至病所，行气血而通经络。三棱针刺法刺激强度较大，活血化瘀功能尤佳。针刺加刺络拔罐，即疏通了督脉及膀胱经之经气，又改善了病变部位的血液循环，加速了炎症的吸收，罐内负压可使深部瘀血由针孔吸拔而出，使离经之血、瘀血随血流而去，祛瘀生新，调节腰背部经络气血，共同起到“通则不痛”之作用。

四、夹脊穴 长针深刺

李先道在多年的临床实践中就急性腰部扭伤以针刺腰夹脊为主，配合其他治疗方法为辅，取得较为理想疗效。

取穴：以腰4~5夹脊为主。如果是一侧腰部扭伤，可取同侧腰4~5夹脊；如果是双侧腰部扭伤，可取双侧腰4~5夹脊。若伴有腰椎病变而出现下肢麻木等症状者，随症配穴，如取委中、环跳、阳陵泉等穴。

操作：急性腰扭伤多是突发，属阳证，施针时，采用1.5~3寸毫针，直刺或针尖稍偏向内侧，刺入2.5寸深左右，使针感放射至足部或尾骨部位。大多用泻法，但还要根据“虚则补之，实则泻之”的治疗原则进行针刺，同时还可适当配合推拿、拔火罐、艾灸（适合扭伤3天以后者）等治疗方法。

孙某某，男，42岁，工人。1986年4月13日来诊，患者于当日上午在工作中因搬重物不慎，将腰部扭伤，当时即感到腰部疼痛，不能弯腰活动，立坐困难。检查见腰部左侧压痛（++），腰肌紧张，弯腰困难，不能咳嗽，局部无红肿，余情尚佳。诊断为急性腰扭伤。治拟舒筋活血，通经定痛。取腰夹脊4~5，用泻法。

该患者针后3min，即感腰部轻松，留针20min，留针期间行针2次，起针后下床活动自如，诸症消失，自己如常走出医院，1周后随访，未痛如常上班。

五、后溪—阿是穴 运动针刺

王颖采用针灸配合腰部俯、屈、仰、弯、环转等活动治疗急性腰扭伤，疗效显著。

取穴：双后溪、阿是穴。

操作：患者取站立位，以28号2寸毫针直刺双侧后溪，针尖指向合谷方向，深度1~1.5寸，得气后行提插泻法，强刺激，各反复行针1min后，留针15min，期间可行针3~5次，留针期间同时作腰部俯、屈、仰、弯、环转等活动。然后再取俯卧位，用28号2.5寸毫针对准阿是穴直刺，深度1~1.5寸，得气后行提插泻法，强刺激，留针20min，期间行针4~5次。每天1次，5次为1个疗程。注意治疗中保暖。

急性腰扭伤主要是因气血凝滞、经脉痹阻所致。所以治疗时，首先强刺激后溪主穴伴腰部活动，其次是针刺腰部压痛点——阿是穴。后溪为手太阳经之输穴，八脉交会穴之一，通于督脉，督脉主治脊柱强痛。针刺后溪可以调畅气机，加之随针感活动腰部，以动行气，增强针感，二者相互推动，相互促进，使经络通，气血行。针刺腰部压痛点阿是穴，可以调畅病变局部的气血。通过临床观察发现：在患者耐受程度内，刺激强度越大，疗效越好，病程越短，疗效愈佳。治疗关键是留针，让患者尽可能多地进行多种姿势活动，尤其是使疼痛明显的姿势。

钱某某，男，34岁，工人。主诉前一天下午向外倒土时不慎将腰扭伤，当时腰部疼痛不能活动，大约10min后方能缓慢行走，但疼痛仍继续存在。今日就诊时，不能下蹲，不能活动腰部，诊断为急性单纯性扭伤，经本法治疗，行针10min时腰痛基本消失，腰部活动自如，局部无压痛，留针20min，每5min行1次手法，1次治愈。

六、独取命门 长针深刺

黄志军应用针刺命门穴治疗急性腰扭伤，取得较理想疗效。

取穴：命门。

操作：患者取侧卧位，弯腰两手抱膝取穴，第二腰椎下即是，

根据患者的体质胖瘦，确定深浅，用长 75mm 不锈钢毫针直刺，得气后捻转 1min，针感达到膝盖下退针即可，并嘱患者前后左右活动腰部。

急性腰扭伤多由剧烈运动或用力不当导致闪挫，或扭转过度引起损伤经脉气血，气滞血瘀，经脉阻塞，不通则痛。腰脊部为督脉所过，督脉为阳脉之海，针刺命门，可通调督脉之经气，目的为激发诸阳之气，同时活动腰部，促进腰部和督脉的气血流畅，而起止痛之功效。

杨某，男，38 岁，1992 年 10 月 6 日就诊。自述摇柴油机用力过猛，突感腰痛，不能直立，腰活动受限，转侧疼甚。采取按摩腰部无效，来诊查治疗。腰压疼拒按，局部无红肿，用上法针刺 1 次疼痛消失，行动正常。

七、全息腰穴 - 人中 针刺配合运动

急性腰扭伤属中医“腰痛”范畴。李小华采用针刺全息腰穴、人中治疗该病，取得满意效果。

取穴：全息腰穴、人中。

操作：令患者站立，常规消毒皮肤，选 1 寸毫针，先针人中，强刺激 30s，再选 1.5 寸毫针，针双侧或单侧腰穴，强刺激 30s，留针 30min，中间每 10min 行针 1 次。留针期间，嘱患者做下蹲起立至少 10 次（下蹲时，两脚跟不能离地，臀部紧贴小腿后侧，）、前屈、左右旋转等方向的活动，幅度由小到大。如针刺 1 次不能完全解除症状，次日再施术 1 次。

全息生物学认为机体局部损伤后发出一种病理信息，在特定穴位上有所反应，在穴位上相关地产生对痛刺激敏感等生理病理现象，同时，在特定的穴位上加以刺激，如针刺、按摩等都会相关地在相应部位产生疗效，穴位选取遵循部位对应原则，脏腑所主对应原则。取腰穴意在解除腰部疼痛及功能障碍；人中为督脉之末穴，刺激之可疏通督脉；第二掌骨指节及头面系统包含人体整体的生理、病理信息。故取腰穴、人中，施以针刺刺激，具有调节腰部功能的功效而达到治疗目的；同时，配合腰部的活动，具有加强针刺信息，从而加快解除腰部肌肉的保护性痉挛，改善局部微循环，达到行气活

血、通经止痛、促进组织修复的目的。

刘某某，男，37岁，工人。腰部疼痛、活动受限，尤以前屈为甚，于1996年7月16日来针灸科就诊。患者于上午10点左右抬设备时，不慎将腰扭伤，疼痛异常、不能活动。查体见腰部两侧肌肉紧张，L₄棘突两侧有明显压痛，叩击痛阳性，无放射痛，棘突无偏歪。诊断为急性腰扭伤。给予针刺人中、两侧第二掌骨侧腰穴，强刺激30s，并嘱活动腰部，30min后起针，即感腰部疼痛消失，活动如常。

八、殷门 强刺

急性腰痛常因局部受凉、搬重物扭伤，或于腰部活动时用力不当而发生，疼痛剧烈，生活不能自理，有的抬来门诊治疗。针刺效果好且迅速，常用局部取穴或远端取穴。蒋幼光应用远端循经取穴殷门，用强刺激手法取得较明显效果。具体方法介绍如下：

取殷门穴，以3寸长毫针，针刺2~2.5寸深，针尖稍偏向大腿外侧。针感为闪电窜麻自大腿窜至足。取得此针感后可再提插3~4次，然后起针。起针后嘱患者站立活动腰部，疼痛即可明显减轻。当日回家后腰部症状可能有轻度反复。以后每日或隔日针1次，症状逐步减轻至消失，一般剧痛在针刺1~2次后即可缓解，以后根据病情可以续针3~4次，症状即可消失，急性腰痛（1~2天内）来诊越早效果越好，如超过5天以上，则恢复较慢。

刘某，男，46岁，干部。10天前因洗凉水澡引起腰痛，近3天来疼痛明显加重，腰部转动困难，不能弯腰，坐位痛甚，以致不能工作。下肢无窜痛。检查：脊柱棘突无明显压痛，于腰椎2~4棘突两侧肌肉明显压痛。弯腰约30°，腰部左右侧弯约20°。不能做腰部旋转运动。遂针刺双侧殷门，取3寸毫针，深刺约2.5寸，针感为闪电窜麻感，针感传至足部，取得针感后提插3~4次起针。针后自觉疼痛明显减轻，可以弯腰约90°，能拾起地上物品，腰左右侧弯达30°，可做腰部旋转运动。2天后来诊，自述针后腰痛明显减轻，当日晚间稍有反复，但未反复至治疗前水平，两天来疼痛继续减轻，可以坚持工作。再针殷门，手法同上。10天后第3次来诊，腰部活动已恢复正常。一年后患者陪同他人来诊，诉说其腰部疼痛一直未

复发。

九、上髂穴 多发针而深之

近几年，张宏采用针刺上髂穴治疗急性腰扭伤，疗效满意。

取穴：上髂。

操作：局部用酒精常规消毒后，用两根 1.5 寸毫针分别在选定的穴位上先直刺入皮下 0.5 寸，同时运用雀啄手法，令患者作前屈、后伸、侧弯等各方位的腰部运动，幅度由小到大，当患者在作某一个动作时突然静止不动并指出腰痛的部位和方向时，医者将针尖方向对准疼痛的部位缓慢刺入，并嘱患者作缓慢的前屈后伸动作，针体随之进退，如此反复针刺疼痛大减时，令患者前屈 30°，将针直刺入上髂穴，使腿部有一种放电感觉直达足部，刺激 3 次后出针。如 1 次施术不能完全解除症状，次日再施术 1 次。

此方法是根据足太阳膀胱经分布循行路线而设。其经脉主干沿肩胛内侧，脊柱两旁到达腰部，进入脊柱两旁的肌肉，《内经》云：“足太阳之脉，令人腰痛，引项脊尻，背如重状。”治疗中运用此穴位诸特点，通过经络的作用，以活血化瘀，通经活络，理气止痛，使腰部痉挛的肌肉得到缓解而止痛。因腰为肾之府，上髂穴是足太阳、足少阴之络，刺激该穴，可激发肾脉的经气，使其气旺血盈直达病所则病必除。更用“多发针而深之，以热为故”的方法，使局部温度升高，肌肉组织的血运增加，瘀去而痛止。

十、急性腰扭伤 取委中 - 人中

康秀钢近年来采用针刺委中、人中穴治疗急性腰扭伤，疗效显著。

取穴：委中、人中。

操作：令患者取俯卧位，取双侧委中，穴位局部常规消毒，用 2 寸毫针刺入委中，用泻法，得气后，留针 20 ~ 30min。留针期间每 5 ~ 10min 行针 1 次。待委中起针后，再令患者采用仰靠坐位，取人中，穴位局部常规消毒，用 1 寸毫针刺入人中，用泻法。得气后，嘱患者慢慢起立，做腰部活动，如轻微的俯仰转侧，下蹲等。可留针 10 ~ 20min。每天 1 次，一般 1 ~ 3 次，可治愈。

腰扭伤多为腰脊正中或两侧腰肌，腰部为督脉及足太阳膀胱经循行所过。《玉龙歌》云：脊强痛泻人中，挫闪腰痛亦可攻，更有委中之一穴，腰间诸疾任君攻”。委中，又为四总穴之一，有“腰背委中求”之说。针刺人中、委中可通达人体督脉与膀胱经（足太阳）之经气，调和阴阳，疏通气机，行气活血。使腰部之瘀滞消散。疼痛得以消除。

患者男，45岁，工人，初诊日期2000年10月19日，主诉：腰部疼痛3h，患者当日与他人搬抬重物时由于用力失衡引起腰部疼痛。查：腰部活动受限，不能俯仰、下蹲、腰骶部有压痛，X线检查，腰椎未见异常，诊断为急性腰扭伤，按上述方法治疗，1次后疼痛大减，腰部略感不适，次日二诊继用上法治疗后，疼痛完全消失，活动自如，痊愈。

十一、天柱针刺 局部叩刺拔罐

王雪梅采用针刺天柱穴加局部刺络拔罐治疗急性腰扭伤，取得显著效果。

取穴：天柱。

操作：用28号1.5寸毫针2根，在双侧天柱穴斜刺，针尖指向哑门，得气后以捻转重泻手法，使患者感觉针处酸胀难忍，并令患者活动腰部，视腰部活动受限的方向做主动运动，如弯腰、下蹲、踢腿等活动。以周身微微出汗为佳，每隔2~5min行针1次。反复刺激至腰部活动无疼痛感，行动自如为止。如腰部仍感僵硬，在局部用梅花针叩打至皮肤潮红，再拔火罐，以少量出血为佳。

腰为人体中枢之通道，是足太阳膀胱经所主，经脉所过，主治所及，天柱为足太阳膀胱经穴，针刺此穴可使经脉疏通，气行血运直达病所，从而取得通则不痛的疗效。再辅以叩刺拔罐改善局部血运，使腰部肌肉僵硬进一步得到缓解，疼痛消失。

十二、深刺秩边 配推拿治疗

林树茂近几年运用针刺秩边穴配合推拿疗法治疗急性腰扭伤，取得满意疗效。

针刺：患者站立，手扶床边，取患侧秩边穴，常规消毒，选用

28号5寸毫针刺秩边穴；针身垂直皮面，用捻转泻法缓慢进针，不要提插，使患者逐渐表现麻窜感应向下肢放射至足跟或足大趾。并嘱患者缓慢活动腰部，左右环转，行针约1min，即可起针，每天1次。

推拿：患者俯卧，运用揉法、推压法、滚法、按法在患处周围治疗，时间约5min，使受术部位受力均匀深透；然后逐步移至压痛点或痛性结节处，由上而下逐个进行经穴按摩，来回施术约5遍，以通经散结，舒筋活络；配合腰部后伸被动活动，幅度由小到大，手法压力由轻到重。斜扳法：嘱患者侧卧，患侧在上，屈髋屈膝；健侧在下，髋膝伸直，医者面对患者，两手分别按着肩、臀部，作相反方向轻巧而有弹性地摇晃数次，待腰背肌放松腰旋转到一定程度时，稍用力斜扳，这时可听到“喀啦”响声，必要时可做两侧斜扳。扳后，再在腰臀部自上而下做滚法、揉法、拿法约3min，并在患处轻轻叩击，按压数次后以进一步舒筋活络并消除和减轻治疗过程中可能出现的手法反应。

腰为肾之腑，足太阳膀胱经挟脊抵腰中。秩边穴为该经之穴，针刺秩边穴可以疏通经脉，活血行气，使腰部气血通畅、脉络通达，从而达到通则不痛之目的。腰部推拿疗法，可使腰椎关节功能紊乱得以改善，同时通过影响全身微循环来改善病痛区域缺血缺氧状态，故对本病具有良好的治疗作用。

张某，男，42岁，公司职员，2000年5月12日就诊。主诉：日前因搬重物，左腰部突然剧烈疼痛，痛如针刺，转动腰部及直立时疼痛加重，活动受限，就诊时由他人搀扶而来。X线检查腰部未见明显异常，诊为急性腰扭伤。治法：取左侧秩边穴针刺，针法如上，起针后患者自觉腰部疼痛减轻；又施以推拿疗法，手法同上。然后嘱患者下床活动，腰部症状消失，活动自如，随访1年未复发。

十三、针推罐 三法并用

廖伯年近年来采用针推罐并用治疗急性腰肌扭伤，获得良效。

针刺：取穴：手三里、人中。痛在一侧腰部者，取健侧手三里；两侧腰痛者，取双侧手三里；腰脊正中痛者，取人中。针刺得气1~2min后，嘱患者试着起坐，主动做腰部旋转、前屈、后伸等活动。

留针 20min。

推拿：针刺后即行推拿法。

(1) 揉揉舒筋法：患者俯卧位，医者站于一侧，用揉、揉等轻柔手法在局部施术 3~5min。

(2) 点拨镇痛法：用拇指点压或弹拨夹脊穴、痛点、腰背部膀胱经穴位、环跳、委中等穴。

(3) 理筋整复法：用腰部斜扳法，常可听到“咯嗒”声。

(4) 击打放松法：从背部到小腿，由上往下用轻柔、有节奏的击打法。

(5) 运动关节法：患者仰卧位，屈膝屈髋旋腰、直腿抬高等方法。每天 1 次。

拔罐：最后行拔罐法。取痛点、肾俞、腰眼、腰阳关、委中。每天 1 次。

《金匱翼》载：“瘀血腰痛者，闪挫及强力举重得之。盖腰者，一身之要，屈伸俯仰，无不由之，若一有损伤，则血脉凝涩，经络壅滞，令人卒痛不能转侧……”，治宜舒筋通络、活血散瘀、消肿止痛。手三里乃手阳明大肠经的重要穴位，《灵枢·经筋》有云“手阳明之筋……其支者，绕肩胛，夹脊”，针刺手三里穴可通调脊柱两旁的经气，促使气血通，腰痛止，是故《甲乙经》云“腰痛不得卧，手三里主之”。腰脊正中乃督脉所过，人中为督脉要穴，《玉龙歌》曰：“脊膂强痛泻人中，挫闪腰疼亦可针。”推拿手法能舒筋通络、活血散瘀，改善血液循环，使损伤的组织修复，并对小关节紊乱、滑膜嵌顿者，可纠正其紊乱，使嵌顿的滑膜复位，具有显著效果。拔罐法具有通经活络、行气活血、消肿止痛、祛风除湿等作用。针刺、推拿、拔罐三种疗法并举，能迅速通经活络，修复受损组织。

赵某，男，40 岁，因搬抬重物致腰痛 2 天来针灸科求治。症见右侧腰痛甚，转侧不利，俯仰困难。查体右侧腰肌痉挛，广泛压痛。诊断为急性腰肌扭伤。嘱患者坐位，针刺手三里（左），得气后持续捻 1min，然后嘱其右手扶左臂，起立，坐下，再起立，似之来回起坐，并做腰部旋转、前屈、后伸等活动。初即感较针刺前明显好转，随之渐觉活动自如。留针 20min 后出针，按上法行推拿治疗，最后施拔罐法。治后腰痛尽消，活动自如，第二日未再来治。随访半年

未见复发。

十四、针药并用 化瘀止痛

尹莹采用针药并用治疗急性腰痛，取得明显疗效。

取穴：轻症：腰脊正中痛选刺人中穴，腰脊两侧痛选刺后溪穴。重症：取委中或痛处局部，行三棱针点刺出血3~5滴。疼痛有所缓解后，再取人中、后溪等穴。

操作：穴位局部常规消毒后，用30号，0.5~1.5寸毫针快速进针，施以中强度刺激，得气后留针30min。每隔5~10min行针1次，留针期间嘱患者起身走动、蹲下站起，并缓慢做前屈后伸、侧弯等腰部活动。每天1次，6次为1个疗程。

中药：采用自拟活血通络方：当归、赤芍、泽兰、地龙、杜仲各15g，丹参、鸡血藤各20g，牛膝、乳香、没药各9g，延胡索12g，甘草6g。气滞偏重者加香附15g，瘀血偏重者加桃仁、红花各9g。每日1剂，水煎分2次口服，6剂为1个疗程。

人中为督脉腧穴，针刺能通调督脉经气，强腰壮肾，活血祛瘀；足太阳膀胱经挟脊、抵腰，委中为足太阳经之合穴，故取三棱针点刺放血，可以疏经通络，活血祛瘀；后溪为手太阳小肠经之腧穴，又为八脉交会穴，具有通督脉，调经气，祛瘀止痛的作用。以上诸穴合用，可使脏腑调和，血气通畅，血脉疏通，阴阳平衡而疼痛缓解。针刺时，配合病人自身腰部活动，可使局部紧张的肌肉得以松弛，对促进气血运行，激发经气有协同作用。中药活血通络汤口服，意在加强疗效。方中当归、赤芍、丹参养血活血；泽兰、乳香、没药、鸡血藤活血化瘀，通络止痛；杜仲、牛膝滋补肝肾，引药下行；地龙通经活络；延胡索行气止痛；甘草调和诸药。针药合用共奏疏经活血、化瘀止痛之功效。

胡某，男，38岁。因不慎扭伤腰部剧痛1天，于2000年3月28日来诊。症见弯腰行走，步履艰难，痛苦呻吟。查体：双侧腰肌紧张，腰椎生理曲度变直，L₄~L₅压痛(+)，L₅~S₁压痛(++)，直腿抬高试验(+)，双4字试验(-)。舌质黯红，脉弦。腰椎CT示：L₄~L₅、L₅~S₁椎间盘突出。诊断为急性腰痛。证属气滞瘀阻，经脉不通。取人中穴针刺，并予强刺激，留针30min。留针期间嘱患

者蹲下站起，慢慢转动腰部，每5min行针1次。针毕患者自觉腰痛大减，腰部转侧活动较前灵便。次日继续按上法针刺取穴并配合活血通络方内服。巩固治疗4天，患者腰部疼痛基本缓解。

十五、滞针运动 针用泻法

李林采用滞针运动疗法治疗急性腰扭伤，均取得满意效果。

取穴：阿是穴。

患者取俯卧位，暴露患处。医者用拇指在患者病变部位寻找痛点，痛点确定后，常规消毒，选用29号3寸毫针，针身与皮肤呈90°快速刺入皮肤。行提插捻转手法得气后，将毫针单向捻转，使局部产生很强的胀痛感，以针下出现阻滞而不能继续捻转为度，然后将针弯曲，用胶布固定，让病人起床做病人扭伤后不敢做的动作，同时配下蹲、弯腰、坐下、起来等动作，如此反复2~3次后，嘱病人俯卧位出针，每天1次。

滞针运动疗法，不同于一般针刺手法，滞针较一般针法的针感更为强烈。急性腰扭伤属实证，“实则泻之”，滞针可以达到重泻之目的；滞针后产生的胀痛感要远远超过腰扭伤产生的疼痛，这就可以大大地提高病人的痛阈，从而达到镇痛的目的。

“不通则痛”，令患者带针做不敢做的疼痛姿势，也就是气血最不通之时，针刺可最大限度地发挥疏通“不通之气血”的功效，从而达到“通则不痛”的目的。

十六、急性腰痛 治法有三

腰痛有急慢之分，急性者，吕景山在临床上有三种治法：

(1) 对应点针法 先寻找腰部的反应点（压痛点），再取左侧或右侧，或腹部的对应点，用1寸针，快速刺入表皮，行雀啄术，边行针边令患者活动腰部，活动范围由小到大，切勿用力过猛。

(2) 针刺人中、哑门 二穴配合，一前一后，相互对应，通调督脉，宣导经气，散瘀定痛。

(3) 后溪、昆仑并用 此二穴同经相应，相互促进，宣通腰背经气，以增强散瘀定痛之力。

男，51岁，希腊驻喀麦隆外交官员。1976年7月15日初诊。

因打羽毛球不慎将腰扭伤3天，遂不能弯腰曲背，呈直立挺腰行走，更不能自行穿脱鞋袜，咳嗽时疼痛加剧，由妻子搀扶而来。检查：命门穴有明显压痛，不能前后俯仰、左右侧弯，不能下蹲。舌质淡，苔薄白，脉弦。治宜通经活络止痛。取穴：人中、哑门。二穴均速进针，刺入3~5分深，施以同步捻转，雀啄术，行针1min后，疼痛减轻一半，留针0.5h，前后行针3次，痛除病愈，腰部活动自如。

十七、鼻针疗法 消瘀散滞

林志强在鼻部取穴针刺治疗急性腰扭伤，取得满意的效果。

取穴：在患者鼻骨下端之中、鼻翼上方左右各取一点。

操作：嘱患者取仰卧位，常规消毒后，用30~32号5分长的毫针直刺，不穿透鼻软骨为度。针刺入后有强烈的酸、麻、痛等感觉，以病人能忍受为度，流泪、打喷嚏取效最佳。若针后无任何感觉，可将针退出1/2改变方向再针，但不宜反复连续进退，留针5~20min，一般留针期间，每5min捻转1次，平补平泻轻手法，针的旋转角度不超过15°。每天针1次，以症状消失为度。

根据“全息生物医学”揭示的生物体普通存在的全息规律，林志强把鼻骨下端之中和鼻翼上方左右3点，当作面朝里背向外盘腿而坐坐在鼻部的一个人的腰部，针后能通调督脉气逆，消瘀散滞。

余某某，男47岁，干部，1988年8月27日下午就诊。主诉因弯腰不慎，突然闪腰，当即腰痛如刀割。由爱人扶上诊床卧位，此后在床上不能转侧，动则痛剧，咳则掣痛，即使轻轻搬动，亦痛不可忍。曾请骨伤医生以林如高麝香正骨水推拿、麝香镇痛膏外敷等治疗皆无效。刻下面色青黄，仰卧于床，呻吟不已，经鼻骨下端之中和鼻翼上方左右各取一针后，嘱其下床活动10min后，一切活动如常人。

十八、独取膻中 粗长针针刺

胡希军在临床上发现以粗长针针刺膻中穴治疗急性腰扭伤，疗效好，见效快。

取穴：膻中。

操作：病人取坐位或仰卧位，膻中穴皮肤常规消毒，选用26号

4寸粗长针，向下呈 45° 角斜刺进针，至皮下后，再沿任脉向下平刺3寸，此时病人针处有麻胀感，行捻转泻法约30s，然后以胶布固定针柄，嘱病人站起，做腰部前屈、后伸、左右屈及环转等运动，动作由小到大，由缓到急，由轻到重，范围不断扩大直到正常。留针30min，留针期间每隔10min行针1次。1次未愈者次日再针1次。

膻中属任脉，心包经之募穴，气之会，为宗气之所聚。宗气可贯心脉以行气血。腰痛取膻中，可强行打通任督之气血，使淤血得除，气滞得通，达到治疗腰痛的目的，乃中医理论之下病上取，阳病治阴之妙用。以粗长针治疗较普通毫针进针更深，压强更大，刺激性更强，更有利于驱除邪实，活血化瘀。在针刺镇痛的作用下，同时配合腰部运动疗法，既能逐渐恢复腰部平衡状态，逐步消除肌肉挛缩，又有利于随时观察治疗效果，调整针刺刺激量，使疾病迅速向愈。

丛某，男，35岁，干部，2000年12月21日就诊，患者因晨练时不慎扭伤腰部，伤后腰痛剧烈，活动不便，咳嗽时腰痛加重。查体见右侧骶棘肌张力增高，压痛广泛，脊柱右侧弯，摄腰椎X光片未见异常，诊为腰肌扭伤。以上法治疗1次而愈。

十九、排针透刺 镇痛力强

董洪英采用排针透刺法治疗腰痛，具有良好的镇痛作用。

取穴：平胸11~腰5椎体棘突下，旁开3寸，即在膀胱经第二侧线之意舍、胃仓、育门、志室及 L_3 、 L_4 、 L_5 椎体旁的相应位置取穴，一般每侧取3~4穴，亦可酌情增加；环跳、委中、申脉均取双侧。

操作：患者俯卧，局部皮肤常规消毒。取29号，3寸毫针，以腰背部病变部位为中心，选取膀胱经第二侧线穴位进行排刺。以 45° 角对准脊柱将针快速刺入皮下后，使针体与皮肤成 $45^\circ \sim 60^\circ$ 角斜刺，针尖刺至椎体为度，行小幅度捻转法1min；环跳穴，以29号，4寸毫针，快速进针，以患者下肢出现放射传导感为度；委中，采取常规刺法，以患者下肢出现放射传导感为度；申脉，采取常规刺法，大幅度捻转1min。留针30min。隔日1次，10次为1个疗程。

腰痛从经络辨证来看，主要与督脉、足太阳膀胱经、足少阳胆经有关。腰局部排针透刺法横贯腰部足太阳膀胱经双线、直抵华佗夹脊穴及循脊之督脉，可达局部排刺、透刺之功，通调整个腰部之经气气血，疏筋通络止痛。远取膀胱经委中、申脉及胆经环跳穴，即上病下取，放射感使经气流通，增强了止痛效果。

二十、攒竹 - 阳陵泉 针刺推拿

何清运用针刺攒竹、阳陵泉穴加手法推拿治疗急性腰扭伤取得满意疗效。

针刺：患者取坐位，局部常规消毒，用 30 号 1 寸毫针直刺攒竹穴 0.5 ~ 0.2 寸，得气后反复捻转提插，幅度以针尖不出皮肤并流出眼泪为度，然后再取 30 号 3 寸毫针刺阳陵泉穴，得气产生针感后用强提插、强捻转刺激 3 ~ 5 次后并令患者活动腰背，左右旋转活动。留针 10min，每天 1 次。

推拿：起针后让患者卧于推拿床上，医者首先用双手拇指腹以八字按摩法触摸痛处，由轻渐重按揉 3 ~ 5min，然后施行分筋手法与脊柱纵轴垂直方向左右分拨 5 ~ 10min，再施理筋手法 5 ~ 10min，将移位的组织纤维恢复到自然位置，最后用侧身斜扳法恢复其紊乱小关节。

腰部扭伤而致的疼痛多由经筋络脉受损，气滞血瘀，不通则痛。攒竹为足太阳膀胱经穴位，膀胱之脉夹脊抵腰络肾，循经选取攒竹以通调足太阳经气；阳陵泉为足少阳胆经的穴位，筋之会穴，针刺阳陵泉能疏通全身之经筋。故二穴合用能通调经气，调和营卫，加之按摩舒理肌肉筋膜，疏通经络，行气活血，加快损伤局部血液循环，促进新陈代谢，能放松痉挛肌肉，解除病痛。诸法合用，优势互补，更臻佳效。

钱某，男，48 岁，1999 年 6 月 24 日就诊。患者骑摩托车时不慎将腰部扭伤，疼痛剧烈，俯仰困难，曾口服参三七片、外敷伤药、静滴 20% 甘露醇 250ml，但疼痛不减，X 光摄腰椎正侧位片未见异常。体格检查，双侧腰肌处压痛（+），前屈 10° ~ 20°，后伸 10°。诊断：急性腰扭伤。治疗：按照上法先直刺攒竹穴 0.5 ~ 0.2 寸反复提插。然后再用 30 号 3 寸毫针针刺阳陵穴，强刺激 3 ~ 5min，嘱患

者活动腰部，留针 10min，再按上述理筋推拿手法治疗，经治疗 1 次后明显好转，疼痛减轻，嘱其卧硬板床休息，第二天复诊 1 次，仍然按上述方法处理，腰部疼痛完全消失，活动自如。随访 1 年，未见复发。

二十一、合穴委中 刺血拔罐

吴小明应用委中穴刺血拔罐治疗急性腰扭伤，疗效满意。

操作：患者取站立位，稍屈膝，取委中，一侧腰痛取患侧，用消毒过的三棱针快速刺破该穴瘀滞之浮络，任其流血，等血止时，用干棉球揉按后，将火罐以闪火法吸附在委中穴上，一般留罐 10 ~ 15min，使出血量达 5 ~ 20ml 左右，起罐时先用干棉球将血擦净，再用 75% 酒精消毒针眼。嘱患者当日禁洗浴、防止感染。

中医学认为本病多由剧烈运动或用力不当致闪挫、跌仆牵引、扭转过度引起的损伤，导致气血凝滞，经脉闭阻，脉络不通则痛。《素问·针解篇》云：“苑陈则除之者，出恶血也”。《素问·刺腰痛论》云：“足太阳脉令人腰痛，引项脊尻背如重状，刺其郄中，太阳正经出血”。《丹溪心法》亦曰：“腰曲不能伸，针委中出血立愈”。急性腰扭伤属实证，根据“实则泻之”的治疗原则，故采用委中穴针刺放血祛邪实，活血散瘀，使邪有出处；并用拔火罐舒发经气，加强气血的运行，使痹阻壅滞的经络得以疏通。刺血、拔罐二者合用，相得益彰，扶正祛邪，因而取得较好的疗效。

李某，男，40 岁。1996 年 3 月 13 日诊。自述昨日因搬液化气瓶时不慎扭伤腰部，疼痛难忍，不能伸直，弯腰活动受限，转侧痛甚，外用关节止痛膏无效来诊。检查：脊柱无侧弯，腰背部疼痛拒按，无红肿。直腿抬高试验（-），捡物试验（+）。X 线摄片腰椎未见异常。拟为急性腰扭伤，遂取上法治疗 1 次即愈。

二十二、急性腰痛 针到痛止

陆惠新在临床上治疗急性腰痛，任选以下一方，每获良效。

（1）针刺人中法 患者取立位和坐位均可，要求肌肉放松，头稍后仰，医者站其右侧，先对鼻唇沟处常规消毒，同时用左手拇、食指从鼻唇沟两侧捏起肌肉，右手持 1.5 寸毫针，对准人中，针尖

向上呈 15° 夹角，用捻转法刺入0.5寸左右。得气后，采用泻法，捻转角度要大，力量要强，反复行针1min。让患者作下蹲，站立4~5次。再作腰部俯仰和转侧运动，留针5min，出针时不扞针孔，一般针刺治疗后疼痛立即消失。若疼痛不止，或减而不显，可在大椎穴处揉按1~2min；再取26号3寸毫针，常规消毒后，针尖朝尾骶骨方向，慢慢推进，快速捻转，使针感沿脊椎正中向下传导，直至疼痛部位，一般1~2次即愈。

《通玄指要赋》云：“人中除脊膂之强痛”，《玉龙歌》说：“脊背强痛泻人中，挫闪腰酸亦可攻”。人中位于人体中线，隶属督脉，泻之能疏通督脉之经气。故本法治急性腰扭伤后，第一腰椎到第四腰椎或第四腰椎到骶骨裂孔段；脊椎正中线旁开2~3cm处疼痛，伴活动受限，不能俯仰者，最为适应。

(2) 针刺委中法 让患者站立，双手自然扶桌，全身放松，医者在委中穴上反复揉按2min后，进行常规消毒，右手持26号2寸毫针，针尖对准穴位，快速刺入1.5寸左右，待有强烈酸胀麻感觉后，采用大幅度捻转手法，反复行针2min。使针感逐渐传导至腰肌疼痛部位，然后将针慢慢退出，不扞针孔。嘱患者反复进行腰部活动，一般疼痛均有减轻。若上法疗效不显，并发现患侧腘窝处皮下，静脉有瘀血时，可用三棱针刺络放血。多数患者刺络放血后，腰部疼痛减轻，活动幅度增大。

《素问·刺腰痛论》云“足太阳脉，令人腰痛，引项背如重状，刺其郤中，太阳正经出血”。《丹溪心法》亦曰“腰曲不得伸，针委中出血立愈”。委中，又名郤中。《针灸大成》称为血郤，又是足太阳膀胱之合穴，是四大要穴之一。针刺委中穴有通络脉之瘀滞、疏膀胱之经气的作用。故本法治急性腰扭伤后单侧或双侧腰部疼痛，转侧困难，仰俯不得，病在足太阳膀胱经者，其效甚捷。

(3) 针刺太冲法 取患者坐位，医者先用双手在两侧太冲处反复揉按1分钟左右，后进行常规消毒，再用右手持26号1.5寸毫针，针尖向足底心方向徐徐刺入1寸左右，得气后用大幅度捻转手法，反复行针2min，留针15min，期间每5min行针1次，行针或留针期间，作腰部俯、屈、仰、弯等活动。多数患者针刺后感到1腰部轻松，疼痛消失。

太冲为肝之原穴，又为足厥阴经之输穴，输主体重肢痛，故本法治急性腰扭伤后出现的任何部位疼痛，同时伴有腰肌紧张，不可俯仰，以及少腹胀满者，用之甚效。

(4) 针刺后溪法 患者取坐位，全身放松，医者先在同侧后溪穴处，揉按1min，后进行常规消毒，用26号3寸毫针，对准穴位快速进针，进针后，沿合谷方向，徐徐用力推进，约2寸左右，使患者手掌有强烈酸胀麻感，再施行捻转手法，边捻转，边嘱患者腰部活动，一般随着强大的针感出现，腰部疼痛也相继减轻，如痛减不显可在对侧后溪穴同时进针，此法一般1~2次即可。

后溪为手太阳小肠经之“输穴”、“八脉交会穴”之一，通于督脉，一穴能治二经之病，故本法治腰部扭伤后一侧腰肌剧痛，或伴有牵制项背者，屡获良效。

参 考 文 献

- [1] 高畅. 互动式针刺法治疗急性腰扭伤72例临床观察. 天津中医, 2002, 19 (2): 23~24
- [2] 叶险峰. 针刺大肠俞治疗急性腰扭伤32例. 中国民间疗法, 2005, 13 (8): 15
- [3] 郭燕. 针刺加刺络拔罐治疗急性腰扭伤65例临床观察. 中医正骨, 2004, 16 (10): 44~45
- [4] 李先道. 针刺夹脊治疗急性腰扭伤125例. 上海针灸杂志, 1996, 15 (3): 222
- [5] 王颖. 针刺结合运动治疗急性腰扭伤32例. 针灸临床杂志, 2007, 23 (2): 20
- [6] 黄志军, 殷立忠. 针刺命门穴治疗急性腰扭伤186例. 上海针灸杂志, 1996, 15 (3): 223
- [7] 李小华, 陈建胜. 针刺全息腰穴、人中治疗急性腰扭伤136例. 中医外治杂志, 2000, 9 (5): 38
- [8] 胡熙明. 针灸临证指南. 人民卫生出版社, 1991, 218
- [9] 张宏. 针刺上缪治疗急性腰扭伤50例. 天津中医, 1994, 11 (2): 14
- [10] 康秀钢. 针刺委中、人中治疗急性腰扭伤32例. 张家口医学院学报, 2004, 21 (3): 55

- [11] 王雪梅, 高虹, 张凯. 针刺天柱加局部叩刺拔罐治疗急性腰扭伤 150 例. 河北中医, 2003, 25 (1): 73
- [12] 林树茂. 针刺秩边配合推拿治疗急性腰扭伤临床观察. 内蒙古中医药, 2004, (1): 23
- [13] 廖伯年. 针推罐并用治疗急性腰肌扭伤. 针灸临床杂志, 2005, 21 (1): 31
- [14] 尹莹. 针药合用治疗急性腰痛 38 例. 湖北中医杂志, 2003, 25 (6): 52 ~ 53
- [15] 李林, 刘艳杰, 王丽贞, 等. 滞针运动疗法治疗急性腰扭伤 369 例. 针灸临床杂志, 1999, 15 (11): 20 ~ 21
- [16] 胡熙明. 针灸临证指南. 人民卫生出版社, 1991, 227
- [17] 林志强. 鼻针疗法治疗急性腰扭伤 100 例. 福建中医药, 2003, 34 (4): 51
- [18] 胡希军, 张南玲, 李春军, 等. 粗长针针刺膻中穴治疗急性腰扭伤 42 例. 针灸临床杂志, 2002, 18 (1): 45
- [19] 董洪英, 孟向文. 排针透刺法治疗腰痛 50 例. 中国针灸, 2005, 25 (2): 118
- [20] 何清. 针刺攒竹、阳陵泉加手法治疗腰扭伤 66 例疗效观察. 江西中医药, 2002, 33 (5): 35
- [21] 吴小明, 泮三九. 委中穴刺血拔罐治疗急性腰扭伤 54 例. 陕西中医, 1998, 19 (6): 272
- [22] 陆惠新. 针刺治疗急性腰扭伤四法. 针灸临床杂志, 1996, 12 (9): 41

【慢性腰痛】

慢性腰痛又称腰脊痛，以自觉腰部疼痛为主症。腰痛的病因非常复杂，临床上常见于西医学的腰部软组织损伤、肌肉风湿、腰椎病变、椎间盘病变及部分内脏病变等。

中医学认为，腰痛主要与感受外邪、跌仆损伤和劳欲太过等因素有关。感受风寒，或坐卧湿地，或长期从事较重的体力劳动，或腰部闪挫撞击伤未完全恢复，均可导致腰部经络之气血阻滞，不通则痛。素体禀赋不足，或年老精血亏衰，或房劳过度，损伤肾气，“腰为肾之府”，腰部脉络失于温煦、濡养，可致腰痛。从经脉循行上看，主要归足太阳膀胱经、督脉、带脉和肾经（贯脊属肾）。故腰脊部经脉、经筋、络脉的不通和失荣是腰痛的主要病机。

本篇共收录了7位针灸医家的临床治验，有的以痛为腧，温针合谷刺；有的局部取穴为主，温针灸配合走罐；有的循经取穴，手法为先；有的针刺耳针疗法腰腿点；有的采用综合疗法。

针灸治疗腰痛因病因不同，疗效常有差异。风湿性腰痛和腰肌劳损疗效最好；腰椎病变和椎间盘突出引起的腰痛，针灸可明显缓解症状；腰部小关节周围的韧带撕裂疗效较差；内脏疾患引起的腰痛要以治疗原发病为主；因脊柱结

核、肿瘤等引起的腰痛，则不属针灸治疗范围。

一、以痛为腧 温针合谷刺

佟秋芬以温针合谷刺法治疗此病，收到了较满意的疗效。

取穴：以痛为腧。

操作：取2寸毫针，针入深度为0.8~1寸。将针垂直刺入后再将针提至皮下，向左、向右各刺1针，然后将针留至进针时的方向和深度。将剪切好的艾条（长约2cm）置于针柄，点燃行温针法。待其燃尽后，复行针刺操作1次，留针20min，其间再重复针刺操作1次。针刺时应据疼痛部位的大小，针刺点的多少。针间距离大约为3cm。每天1次，10次为1个疗程，疗程间休息2~3天。

中医学认为，本病属于痹证。经云：“邪气客于太阳之络，令人拘挛，背急……”，《素问·缪刺论》又云：“寒气客于背俞之脉则脉泣，脉泣则血虚，血虚则痛……”，以《素问·举痛论》结合本病患者多数腰部怕冷，则本病必属寒痹。而“合谷刺者，左右鸡足，针于分肉之间，以取肌痹。”（《灵枢·官针篇》）温针能温通经络，行气活血，祛湿除寒，二法合用，则有温通经络，祛除顽邪之功，故收到了较满意的疗效。

张某，男，41岁，司机。腰部疼痛7年，时轻时重，近5天来疼痛明显加重。查：L₄~S₁棘突压痛，两侧骶棘肌紧张如板，压痛、叩击痛明显，活动不能，舌淡，苔薄白，脉沉缓。诊为慢性腰肌劳损（双侧），经上述温针合谷刺法治疗，针6次后疼痛明显减轻，2个疗程后诸症消失，随访2个月未见复发。

二、局部取穴 温针灸走罐

郭丽霞长期应用温针灸配合走罐疗法治疗腰肌劳损，取得了满意疗效。

取穴：华佗夹脊穴、阿是穴、腰俞、肾俞、大肠俞、委中。

操作：患者取俯卧位，常规消毒后，用2寸毫针直刺，提插捻转施用补法（委中用泻法），待得气后，纯艾条切20mm小段，用火点燃下端后，插在针柄上，每个艾段燃烧10min左右，待艾段燃完后，继续留针20min。出针后用医用凡士林均匀涂患部，然后取一玻

璃火罐，用闪火法吸附腰部，沿足太阳膀胱经走罐，至皮肤呈紫红色。每天1次，10次为1个疗程。

膀胱之脉，夹脊抵腰络肾，循经远取委中乃四总穴之一，“腰背委中求”，此穴有通络止痛的作用，能通调足太阳经气；针刺腰俞、肾俞和大肠俞穴位，通调太阳经经气，气行则血行，通则不痛，有疏通筋脉之功效。取腰部阿是穴、夹脊穴针刺，以达通其气血、调其经脉、通络止痛的目的。诸穴合用，使阴阳调和、气血畅通。艾叶具有温经通络，行气活血，祛湿逐寒，消肿散结的作用。在针刺同时施用灸法，患者感到腰部灼热感极强，从而改善局部血液循环，促进新陈代谢。温针灸配合走罐疗法集针刺、药物渗透、物理疗法于一体，通过经络、腧穴直达病所从而达到消除肿胀，松解神经根的粘连，解除局部痉挛状态，消除或减轻疼痛的作用。治疗期嘱患者宜卧硬板床休息，以减轻疼痛，缓解肌肉痉挛，防止继续损伤。

张某，女，37岁，高校教师，1999年3月17日就诊。主诉：腰痛半月余。自诉一年前有腰部扭伤史，半月前换衣服时不慎受凉，遂出现腰痛、重着，每遇阴雨天加重。查体：第三、第四腰椎横突处有明显压痛，可触及条索状物，以右侧为重，局部无红肿，直腿抬高试验阴性。X线摄片示：腰椎未见异常。诊断：腰肌劳损。遂用前述方法治疗1个疗程痊愈。

三、循经取穴 手法为先

杨庆林通过多年的临床实践，采用针刺加隔姜灸治疗腰肌劳损，效果理想。

取穴：肾俞、腰阳关、命门、次髂、环跳、志室、委中、阳陵泉、然谷、昆仑，每次选3~5个穴。

操作：对于急重的患者，采用强刺激手法，较大幅度快速左右捻转，一般要求针感向腰部放射。如不能达到针感的放射目的，则可将针稍提起，以捻转为主，提插为辅，刺激强度以病人能耐受为度。留针30min，每隔5min捻针1次，以加强治疗的效果。对慢性腰腿痛的患者，则行中等刺激手法，以提插为主，捻转为辅，使患者感到舒适为度，留针30min。

隔姜灸：取厚约0.3cm的新鲜姜片一块，用针将姜片穿刺数孔，

上置艾柱放在针刺的穴位上，点燃施灸。如灼热剧烈时，可将姜片提起，稍停后再灸，直至皮肤潮红湿润为止。每穴可灸3~5壮，每次选3~5穴。较重的患者每天1次，较轻的患者可隔日1次，10次为1个疗程，一般治疗1~3个疗程。

针刺可以疏通经络脏腑之气，从而达到调整功能的作用。隔姜灸是通过灸火的热力通经活络，达到祛除阴寒、回阳救逆的作用。针刺加隔姜灸治疗腰腿痛对疼痛剧烈、活动功能受限的患者一般通过4~8个疗程治疗，都能使其疼痛消失和减轻。

张某，女，24岁。患者腰部及右下肢疼痛20余天，阴雨天加重，呈跛行。经该厂医务室治疗多天，不见好转，于1985年4月21日转针灸科门诊接受针灸治疗。门诊查抗链球菌溶血素“O”800U，血沉46mm/h。诊断为风湿性腰腿痛。杨庆林采用上法治疗2个疗程，患者疼痛完全消失，检查抗链球菌溶血素“O”为200U，血沉为9mm/h。随访1年未见复发。

四、手针疗法 见效快

祝庆顺采用针刺手针疗法腰腿点为主配合局部针刺拔罐治疗腰痛，取得理想疗效。

操作：患者坐位，先取患者健侧腰腿点，健侧效不佳再取患侧，双侧疼痛取双侧腰腿点。取穴：腕横纹前1.5寸，第二伸指肌腱桡侧及第四伸指肌腱尺侧，局部消毒后，用2根1寸毫针，分别在两穴以30°~45°角进针，针尖向掌面，从伸指肌腱和掌骨间刺入，深5~8分。双手同时捻转两针，留针15~20min，5min左右运针1次，同时让病人做弯腰活动，一般1~3min腰痛即明显减轻。急性腰扭伤每天1次，3次为1个疗程。慢性腰肌劳损每天或隔日1次，10次为1个疗程。可加体针肾俞、气海俞、大肠俞、阿是穴，针后拔火罐，靠近脊柱痛加针人中。

王某，男，44岁，农民。1995年2月3日诊，因弯腰劳动时扭伤腰部疼痛3天，腰部弯腰转动困难。检查：两侧骶棘肌紧张压痛，前屈后伸，左右屈活动受限。诊断：急性腰扭伤。治疗：针两侧腰腿点，同时嘱患者前后左右活动腰部，3min后就逐渐减轻，留针20min后腰痛大减，活动时只有轻微痛感，第二天按原法治疗1次，

腰痛症状消失，腰部活动自如而愈，随访至今未复发。

五、病因不同 治法各异

腰痛的病因很多，其治法与疗效也各异，故必须明确辨证。陈全新治疗经验如下：

(1) 寒湿腰痛

取穴：肾俞、委中，平补平泻。大椎、命门，隔姜片灸5~7壮，退针后在腰天应区（过敏痛区）用梅花针轻度叩刺或拔火罐。

操作：病员俯卧，用3寸毫针从肾俞穴向下平刺，透气海俞、抵大肠俞，使针感沿肾俞向腰部扩散，捻针1~2min后留针20min，留针期间可间歇运针1~2次，以增强针感。临床疗效表明，针感越明显，疗效越佳。在留针同时，施用艾炷隔姜灸，退针后可配合梅花针在腰过敏痛区叩刺或拔火罐，以达温通经络，行气止痛效果。

(2) 外伤腰痛 疼痛随扭挫后出现，临证时应辨明伤在筋肉或筋骨，才能施治得当。

①急性腰肌扭伤：疼痛拘急多局限于腰肌，腰椎无明显畸形及压痛，下肢无牵痛。脉多滑数，舌诊可见小瘀点。

取穴：腰痛点（手背2~3掌骨间过敏压痛点）、委中，用平泻刺法。

操作：嘱病员取舒适侧卧位或坐位，选取手背腰痛点后，用1寸毫针直刺5分，得气后紧持针柄，针尖斜向前臂作中等度往返捻转。待针感上传后嘱病者轻摇动腰部，操作者鼓励病人做腰部活动同时持续捻针，病人摇摆腰部动作可从小到大，如无合并腰椎病变，往往经刺后5~10min症状则明显缓解，然后再刺委中穴，以收疏通足太阳经络气血之功，巩固疗效。

②腰椎扭挫伤：腰脊强直痉急，继而逐渐向下肢扩散。轻症腰足牵痛隐隐，重症疼痛明显，每于活动或喷嚏时则疼痛增剧。直立时腰椎平直，甚至侧弯。椎旁触痛，按之痛向下肢放射。由于经络气血瘀阻不通，每于病部及下肢出现感觉迟钝，病久则肌肉痿削。舌诊可见瘀点或瘀斑，脉多滑数。

取穴：华佗夹脊、肾俞、肝俞、委中、环跳、秩边，交替选用，针用平泻，久留。

操作：病人取俯卧位，施术者先用手揉按痛点周围以疏通气血，缓解病部肌肉痉挛，然后于痛点上方寸许，挟脊沿皮向下平刺，针下得气后用捻转手法运针，待针感向下扩散后再泻刺委中。在留针20min期间可间歇捻针2~3次，同时采用梅花针叩刺过敏痛区至中度潮红。

如选用肝俞、肾俞透刺，则可在腰过敏痛区加用拔火罐，以达活血通络止痛之目的。

腰痛如确诊为腰椎间盘突出，应配合腰牵、按摩手法复位才能根治。

患者，女，腰部剧痛，当地医院诊治，腰仍强痛不止。由家属背来求诊。病人不能站立、端坐，稍移动腰足则呻吟呼痛，眩晕，视之腰椎无畸形、左侧腰肌强直，触痛明显，腰椎旁无明显压痛，脉弦细，舌淡、有齿印。证脉合参，患者肝肾本虚，又因端坐过久气血运行不畅，骤然起立导致气血郁滞肌腠，经络气血不通而痛。病为急性腰肌扭伤。乃为之针刺手背2~3掌骨间腰痛点，得气后针尖斜向前臂，用逆时针方向捻转，病人自觉针感抵肘、肩、背。嘱病者稍移动腰足，痛感已不明显，捻针过百次后，扶其起立，令其逐渐摆动腰部已无所苦。留针30min期间再捻针3次，退针后腰痛若失，只余微胀。再经艾条温灸肝、脾、肾俞，结束治疗。翌日到诊，视之步履如常人，俯仰自如，病痊愈。

六、三法并用 综合治疗

王伟采用针刺结合捏脊、走罐治疗腰肌劳损，疗效满意。

针刺：患者取俯卧位，使腰肌松弛，慢性腰肌劳损属足太阳膀胱经病，取膀胱经的肾俞、大肠俞、委中。穴位常规消毒后，用1.5寸30号不锈钢毫针刺入穴位1寸左右，得气后，根据虚补、实泻的原则，腰肌劳损属中医气滞血瘀，不通则痛，为实证，行提插捻转补泻中的泻法，针感以患者能耐受为宜。间隙动留针30min，10min行针1次。隔日1次，10次为1个疗程。治疗期间不用药物及其它治疗。

捏脊：患者俯卧位。医者立于病人左侧，用双手拇指与食指、中指提捏病人脊背（膀胱经），先从尾骶部开始向上，沿脊柱两侧膀

膀胱经捏至大椎穴水平，共3遍，以皮肤充血潮红为度。

走罐：先在腰背部需要走罐的部位，涂上适量的按摩乳，走罐的部位从关元俞（第五腰椎水平）到膈俞（第七胸椎水平），沿膀胱经腰背部第一、第二侧线，将罐拔紧后，以手握住罐底，稍倾斜，即推动方向的后边着力，前边略提起，慢慢向前推动，这样在皮肤上下循经来回推动3~6遍，至皮肤充血潮红、略为发紫为度。

针刺、捏脊、走罐的次序为：先捏脊，次针刺，再走罐。

慢性腰肌劳损多由劳累过度、跌仆闪挫，经筋络脉受损，或久坐立，各种原因的体位不正，导致气滞血瘀，气血运行不畅，脉络痹阻，发生腰痛。根据“循经取穴”的理论，大肠俞、肾俞属足太阳膀胱经穴，位居腰部，是治疗腰痛、腰肌劳损的要穴，而且腰肌劳损的病人往往在这2个穴位有明显的压痛。委中穴，也为膀胱经穴，是治疗各种腰痛的要穴。拔罐可使局部毛细血管扩张，血液循环改善，血流量增加，组织代谢增强，从而使病变部位尽快得到康复。

七、针刺穴位注射 疏经通络

宋理萍采用针刺结合穴位注射治疗腰肌劳损，疗效显著。

传统针灸：以阿是穴为主配合腰部夹脊、命门、肾俞、大肠俞、足三里、承山、委中等，进针后提插或捻转行针以得气，施以平补平泻法，留针20min，每天1次。

穴位注射：维丁胶性钙注射液1ml加维生素B₁₂注射液500μg，取两组穴位，肾俞加足三里，大肠俞加阳陵泉，避免当天已针刺的穴位。穴位常规消毒，用一次性5ml注射器抽取维丁胶性钙注射液2ml加维生素B₁₂注射液500μg，选取1组穴位，进针后用提插手手法，得气后回抽无血，将药液缓慢注入，每穴1ml，每次1组，两组穴位交替注射，隔天1次，7次为1个疗程。虽罕见有过敏反应，但注射后应嘱患者休息半小时后方可离开。

慢性腰肌劳损属中医腰痛范畴，多因劳累过度，因挫跌仆，经筋络脉受损，或各种原因引起体位不正，都可致气滞血瘀，脉络受阻。亦有素体禀赋不足，或年老精血亏衰，或房劳伤肾，精气虚惫，发为腰痛。以腰部痛缠绵难愈，腰部活动受限，反复发作，遇阴雨

天或劳累加重，得休息减轻为特征。针刺腰部夹脊、腰俞、肾俞、大肠俞、足三里、承山、委中等穴可起到补益肾气、疏经通络、止痛的作用。配合穴位注射既起到刺激穴位的作用，同时所选的药物中维生素 B₁₂ 参与造血功能，更为细胞合成核酸过程中提供辅酶，维持脊髓神经纤维的功能。而维丁胶性钙每毫升内含维生素 D5000U、胶性钙 0.5g，可给人体提供必需的钙剂，促进钙的吸收和维生素 D 的利用。

李某，男，65 岁。2002 年 1 月 20 日初诊。腰腿痛反复发作多年，自觉腰部酸痛，足膝无力，劳累及阴雨天更甚，久行、久站时亦引起症状加重。曾经中药及物理治疗，时轻时重，缠绵不愈。X 片示：腰椎 4、5 棘突轻度增生，余无异常。检查：脊柱生理弧度减少，腰肌轻度痉挛，活动度基本正常，第五腰椎棘突旁两侧骶棘肌压痛弱阳性，直腿抬高试验阴性，屈颈试验（-）。舌质淡，脉沉细。综合症状体征诊断为腰肌劳损肾虚型。采用上述方法治疗 2 个疗程后，诸症缓解，腰部压痛消失，自觉行走较先前有力，随访半年未复发。

参 考 文 献

- [1] 佟秋芬，王秀云．温针合谷刺治疗慢性腰肌劳损 42 例．针灸临床杂志，1999，15（9）：21
- [2] 郭丽霞．温针灸配合走罐法治疗腰肌劳损疗效观察．江西中医药，2006，（6）：48
- [3] 杨庆林，史文慧，张均安．针刺加隔姜灸治疗腰腿痛 225 例．中国民间疗法，2006，14（3）：15
- [4] 祝庆顺．针刺手针疗法腰腿点为主治疗腰痛 76 例．针灸临床杂志，1999，15（2）：28～29
- [5] 胡熙明．针灸临证指南．人民卫生出版社，1991，219
- [6] 王伟，陈勇，张奕．针刺捏脊走罐相结合治疗腰肌劳损 76 例．辽宁中医杂志，2004，31（8）：682
- [7] 宋理萍．针刺结合穴位注射治疗腰肌劳损的临床体会．中医药学刊，2006，24（4）：750

【腰椎间盘突出症】

腰椎间盘突出症又称腰椎纤维环破裂症，或称腰椎髓核突出症，系指腰椎间盘在退行性变化过程中，由于纤维环破裂，髓核突出，压迫神经根所造成的腰腿痛综合征。属中医学的“腰腿痛”、“腰脚痛”、“腰痛连膝”等范畴。

本症多见于青壮年人，有外伤史或腰部劳损史，常引起腰痛、臀部、大小腿、足趾部麻痺、疼痛，脊柱侧弯，腰活动和直腿抬高受限，引起肌力、反射、感觉的改变等一系列临床表现。本病主要与外伤，尤其是积累劳损引起纤维环破裂有关；其次受寒也为其一个诱因，受寒后使腰背肌肉痉挛和小血管收缩，影响局部的血液循环，进而影响椎间盘的营养。

本篇收录了 17 位针灸医家的临床治验，有的以夹脊穴为主，有的以腰突点、腰眼为主，有的取足三阳郄穴，有的采用辨证取穴，有的取人中、委中为主；从针刺手法来看：有的采用白虎摇头法，有的采用傍针刺，有的采用接气通经法等；从治疗方法来看：有的以针刺为主，有的采用针推并用，有的采用针刺配合中药等。

针灸对本病有较理想的治疗效果，但重症患者要求绝对卧床并且一定睡硬板床。病情好转后，适当进行腰背肌功能锻炼，促进康复，

可选择拱桥式或飞燕式锻炼方法。嘱患者坚持锻炼，才可取得良好效果。

一、脊柱九针 定位明确

腰椎间盘突出症是引起腰腿痛的常见疾病，刘进先采用自拟“脊柱九针疗法”治疗本病，取得理想疗效。

取穴：根据神经根症状定位，并结合 CT、MRI 检查结果，主穴选用突出椎间盘的相应椎体及其上下两个节段椎体棘突下；棘突旁开 1.5 ~ 1.7cm，向上 0.2 寸，即相当于夹脊穴，以上共九点。辅以患侧下肢的环跳，双侧太溪、委中、阳陵泉等穴。

操作：选用 28 号，1.5 寸毫针，腰部进针点直刺 1.5 寸，行针得气，针感有向下肢传导者疗效更佳。电针穴位共 3 组，同侧夹脊穴第一针和第三针为一组，双侧阳陵泉为另一组。接 G6805 型电针机，采用疏密波，电流强度以患者舒适为准，每次 20min，每天 1 次，10 次为 1 个疗程。

腰椎间盘突出症属于中医学痹证范畴，其发病由于肝脾肾不足，气血亏虚，卫阳失调，以致风寒湿邪乘虚而入，搏于肌肉、经脉、关节。气血运行不畅，瘀血内停，不通则痛，故导致下腰部疼痛或坐骨神经痛。针刺治疗具有通经活络，活血祛瘀的作用。脊柱九针疗法与《灵枢·官针》篇中的齐刺法相似，“齐刺者，直入一，傍入二，以治寒气小深者。或曰三刺，三刺者，治痹气小深者也。”而“九针疗法”的取穴是根据突出椎间盘的位置来定位，故“九针疗法”较常规取穴针刺疗法具定位科学，针对性强，且直达“地部”，患者的针感强，疗效明显的特点。

患者，女，52 岁，退休。因腰部疼痛，伴左下肢放射性疼痛 1 天于 2001 年 2 月 8 日来针灸科就诊。查体见腰前屈活动明显受限，腰椎左侧偏歪，腰肌紧张，L₄ ~ L₅ 棘突下及椎旁压痛，直腿抬高试验 40°。腰椎 CT 检查示“L₄ ~ L₅，L₅ ~ S₁ 椎间盘突出”。诊断为急性腰椎间盘突出症。针刺治疗采用“九针疗法”，治疗 1 个疗程后，患者症状已减轻一半，后巩固治疗 2 个疗程后症状完全消失，随访半年未复发。

二、夹脊穴 短刺

欧阳八四采用短刺加电针夹脊穴治疗腰椎间盘突出症，取得了较满意的效果。

取穴：相应节段的华佗夹脊为主，环跳、承扶、委中、阳陵泉、足三里、悬钟、昆仑、足临泣为辅。

操作：采用短刺法，得气后在夹脊穴上接通针灸治疗仪（苏州华佗针灸用品厂生产），以连续波刺激，电流频率约 100 ~ 150 次/min，电流输出大小以患者感觉舒适为宜；环跳、阳陵泉、昆仑等，平补平泻手法，可接通电针，留针 30min，每天或隔天 1 次，10 次为 1 个疗程，疗程间休息 3 ~ 5 天。

腰椎间盘突出症属于中医痹证或筋伤范围，大多表现为肝肾不足，筋骨不坚，血瘀经脉，滞而不通，痰瘀互结为其主要病理因素。治拟行气活血、宣痹通络为先。采用短刺华佗夹脊穴，体现中医直达病所的理论，属局部取穴，配合电针，使局部既产生电兴奋，又产生针刺的通调作用，由此改善局部微循环，减轻神经根的水肿，缓解神经根等组织的压迫，使致痛物质的释放得到抑制，也相应地改善了临床症状，使经气流畅而痛止。

李某，女，46 岁，工人。1999 年 4 月 15 日就诊。2 月前因搬动重物时扭伤腰部，经治疗腰部疼痛好转，但出现左下肢疼痛，反复发作，1 周前因受凉症状加重。诊时患者左腰骶部及下肢疼痛，伴下肢远端麻木，行走不利，咳嗽时症状加重。查 $L_4 \sim S_1$ 左侧旁 1 横指处明显压痛，并向左下肢放射，直腿抬高试验左腿 50° （+），右腿 75° （-），挺腹加压试验（+）。诊断为腰椎间盘突出症，腰椎 CT 亦证实之。予短刺 $L_4 \sim S_1$ 夹脊，合用环跳、阳陵泉、足三里、悬钟、昆仑、足临泣针刺，每天 1 次。3 次后诸症明显减轻，7 次后症状与体征基本消失，后又巩固治疗 5 次，随访半年未发。

三、水针注射 华佗夹脊穴

腰椎间盘突出症又名腰椎间盘突出纤维环破裂症，临床上以 L_4 、 L_5 和 L_5 、 S_1 的椎间盘最易发生病变。一旦患病，病程长，痛苦大。宫玉锁以水针华佗夹脊穴及阿是穴治疗该病取得了满意的疗效。

取穴：病变椎体及上两个椎体和下一个椎体两侧的华佗夹脊穴。有压痛、条索者更佳。采用审、切、循、按、扣等五种中医触诊手法，沿腰及下肢的足太阳膀胱经寻找痉挛、结节、条索及敏感压痛点为治疗点，一般穴少而精，仅1~3个穴位即可。

操作：取俯卧位，常规消毒，深刺用长针头，浅刺用短针头。抽取维生素B₁注射液2ml，维生素B₁₂注射液1ml混合，刺入穴位有针感后，急性腰腿痛用快速推注，慢性发作病用缓慢推注。华佗夹脊穴有明显压痛者为主穴，宜多推注。

腰椎间盘突出症多数是由腰部急、慢性劳损引发的椎间盘纤维环破裂所致，遇风、湿、寒、凉复发。水针疗法不仅能起到针刺作用，还能起到药物营养神经，消除水肿，缓解肌肉痉挛，促进髓核还纳等作用。

患者，男，37岁，1999年7月10日初诊，腰痛伴下肢刀割样疼痛并行走困难3周，无明显诱因。查：直腿抬高试验左腿90°，右腿45°，加强试验左（-），右（+），踝趾背伸及趾屈右侧较左侧减弱，L₃~L₅棘突旁压痛（+），CT提示：L₄~L₅，L₅~S₁椎间盘突出症。用本法隔日1次，连续治疗5次，症状明显减轻，治疗10次后，症状消失，未查到阳性体征，嘱患者行功能锻炼，注意休息，恢复工作。

四、扬刺为主 综合治疗

高雅贤应用《内经》扬刺法配合穴位注射及中药离子导入治疗腰椎间盘突出症，取得较好疗效。

针刺：主穴：取肾俞、腰痛穴（位于椎间盘突出侧的同侧，距棘突下旁开2寸处）、髂点（在腰眼穴下1~2寸处）、居髂。配穴：环跳、秩边、殷门、委中、飞扬、足三里、昆仑。

操作：常规消毒，主穴用扬刺法（直入一、傍入四），选用31号，2.5寸毫针，取腰痛穴直刺1~1.5寸，刺在病变腰椎节段的横突上，施捻转提插手法，令得气，针感传至足；再在其上下左右0.4寸处各刺一针，针尖朝向主穴，用捻转手法使其得气，针感向深层与四周扩散。髂点、居髂穴直刺1~2寸，针要深达骨面，上提0.1寸，施捻转提插手法，令得气，针感传至足，其余四针刺法同腰痛

点。肾俞穴直刺 1.5~2 寸，刺在第二腰椎横突上，施捻转提插手
法，令得气，针感传至足。配穴用常规针刺法，留针 30min，每日治
疗 1 次，10 次为 1 个疗程，疗程期间休息 2~5 天。

中药离子导入：生草乌、细辛、桂枝、乳香、没药各 15g，伸筋
草、透骨草、独活、威灵仙、鸡血藤、牛膝、地龙各 20g，木瓜
30g。上药煎煮取汁 200ml，兑入等量陈醋备用。用推按运经仪治疗，
每次根据病情选 2~4 个 8cm×6cm 大小的药垫，在药液中浸泡后分
别放置腰痛点、髂点、居髂穴或阿是穴处，将 2~4 个电极分别放在
药垫内，选择中频脉冲电流，调整电流强度至患者能耐受为度，每
次 30min，每天 1 次。

穴位注射：取 10ml 一次性注射器及 5 号针头，抽取当归注射液
9ml、维生素 B₁₂注射液 1ml 混合，于 L₁~S₁，取 5~6 个夹脊穴常规
消毒后刺入，提插得气后，抽无回血再缓慢推药，每穴 1.5~2ml。
出针时用消毒干棉球按压针孔，避免出血及药液外溢。隔日 1 次，
10 次为 1 个疗程。

男，40 岁，2005 年 12 月 12 日初诊。主诉：左下肢疼痛 1 年，
加重 5d。患者 1 年前因劳累过度，及长期居住于潮湿阴冷工棚，出
现左下肢放射性疼痛，咳嗽、伸腿时疼痛加重。曾服用中药、西药
及推拿治疗，症状减轻。5 天前因工作中感受寒湿，腰痛伴左下肢疼
痛加重，不能直腰，咳嗽或喷嚏后疼痛加重，跛行，舌淡苔白，脉
沉紧。查体：L₄~L₅、L₅~S₁ 左侧棘突下旁开 2 寸处压痛，放射痛，
左侧髂点、秩边、殷门、委中、飞扬穴压痛。左直腿抬高 30°，加强
试验（+），后伸试验（+），左膝腱、跟腱反射减弱。腰椎 CT 示：
L₄~L₅ 椎间盘突出，硬膜囊及左侧神经根受压；L₅~S₁ 椎间盘膨出，
硬膜囊轻度受压。西医诊断：腰间盘突出症；中医诊断：腰痛，属
寒湿痹阻。按上法治疗 3 次后，症状明显减轻；治疗 10 次后，疼痛
完全消失，生活自理，直腿抬高试验达 80°，临床治愈。1 年后随访
未复发。

扬刺法是《黄帝内经》十二刺法之一。《灵枢·官针》曰：“扬
刺者，正内一，傍内四而浮上，以寒气之博大者也。”本法适宜治疗
寒气浅而面积较大的痹证。高雅贤根据扬刺法的特点，改良此法使
针刺深达骨面，直至病所，针感向深层与四周扩散，以达祛寒除湿、

活络舒筋之功。临床上腰椎间盘突出症急性发作时，病变椎体的一侧上下各1寸，向左或向右2~3寸处都有压痛、放射痛，病灶范围大，部位较深，一般针刺法见效甚微。《灵枢·始终》云：“久病者邪气入深，刺此病者，深内而久留之。”故高雅贤用改良扬刺法，五针同用，刺激量大，针感强，刺激面广，可作用于病变部位较深之痹痛。离子导入，通过热能和药物的双重作用而取效。热能疏松腠理，开发毛孔，活血通络，松弛痉挛经脉，药物能对症治疗。病变腰椎节段的夹脊穴注射当归注射液具有活血化瘀、通络止痛之功，维生素B₁₂可改善组织代谢，营养神经。穴位注射可改善局部的血液循环，促进局部充血肿胀的改善，从而达到止痛的作用。

五、腰突点-腰眼 短刺法

吴世忠在临床上采用短刺腰突点为主治疗腰椎间盘突出症，疗效显著。

取穴：主穴：腰突点、腰眼。腰突点位于椎间盘突出侧的同侧，距棘突间隙中点3~3.5cm处。配穴：下肢痛偏足太阳经配患侧秩边、委中、束骨，偏足少阳经配患侧环跳、阳陵泉、足临泣。

操作：腰部和臀部穴位选用3寸针灸针，下肢穴位选用2寸针灸针。穴位常规消毒，腰突点进针后，慢进直达横突，然后退针稍许，以25°角向下向内沿横突的下缘进针，直达神经根，此时常出现麻、酸、胀等异感直传至足。若未出现，则提针少许，稍变针刺方向再进针，直至出现异感。秩边和环跳进针后深刺直至出现麻木或放电感直传至足。其他穴位进针得气后平补平泻。治疗每天1次，10次为1个疗程，疗程间休息3天。

“短刺法”出自《灵枢·官针》：“短刺者，刺骨痹稍摇而深之，致针骨所，以上下摩骨也。”可治疗深部病痛。主穴腰突点位于患侧的椎间孔神经根处，此处即受突出的椎间盘压迫，短刺此处可疏通局部气血；针刺腰眼亦可疏通腰部气血。针刺两个主穴可促进突出椎间盘和水肿神经根及周围组织的血液和淋巴回流，改善神经根的缺血、缺氧，降低致痛物质的浓度，消除组织水肿，祛除腰部的瘀血和水湿，使腰部的气血重新畅通。配穴环跳、秩边为足少阳、足太阳经脉气所发；委中、阳陵泉为足太阳、足少阳经脉气所入，为

合穴，“主逆气而泄”；束骨、足临泣乃足太阳、足少阳脉气所注，“主体重节痛”。诸穴远取，有行气活血、祛风除湿、强健腰膝、宣痹止痛、通经活络之功，如此近取与远取相佐，足太阳、足少阳经的经气重新畅通，“通则不痛”。

曹某，女，42岁，教师，2004年8月2日就诊。自诉：腰及右下肢因搬物扭伤，致疼痛3年余，时轻时重，3天前受寒又作，现腰及右下肢疼痛较剧，不能行走，不能直腰，咳嗽尤剧。查体： $L_5 \sim S_1$ 右侧3cm处压痛及放射痛阳性，右委中、承山压痛，右直腿抬高 $30^\circ (+)$ ，加强试验 $(+)$ ，屈颈试验 $(+)$ ，“4”字试验 $(-)$ 。经做CT检查示 $L_5 \sim S_1$ 椎间盘向右突出，压迫右侧神经根。诊断为腰椎间盘突出症。经上述方法治疗8次后症状及体征明显改善，治疗16次后痊愈，随访1年无复发。

六、深刺为主 配刺络拔罐

皮敏多年来采用针刺加刺络拔罐的方法治疗腰椎间盘突出症，取得满意疗效。

取穴：相应病变腰椎夹脊、阿是穴、环跳、秩边、委中、阳陵泉；病变在足少阳经者，加风市、足临泣；在足太阳经者，加承扶、昆仑。

操作：患者侧卧位，患侧在上，选定穴位，皮肤常规消毒后，取3寸毫针，针刺环跳、秩边、委中，快速进针后，提插捻转，针感以放电感达到肢末为度，不留针。腰椎夹脊穴用1.5寸毫针，深刺1~1.2寸，视肌肉厚度而定，针尖向脊柱斜刺，并使针感向下肢放射；余穴用1.5寸毫针，得气后施以平补平泻法，留针30min。起针后，选定相应病变腰椎夹脊穴或阿是穴，每次1穴，常规消毒后，用三棱针点刺出血，后用口径适合的火罐在其上拔罐，留罐时间5min，或以罐内出血停止为度，拔罐后用消毒干棉球擦拭干净。针刺每天1次，10次为1个疗程，休息3天，继续下1个疗程；刺络拔罐每日或隔天1次，3~5次为1个疗程。

腰椎间盘突出症在痹证中属于“骨痹”的范畴，《灵枢·官针》曰：“输刺者，直入直出，深内之主骨，以取骨痹。”本法针对相应病变腰部夹脊穴等有关穴位深刺以达到治骨痹的目的。本病乃经络

气血阻滞所致，且通常缠绵难愈。《灵枢·寿夭刚柔》有云：“久痹不去身者，视其血络，尽出其血。”故用三棱针刺络拔罐，以通经络行气血，散瘀消肿止痛。两法合用，事半功倍。治疗期间，注意休息，适当配合功能锻炼，对本病的预后帮助很大。

李某某，男，45岁，干部，1995年10月21日初诊。主诉：腰骶部疼痛及左下肢放射性疼痛5个月。曾服用中药及牵引治疗4个月，症状无明显改善。检查时见脊柱侧弯，直腿抬高试验（+），胫骨前皮肤感觉迟钝，足背伸肌和踝伸肌肌力减弱，L₄、L₅椎相当于夹脊穴位置及足少阳经循行下肢路线多处压痛明显。MRI示：L₄~L₅椎间盘突出。取穴：针刺L₄、L₅夹脊以及秩边（左）、环跳（左）、委中（左）、阳陵泉（左）、风市（左）、足临泣（左）。针刺后选L₄、L₅夹脊或阿是穴刺络放血拔罐，每1次。先后共治疗3个疗程，患者症状及主要体征完全消失，功能恢复正常，达到临床治愈。

七、辨证取穴 气至而有效

严萍应用针刺配合电针治疗腰椎间盘突出症，取得良好效果。

取穴：气滞血瘀：肾俞、大肠俞、环跳、委中、阳陵泉、悬钟；寒湿凝滞：三焦俞、气海俞、关元俞、足三里；肝肾亏损：肾俞、命门、环跳、秩边、委中、承山、三阴交。

操作：皮肤常规消毒后，采用29号不锈钢毫针，快速进针，针刺得气后要求针感向下肢远端传导，接通WQ-10C型电针治疗仪，用两组导线按正负极分别夹在针柄上，采用疏密波，刺激强度以患者感觉适度为宜（如强度过强，超出患者适度，可使患者肌肉痉挛，疼痛加剧；如强度太弱，则无治疗效果。）达到“气至病所，通则不痛”的目的。每次治疗30min，每天1次，10天为1个疗程。

腰椎间盘突出症病因病机多为劳累过度或跌仆闪挫致经络受损，气滞血瘀；或因风寒湿邪侵袭人体，流注于经脉引起营卫不和，气血痹阻，不通则痛。本着“经脉所通主治所及”之理，并着重强调针刺得气及针感的传导，加用电针以激发经气，疏通经络达到“气至病所，通则不痛”，所谓“气行则血行”。气机通畅，则瘀血自

散，从而止痛。

患者，男性，54岁，工人，于2003年10月17日就诊。主诉：右侧腰、臀部至大腿、小腿后侧疼痛4天。患者9天前无明显诱因出现右侧腰痛，1天后臀部及下肢后侧也出现疼痛，自服止痛药后疼痛不减，故求治于针灸科，右侧肾俞穴及臀部有明显深压痛，活动时腿部疼痛加剧，疼痛以刺痛为主，痛点固定，右侧直腿抬高试验(+)。CT腰椎扫描示：L₃~L₅椎间盘突出。舌质紫黯，有瘀斑，脉弦紧。诊断：L₃~L₅椎间盘突出。治以活血化瘀，通络止痛。采用2寸毫针刺右侧肾俞穴，用3寸毫针刺右侧环跳，让患者产生触电样传感到小腿，配以承扶、殷门、委中、承山、昆仑等穴，并在委中、昆仑二穴加用电针，患者有发热感，留针30min，治疗1次后，患者感疼痛有所减轻，活动也有所好转。连续治疗10次后，症状完全消失，至今未复发。

八、针推并用 疏经通络

刁洪亮用针刺推拿方法治疗腰椎间盘突出症，疗效较好。

针刺：取腰部肾俞、大肠俞、夹脊穴、阿是穴，常规消毒后，用毫针向脊柱针刺1.2寸左右，得气后接电针治疗仪，选用疏密波或连续波，电流强度以微麻跳动、舒适为佳，不得过强刺激，留针20min出针。继取下肢穴位，根据病患部位的不同而按不同经络取穴，痛麻在下肢的后侧、病在膀胱经者取环跳、承扶、委中、昆仑，痛麻在下肢的外侧、病及胆经者取环跳、风市、阳陵泉、丘墟。针刺环跳务必要求针感传至足心或趾端，其他穴位刺法得气后加电疏密波或连续波（同前），留针20min出针。

推拿：①松法：患者俯卧位，术者用按揉、擦法在患者脊柱的两旁膀胱经及臀部、下肢后外侧施术5min，以放松局部肌肉。②点拨法：用拇指或肘尖点压肾俞、大肠俞、阿是穴、委中、阳陵泉，以酸胀为度；再用拇指在痛点上与肌纤维垂直方向用力弹拨3~5次，以患者能忍受为度。③扳法：患者侧卧，贴近床面的下肢自然伸直，另一下肢屈曲，术者面对患者而立，一手固定肩前部，另一手按于臀部，两手同时适度用力，方向相反，一推一扳，可听见“喀嚓”一声。换另一侧用同样方法施术1次。患者俯卧位，双下肢

自然伸直。术者一手按在患者的腰部，另一手前臂托住双膝稍上部用力向上拔伸后扳 3~5 次。④迭法：患者仰卧，双下肢屈膝屈髋，术者立其侧位，左手前臂按压在受术者双膝关节的稍下方，右手托置患者腰骶部，一压一提，相反用力，使受术部位尽量屈曲。⑤摇法：患者仰卧，双下肢屈膝屈髋，左右各摇晃 3~5 次。⑥拔伸牵引法：患者俯卧位，双手紧握床头，助手握住双踝关节稍上部位，用力向后与身体平行牵引，术者双手重叠于患者腰部，随呼吸术者双手用力下压。⑦结束手法：患者俯卧，用揉法、擦法，放松肌肉，最后用桑枝棒拍打腰骶部及下肢后外侧而结束。其目的在于解除肌肉痉挛，拉宽椎间间隙，使腰椎间盘突出回纳，改变突出位置，松解神经根粘连，改善局部血液循环，减轻或消除对神经的压迫。

李某，男，于 2003 年 6 月 15 日初诊。腰痛伴右下肢放射痛，反复发作已有 6 个月，加重 1 月余。服药、理疗、针灸按摩、外贴膏药等治疗无效。腰胀痛，右下肢剧痛、麻木、肢冷，行走站立时加重。查腰部活动明显受限，L₄、L₅、S₁ 右侧棘旁压痛，并向右下肢放射痛，直腿抬高试验（+），腰椎 CT 检查示 L₁、L₂、L₃ 椎间盘膨出，L₄、L₅、S₁ 椎间盘突出。经针刺推拿结合治疗 7 天，疼痛消失，惟患肢稍感麻木，服中药善后，麻木消除。2 年未复发。

九、足三阳郄穴 通络止痛

赖远征以针刺足三阳经郄穴为主，同时配合穴位注射当归注射液治疗急性期腰椎间盘突出症，获得理想疗效。

取穴：常规穴取委中、环跳、阳陵泉、肾俞、大肠俞、腰阳关、阿是穴。证属足少阳经型取足少阳经郄穴外丘；证属足太阳经型取足太阳经郄穴金门；证属足阳明经型取足阳明经郄穴梁丘；证属混合型取外丘或金门或梁丘。

操作：常规消毒后，选用 28 号，1~1.5 寸毫针刺入郄穴，边刺边问患者感觉，以患者诉下肢有麻木感或胀感为度；其余穴位根据具体情况分别选取 28 号，1.5~3 寸毫针，亦要求针刺有较强得气感，选用 G6805 II 型电针仪，导线加在同侧郄穴、肾俞穴、阿是穴或环跳、阳陵泉或委中。选用疏密波，强度以病人能耐受为度，通电 30min。每天 1 次，10 次为 1 个疗程。

穴位注射：取2个阿是穴，用当归注射液。局部消毒后，刺入后得气，回抽无血，每穴注入药物2 ml，每次共注入4ml，每天1次，10次为1个疗程。

腰椎间盘突出症主要表现为足三阳经循行部位疼痛，故取足三阳经郄穴通络止痛，配以腰部督脉穴腰阳关和足太阳膀胱经穴肾俞、大肠俞、环跳、委中及阿是穴以疏调腰部经络之气，筋会阳陵泉舒筋通络增强郄穴止痛作用；同时配合穴位注射当归注射液活血止痛。

十、人中-委中 强刺激

杨艺用针刺疗法治疗腰椎间盘突出症，取得一定疗效。

取穴：人中、委中为主穴，取大肠俞、环跳、阳陵泉、悬钟、昆仑为配穴。

操作：先取仰卧位，针人中，捻转360°，用雀啄泻法，施术至患者眼球湿润为度，然后抬直患腿，针刺委中，使下肢抽动3次为度，不留针；再取侧卧位，大肠俞直刺3~5寸，环跳直刺2~3寸，使针感均向下肢放射至足踝部直至趾端为宜；最后针悬钟和昆仑穴，直刺0.5~1寸，令局部有酸胀感为宜，若疼痛沿胆经放射，则取风市、阳陵泉、足三里、悬钟。并根据针刺穴位、疼痛处面积大小，将鲜生姜片切成厚约0.2~0.3cm，上置艾绒点燃后放于患处，至皮肤潮红。1个月为1个疗程，疗程间休息1周，再行下1个疗程。治疗期间，患者卧硬板床休息。

腰椎间盘突出症属中医学“痹证”、“腰腿痛”范畴，辨证多与脾肾精血亏虚、督脉失养有关，加之机体感受风、寒、湿邪或跌仆挫伤，以致脉络闭阻，气血失和，不通则痛。从本症疼痛的部位来看，多位于督脉及膀胱经循行的部位，故针灸取穴多取此两经的穴位及夹脊分布的夹脊穴，此外兼取脾经、肾经、任脉等补元固本之穴或治疗腰痛的特定穴等，使经络气血得以宣通，则其痛自止。并且针灸配合其他非手术的中医外治疗法，其协同作用更能使治疗效果提高。

患者，女，51岁，教师。腰骶臀腿痛4天。有慢性腰痛史7年，4天前因劳累后引发腰腿痛，剧痛难忍，行动困难，夜不能寝，腰痛放射至左小腿外侧酸痛，遂来本院求医。临床检查：腰椎明显向左

侧弯，两侧腰椎棘突旁肌肉痉挛，压痛明显，髂胫束、骶部及臀上神经均有明显压痛。直腿抬高试验左侧 15° ，右侧 30° 。右膝反射引出，左膝反射未引出，腰CT示 $L_3 \sim S_1$ 小关节增生， $L_4 \sim L_5$ ， $L_5 \sim S_1$ 椎间盘膨隆并向后突出。在明确诊断为腰突症后，经针刺加灸治疗3次后症状明显缓解，疼痛减轻。治疗15次后症状和体征基本消失，随访2个月疗效稳定。恢复工作，得以痊愈。

十一、针推穴注 标本兼治

梁树波应用针刺、推拿、穴位注射综合疗法治疗腰椎间盘突出证病，取得较好的疗效。

针刺：主穴：腰部夹脊穴、肾俞、阿是穴。配穴：秩边、环跳、殷门、承扶、委中、承山、昆仑、太溪、三阴交、阳陵泉、太冲（下肢单取患侧）。操作：患者取俯卧位，常规消毒后，取1.5~3寸毫针垂直于皮肤直刺进针，当产生酸、胀、重之感，提插捻转至穴位周围产生电击样灼热感，并向患肢放射至小腿部为佳。夹脊穴及阿是穴可选用电针疏密波治疗，输出调节至肌肉微颤动、患者可耐受为度。每次留针30min。每天1次，7次为1个疗程。

推拿：①令患者俯卧于治疗床上，医师用抚摩法、推法、掌揉法及单手掌按压法等手法沿脊柱两侧从上往下、由轻到重反复揉按5~6遍以放松腰部肌肉。②用双手掌加压法、肘关节鹰嘴加压法松弛紧张的腰骶部筋膜及梨状肌。③沿坐骨神经循行路线选取阿是穴进行点按。④采用双侧腰部斜扳法。⑤牵引下复位法：患者俯卧位，令两助手分别扶持患者腋下及双踝部反向用力持续牵引，术者按压椎体突出部位，腰部疼痛者可用1%利多卡因6~8ml局部痛点注射后再进行此法，急性期腰部疼痛严重时慎用此法。⑥最后用轻手法自腰至双下肢抚摩整理以收功。卧床休息10~15min可活动。1~2天后再做腰部肌肉及功能锻炼，隔2~3天后，再行第2次推拿，7次为1个疗程。

穴位注射：分2组取穴。第1组：肾俞、大肠俞（均双侧）；第2组：环跳、足三里、阳陵泉、承山、太溪（均患侧）。药物选用复方当归注射液2ml，夏天无注射液2ml、维生素 B_6 2ml。2组穴位交替注射，每穴2ml，每天或隔天1次，7次为1个疗程。

腰椎间盘突出症属中医学痹证范畴，其主要病机为感受风寒或坐卧湿地，经筋脉络受损，瘀血凝滞所致。针刺治疗可以扩张其周围血管，改善微循环，增加血流量，清除组织间隙的水肿，加速组织代谢，松解周围组织的粘连，使神经根无菌性炎症得以消除。而有效的推拿手法可以降低椎间盘压力，增加盘外压力，促使突出髓核有所回纳或吸收，为受损伤纤维环的修复创造有利条件，并改变突出物与神经根的位置，松解粘连，解除或减轻突出物对神经根的压迫。因此，综合疗法治疗本病可以标本兼治，动静结合，是保守治疗的有效方法。

孙某，男，23岁。自诉2天前打篮球扭伤腰部，当时感觉患部疼痛，但还能行动。1天后，症状加重，自感左下肢疼痛难忍，酸麻胀痛无力，行走困难。检查L₄棘突左侧压痛明显，并向大腿后侧放射到左足跟部，直腿抬高试验（+）。腰部CT示：L₄~L₅间盘突出。采用上述方法治疗1个疗程后，腰部及左下肢未再次出现疼痛，直腿抬高试验（-），行走正常。

十二、腰夹脊穴 傍针刺

于秀梅采用“傍针”刺法治疗腰椎间盘突出症，获肯定疗效。

取穴：主穴：病变相应节段的腰夹脊穴、白环俞。配穴：秩边、阳陵泉。下肢症状外侧重者，加悬钟、丘墟；后侧重者，加委中、承山、昆仑。

操作：患者取卧位或侧卧位（侧卧时患侧肢体在上），腰、臀部及患侧下肢充分暴露。取26号不锈钢毫针，用75%酒精棉球消毒穴位处的皮肤后，将针迅速刺入皮下，然后调整方向，将针刺入深层。腰臀部穴位要采用傍针刺，即在穴位正中针刺后，旁边加刺一针。腰夹脊穴针尖要向椎体方向斜刺。施用提插手手法，至针下有得气感为止。针用平补平泻法，中等刺激强度，留针20min，每天1次，10次为1个疗程，疗程间隔3天。

针刺治疗腰椎间盘突出症，因所选穴位附近多伴有脊神经或坐骨神经走行，故可解除局部肌肉痉挛、消除神经根水肿和血肿。临床采用傍针刺法，可加强刺激量，增强局部针感，充分发挥针刺疏通气血的作用，促进局部炎症的吸收而达“通则不痛”的目的。

十三、白虎摇头 泻实通经

吴越针灸并用，针刺以白虎摇头手法治疗该病，疗效显著。

取穴：根据 CT 片取与椎间盘突出部相对应的夹脊穴、肾俞、大肠俞、气海、秩边、环跳、委中、承山、阳陵泉。

操作：单侧型：针刺取患侧上述穴位，灸取健侧，同时进行；双侧型：针刺取双侧上述穴位，先针刺，后施灸，每穴隔姜灸 3~5 壮。常规消毒后，取 28 号 3 寸毫针分别在上述穴位直刺进针，得气后，以左手押在针穴上方，右手持针柄，似摇“船中之橹”样，将针体向左右摇摆，在向前摇着转针时，针成半圆型，由右下方摇着进至左上方，在向后摇着转针时，针成半方形，由左上方退至右下方，成“L”形。如此反复摇摆，使针感下传。左右摇针的动作必须用力均匀自然，左右对称，幅度不可忽大忽小，速度不可忽快忽慢。每穴施术 6~18 次为宜，手法施毕即将针拔出，缓慢揉按针穴。每日针灸 1 次，15 天为 1 个疗程。

临床上，腰椎间盘突出症以消除神经根及其周围组织的水肿、充血、粘连等无菌性炎症为治疗的关键，故针刺时应以“泻法”为宜，以泻其“实”。“白虎摇头法”又称“赤凤摇头”，《针灸大成》明确指出：“赤凤摇头手法，泻”，以此手法施治，可达泻实通经、活血消肿、散结止痛、祛邪扶正的作用。同时，泻患侧补健侧或先泻后补的方法，又可对腰椎双侧及前后肌群进行适宜的补泻调整，可有效缓解肌肉的痉挛状态，减轻受压神经根的水肿，松弛受损肌肉的张力，使病损腰椎恢复平衡状态。

十四、后顶交叉透刺为主 配合运动疗法

王小兰采用后顶穴透刺运动针法结合体针治疗腰椎间盘突出症取得较好疗效。

取穴：主穴：后顶；配穴：根据疼痛部位循经取穴，常用穴位如下：腰椎夹脊穴、大肠俞、小肠俞、秩边、环跳、风市、委中、阳陵泉、承山、昆仑，每次选 6~10 个穴位，随症可适当加减，相应夹脊穴每次选用 1~2 个。

操作：患者取坐位，易晕针者取卧位。穴位常规消毒后，用 28

号 1.5 寸毫针从后顶上 2 分处向该穴斜刺，进针后即沿皮下针刺，中央型患者针尖朝向风府穴刺入 1.2 寸左右，行捻转平补平泻法 20s；若单侧型患者，行针后将针仍慢提至皮下，针尖斜向患肢对侧（沿人字缝）方向，平刺 1.2 寸左右，行针手法及时间同上；双侧型患者针刺入一侧行针后再慢提至皮下刺入另一侧，行针手法及时间同上。行针时令患者缓缓伸展腰部，用力蹬踹患肢，运动髋、膝关节。每 5min 行针 1 次，如此反复 3 次，让患者起立，做屈伸旋转腰部、蹬屈下肢活动 10 ~ 15min 后取针。配穴常规针刺，局部得气后用 G6805 电针仪，连续波，留针 30min，取针后局部辅以拔火罐治疗。

中医学认为腰椎间盘突出症多由于劳累过度或跌仆闪挫或感受风寒湿邪侵入肌体日久等原因，以致经络受损，气血阻滞，不通则痛。其病位在腰部，乃督脉、足太阳膀胱经循行所过之处，故选用后顶穴作为主穴，随症多向透刺太阳经脉，启动督脉阳气，使阳气直达太阳经脉，溢而下行，疏通经络，调畅气血，通则不痛。并在行针留针时配合运动，可使经气迅速抵达病所，使痉挛紧张的筋肉得到舒展放松，粘连韧带松开，增强弛缓肌肉的张力，促进局部组织的解剖复位，使腰椎逐渐恢复平衡状态。

十五、接气通经 气至病所

张旋运用接气通经针刺法治疗腰椎间盘突出症，取得满意疗效。

取穴：双肾俞、阿是穴、环跳、委中，若患者兼有大腿外侧的麻木疼痛，则加取风市、阳陵泉。单穴均取患侧。

操作：患者取侧卧位，患肢在上，健肢在下，并使患肢屈膝。穴位常规消毒后，取 28 号 2 寸毫针在双肾俞快速直刺进针，使穴位周围产生酸胀重之针感。然后取 28 号 2 寸或 3 寸毫针在阿是穴快速直刺进针，至一定深度后，行雀啄法，使产生向臀部方向的针感传导或针感直接传导到足部。再取 28 号 3 寸毫针在环跳穴快速直刺进针，至一定深度后，行雀啄法，使产生向患肢下侧的经络传导或过腘窝或一直传导到足底。取 28 号 1.5 寸毫针在委中穴快速直刺进针，至一定深度后，行雀啄法，使产生沿经络方向向小腿和足部传导的针感，可行气至足底或足尖。若有大腿外侧的麻木疼痛，再取

28号2寸毫针在风市穴快速直刺进针，至一定深度后，捻转提插，使产生在大腿外侧向上和向下的针感传导。又取28号2寸毫针在阳陵泉快速直刺进针，至一定深度后，行雀啄法，使针感沿少阳经方向向患肢远端传导。辨证属寒湿型的腰腿痛，可使用温针。每天1次，每两周1个疗程，疗程间休息4天。

腰椎间盘突出症属于中医学腰痛范畴。本病以腰痛和大腿的后外侧疼痛为主要症状，经络辨证分太阳型、少阳型和二经混合型。接经配穴法是接气通经法中的一种选穴方法，是在相应经脉上选取两穴配伍进行针刺治疗，可加强针刺刺激，调和阴阳气血。张旋在太阳经上取双肾俞治肾虚其本，取委中穴，取“腰背委中求”之义。在少阳经上取环跳、风市、阳陵泉，在行针时均以驱使经气下行，行气过经，畅通经脉，行血气而营阴阳，达到“气至病所”而缓解腰腿痛的目的。欲使针刺穴位后针感下行，关键在于取穴要准确。如针感不循经传导，可调整针刺方向或行雀啄法以催气过经。

十六、辨证分型 针药并用

李振海采用针药并用法治疗腰椎间盘突出症患者，疗效满意。

(1) 辨证分型

①肾虚型：主症见腰腿痛症状之外，尚兼有头晕目眩，腰膝酸软。

②血瘀型：疼痛夜间尤甚，或可见舌紫黯有瘀斑，脉细涩。

③寒盛型：四肢发凉，畏寒，遇凉加重。

(2) 针灸治疗

①通用方：腰部的阿是穴、大肠俞、关元俞、腰阳关、十七椎下、环跳、水沟。

②按部配穴：太阳型（下肢后侧疼痛）配殷门、委中、承山；阳明少阳型（下肢前、外侧疼痛）配足三里、阳陵泉、外丘、阳交；直腿抬高试验（+）者配攒竹。

③按病机配穴：肾虚配肾俞、太溪；血瘀配血海、膈俞，局部刺络拔罐；寒盛者关元加温针灸。

④针刺方法：腰部阿是穴毫针刺与刺络拔罐法交替使用。刺络拔罐时，刺络要有一定深度，用5ml注射器针头，几乎全部刺入，

只刺1~2分达不到治疗本病的目的。环跳穴用分经得气法，本穴位于坐骨神经主干处，针尖微向前时，刺中的是腓总神经纤维，能使小腿前面得气，适用于阳明少阳型坐骨神经痛；针尖微向后时，刺中的是胫神经纤维，能使小腿后面得气，适用于太阳型坐骨神经痛。此穴泛泛得气容易，真要做到气至病所较难。但只要认真体验，细心“微调”针尖方向，是可以做到的。攒竹穴行运动行针法，即针刺的同时，让患者活动患侧肢体。足三里针刺1~1.5寸，使针感达足背。阳陵泉针刺1~1.5寸，使针感达外踝。其他穴用平补平泻法。

(3) 中药治疗

①通用方：桂枝、独活、秦艽、防风、仙茅各10g，仙灵脾15g，川断、桑寄生、杜仲、僵蚕各各10g，全蝎5g，茯苓15g，延胡索、姜黄各10g、甘草5g。

②随症加减：寒盛型加川乌5g（先煎）；肾虚型加山萸肉20g，鹿角胶15g；血瘀型加土鳖虫10g，桃仁10g，红花10g。

本病属于中医学痹证范畴，而痹证是风寒湿杂至为患，但经临床观察，李振海认为本病的主要病机是虚、瘀、寒。肾虚为本，肾主骨，主生长发育。而现代医学认为腰椎间盘突出症是退行性病变，因此肾虚是本病的根本。有瘀无风，因为瘀血为患，固定不移，本病痛而有定处，即或无瘀证的舌脉，但仍是本病的基本临床病机。寒是重要致病因素，寒主收引。患者受寒冷病情加重，因此寒是本病的重要病理机制。

十七、远针近推 综合治疗

孙国栋采用远针近推法治疗腰椎间盘突出症，取得了较好疗效。

(1) 针刺治疗

头针：取穴：单侧患病取对侧，双侧患病取双侧。足运动区，感觉区中、下1/3，运动区中、下1/3。针法：与头皮成15°角，快速进针。感觉区、运动区从上往下，足运感区从前往后针刺，深达帽状腱膜下。达部位后，快速捻针1min后留针。

手针：取穴采用朱振华手针新疗法穴位：单侧患病取对侧，双侧患病取双侧。腰腿1、腰腿2、坐骨神经穴、脊柱点。腰腿1、腰

腿2以 $30^{\circ} \sim 40^{\circ}$ 斜刺，约3~5分深。余穴直刺深约3分，行针后留针。

局部针刺：取穴：阿是穴（按病变部位取相应背俞穴）、环跳、殷门、阳陵泉、委中、承山、悬钟。行提插捻转手法，留针5min，再行提插捻转手法后取针。

（2）手法治疗

松筋：自颈部至腰骶部自上至下施轻柔的揉、按、揉等手法松解腰背肌肉。

局部施治：局部针刺拔针后，在压痛点及四周施揉、按揉、弹拨、然后术者双掌重叠，用手掌根自上而下按压胸腰椎棘突3~5遍，再行双侧腰部斜扳法。

牵抖按压：患者双手扶住床头，助手双掌按压患病部位棘突，医者用双手分别握住患者双踝部渐渐用力向后、上方牵拉。然后在牵拉的基础上进行波浪式抖动，抖动3次加大力度牵拉1次。

在压痛点及四周施揉、按揉、弹拨，擦热腰骶部。推拿治疗期间每隔5min头部快速行针一次。治疗期间卧硬板床。

腰椎间盘突出症主要是由于椎间盘病变纤维环破裂后髓核突出，刺激或压迫神经根、血管或脊髓等组织，引起以腰痛和坐骨神经痛为主要临床特征的疾病。治疗的主要目的是使突出的腰椎间盘突出而解除神经根的压迫，促进炎性水肿的吸收及膨胀的髓核组织脱水。针刺治疗主要是有缓解腰部肌肉痉挛，促进血液循环和调解神经、肌肉的兴奋性的作用。手法治疗能改善局部组织血液循环，调整脊柱顺应性，有效地纠正小关节紊乱，解除腰臀部肌肉痉挛，改变突出髓核与神经根的位置关系，加速髓核中水分吸收。牵引下行有节奏的振颤按压，可使椎间隙增大，减少椎间隙内的压力，有利于椎间盘的还纳复位，减轻或消除突出物对神经根的压迫，消除致痛物质的刺激，使症状缓解或消除。

远针近推法是孙国栋在多年的临床工作中总结出来的，一种针灸和推拿相结合治疗各种疾病的治疗方法。是指在患者病变部位及其远端（主要是头针和手针）进行针刺，并且在病变远端留针的情况下，在其病变局部进行推拿的一种治疗方法。本法来源于经络腧学理论中的巨刺、缪刺，生物全息论，针刺麻醉及历代医家的临床

经验。这种治疗综合了腰椎间盘突出症的多种有效治疗方法,各法配合,相得益彰。

参 考 文 献

- [1] 刘进先,韦扬帆.“脊柱九针疗法”治疗腰椎间盘突出症 40 例.上海针灸杂志,2003,22(12):15~16
- [2] 欧阳八四,高洁.短刺加电针夹脊穴治疗腰椎间盘突出症 43 例临床观察.江苏中医药,2005,26(7):33~34
- [3] 宫玉锁,石斌.水针夹脊穴为主治疗腰椎间盘突出症 30 例临床体会.甘肃中医,2001,(2):41
- [4] 高雅贤,刘学霞.扬刺法穴位注射加离子导入治疗腰椎间盘突出症 46 例.山东中医杂志,2007,26(1):37~38
- [5] 吴世忠.短刺腰突点治疗腰椎间盘突出症 80 例.四川中医,2006,24(2):106
- [6] 皮敏.针刺加刺络拔罐治疗腰椎间盘突出症 80 例临床观察.江西中医药,1996,27(5):49
- [7] 严萍.针刺配合电针治疗腰椎间盘突出症 40 例临床分析.贵州医药,2006,30(4):357
- [8] 刁洪亮.针刺推拿治疗腰椎间盘突出症 156 例.实用中医药杂志,2007,23(3):171
- [9] 赖远征,庄礼兴,庄子齐,等.针刺郄穴为主治疗腰椎间盘突出症的临床研究.上海针灸杂志,2004,23(9):22~24
- [10] 杨艺.针灸治疗腰椎间盘突出症 78 例.上海针灸杂志,2006,25(6):17~18
- [11] 梁树波.针推穴注综合疗法治疗腰椎间盘突出症 70 例疗效观察.新中医,2005,37(1):63~64
- [12] 于秀梅.“傍针”刺法治疗腰椎间盘突出症.针灸临床杂志,2001,17(12):28
- [13] 吴越.白虎摇头法治疗腰椎间盘突出症 31 例.福建中医学院学报,2001,11(2):35
- [14] 王小兰.后顶透刺运动针法为主治疗腰椎间盘突出症 78 例.长春中医药大学学报,2000,16(1):35~36
- [15] 张旋,张正兴.接气通经针刺法治疗腰椎间盘突出症 53 例.湖南中医药

导报, 1999, 5 (6): 18~19

- [16] 李振海. 针药并用治疗腰椎间盘突出症的临床观察. 上海针灸杂志, 2006, 25 (2): 24~25
- [17] 孙国栋, 张本武. 远针近推法治疗腰椎间盘突出症 68 例报告. 中国中医骨伤科杂志, 2005, 13 (3): 35~36

【第三腰椎横突综合征】

第三腰椎横突综合征是一种常见的腰部或腰臀部疼痛疾病，过去把本病归属于腰肌劳损，但由于第三腰椎横突的解剖特异，近来已把该病作为一种独立的疾病来认识。这是因为第三腰椎横突特别长，在腰部多变的活动中，其承受的杠杆作用最大，第三腰椎横突附着的软组织的牵拉力亦增加。故在此部位容易发生损伤。损伤后，由于出血、水肿、粘连、疤痕挛缩、筋膜增厚等，致使腰神经后外侧支在穿过病变组织时受到“卡压”，故第三腰椎横突综合征亦是“卡压综合征”的一种。

本病与急性腰部软组织损伤后，未能给予及时治疗或诊治不当，或因反复多次损伤致使横突周围局部出血、渗血、产生纤维性变性，或形成疤痕粘连，筋膜增厚，肌腱挛缩等病理改变，致使穿过肌筋膜的血管神经束受到刺激和压迫，影响神经的血供和营养，可使神经水肿变粗而出现第三腰椎横突周围乃至臀部、大腿后侧及臀上皮神经分布区域的疼痛。

本篇共收录了 17 位针灸医家的临床治验，有的采用刮痧配合拔罐治疗；有的采用阿是穴合谷刺法加拔罐；有的以痛为腧，梅花针叩刺；有的取阿是穴三针齐刺；有的以气海俞为主，电针配火罐；有的采用腕踝针加推拿；有的采

用扬刺滞针法；有的采用压痛点，鬃针埋藏等，均取得了较理想疗效。

一、刮痧配拔罐 行气通络止痛

杨现新采用刮痧加走罐、拔罐法治疗第三腰椎横突综合征，疗效满意。

取穴：阿是穴，即第三腰椎横突尖端的体表投影处，左右各1穴，该处按之多有压痛；命门、肾俞、腰眼、环跳、委中、承山、足三里、解溪、太溪等穴位。

操作：暴露治疗部位。医者用吕教授刮痧油涂抹患处，右手持拿刮痧板，蘸取刮痧油，利用腕力和臂力，按血液循环方向和穴位所属的经脉线，由上而下，由内而外顺次刮拭，用力均匀适中，由轻渐重。刮拭面应尽量拉长，每个部位刮30~60次，以病人能耐受或出痧为度。每次刮治时间以30~45min为宜。初次治疗时间宜长，但手法不宜太重。间隔3~5天后可再行刮拭1次。反复施行，直到患处无痧斑、瘀块，痊愈为止。通常连续刮2~3次为1个疗程。疗程结束后，间隔10天再行下1个疗程。如果刮拭2个疗程仍无效果，应进一步检查。必要时加用拔罐、走罐和扣击术，以观其效。

拔罐：对部分患者刮痧后行局部坐罐和走罐术，主要取命门、肾俞、腰眼、环跳、委中、承山、解溪、太溪等穴位，留罐时间一般为15min左右。去罐后再行轻刮或按搓拔罐部位，最后以扣击委中手法结束。每3天1次。

第三腰椎横突综合征是临床较常见的腰痛病之一。由于第三腰椎生理解剖上的特殊性，使附着于横突周围的软组织很容易受到撕裂损伤，从而引起局部组织炎性肿胀、充血、渗出等病理变化，继而发生滑膜、纤维组织、纤维软骨等增生，瘢痕粘连，筋膜肌腱挛缩等，产生相应症状。其病位深，着骨而痛，故可归于中医之骨痹范畴。

刮痧是中医的传统疗法之一，能达到疏经活络，调气行血止痛，松解粘连，改善局部血液循环，促进细胞代谢，增强机体免疫力等功效，是治疗第三腰椎横突综合征的有效疗法。再配合局部拔罐、扣击，三者相得益彰，可起到舒筋活血化瘀、行气通络止痛之作用。

魏某,女,54岁,门诊患者。主诉腰痛6年,加重5天。自诉6年前曾有腰部扭伤史,每遇劳累后腰痛加重,5天前搬重物又伤腰,弯腰时疼痛加重,双下肢放射性疼痛。查体:腰肌紧张,双侧第3腰椎横突处压痛(++),可扪及结节样变,X线摄片未见异常改变。用前述方法治疗3次后痊愈。

二、阿是穴 合谷刺加拔罐

陈章妹采用合谷刺法加拔罐治疗第三腰椎横突综合征,取得了满意的疗效。

取穴:患者俯卧位,腹部垫一枕头,同侧 L_2 、 L_3 棘突间旁开2~3cm处找到压痛点,深按有触骨感时即为腰三横突尖部,并标上紫药水点作体表定位。

操作:紫药水点处常规消毒后,根据病人的胖瘦选用规格为28号,直径29号,2寸或3寸的不锈钢毫针刺入约4~7cm,达横突尖端,沿腰三横突尖部上缘及尖端稍有间隔地连续刺3~5次,将针稍微提起,再沿腰三横突尖部下缘刺1~2次,注意此时要减慢施术速度,针下有落空感即可出针。然后以针眼为中心,用闪火法拔一火罐,留罐10~15min起罐。3天1次,连续3次为1个疗程。

注意:

(1) 针刺时应避免操作紧贴横突前下缘的横突前动脉。因腰背筋膜大部分纤维均止于横突尖部上缘,针刺时重点应放在横突尖部上缘,而在针刺横突尖部下缘时,应减慢施术速度,给动脉提供一定的应激时间,手下有落空感即可,不应沿骨面继续下滑,以减少刺伤横突前动脉的可能性。

(2) 急性损伤和发病早期应卧硬板床休息,避免做弯腰和蹲下动作,以利于损伤处组织的恢复。

(3) 平时注意腰背肌功能锻炼,这样有益于控制复发和预防本病的发生。

从现代医学来看,第三腰椎属腰部中段,其横突最长,为腰部应力中心,躯体活动的枢纽,故易发生损伤。若急性外伤或慢性劳损造成横突尖部软组织的某些毛细血管出血,肌纤维断裂,得不到合理治疗,久之则发生无菌性炎症,纤维组织增生、肥厚及粘连,

腰背筋膜张力增高,压迫腰1~3神经后支小静脉,从而产生腰臀部疼痛等症状。

中医学认为,局部受损后,经筋络脉受损,致局部气血运行不畅,经脉痹阻,不通则痛。治取《灵枢·官针》“合谷刺者,左右鸡足,针于分肉之间,以取肌痹”的一针多向刺法之意,外加拔罐,直接或间接作用于病变组织,以达行气活血,舒筋通络,散瘀止痛之功效。此法可使挛缩粘连的组织松解,降低腰背筋膜的张力,促进瘀血和渗出的吸收,改善局部血液循环及新陈代谢。

朱某,男,7岁,干部,2001年3月20日就诊。主诉:右侧腰痛1年,加重3天。病史:1年前学驾车时突发右侧腰痛,活动不利,经内服药物及卧床休息后疼痛减轻,但其后经常感右侧腰部酸痛,不能久坐,夜间不能固定一种姿势入睡,遇劳累或气候变化时酸痛加剧,3天前因劳累腰痛加剧,并牵及右大腿后侧痛。查腰椎生理弧度尚存,右侧腰肌紧张,右腰三横突尖端压痛明显,并牵及右臀及大腿后侧。直腿抬高试验右80°,左90°,加强试验(-)。舌淡色紫,苔薄白,脉弦细。腰椎正侧位片示:腰椎轻度骨质增生。用上述方法治疗1次,症状已除大半,隔3天再治疗1次后痊愈。随访1年末复发。

三、以痛为腧 梅花针叩刺

第三腰椎横突综合征是常见的慢性腰腿痛疾病之一,刘垒采用七星针叩刺配合拔罐治疗该病,取得满意疗效。

取穴:阿是穴。

操作:患者取俯卧位,腹下垫一枕头,使腰椎后凸,骨性标志浅在易触及。在L₂~L₃棘间患侧旁开3~3.5cm触摸出第三腰椎横突尖部,找到压痛最明显处,用甲紫溶液作标记。常规消毒皮肤,用高温消毒后的七星针以中等强度均匀叩刺定点处皮肤约3~5min,至皮肤潮红,有细小血点出现。然后选用大小适宜的火罐,消毒罐口后,用闪火法将火罐拔于患处10min。拔罐后患处皮肤可有少量暗紫色血液渗出,用消毒棉球拭净,局部敷以凡士林膏以防长期叩刺而致病变部位皮肤变硬,最后再以消毒纱布覆盖。隔日治疗1次,5次为1个疗程。

第三腰椎横突综合征属中医学痹证范畴，多由外力或风寒湿邪等因素损伤足太阳经筋，气滞血瘀，或寒湿结于腰部，经筋拘挛，日久筋结，痹阻不通所致。治当疏通经络，祛瘀散结，通则不痛。在治疗上，刘奎突出“以痛为腧”的局部取穴原则，采用七星针叩刺患处皮肤至微微出血，以加速局部气血运行，改善微循环，达到活血通络止痛的目的。本病多属实证，根据“实则泻之”、“菀陈则除之”的治疗原则，在针刺出血的基础上，复加拔火罐则更促进血液循环，有活血化瘀、消炎导滞、推陈致新之功，从而强化了针刺的效果。

四、三针齐刺 直达病所

聂怀利采用针灸齐刺法配合推拿治疗第三腰椎横突综合征，取得了满意效果。

取穴：阿是穴。

操作：患者俯卧，阿是穴常规消毒，用28号2寸毫针在其正中直刺一针。从其两旁斜刺两针，使三针并列。留针30min，每隔10min行针1次（主要用提插泻法）。

推拿：患者俯卧，医者在其腰部做推、滚、揉、按数遍。重点揉按患侧腰骶部，点按肾俞穴1min；患者健侧卧位，医者立其身后，将双拇指重叠，由上至下揉拨其骶棘肌外缘，重点揉拨第三腰椎横突痛点处（阿是穴），前臂揉患侧臀部2~3min。肘尖按压髂前上棘后上方敏感点1min，点按承扶、殷门、委中、承山、阳陵泉等穴。

以上治疗每天1次，10次为1个疗程。

本病属中医学腰痛、痹证的范畴，其发病机制主要是风、寒、湿、瘀痹阻经络，气血运行不畅所致。齐刺为《内经》十二刺法之一，“齐刺者，直入一，傍入二，以治寒气小深者。或曰三刺，三刺者治痹气小深者也。”由于阿是穴是病变要害之所在，故三针齐刺可使针感直达病所，“有的放矢”；配合局部按、揉、推、滚，特别是弹拨，可剥离粘连、软化瘢痕，增加局部血液循环。提高痛阈，达到“通则不痛”的作用。齐刺法与推拿结合，相辅相成，共奏温经散寒、活血通络之功效。

王某，男，34岁，工人。1998年10月25日就诊。患者自述一年前因抬重物致腰部疼痛，尤以左侧为甚。曾经理疗、针灸、外敷膏药，疼痛虽有减轻，但时有腰臀部的疼痛，并向左膝平面以上放射，尤其在弯腰及旋转腰部时疼痛加重。检查：左侧腰肌紧张，直腿抬高试验左侧小于右侧，左侧第三腰椎横突处有明显压痛，并触及条索状硬块。X线片示第三腰椎横突过长。诊断为第三腰椎横突综合征，给予上述治疗二疗程。患者症状消失，体征（-）。随访半年未复发。

五、齐刺配温针灸 通经止痛

侯宽超采用齐刺加温针灸治疗第三腰椎横突综合征，效果满意。

操作：患者取俯卧位，用30号2.5寸毫针，在第三腰椎横突尖端的体表投影处（即压痛点）直刺一针，进针1.2~1.5寸，再在第一针上、下侧旁开0.5寸处呈45°角各进1针，针刺方向朝向第一针，进针深度以针下有抵触感时（说明针尖已触到第三腰椎横突尖端部），将针稍退为宜；然后采用搓针导气法（将针如搓线状单向转运，勿转太紧，令人肥肉缠针，难以进退），使针下产生强烈酸胀感，留针，将纯艾条切20mm小段，用火点燃下端后，插在针柄上，每个艾段燃烧12min左右，待艾段燃完后，继续留针10~15min。出针后，让患者取仰卧位，双下肢伸直，做患侧下肢直腿抬高锻炼，每侧20次左右，每天1次，7次为1个疗程。

第三腰椎横突综合征，在中医学中虽无此病名，但对其认识却较丰富。根据本病的发病特点，其病因病机为：①肾精不足，筋骨失养；②寒湿痹阻，经脉不通；③急性扭挫，气血瘀阻。以上病因病机中，外伤病因是不可少的，然而也与先天发育不足密切相关。各种病因病机最终导致横突顶端周围筋脉瘀阻，气血不荣筋脉而发本病。采用齐刺法直接作用于局部，针感可向疼痛部位强力放射，气至病所，宣通气血，松解粘连。同时配合温针灸，可起行气活血、散瘀通经、止痛的作用。

曹某，男，30岁，2002年1月30日上午就诊。主诉：腰痛半月余。自诉1年前有腰部扭伤史，半月前换衣服时不慎受凉，遂出现腰痛，重着，每遇阴雨天加重。查体：第三腰椎横突尖端有明显

压痛，可触及条索状物，以右侧为重。X线摄片示：无异常。用前述方法治疗2次痊愈。

六、气海俞为主 电针配火罐

曾庆荣以气海俞为主穴，大肠俞、秩边、环跳为配穴，采用电针、拔火罐治疗第三腰椎横突综合征，疗效显著。

取穴：主穴：气海俞（患侧）。配穴：大肠俞（患侧），伴坐骨神经痛或腹股沟痛、大腿内前方痛者加秩边、环跳，均为患侧。

操作：

（1）电针 取气海俞，以消毒干棉球裹持针身快速进针，采用特殊进针角度，过皮后针尖略向内上方（约与皮肤成 80° 角）刺入，以针尖触及第三腰椎横突为度，患者即觉酸麻胀感，甚者针感可沿同侧股神经下传；大肠俞直刺0.8~1寸，秩边、环跳直刺3.5寸，待产生针感后接D8606-II型治疗仪，疏波，刺激量以患者自觉舒适为度，留针30min，每天1次，10次为1个疗程。

（2）拔火罐 取俯卧位，于上述穴位以大号罐闪火法拔火罐，留罐15min，每天1次，10次为1个疗程。

中医学认为腰为肾之府，督脉并于脊里，肾附其两旁，膀胱经夹脊络肾；第三腰椎横突是膀胱经所过，故本病与肾和膀胱经关系最为密切，多由风寒湿邪或瘀血阻滞于膀胱经或肾虚膀胱经失养所致。

气海俞是足太阳膀胱经腰背部的穴位，主治腰痛、腿膝不利。其位于第三腰椎棘突下、督脉旁1.5寸处，局部解剖该穴在腰背筋膜、背最长肌和髂肋肌之间，布有第二腰神经后支外侧支，深层为第一腰丛，内上方为第三腰椎横突。直刺气海俞，针尖到达第三、四腰椎横突间隙，仅能刺激局部的组织，促进该部位的炎症吸收。而略向内上方进针，除了刺激沿途的组织外，针尖刚好能到达第三腰椎横突，直达病所，配合脉冲电刺激，使整个病位炎症迅速吸收，故收理想疗效。

王某，女，27岁，1999年10月18日初诊。主诉：左腰臀腿痛2月。体查：左侧骶棘肌外缘第三腰椎横突尖端处有局限性压痛，屈颈试验、左直腿抬高试验均阴性，腰椎正侧位片及骨盆正位片未见

异常。诊断：第三腰椎横突综合征。按上述方法治疗，2次后症状明显改善，治疗10次疼痛、压痛消失随访半年无复发。

七、阿是穴—委中 透穴刺

郭之平采用透穴刺法治疗第三腰椎横突综合征，取得较好的疗效。

取穴：阿是穴、委中。

操作：用3寸半毫针。当第三腰椎横突尖外端，距后正中线旁开3寸半（约6cm）紧贴横突后侧略偏下进针，经膀胱经第二旁线，穿过第一旁线，斜透至夹脊穴，进针约3寸，行针得气后酸麻胀感自腰部下传至臀部，可达股内侧。留针20min，辅以TDP治疗仪照射。急性期腰痛较剧、重着拘挛、难以屈伸。气滞血瘀较重，体质较盛者用泻法；痛势中度，无明显虚证者用平补平泻法；病程较长，痛势较缓，其痛悠悠，腰部疲软乏力或素体较弱者用补法。

第三腰椎位于腰椎中部，其横突较长，附于其上的软组织有多组肌肉、横突间韧带与腰背筋膜，其结构复杂且走向不同，为腰部功能活动的力学杠杆支点，所受作用力最大。长期负重或劳损，导致局部软组织充血、水肿等无菌性炎症，刺激穿行其间的 $L_1 \sim L_3$ 。脊神经后支而引起疼痛。中医认为，腰痛多因扭伤、过劳伤及脉络，或风寒湿邪痹阻筋脉，腰部枢机不利。由于病位属督脉及膀胱经经筋所布，阿是穴是神气游行出入之所，也是正邪相会交争之处，故取阿是穴透刺膀胱经至夹脊穴；夹脊穴近督脉，既能通督脉之气以滑利腰椎关节之枢机，又可调腰背诸阳经经气，使经络气血调畅，则腰痛自愈。

八、腕踝针加推拿 解痉止痛

高宏采用腕踝针加推拿治疗第三腰椎横突综合征，取得满意疗效。

取穴：下5（伴内收肌压痛的加下1）。

操作：选用30号，1.5寸毫针，常规消毒，使针与皮肤呈 30° 角快速进针，进针后小心地将针退至皮下，将针放平使之与皮肤呈 $5^\circ \sim 15^\circ$ 角，然后沿皮下组织表浅地刺入一定深度。针刺完成后嘱病

人活动下肢，要求针刺部位无感觉，若有需重新调针使之达到无感觉的要求。留针 30 ~ 60min。

推拿：

(1) 用滚法施于两侧腰部肌肉及患侧臀部（肌紧张侧和压痛点处做重点治疗），2 ~ 3min。

(2) 在患侧第三腰椎横突尖端做按压、弹拨 3 ~ 5min。

(3) 掌根揉腰部肌肉 2 ~ 3min。

(4) 放少许按摩乳用擦法擦两侧腰部肌肉，患侧第三腰椎横突部位为重点。

(5) 按揉臀上皮神经部 1 ~ 2min。

(6) 病人仰卧，在内收肌起点处按揉 1 ~ 2min。

(7) 点按委中、承山各 30s。

(8) 做患侧和双侧屈髋、屈膝之被动活动各 10 次，结束治疗。10 次 1 个疗程，每天治疗 1 次。腕踝针是一种特种针法，是根据病症所在部位“按区选点”，对以疼痛为主的一些病证疗效尤其显著，而且针刺越表浅症状消失越完全。腕踝针属于远道取穴的表浅轻刺法，其十二个刺激点均分布在十二经脉的经线上大致相当于十二经的络穴。在这些部位浅刺皮部，可以调整相应的经脉之气及相关络属脏腑功能，起到祛邪扶正、舒通经络、解痉止痛的作用。第三腰椎横突综合征正是一种以疼痛为主症的疾病，腕踝针的舒通经络、解痉止痛恰好能很好地解决主要矛盾。

推拿是治疗软组织损伤病变常用的有效方法，推拿可增强肌肉的张力和弹性，使其收缩机功增强和肌力增加，有利于肌肉耐力的增强和工作能力的提高；推拿又可促进血液和淋巴循环，可使软组织的弹性和活动性得到增强，还可调整神经系统功能，从而调整疲劳肌肉的适应性和营养供求状况。通过推拿能有效缓解第三腰椎横突综合征引起的肌肉痉挛，恢复周围软组织的弹性和活动性。

九、围刺加推拿 针到气到

王寿彭采用围刺加手法治疗第三腰椎横突综合征，效果显著。

取穴：以第三腰椎横突尖端硬结处或压痛最明显处为第一点；第三腰椎横突尖端内移 0.5cm 处横突上下缘分别为第二点和第三点；

此三点为三个中心阿是穴；第一点的中心阿是穴上下旁开 2mm 处；第二、三点阿是穴左右各旁开 2mm 处均为附阿是穴。另选双侧外关和委中穴。

操作：根据病人胖瘦不同分别选用 2~3 寸毫针在 3 个主阿是穴上直刺进针，进针深度直达骨膜或刺透局部增厚的结节。3 个主阿是穴针刺完毕后，再分别针刺每个主阿是穴旁边的附阿是穴。每个主穴旁边的两个附阿是穴针刺时均采用斜刺，两针尖呈 V 型刺向主穴针尖方向。主、附阿是穴针刺时针感可传至疼痛局部及疼痛所放射的区域。阿是穴针刺完毕再刺双侧委中穴，得气后留针，每隔 10min 行强刺激 1 次，30min 后取针，局部按压 3min，以防组织内出血。外关穴待手法治疗后再针刺，针刺时嘱患者活动腰部。

推拿：针后术者以大拇指点压在第三腰椎横突尖端硬结处，力度要直达横突尖端，分别施用点、拨、理、揉等手法约 10min，然后嘱患者侧卧床边，健侧朝下，患侧朝上，健侧下肢放在床上，患侧下肢向床沿前下方下垂，术者一手扶住患侧肩部，一手握住患侧膝部，双手同时向相反方向用力扳动，大部分患者在斜扳时均可听到腰部弹响。一侧病变斜扳一侧，两侧病变斜扳双侧。

此病以疼痛为主，中医认为通则不痛，痛则不通。皆因各种急慢性劳损，造成经筋受损、气血凝滞转枢不利。第三腰椎横突处取阿是穴群针围刺，针刺深度直达骨膜或结节之处，正是经络中气血凝滞之点，每针均直达痛点病灶，做到针到气到、气到经通。从现代病理学分析，第三腰椎横突处多数患者均可触到增厚的结节或条索状物，为损伤后无菌性炎性渗出物吸收后导致组织增厚粘连所致。以阿是穴群针围刺，以结节或条索状物的中轴为中心呈线状针刺，病灶处每针间距为 1mm，形如邮票边线的小孔，在此基础上为下一步手法分解粘连创造了条件。手法点、拨、理、揉，使粘连得以松解，痉挛得以解除，血液循环得到进一步改善。斜扳则使发生小的位移的肌束、小关节得以复位。经过上述治疗后，再针刺手少阳经外关穴和足太阳膀胱经的委中穴，同时嘱患者活动腰部，进一步疏通经络，调和气血而使腰痛快速治愈。

十、温针灸 配经穴按摩

第三腰椎横突综合征。临床以腰痛伴下肢放射性或传导性疼痛为主要病症。张戈运用经穴按摩配合温针第三腰椎华佗夹脊穴治疗该病，疗效较理想。

温针灸：患者俯卧位，取双侧第 L_3 、 L_4 腰椎华佗夹脊穴（ L_3 、 L_4 椎棘突旁 0.5 寸）。医者用 30 号，2 寸银针。以平补平泻手法。针尖斜向棘突方向刺入，以酸麻向腰放射为度，然后将艾条剪至一寸长短。插入针柄，点燃艾条，患者多有温热及热流向下传导的感觉，待针柄上艾条燃烧完毕，针柄冷却后取针。

经穴按摩：①通督脉：患者俯卧位，医者由上而下直推督脉 5～6 次。然后由上而下以双手拇指在督脉两侧推揉 5～6 次，重点推揉 L_1 ～ L_5 华佗夹脊穴。②弹拨、按揉经穴及患处结节：由上至下以双手拇指弹拨足太阳经 5～6 次。依次揉按肾俞、膀胱俞、中膂俞、环中、委中，然后重点弹拨 L_3 ～ L_4 椎棘突结节或条索状物 3min，先左右分离，再前后弹拨。弹拨幅度宜小，频率宜快，由浅入深，由轻到重，再由重到轻，使患者能忍受为度。

横突复位法：①对抗牵拉法：患者俯卧位，双手抓住床前缘，医者双手握住患者双足踝，脚抵住床后缘，对抗牵拉 5～6 次，以分离神经粘连，拉宽椎间隙。②反背复位法：先以滚法放松腰部肌肉，医者与学生背立，压者用两肘挽住患者两臂肘弯，作弯腰屈膝挺臀，将患者反背起，使其双脚离地，以臀部依次抵患者骶部及腰 L_3 、 L_4 椎棘突，用左右插晃和膝关节一屈一伸摇动 5～6 次，结束后嘱患者弯腰抱膝以放松腰腿部肌肉，缓解因反背法所致的腰肌紧张状态。

张戈认为腰椎疾病的发生，是由于直接或间接等原因使脊椎节段性偏离正常位量，从而使具有总督一身阳气的督脉气机不能畅达，气血正常运行发生障碍所致。故张戈以通督脉手法作为整复脊椎节段性错位，从而达到通经络、调气机、振奋阳气、协调经脉功能。治疗时以温针刺第三、第四腰椎华佗夹脊穴，达到温通经络、行气活血作用，使腰部局部循环加强，又因针刺斜向棘突方向，使腰椎内血管、神经等因艾条温热而产生良性刺激，使腰椎内血管神经营养得到改善，使椎体内产生化学物质达到镇痉止痛的目的。《医宗金

鉴》言：“伤损腰脊之证，或因堕坠，或因扑打瘀血，留于太阳经。”故采用经穴按摩手法疏通，督脉及足太阳经，以推揉结合弹拨手法，重点按肾俞、膀胱俞、环中、阳陵泉、委中、太溪等穴以疏导经脉，缓解腰肌痉挛，弹拨 L_3 、 L_4 椎棘突以分离结节或条索状物，使局部循环加强外，还使组织温度升高，有利于无菌性炎症的渗出吸收，充血消散。按摩时注意刚柔相济，对急性期宜轻柔，慢性期宜重刺激手法。

卢某，男，57岁。1991年10月就诊。自述腰部疼痛不适伴左侧臀部及大腿后侧疼痛1个月，受凉后加重两天，不能久坐久立，弯腰工作20min即感臀部烧灼样痛，有陈旧性腰肌扭伤史。检查：双侧腰肌紧张，触压椎突以 L_3 、 L_4 椎明显压痛，棘突旁左侧有长约0.8cm的硬性结节索状物，压之疼痛并放射至臀部，直腿抬高试验及挺腰压腹试验（+）。X光摄片示： L_3 、 L_4 、 L_5 椎前、后缘唇样变， L_3 、 L_4 椎间隙变窄。苔白腻，脉濡数。诊断：第三腰椎横突综合征（急性期）。中医属寒湿痹阻型。遂施以温针、经穴按摩法，3次后腰痛减轻，6次后能坐较长时间。再行反背复位法4次后，腰腿疼痛消失。巩固治疗12次，而获痊愈。随访半年未见复发。

十一、针刀治疗 疏通经脉

曹岱用小针刀治疗腰三横突综合征，取得良好疗效。

针刀以松解横突尖部粘连与疤痕为主，发作期、缓解期均可治疗，双侧患者取较重一侧治疗。患者取俯卧位，平卧于床，第三腰椎横突尖应与第二腰椎棘突下缘同一水平，距脊柱正中线约3.5cm处常规消毒，无菌洞巾敷盖，刀口线与人体纵轴平行刺入，针体垂直于腰部皮肤，在皮下3.5~4.5cm处针刀触及骨面即是横突，纵行疏通1~2刀，再用横行剥离法，针刀向外探，感到肌肉与横突间有松动即出针，以棉球压迫针孔，重手法弹拨痛点2次，亦可用泼尼松龙25mg、普鲁卡因20mg封闭1次。

杜某，男，36岁。以腰痛3年为主诉来诊，3年前因搬运重物不慎扭伤腰部，经治疗后好转，每逢劳累则右侧腰部疼痛，痛处固定不移，为刺痛，俯仰活动受限，有时向背部放散，伴有臀部酸痛。曾经采用针刺，按摩，理疗等方法未能治愈而来诊。查体：右侧第

三腰椎横突部有硬结。压痛(+)，直腿抬高试验(-)，加强试验(-)，双下肢肌力正常，膝腱反射正常，巴彬斯基征(-)。腰部CT未见异常，腰部正位像可见右侧第三腰椎横突向上倾斜，左右不对称。诊断：第三腰椎横突综合征，以上述方法治疗1次而愈，1年后随访未复发。

第三腰椎横突较长，且居腰椎中心，活动度、抗应力大。由于腰背筋膜、骶棘肌和第三腰椎横突尖部慢性磨擦劳损或急性磨擦损伤、出血、机化发生粘连而致腰部屈伸活动时引起腰背筋膜和骶棘肌保护性痉挛性疼痛而发病。基于该机制，一般的针刺，理疗，按摩方法难以彻底改变第三腰椎横突局部病理状态，这也成为该病缠绵难愈的契机，小针刀疗法很好的解决了这一临床难题。从中医角度来看，本病多属瘀血阻滞足太阳膀胱经脉所致，疼痛部位在大肠肾俞附近。以针刀疏通经脉后，随着结节的消失，患者的排便功能多有明显改善，可见中医经络与脏腑功能相互关联理论之精妙。

十二、扬刺滞针法 通则不痛

刘东应用扬刺滞针法治疗第三腰椎横突综合征，取得满意疗效。

取穴：阿是穴（患侧第三腰椎横突尖部）及阿是穴上下、左右各旁开1.0cm处。

操作：取28号2~3寸毫针，穴位皮肤常规消毒后，毫针经阿是穴直刺达横突尖部，得气后强刺激10~15s，其余4穴针尖亦均指向横突尖部，深达横突或横突尖部，得气后亦行强刺激5~10s，留针30min。起针时，先起旁开的4针，然后将阿是穴之针单向捻转至滞针，并于横突尖部行捣针法3~5s之后稍用力快速向上提针2次，使局部筋肉皮肤也随之提高，再反向捻针至针下松弛后起针。起针后，于阿是穴处用大号火罐行闪火法拔罐15min。每天1次，10次为1个疗程。

本病属于中医腰痛范畴。该病的发生与第三腰椎的解剖生理特点有关。第三腰椎居腰之中心，且为腰椎横突中最长者，位于腰椎生理前凸的顶点，活动度较大。其横突上附有的肌肉与筋膜也最多，且是部分肌肉收缩运动的一个支点。肌肉收缩时，该处受力最大，所以在长期弯腰劳动中，常常因慢性牵拉损伤或急性拉伤而出现横

突周围发生水肿、渗出等创伤性炎症反应，继发纤维组织、纤维软骨增生、粘连，邻近神经纤维可因反复刺激变性而产生腰痛和腰肌痉挛。中医认为，局部遭受损伤后，筋肌脉络受损，致局部气血运行不畅，瘀滞不通，不通则痛，故治疗以疏通经络，祛瘀生新，通络止痛，松解粘连，达到“通则不痛”的目的。

常某，男，32岁，干部。于2000年4月20日就诊。因左侧腰部疼痛，晨起加重2个月来诊。患者于2个月前因骑车不慎扭伤腰部，经治有所缓解，但腰痛时轻时重，每于晨起时加重，活动后疼痛略有减轻。诊见：左侧第三腰椎横突部可触及一条索状筋结，横突尖部触痛明显，余均阴性。腰椎X线正位片示：双侧第三腰椎横突过长。诊断为：第三腰椎横突综合征。治疗取左侧腰三横突部，治法如前所述，每天1次。共治疗8次，腰痛消失，局部筋结消散，治愈。

十三、针拨配穴注 活血化瘀

赵泽顺采用针拨和穴位注射治疗第三腰椎横突综合征，疗效显著。

取穴：患者取伏案坐位，暴露腰部，在志室穴下的一横指，骶棘肌外侧缘第三腰椎横突尖部触压有局限性压痛点，即为治疗点，用紫药水作好标记。一般为一侧，亦有两侧同病者。

操作：用10ml一次性塑料注射器（玻璃注射器操作时乳头易碎裂），另外套上9号针头，吸取红花注射液2ml，当归注射液2ml，皮肤常规消毒后，针尖斜面与脊柱平行对准定好的标记进针。针深至第三横突尖骨面，再慢慢将针移至横突尖与其软组织间，沿横突尖从上而下提插5~6次，再从上而下左右来回拨动针尖5~6次。相当于用针尖切剥分离，使横突尖骨面与其软组织间的粘连或斑痕得到松解。动作要求轻柔，切忌鲁莽。切剥分离后回抽针管视无回血将药液缓缓注入。如有回血将针稍稍提出再将药液缓缓注入。出针后用酒精棉球紧压针眼，以防出血。治疗后要求每天扭腰、弯腰、下蹲等运动。1次不愈者，隔4~5天再做第2次。

针拨和穴位注射是利用9号针头锋利的针尖直接在斑痕或粘连的组织中进行切割分离，使斑痕或粘连组织得到松解，随即又将药

液注射其中，一方面当归、红花具有活血化瘀、消炎止痛作用，另一方面药液对粘连组织起到冲击分离作用。治疗后要求做弯腰、扭腰、下蹲运动，防止分解后组织再度粘连。

宋某，48岁，演员。腰痛反复发作8年，认为是练功造成的软组织损伤，经服中药、西药、针灸、理疗等症状虽能缓解，但遇到天气变化、劳累后又发作。此次发作系早上起床时突然觉腰部剧烈疼痛，不能翻身伸腿，伸腿时疼痛向右下肢放射。于1997年4月21日送外科门诊，查小便常规（-），X线腰部平片发现泌尿系结石，腰椎CT示L₄、L₅椎轻度骨质增生，排除腰椎间盘突出病变。专科体检：直腿试验（+）。右侧腰椎横突出尖触压疼痛。诊断：第三腰椎横突综合征。转针灸科予针刺和当归、红花注射液穴位注射治疗，治疗后即感疼痛减轻，右下肢较前能伸直亦能搀扶行走。第4天患者自行来复诊。述腰痛已不明显，但不能久坐久立，有时右下肢还出现放射样疼痛。给予第二次治疗，治疗后患者每天坚持做弯腰、扭腰和下蹲运动，现腰部轻松无任何不适。随访半年未复发。

十四、综合治疗 消肿止痛

腰三横突是腰部活动受力的集中点，所以腰椎前屈后伸、左右旋转用力过大易受损伤。曹郑云采用综合疗法治疗，取效满意。

针灸：患者俯卧位，取患侧肾俞、气海俞、大肠俞、志室、腰眼、环跳等穴。穴位常规消毒，用28号2寸毫针，直刺肾俞、气海俞、大肠俞1.0寸，斜刺志室、腰眼1.0寸，得气后，用捻转泻法，使局部有酸、胀、重感。选用4.0毫针，直刺环跳穴3.0寸，得气后，用提插捻转泻法，运针时针感达足跟。留针30min，每10min，行针1次。7次为1个疗程，每个疗程之间间隔1天。

推拿：

（1）拇指弹拨法：患者俯卧位，用拇指弹拨患侧第三腰椎横突顶端及条索状物，力量不可过重，以酸、困、胀感为宜。时间2min。以活血散瘀，剥离粘连，消肿止痛。

（2）俯卧斜拨法：患者俯卧位，摸清腰三椎体横突条索状物，以左侧为例。医者站住患者左侧，左手拇指或手掌顶于患者腰三横突条索状物，右手扳患者左膝关节，然后使患者左腿慢慢向外展开，

连作3次。以消肿止痛，缓解痉挛为目的。

(3) 肘压环跳法：患者侧卧位，患侧在上，患肢屈曲，健肢伸直，以肘压“环跳”及臀部条索状物，时间2min。以疏通经络，缓解疼痛，消除痉挛。

中药：瘀血型腰痛（患病至就诊6天以内），治宜：活血化瘀，理气止痛。方用身痛逐瘀汤加减。药物组成：川芎10g，桃仁20g，红花10g，甘草3g，穿山甲12g，当归10g，五灵脂10g，没药10g，香附15g，牛膝15g，地龙10g。每日1剂，水煎2次，早晚分服，寒湿型腰痛（初期未愈复感寒湿之邪，患病超过6天以上）。治宜：散寒祛湿，化瘀通络。方用身痛逐瘀汤合肾着汤加减药物组成：干姜9g，茯苓15g，白术15g，苍术15g，甘草6g，川芎10g，桃仁10g，红花10g，当归10g，香附10g，牛膝15g，地龙10g，穿山甲12g。加减：寒邪偏胜者，加附子、细辛；湿邪偏胜者，加薏苡仁、防己；风邪偏胜者，加防风、独活。用法同瘀血型。以上两型7天为1个疗程。

本病根据临床表现隶属于“腰痛”之范畴。临床以腰痛较剧，活动受限，痛处拒按，舌质紫黯或有瘀斑为主要症状。病久未愈可出现腰部冷痛重着，转侧不利，舌质黯、苔薄白等。多因外伤瘀血或风寒湿邪侵袭等造成经络阻滞，气血运行不畅，不通则痛。因而本病治疗当以活血化瘀，理气止痛为基本法则，贯穿于治疗的始终，同时根据病因病机，临床症状的标本缓急进行加减辨证论治，则疗效更佳。方中桃仁、红花、当归、川芎活血化瘀；没药、五灵脂消肿止痛，以增强祛瘀之力；穿山甲、地龙化瘀通络；香附行气以活血；牛膝引瘀血下行，并能强壮腰膝。诸药合用，共奏活血化瘀，搜剔通络，行气止痛之功。若寒湿腰痛显著，加肾着汤以散寒祛湿。手法、针灸治疗不仅能使患者局部肌肉韧带紧张、粘连得以松解，而且还能调理气血，疏通经络，达到活血化瘀，消肿止痛，解除腰肌痉挛之效果。

陈某，男，46岁，2001年8月10日初诊。自述：昨日不慎，扭伤腰部。腰部活动受限制，身体侧弯，行走困难。刻诊见：患者痛苦病容，左腰肌紧张，患侧第三腰椎横突尖端及臀中肌后缘与臀大肌前缘的衔接处可触及条状物，压痛明显，并向下放射至腘窝，

日轻夜重，舌质紫黯，脉涩。X线片示：第三腰椎横突过长。此属腰部用力不当，损伤经脉气血，气滞血瘀，不通则痛。治宜：活血化瘀，理气止痛。以身痛逐瘀汤加减治疗。方药组成：川芎 10g，桃仁 10g，红花 10g，甘草 3g，穿山甲 12g，没药 10g，当归 10g，五灵脂 10g，香附 15g，牛膝 15g，地龙 10g，乳香 10g，延胡索 10g。每日 1 剂，水煎，早晚饭后分服。同时，配合针灸推拿手法治疗。共治疗 1 个疗程。行走自如，临床症状消失。嘱注意休息，避免受凉，随访半年，未见复发。

十五、压痛点 鬃针埋藏

魏从建采用鬃针埋藏法治疗第三腰椎横突综合征，取得了较好的疗效。

取穴：第三腰椎横突压痛点，单侧疼痛取同侧的局部压痛点，两侧疼痛则双侧压痛点同时选用。

操作：选用 7 号注射针头，针芯内穿入鬃针，即消毒好的猪鬃（其消毒方法：选猪颈项部的长鬃毛，剪去根部和末梢，放入清水中加碱煮沸去垢，反复数次至水清为止，取出待用），所选穴位无菌操作，捏起皮肤。将针尖刺入所选部位，针尖向脊柱方向横行穿过条索或硬结，在距离进针点约 3cm 处出针，轻轻从针尾推进鬃针，使其露出针尖，用左手按住鬃针，右手轻轻的拔出注射针头，将鬃针留在穴位内，然后剪去暴露的鬃针，轻轻拉平皮肤，使其两端藏于皮下，针孔用消毒纱布覆盖即可。10 天后如未痊愈再埋藏 1 次。嘱病人避免受凉，避免腰部的突然用力和过度劳累。

鬃针为一种异性蛋白，在深埋的组织中吸收时间较长，对穴位的刺激强烈而持久，直接修复和调整病变部位的生理异常，疏通筋络，活血化瘀，消除局部组织的炎症水肿，使机体恢复正常状态。在治疗过程中还发现，部分患者在治愈后肌萎缩可得到一定程度的改善，且年龄越轻，治愈率越高。

十六、穴注配针刀 分期治疗

任平霞采用分期辨证治疗第三腰椎横突综合征，效果满意。

分期标准：①早期（炎症水肿期）：病史短，一般 3 个月以内，

一侧或双侧腰部或腰臀部疼痛，第三腰椎横突尖部局限性压痛，或引出臀部及大腿后侧放射痛。②中后期（机化结节期）：病史3个月以上，腰部或腰臀部痛重，第三腰椎横突尖部可触及纤维性软组织硬结，大多数病人合并臀上皮神经嵌压症状。

操作：采用分期辨证治疗方法：①早期行局部封闭加斜扳手法治疗；②中晚期采用注射针刀加斜扳手法治疗。

（1）早期 配制好0.5%利多卡因针20ml、曲安奈德针20mg、维生素B₁₂针1mg混悬液备用。以第三腰椎横突尖部压痛点为进针点，常规消毒，针尖与皮肤呈45°角，进针1.5~2寸时，即可触及横突尖，回抽无血后，沿该横突尖周围及其上下缘充分浸润注射。注射完毕后，用拇指卡入横突尖，反复拨动数次，将其周围紧张的肌肉推开松解。每周1次，症状消失后，停止注射。一般1~3次。

（2）中后期 对于病史长，第三腰椎横突尖部已有硬结形成者，做注射针刀治疗。患者俯卧位，腹下垫枕，在腰部骶脊肌外缘第三腰椎横突尖部找出压痛最明显处，紫药水做标记，皮肤消毒，铺洞巾，术者戴手套，将已抽取好配制药液（同封闭用药）的注射针刀贴横突压痛点进入，刀锋与脊柱纵轴平行，进针至横突尖酸胀感处，注药3ml，用横行剥离法，贴横突尖剥离铲除软组织附着的痛点，边松解边注药，感觉肌肉与骨质之间有松动感时，出针，以消毒棉球压迫针孔片刻，创可贴粘帖针孔。合并臀上皮神经嵌压者，同时做臀部压痛点封闭或针刀治疗。视病情恢复情况，必要时两周后再做1次。

手法治疗：让病人取健侧卧位，病侧下肢屈髋屈膝，健侧下肢伸直，术者面对患者而立，以一手置患者肩部，另一手（多用肘部）置患者在上的髂嵴部，双手相对用力缓慢移动脊柱，使脊柱产生一定的扭角度，当着力点作用于第三腰椎横突及其附近的关节突时，突然两手一前一后用力扳动，这时往往能听到“喀嚓”响声。手法完毕后，嘱病人卧床休息约10min。

第三腰椎位于腰中部，因其为腰椎前凸的顶点，而成为腰椎屈伸旋转活动的枢纽，且第三腰椎横突最长，故所受的杠杆作用力最大，横突尖又是骶棘肌、腰方肌、腹内斜肌和腹横肌腱膜的交叉应力点，在突然扭伤腰部或过多持久地弯腰活动或负重后，其上附着

的肌肉、腱膜等软组织很容易出现撕裂、出血、渗出等创伤性炎症反应，从而产生肌紧张、肌痉挛，出现腰痛等局部症状。此为疾病早期，行局部封闭治疗。封闭药液中的利多卡因不仅具有局麻作用，同时可以改变局部的血液循环，促进炎性物质的吸收与排泄；曲安奈德针具有减轻局部水肿及消炎作用；维生素 B₁₂ 有改善神经营养的功能。诸药合用，可阻断“局部疼痛 - 血管痉挛 - 组织缺血缺氧 - 酸性代谢产物积聚 - 疼痛”的恶性循环，改善局部代谢环境，从而达到治疗疾病的目的。值得提出的是，由于第三腰椎横突周围软组织丰富，故封闭时范围要广，应以压痛点为中心，包括内至小关节，外至横突尖在内的骨膜及相邻的软组织，才能有效的消除肌肉痉挛，提高疗效。

病史较长或反复发作，第三腰椎横突尖部长期反复损伤、出血、渗出等继发的瘢痕粘连波及至行于横突背面的脊神经后支时，即会出现臀腿部疼痛、麻木等臀上皮神经嵌压症状。此为疾病的中后期。此时封闭疗法虽能消除无菌性炎症，却难以去除局部的瘢痕粘连，而应用注射针刀边注药边松解，一方面注药可以消炎止痛，消除患者恐惧心理，另一方面运用针刀可以松解粘连，改善局部血液循环，增加营养供给，加强新陈代谢，使剥离的瘢痕组织尽快吸收，解除相应肌群对腰椎的异常牵拉，恢复肌肉的静态和动态平衡。

在封闭或针刀治疗后，再辅以斜扳手法治疗，既可以进一步缓解腰背肌的紧张痉挛，又可以纠正腰椎小关节错位，巩固治疗效果。

十七、针刺为主 气至有效

管建红采用电针后施以火罐再行推拿的方法治疗第三腰椎横突综合征，取得满意疗效。

针刺：令病人俯卧，暴露腰部，取第三腰椎横突端点在体表的投影点（相当于气海俞或稍外的位置）为主穴，以 1.5 或 2.5 寸 30 号的毫针，视患者的胖瘦程度，刺入 1.3 ~ 2.4 寸，当手下出现针尖触及横突端骨质的感觉时，捻转得气，即可停针；然后用《内经》“傍针刺”（正中一针，傍入一针）的方法在主穴旁再斜刺一针，刺入 1.3 寸左右；另可配取委中或承山穴。腰部的两针用导线接电针机，电针波型选疏密波，电流强度以病人能耐受为度，留针 30min。

拔罐：针刺完毕后，以第三腰椎横突端点为中心，用闪火法将大号火罐拔上，留罐 10~15min。

推拿：去火罐后，以推拿手法治疗。先在局部施以滚法或按揉，再用拇指在第三腰椎横突端点渐重渐轻地用力点按或弹拨 3~5 次（身体壮实者可以肘点代替指按），最后施以掌揉法，有腰椎后关节紊乱者可行腰椎侧卧位斜扳手法。

上述治疗，隔日 1 次，3 次为 1 个疗程。治疗期间嘱患者减少腰部活动及用力，避免久坐久站，注意保暖。

本文所述治疗方法中，傍针刺属《内经》刺法，多应用在压痛较明显且固定不移的痹证。电针具有较好的解痉、止痛消炎作用，止痛更佳；火罐，能行气活血、消肿止痛、祛瘀生新；在病变局部施以推拿则可舒筋活血、通络止痛。

在治疗过程中，管建红认为必须注意以下几点：一是针至病所，即毫针必须刺中第三腰椎横突端点，针刺过浅或偏离该点，疗效都将下降；二是应用电针，在针刺到达横突端点即腰肌筋膜附着点的基础上，由于电针的解痛、止痛、消炎作用较好，因此，使用电针能取得更好的疗效；三是推拿，必须注意手法的运用，先用滚法、按揉，意在使腰部得到进一步的放松，次用点按、弹拨，目的在于消瘀散结，最后以揉法收功并增加病人的舒适感，所有手法除点按弹拨用力要渐重渐轻之外，其余手法的运用切忌过重，应以柔和为主；四是治疗期间不能劳累，在恢复过程中若用力不当，往往会产生新的损伤，使得病情加重，病程延长，因此，应尽量减少腰部的活动及用力，必要时应卧硬板床休息。

张某，男，15 岁，1994 年 3 月 5 日就诊腰部疼痛、活动困难 1 周，有打篮球时用力不慎扭伤史，曾做针灸治疗 1 次，未见显效。检查：腰部前屈、左右侧屈均明显受限，脊柱无侧弯，两侧腰肌紧张度增加，第三腰椎横突端点明显压痛，左侧较右侧为甚。诊断：第三腰椎横突综合征。按上述方法治疗后患者当即感到轻松许多，腰部可做小幅度活动。隔日复诊时，患者诉腰痛已减大半，活动亦方便许多，守前法继治 2 次而告痊愈。

参考文献

- [1] 杨现新. 刮痧加拔罐治疗第三腰椎横突综合征 28 例. 中国民间疗法, 2004, 12 (10): 34
- [2] 陈章妹. 合谷刺法加拔罐治疗第三腰椎横突综合征 122 例. 国医论坛, 2003, 18 (3): 25
- [3] 刘垒, 沈凌. 梅花针叩刺配合拔罐治疗第三腰椎横突综合征 56 例. 山东中医杂志, 2002, 21 (9): 546 ~ 547
- [4] 聂怀利, 袁淑华. 齐刺法配合推拿治疗第三腰椎横突综合 60 例. 中医外治杂志, 2202, 11 (5): 42
- [5] 侯宽超. 齐刺加温针灸治疗第三腰椎横突综合征 71 例. 中医外治杂志, 2005, 14 (1): 42
- [6] 曾庆荣, 黄普全. 气海俞治疗第三腰椎横突综合征 62 例疗效观察. 新中医, 2002, 34 (5): 43 ~ 44
- [7] 郭之平, 赵惠琴, 吕霞霞. 透穴刺法治疗第三腰椎横突综合征 59 例. 山东中医杂志, 2003, 22 (9): 554 ~ 555
- [8] 高宏. 腕踝针加推拿治疗第三腰椎横突综合征 85 例报道. 浙江临床医学, 2004, 6 (5): 390
- [9] 王寿彭, 奇铁男, 田欢狮, 等. 围刺加手法治疗第三腰椎横突综合征 72 例. 中华临床医学杂志, 2006, 7 (1): 69 ~ 70
- [10] 张戈. 温针配经穴按摩治疗第三腰椎横突综合征 6 例. 四川中医, 1994, (5): 49 ~ 50
- [11] 曹岱, 于泓. 小针刀治疗腰三横突综合征 74 例. 中医药学刊, 2002, 20 (5): 703
- [12] 刘东, 许向东, 孙良金. 扬刺滞针法治疗第三腰椎横突综合征 56 例. 吉林中医药, 2000, (6): 48
- [13] 赵泽顺, 龙贵平. 针拨和穴位注射治疗第三腰椎横突综合征 52 例. 针灸临床杂志, 2001, 17 (9): 21
- [14] 曹郑云. 综合疗法治疗第三腰椎横突综合征 86 例. 河南中医, 2004, 24 (4): 40 ~ 41
- [15] 魏从建. 髂针埋藏治疗第三腰椎横突综合征 54 例. 安徽中医学院学报, 2006, 25 (4): 25 ~ 26
- [16] 任平霞, 李江波, 袁付成. 分期治疗第三腰椎横突综合征 154 例. 颈腰痛

杂志, 2006, 27 (5): 424 ~ 425

- [17] 管建红. 电针火罐推拿治疗第三腰椎横突综合征. 中国民族民间医药杂志, 1996, (22): 12 ~ 13

【腰椎管狭窄症】

腰椎管狭窄症是指腰椎椎管/神经根管及椎间孔变形或狭窄引起的相应一系列临床症状，又称骨性神经根卡压综合征。好发于40~60岁的男性体力劳动者，患椎间盘突出症者约有50%同时存在腰椎管狭窄症。间歇性跛行、下腰痛和腿痛是本病主要的临床症状。大多数患者在步行久后，出现单侧或双侧腰痛、腿痛、下肢麻木、沉重、无力、甚至跛行，下蹲休息后症状可以缓解，若继续行走则又可出现同样的症状。临床还可见患者脊柱侧弯，肌力减弱，以伸肌肌力减弱为主，并伴有痛觉、触觉减退。

本病有原发性和继发性两种，前者是由于先天性骨性椎管发育异常所致，表现为矢状径、横径均小，椎板肥厚，椎板间隙小，关节突大并向中线靠拢等，但原发性腰椎管狭窄症临床极少见。继发性腰椎管狭窄症主要是腰椎管周围各部分退行性变引起。常与椎管周围骨性结构退行性变、黄韧带肥厚或松弛、椎间盘退变萎缩到有关，此外，外伤或脊柱区手术都可能造成局部解剖关系失常而致椎管狭窄。

本篇共收录了10位针灸医家的临床治验，有的采用次髂穴穴位注射；有的以调椎整曲法为主，进行综合治疗；有的采用钩针进行松解；有的针药并用，活血化瘀；有的以小针刀为主，

手法、中药并用；有的针刺夹脊穴，配合按摩；有的采用中药穴位注射配激素硬脊膜外封等，均取得了较理想疗效。

一、次骶穴位注射 镇痛

王宛彭应用次骶穴位注射治疗腰椎管狭窄症，均收到满意疗效。

取穴：次骶。

操作：病人俯卧或侧卧位，于患侧髂后上棘内下方约 1cm 凹陷处，即第二骶后孔为次骶穴。局部常规消毒，用 6~7 号针头做皮丘后刺入，回吸无血及液体即可注射药物，注药后休息 10~20min，无异常反应即可离院。每次注射药物为 0.3% 利多卡因 10~15ml，地塞米松 10mg，维生素 B₁₂ 100μg。每周注射药物 1 次，3 次为 1 个疗程。

次骶穴为足太阳膀胱经穴，位于第二骶后孔中，骶后孔内通骶管，当局麻药液注入骶管，通过扩散，可致节段性骶神经阻滞，故经骶后孔阻滞对坐骨神经、股后皮神经、臀上、臀下皮神经分布区的痛性疾患具有镇痛作用。因此次骶穴注射即有穴位针刺治疗，又有骶神经阻滞的双重作用。

通过针刺与注药对次骶穴的渗透、刺激，除对疼痛反应的抑制外，也可是病程变化，改善气血运行，达到通经止痛之作用。一定量的药液也可对粘连组织起到离解作用。穴位注射亦因刺激穴位，促进内源性阿片肽的合成与释放，由于体内内源性阿片肽含量提高，镇痛效果极佳。

王某，女，42 岁，工人。1994 年 5 月 10 日初诊。主诉：腰痛 2 个月。2 月前因抬重物，腰部扭伤，而出现腰痛，活动受限。2 周后疼痛向双下肢放散，出现双下肢外侧疼痛，以左侧为重，伴有酸胀、麻木，并有间歇性跛行。因病情渐进性加重，遂来求治。检查：L₃~S₁ 之间左侧及环跳穴处压痛明显，左直腿抬高 50°，右直腿抬高 70°，屈颈试验（+），腰痛过伸试验（+），拉氏试验（-），麦氏试验（-）。CT 所见：8cm 层面：腰间盘后缘变平，两侧黄韧带宽分别为 0.35mm 和 0.42mm，硬膜囊周围脂肪囊消失。L₃、L₄、L₅ 椎管前后径分别为 1.3、1.29、1.3cm。诊断：L₃、L₄、L₅ 椎管狭窄症。用次骶穴位注射 3 次，自觉腰腿疼痛减轻，仅外踝处沉重感。

经5次治疗,诸症消失,行走自如,双下肢直腿抬高试验(90°),屈颈试验,腰背过伸试验均为阴性。

二、调椎整曲法 综合治疗

韦以宗根据“一说两论”即“圆筒枢纽学说”、“板块移动椎曲论”,“平行四边形理论”,应用调椎还曲法治疗椎管狭窄症,取得了满意疗效。

理筋方法:以中药外敷颈背部、腰骶部肌肉,同时配合按摩手法,达到理顺筋肌,松解肌肉之功,若肌肉僵硬者配以中药喷脊,疏通背部三阳经,加强松肌理筋之功。每天1~2次。

骨空调压法:用毫针沿颈腰“华佗夹脊”穴,每相隔2cm1针,针至椎板,每天1次至治愈。

针灸电针法:针肩中俞、肩外俞、天宗、秉风、三风(双侧风池、风府);肾俞、八髎、环跳、阳陵泉、委中、承山、光明、悬中等,并加电针,每天1次,每次30min。

调椎整曲法:①根据患者颈、腰椎生理曲度行相应的颈、腰椎牵引,颈椎曲度变直、反弓者行仰卧位牵引加折顶回旋按摩手法,颈椎曲度加大者行坐位或仰卧位牵引,牵引重量3kg,牵引时间30min左右;腰椎曲度消失、反弓者行俯卧位骨盆牵引配以中间加压手法或俯卧位悬吊牵引胸腰枢纽,腰椎曲度加大者行俯卧位骨盆牵引,两端加压或仰卧位悬吊牵引腰骶枢纽,牵引重量40kg左右,不宜超过患者体重,牵引时间不少于1h,牵引后需卧床休息相应牵引时间。②先拿、捏、揉、揉颈背、腰骶部肌肉,然后行颈胸枢纽、胸腰枢纽、腰骶枢纽旋转复位法以调三大枢纽,或骨盆斜扳法使偏歪棘突复位。

中药:据患者病情症状辨证用药,以益气养血、温通经脉、补益肝肾为主。鹿茸、附子、杜仲、川断各10g,茯苓20g,麻黄5g,白术10g,细辛3g,五味子10g,牛膝15g,独活8g,归身、泽泻10g,小茴香5g,沉香8g,枳实5g,甘草6g。临床根据症状再辨证加减。

功能锻炼:根据颈腰椎曲度分别行拿捏颈肌、抱膝揉腰、点头哈腰(腰曲加大者)、过伸五点式(腰曲变直者)等练功法。

人体脊柱是由椎骨和椎间盘组成，椎骨旋转移位，椎间盘变性（突出、膨出或脱出）必然会导致脊柱生理曲度（椎曲）异常。而人的椎曲决定了椎管和椎间孔的宽度，同时也决定了脊髓在椎管内的位置和脊神经的排列，因此人体椎曲改变必然导致椎管和椎间孔异常，使所通过的脊髓、神经受到激惹或压迫，进而产生疼痛、麻木、无力等临床症状和体征，所以椎曲异常是脊柱疾病的根源所在，当然也是椎管狭窄症的根源所在。因此，根据“一说二论”应用调椎还曲法治疗椎管狭窄症取得了较好的临床疗效。

三、钩针松解术 刺激量大

杨洸运用钩针治疗腰椎管狭窄症，效果满意。

取穴： $L_3 \sim L_4$ 节段明显狭窄者取气海俞， $L_4 \sim L_5$ 节段明显狭窄者取大肠俞， $L_5 \sim S_1$ 节段明显狭窄者取关元俞。

操作：取钩针 1 把，消毒后备用，让患者平卧于手术台，腹部下垫枕，暴露腰椎，定位后，用紫药水做标记，皮肤常规消毒，铺无菌巾，戴无菌手套，取 1% 利多卡因在标点处做一皮丘，行局部浸润麻醉，每点 2 ~ 3ml，深约 2cm，按定点部位，左手持无菌敷料，固定皮肤，右手持钩针自表向里刺入皮肤、筋膜、肌肉，钩断部分筋膜肌肉。特别是对浅筋膜的钩治要彻底，钩提 4 ~ 6 次不等，有落空感即可。然后出针，用无菌敷料包扎，3 天后去除。治疗后嘱患者佩戴腰围 2 周。无需服用其他药物。如果疗效不佳，1 月后仍可重复治疗。

腰椎管狭窄症属于中医腰腿痛疾病的范畴，病因与先天肾气不足和肾气衰退以及劳役伤肾有关，此外也与反复遭受外伤、慢性劳损和受风寒湿侵袭等有关。肝主筋，肾主骨生髓。中年以后，肝肾渐亏，因此所发生的椎间盘退变、黄韧带肥厚、椎体后缘骨质增生、小关节突肥大等都是肝肾亏虚的表现，也是造成中年以后腰椎管狭窄的主要原因。

钩针是在古九针的基础上发展起来的一种新兴治疗工具，杨洸在临床实践中发现，由于腰椎不断活动，时间久之，使下腰段脊柱两边特别是足太阳膀胱经局部的筋膜及浅层肌肉变硬变性而失去弹性，造成腰椎后伸应力过大，被动造成腰椎管狭窄的相对狭窄，此

即所谓的“弓弦效应”。钩针能够彻底松解脊柱两旁病变的筋膜及肌肉组织,能把变性变硬的筋膜及肌肉松解并切断,使腰椎后屈应力瞬间减低并能使脊柱恢复前屈活力,不同程度的、相对的扩大了椎管容积,而由于椎管狭窄所导致的症状也会不同程度的减轻或消失。

中医理论认为:腰椎管狭窄症疼痛范围为腰部或下肢外侧或后侧,位于膀胱经循行路线上,属于膀胱经循行路线上的病理反应,故为膀胱经的主治病证;腰为肾之府,膀胱与肾互为表里,故取膀胱经之气海俞、大肠俞、关元俞为膀胱经在腰部的主穴,气海俞可协调阴阳,枢转气机;大肠俞可宣导阳气,疏通经脉;关元俞有激发经气,活血散瘀,培元固本之功。三者均为治疗腰腿痛之要穴。因此,钩治气海俞、大肠俞、关元俞不仅可以疏通局部经筋、经脉之气血,更重要的是钩治刺激量大、作用范围广,促进局部血液循环,消除无菌性炎症,提高敏感神经的痛阈,从而消除神经痛,同时消除神经痛而引起的肌痉挛性疼痛。能够达到经气内外相通、上下相接的目的,故本法止痛作用很强。因此,对于腰椎管狭窄症导致的腰腿痛,用钩针钩治气海俞、大肠俞、关元俞为主的治法能达到较强的镇痛作用,是一种比较理想的治疗方法。

四、从肾督着手 针药并用

黄巍以李同生老师自拟通督活血汤加背部深刺腰阳关为主采用电针治疗腰椎管狭窄,取得好的疗效。

中药:病人症状沉重期须卧硬板床休息,症状减轻后可作轻微行动,服药以活血化瘀,根据症状加舒筋活络,养血补气,散寒祛风,补肾益精,健脾祛湿,行气导滞之药。主方通督活血汤:黄芪15g、当归、丹参、赤芍、泽兰叶、杜仲、金毛狗脊、苏木、地龙、葛根各9g,鹿角霜15g。水煎服,每日1剂,10次为1个疗程,疗程间隔5~7天。

针刺:腰阳关、环跳、大肠俞、委中、承山、阳陵泉,均选28~32号,2~5寸长毫针,快速刺入穴内,并提插捻转手法,得气。其中环跳针感放射至足背,腰阳关深刺1~2寸,双下肢或一侧有麻电感向下放射,再接上G6805治疗机,选连续波,频率达每分钟200次以上,留针20~30min,隔日1次,10次为1个疗程,疗程间隔5

~7天。

据中医文献记载,《内经·素问·刺腰痛论篇》曰:“衡络之脉令人腰痛……衡络绝,恶血归之”。及《金匱翼》中关于“瘀血腰痛”多责之于“瘀血血脉凝涩”,“经络壅滞”,“肾主腰脚,其经贯脊络肾”,宜从肾督着手参照现代医学对本病的认识,辨证结合辨病,故用活血化瘀,通过研究,活血化瘀有改善微循环,抗感染,促进增生性病变的转化或吸收,清除炎性肿胀,调节代谢失调,促使病损愈合减轻马尾神经的压迫,加速了椎管病损组织的修复。

《灵枢经》记载:“针刺之要在于得气,气至而有效”。电针刺激督脉腰阳关为主,得气快,有产生明显镇痛作用。腰阳关穴其内是马尾和脊髓液,直刺1~2寸,故深刺不会损伤脊髓,是安全有效的。

张某,女,35岁,工人,1993年3月14日初诊,主诉:腰腿疼痛麻木半年,跛行20天。患者8年前曾抬沉重木材倒在地,致使腰部损伤,当时疼痛,行走困难,经当地医生治疗后疼痛好转,半年前开始腰腿痛,下肢麻木,伴有酸胀感,曾诊断为坐骨神经痛,腰椎病,经理疗,服中西药物后效果不显,腰腿痛,跛行。前来求治,经拍腰椎片,CT报告为腰椎间盘突出症(L₄、L₅间),并腰椎管狭窄给予通督活血汤,每日1剂,另用脊柱深刺腰阳关为主穴电针治疗半月,症状明显减轻,并要病人睡硬板床。治疗2个疗程后,病人痊愈从事原工作,半年后随访未复发。

五、小针刀为主 三管齐下

王维佳在临床治疗中采用小针刀为主治疗非骨性腰椎管狭窄症取得较好的疗效,若配合中药手法则能提高疗效。

小针刀疗法:根据临床症状及X片,CT报告,决定治疗节段。常规消毒,在棘突旁一横指处,局麻下垂直进针在腰L₄、L₅或L₅、S₁椎板间孔处缓慢进针,当接近神经根时患者常感下肢酸胀或有热感,到接触神经根时,患者常诉下肢有放射麻木感,此时稍退针待下肢感觉消失后,在椎板间孔内做上下的纵行切割和左右的横行剥离,若感觉椎板间孔内紧张可做上、下、左、右摇动,扩大椎板间孔的针刀切口,此时患者常感下肢轻松感或原有的冷感转热感即可

出针。若合并下腰痛可在小关节突附近切剥数刀出针。

手法治疗：小针刀结束后，可配合腰椎左右斜板各 1 次，患肢被动抬高至 90° ，30 次，直腿抬高 90° 合足背屈 30 次。

中药治疗：王维佳将非骨性腰椎管狭窄症分三型治疗。气血不足型：以八珍汤合补阳还五汤加减；肝肾不足型：以独活寄生汤加减；湿热内蕴型：以知柏地黄汤合龙胆泻肝汤加碱。方中酌情选用泽泻、茯苓、车前子、地龙、全蝎、蜈蚣、乌梢蛇、蕲蛇等。

腰椎管狭窄症是一组综合征，除少数属发育性差外，绝大多数为继发性改变所致。王维佳根据腰椎管狭窄外科治疗的原则，以及目前在手术治疗上采用不同腰椎管扩大成形术治疗腰椎管狭窄的原理，应用于小针刀中。因小针刀的局限性，故只应用于非骨性的腰椎管狭窄症。治疗的机制主要是通过小针刀松解，扩大椎板间孔间的黄韧带，起到后减压而扩大椎管的目的，特别适应于腰椎间盘突出，黄韧带肥厚的病人。黄韧带在椎板间孔处最厚，由于椎板间孔与椎间隙平面处在相对应的平面，故黄韧带的厚度与腰椎节段运动范围的大小，狭窄关系很大。故此法应用后能改善症状。治疗椎间关节的目的是因为下腰痛与椎间关节密切，小针刀可消除椎间关节的滑膜炎和退变所致的疼痛。

由于小针刀在非骨性腰椎管狭窄的治疗中不像手术治疗这样完全，彻底，故王维佳在小针刀的基础上加用手法。侧扳是为了解除椎间关节滑膜嵌顿所致的腰痛，调整膨出的椎间盘与神经根的位置，直腿抬高背屈手法为松解软组织与神经根粘连而设。

根据辨证论治的原则，应用中药内服以达到舒筋通络，增强血运，消除因继发因素而致的软组织水肿、炎症反应，达到间接扩大椎间孔、椎管的目的。

六、针刺夹脊穴 配手法治疗

黄金忠采用针刺夹脊穴及按摩手法治疗腰椎椎管狭窄症，取得理想疗效。

针刺：取穴：双侧 $L_2 \sim L_5$ 华佗夹脊穴，用 28 号 2 寸毫针与皮肤成 60° 角向脊柱方向斜刺，至患者有局部酸、胀、麻、放电样感觉后，接 G6805 治疗仪，用间断波形，中等刺激强度，平补平泻，刺

激 30min。每天 1 次，10 次为 1 个疗程。

按摩：

(1) 患者俯卧位，医者站于患者一旁，先用揉法施于患者腰部，配合手指按压肾俞、腰阳关、气海俞、大肠俞、关元俞，并用掌根按脊椎两旁夹脊穴，接着从腰部到臀部下肢后侧至小腿施揉法。

(2) 患者侧卧，医者站于一旁用斜扳法活动腰椎，左右各 1 次。

(3) 患者仰卧，医者站于患侧，用揉法施于大腿前侧、外侧至小腿外侧，上下往返数次，随后拿委中、承山、阳陵泉、三阴交，最后轻轻抖动患肢。上述手法每次约 20min，每天 1 次，10 次为 1 个疗程。

治疗期间嘱患者卧硬板床休息。

腰椎椎管狭窄症是由于先天性椎管较为狭小，中年以后又加骨质增生、黄韧带及椎板肥厚、小关节肥大、椎间盘退变等腰椎退行性变，使椎管容积进一步狭小而发病。本病好发于 40 岁以上的人。

采用针刺夹脊穴配合按摩治疗腰椎椎管狭窄症是取其夹脊穴挟督脉伴太阳经而行，其下有由椎体下方发出的脊神经后支及相应动静脉丛。针刺夹脊穴直接作用于病变部位，能使棘间韧带的紧张缓解、黄韧带收缩。同时配合按摩手法，可使局部毛细血管扩张，以增加椎管的血液供应，解除肌肉痉挛，改善微循环，使椎管相对扩大，从而使神经根受压减轻，达到治疗疾病的目的。

七、针推药 三法并用

林英恩采用针药推结合治疗腰椎管狭窄症，取得满意疗效。

针刺：以腰俞、次髎、后溪，申脉为主，常规消毒进针，行捻转补泻，其中腰俞以补为主，次髎平补平泻，后溪多泻少补，申脉多补少泻。留针 30min 左右，每 10min 行针 1 次，每天 1 次，15 次为 1 个疗程。

推拿：

(1) 手法 以揉、按、拿、揉、点、拍等手法为主。

(2) 顺序 先后面、后前面，由上至下。

(3) 取穴 以背部，下肢后侧足太阳膀胱经经穴为主，前面以髀关、风市、血海、足三里、阳陵泉、解溪、涌泉为主。

(4) 施术时间 共约 45min。最后以牵抖法结束按摩。每天 1 次, 15 次为 1 个疗程。

中药: 以芍药甘草汤为主方, 子时午时必需服药 1 次, 亦可煎汤代茶饮, 每日 1 剂, 15 次为 1 个疗程。

嘱患者以搓腰补肾法及烫脚搓涌泉法配合治疗, 锻炼以做环腰运动为主。

腰椎椎管狭窄主要由于椎间盘突出、脱出, 骨质增生及其他原因引起, 中医经脉辨证主要是由于督脉和跷脉不通或失养所致, 属于传统医学中的筋痹、腰腿痛、骨痹等范畴。由于此类疾病的患者年龄偏大, 不易于手术治疗。而且手术治疗方法亦是一种创伤, 尤其是对于骨质增生的患者更是效果欠佳, 故本方法有安全和易于接受之特长。

在施用手法之时要因人而异, 要轻重适宜。不要急于求成, 否则会有新的伤害, 所以在施用手法时要做到刚柔相济以此达到通痹、解痉、止痛、舒筋、活血、通络、行气之目的, 腰俞、次髎均为治疗腰腿痛的常用穴, 有调整肾阴肾阳平衡之功, 后溪为小肠经的输穴, 八脉交会穴之一, 通督脉, 有散风疏通经络的作用; 申脉为八脉交会穴之一。通阳跷脉。为阳跷脉的起始点, 有清神志, 舒筋脉, 理通阳跷的作用。二穴共用同起调气血, 通经络, 舒筋脉的作用。

口服中药之芍药甘草汤, 不仅治脚挛急, 凡因跌打损伤或睡眠姿势不正确而导致的腰背牵强者用之同效, 方中芍药治血痹, 散恶血, 能通血络之瘀, 甘草之药, 五行五味均归为脾胃, 主四肢肌肉。故合而共效。

杨某某, 男, 67 岁, 腰痛伴行走困难 3 年余, 每行走 300m 要蹲下休息再行, 所以随身都带有一小凳, 查体, 一般情况, 心肺无异常, 无糖尿病史。腰局部压痛不明显, 直腿抬高试验 (+)、"4"字试验 (-), CT 示腰椎退行性变并 L₄~L₅ 腰椎间盘突出, 且伴椎管狭窄 (最窄处约 9mm)。诊断: ①腰椎退行性改变。②腰椎间盘突出并椎管狭窄。经上法治疗 3 天后即感觉明显减轻, 经 2 个疗程后症状消失, 半年后随访无复发。

八、综合治疗 松则不痛

张建福采用骶管注药疗法、粗针头松解、药物及功能锻炼综合治疗腰椎管狭窄症，取得了较满意疗效。

骶管注射药物疗法：取利多卡因 5ml 曲安奈德 12.5mg，维生素 B₁₂ 1mg，维生素 B₁ 200mg，生理盐水 15ml。患者俯卧位，下腹部垫枕，臀部抬高，对骶骨裂孔处按常规消毒，以 7 号注射针头由骶裂孔处斜向上方刺入，手下感觉有落空感，经抽吸无血液或脑脊液，即将上药混合加压注射，注射过程中要不断询问患者的感觉，如出现头晕、心慌、出汗、欲呕等症状，可根据情况酌情减慢注射速度或停止注射。并用拇指点按内关、足三里、合谷等穴位，一般数分钟症状即可缓解。每周注射 1 次，一般注射 3~4 次。

粗针头松解法：伴有棘上韧带、棘间韧带压痛，L₃ 横突、骶棘肌止点处的压痛处及下肢沿坐骨神经走行方向的骨突部位处的疼痛点，每个痛点用确曲安奈德 10mg 或醋酸泼尼松龙 10mg，利多卡因 2ml，生理盐水 2ml，吸入注射器内混合后，以 12 号针头刺入痛点进行局部封闭，然后用针头顺肌腱或韧带方向纵行疏通，再在附着点处进行横行铲剥，每周 1 次，一般 2~3 次。

中药：用自拟蠲痹通络止痛汤内服，药用当归 12g，川芎 12g，丹参 30g，生地 12g，秦艽 10g，制川乌 8g，制草乌 8g，羌活 10g，牛膝 10g，全蝎 10g，制马钱子 1g，甘草 6g。病程较久者加黄芪 30g，党参 12g；遇风寒加重者加防风 12g，羌活 10g；腰腿冷痛者加制附片 10g，肉桂 8g；腰膝酸软者加杜仲 10g，牛膝 12g；大便干结者加大黄 10~20g；久痛入络痛甚加蜈蚣 3 条，乌梢蛇 15g。每天 1 剂水煎服，1 周为 1 个疗程，一般服 2~3 个疗程。

功能锻炼：①身体悬空锻炼法：身体强壮者可以攀单杠，身体悬空，利用身体重力牵引，使腰背部的肌肉放松，纠正脊柱侧弯，调整椎间关节的平衡。身体虚弱者或年龄较大者，用上法较为困难，可改用室内攀梯法代之。方法是将一长梯靠于墙上，与地面的角以 60°~70°为宜，患者攀于梯上后，双手攀援而使身体挨梯而双足下垂悬空。每天可做 4~6 次，每次时间以病人能耐受为宜。②飞燕点水法及拱桥锻炼法，进行腰背肌锻炼，初始每天 150 次，以后渐加

量。③空中蹬车锻炼法：患者仰卧位，双下肢屈膝屈髋各 90° ，先用猛力将左下肢向下蹬伸，然后用同法蹬右下肢，如此一左一右交替进行。每次可作 30 ~ 50 次，每天数次。此法可锻炼下肢肌肉力量，并可带动髋部肌肉，蹬车时的爆发力可带动下腰椎关节间的运动。

骶管注药疗法是骶管硬膜外冲击疗法，通过骶管注射可使药物直接作用于病灶，药液产生一定的液压可对粘连的组织和神经根起到钝性分离作用，药物浸润硬膜外腔及神经根周围，以消除神经根无菌性炎症，改善神经根的血液供应和营养状态。利多卡因可麻醉止痛，阻断疼痛刺激的传导，改善局部血液循环及营养状态；曲安奈德可起到抗炎、提高血管紧张性、减轻充血、降低毛细血管通透性的作用，从而抑制炎性细胞浸润，减少渗出，使细胞间质水肿减退，抑制成纤维细胞的增生和肉芽组织的生成，防止粘连；B 族维生素能营养神经，促使神经功能恢复。粗针头松解法是利用小针刀疗法松解软组织的原理，直达病所，解除神经的卡压及肌肉的痉挛，改善局部血液循环，由“痛则不松”而达到“松则不痛”。蠲痹通络止痛汤有祛风除湿、和血祛瘀、通络止痛的作用，可改善局部血液循环，解除神经根的压迫，利于无菌性炎症的消退。练功疗法可恢复脊柱力的平衡，通过腰背肌肌力的练习，增强的肌力可维持腰椎的稳定，利于病情的恢复。

九、针药结合 辨证施治

姚立群根据病情采用针刺中药治疗腰椎管狭窄症，收到满意疗效。

针灸：循经取穴，以足阳明胃经、足少阳胆经、足太阳膀胱经穴为主，常用承山、阳辅、足临泣、阳陵泉、委中、环跳、大肠俞等，根据病之虚实缓急，运用迎随补泻和飞经走气手法 5min，留针 30min。隔日 1 次，20 天为 1 个疗程。

中药：以补阳还五汤为基本方，黄芪 60g，丹参、枸杞各 20g，当归 15g，桃仁、赤芍各 12g，红花 9g，川芎、泽泻各 6g。若疼痛较重，酌加白花蛇舌草、制川乌、地龙等；寒湿偏重，酌加附子、干姜、苍术等。上药每日 1 剂，加水 500ml 浸泡 1h，先武火，后文火水煎 30min，取汁，分早晚各服 1 次。10 天为 1 个疗程。

腰椎管狭窄症是一种临床综合征。除导致腰椎管狭窄的各种独立的临床疾病以外，任何原因引起的椎管、神经根管、椎间孔的任何形式的狭窄，并引起马尾神经或神经根受压迫的综合征者，应统称为腰椎管狭窄症。主要的病理变化是腰椎间盘退行性变化，椎体和小关节骨质增生，黄韧带或后纵韧带肥厚、钙化等。

中医学认为，本病属痹证范畴，病因与肾气不足及复感风寒，外伤挫损有关。肾虚为本，伤痛为标。《证治准绳》谓：“有风、有湿、有寒、有热、有挫闪、有瘀血、有滞气、有痰积，即标也。肾虚，其本也。”患者多为中老年，肝肾亏损，气血不足，而风寒湿邪易乘虚侵入，瘀阻经脉。针刺中施以补泻手法，具有益肾固体，通经活络的作用。补阳还五汤重用黄芪大补元气，当归、川芎、赤芍等活血化瘀，疏通经络。针药结合，使血行风祛，气血得充，肝肾得补，标本同治。针药结合辨证施治，可达到改善微循环，消除神经周围的炎症、水肿及肌肉痉挛，消除疼痛的作用。

患者，男，53岁。腰肌劳损7年，加剧伴间歇性跛行1个月，患者行走数百公尺即出现右小腿疼痛、发胀无力，足背外侧有麻木感。坐下或卧床数分钟后，症状明显减轻或消失。查体见腰生理弧度变直，双侧腰肌僵硬，腰部无明显压痛点，直腿抬高试验（-），腰部背伸受限。舌质黯，苔白腻，脉弦细。CT示腰椎椎体后缘增生，小关节骨质增生，诊为椎管狭窄症。给予针药配合治疗1星期后，症状减轻，行走距离增至数公里。2个月后，症状基本消失，偶感右小腿外侧不适。

十、中药穴位注射 配硬脊膜外封

戴自明采用中药穴位注射及硬脊膜外腔封闭等水针疗法治疗腰椎管狭窄症，获得满意效果。

中药制剂穴位注射：用药：10%当归注射液。穴位：主穴：阿是穴或相应病变夹脊穴。配穴：肾俞、气海俞、大肠俞、关元俞、白环俞、委中、阳陵泉、承山、绝骨。

每次酌情选用2~4穴（亦可交替选用），无菌操作，以5号普通针头抽吸药液，常规进针后做轻微提插，使局部产生酸胀感并上下放散，回抽无血，即可推药缓慢注入。每穴每次注入药液2~4ml，

穴注后可加 TDP 照射以促进局部血液循环和药物吸收。急性发作期每天 1 次，缓解期隔日 1 次，6~10 次为 1 个疗程，疗程之间间隔 3~5 天。穴位注射多用于症状较轻的病例。一般治疗 1~2 个疗程即可缓解。

西药激素硬脊膜外腔封闭：用药：泼尼松龙混悬液 2ml 加 0.5% 利多卡因注射液 1ml。

患者取侧卧位，尽量屈颈、弯腰抱膝，根据不同病变部位分别选取 $L_3 \sim L_4$ 、 $L_4 \sim L_5$ 、 $L_5 \sim S_1$ 棘间为封闭点，在严格无菌操作下，抽吸好混合药液，常规进针至硬膜外后，如回抽无血液及脑脊液外溢，负压明显，即可将药液缓慢一次注入。注入后，应令患者保持头高脚低位。继续静卧 15~30min，并同时加 TDP 照射后方可下地活动。若患者出现头晕目眩、恶心呕吐、面色苍白、血压下降等异常反应，当立即静推 50% 葡萄糖 40~80ml，卧床休息 15~30min。如有反应，则及时实施其他急救措施。若仅有轻微头晕腿软现象，则不必特殊处理，稍加休息后可自行恢复。每 4~6 天封闭 1 次，4 次为 1 个疗程。本法多用于压迫症状明显、疼痛较剧之病例，但由于本类药物有一定副作用，不可久用，一般不得超过 2 个疗程，或痛势缓解后改以穴注治疗。

以上两种方法亦可相互配合，交替使用。

当归能改善微循环，抑制血小板凝聚，提高纤溶酶的活性，促进已形成的纤维蛋白溶解，其水溶部分更能有效地抑制血小板的粘附、聚集和释放功能，解除血管痉挛，扩张血管，改善血液流变性，增加血流量，降低外周阻力，促进代谢产物吸收，改善局部组织缺血缺氧，对特异性和非特异性免疫功能都有增强作用，并具有镇痛、消炎作用及升白细胞等活性，用穴位注射活血行血，通经活络而达到通则不痛的效果，且一般剂量无任何毒性及不良反应，可持续应用，安全可靠。激素类药物泼尼松龙能增加血管的紧张性，减少充血，降低毛细血管的通透性，抑制纤维母细胞及毛细血管的增生，防止和松解局部粘连，减轻疤痕，起到改善神经根周围条件的作用，并可增加细胞基质对粘多糖酶的抗力，抑制激肽原酶的活性，中和及排除湊合在局部胶原纤维变性坏死而释放的多肽类和单胺类物质，使椎管内的炎性反应迅速消退，而与之合用的局麻药物利多卡因则

能加强改善椎管内微循环,促进活性物质迅速从椎管内排除,中止和减轻对伤害感受器的刺激,阻断疼痛的反馈性恶性循环,从而达到解除病痛的目的。

参 考 文 献

- [1] 王宛彭,周莅莅,赵长福,等.次髂穴位注射治疗腰椎管狭窄症 70 例.吉林中医药,1996,(5):23
- [2] 韦以宗,潘东华,王秀光,等.调椎整曲法为主治疗椎管狭窄症.世界中医骨科杂志,6(1):95~98
- [3] 杨洸,鲍铁周,王爱红.钩针松解术治疗腰椎管狭窄症 45 例.河南中医,2007,27(3):64
- [4] 黄巍,李进,邢宏义.通督活血汤加背椎深刺以腰阳关为主穴治疗腰椎管狭窄作用的临床研究.中国中医骨伤科,3(2):22~23
- [5] 王维佳.小针刀配合手法、中药治疗非骨性腰椎管狭窄症.浙江中医学院学报,1997,21(2):41
- [6] 黄金忠,谢远见.针刺夹脊穴及按摩治疗腰椎管狭窄症 84 例.中国民间疗法,2004,12(7):38
- [7] 林英恩.针药按结合治疗腰椎管狭窄症 88 例.按摩与导引,2007,24(2):7~8
- [8] 张建福.综合疗法治疗腰椎管狭窄症 36 例报告.中医正骨,2005,17(5):52
- [9] 姚立群.针药结合治疗腰椎管狭窄症 48 例.上海针灸杂志,2004,23(1):21
- [10] 戴自明.穴注及封闭治疗腰椎椎管狭窄症 80 例.中国骨伤,1999,12(1):33~34

【梨状肌综合征】

梨状肌综合征，亦称梨状肌损伤或梨状孔狭窄综合征，是指因梨状肌发生损伤、痉挛、变性以致梨状孔狭窄，从而使通过该孔的坐骨神经和其他骶丛神经及臀部血管遭受牵拉、压迫所产生的一种病症。本病以老年人多见。

临床表现主要为通过梨状肌上、下孔的神经、血管及梨状肌本身损害的症状，其中最突出的是干性坐骨神经痛。起病可急可缓，病前多有外伤、过度体力劳动或受凉史。病程大多为慢性间歇性经过。通常累及一侧下肢。初期症状多为臀部钝痛、刺痛并伴有紧困、酸胀感，且疼痛常向大腿后侧、小腿后侧及足背或足外缘放射，走路或其他体力活动时加剧。此外，有时疼痛尚伴有下腹部及会阴部感觉异常。

本篇共收录了 13 位针灸医家的临床治验，有的以痛为俞，傍针刺；有的刺血配合小针刀；有的局部取穴为主，多向刺；有的采用阿是穴巨刺拔罐；有的采用阿是电针，环跳穴位注射；有的采取辨证取穴，白虎摇头；有的采用局部用穴，综合治疗等。

针灸治疗该病效果较理想，急性期最好能卧床休息，减少活动，以利于神经根水肿的吸收，缩短病程。注意臀部、下肢的保温，避免风寒湿等不良刺激。

一、以痛为俞 傍针刺

梨状肌综合征是由于梨状肌刺激或压迫坐骨神经引起的一侧臀腿疼痛的病证。钟泽鑫采用傍针刺为主治疗该病，取得良好疗效。

取穴：主穴：梨状肌综合征 A 穴（在臀部梨状肌投影部压痛最明显处或条索状中点之阿是穴），梨状肌综合征 B 穴（以次于 A 穴之疼痛点或条索状物一侧消失处为 B 穴）。配穴：太阳型（疼痛沿膀胱经循行向下放射）取委中、昆仑；少阳型（疼痛沿胆经循行向下放射）取阳陵泉、悬钟；混合型取阳陵泉、委中。

操作：侧卧位，患侧在上，局部常规消毒，选用 3 寸毫针，取梨状肌综合征 A 穴，直刺至梨状肌中，行大幅度捻转提插法，以患者能耐受为度，使产生较强针感；复针 B 穴，针刺方向为 A 穴针尖处，两穴合用使患者臀部产生强烈的酸胀感或出现放射感至下肢和会阴部。针委中、阳陵泉时要求针感如触电样传到足跟部或足趾部；针悬钟、昆仑均以得气为度。每穴留针 15min，每 5min 运针 1 次。每天 1 次，7 次为 1 个疗程，各疗程间隔 3 天。

傍针刺为《内经》十二刺之一，《灵枢·官针》云：“傍针刺者，直刺、傍刺各一，以治留痹久居者。”此法用于压痛明显，而且固定不移，久久不愈之痹证，常取良效。遵循“以痛为俞”的原则，采用傍针刺加强针感，使经络气血运行加快，邪气得以宣泄，经脉得以通畅，达到通则不痛的效果。在针刺过程中，应注意使针感传至小腿及会阴部以提高疗效。针刺委中、阳陵泉对消除腿部症状起重要作用。

钟某某，男，43 岁，工人，1994 年 10 月 10 日就诊。主诉：右侧臀部及下肢疼痛 2 年，加剧 1 周。症缘于 2 年前因不慎扭伤而出现右侧臀部疼痛，疼痛放射至右下肢，每于劳累及受凉时尤甚，虽反复服用中西药及封闭治疗，病情反复。1 周前因受凉后而致上症加剧，行走不利。体检示：右侧臀部梨状肌投影部明显压痛，可触及一条痉挛肌束，右小腿外侧、外踝部压痛，右梨状肌紧张试验（+）。诊断：梨状肌综合征。治疗：经用上法治疗 7 次，症状、体征消失，随访 1 年未见复发。

二、刺血配小针刀 局部整体同治

梨状肌损伤综合征是伤科常见病，汤忠军根据此病患处疼痛剧烈，伴有同侧大腿后外侧放射性疼痛等症状，采取刺血配合小针刀治疗，疗效满意。

刺血：在压痛最明显处用掌根揉按片刻，使该部位络脉怒张，用碘酒棉球消毒后，左手绷紧皮肤，右手持三棱针迅速点刺3~5下，并加拔火罐帮助瘀血外排，留罐10~20min，起罐后根据“循经取穴”的原则，在患部下肢选取1~2穴点刺出血，取“上病下取”之意，2天治疗1次，嘱患者当天避免洗冷水澡。

小针刀：患者侧卧，患侧在上，健侧腿伸直，患侧腿屈曲，身体略向前倾，使患侧膝部着床，找准梨状肌压痛点常规消毒，铺无菌手术巾，术者持小针刀在压痛点处进针刀，刀口线与梨状肌纵轴平行，针体与臀部平面垂直，当刀锋刺入皮下后继续摸索深入，待出现酸胀感时，先进行纵向剥离，后行横向剥离，有硬结者须切开剥离，紧接着横行铲剥。术毕后出针，盖上无菌纱布即可。必要时5天后再进行第2次手术。

小针刀治疗，一方面直接松解粘连硬化，切断部分梨状肌纤维，解除挛缩，使坐骨神经游离松解；另一方面能够疏通经络，加速局部气血流通，促进梨状肌组织炎症吸收，从而消除各种病理因素对坐骨神经产生的刺激及压迫而达到止痛的目的。刺血配合小针刀治疗本病，可以达到局部与整体同治，改善血液循环，促进损伤组织的修复。

三、局部取穴 多向刺

吴汉阳根据《灵枢·官针》十二刺之“恢刺”、五刺之“合谷刺”为基础，发展为“多向刺”，多方向针刺拘急的梨状肌肌肉组织。

取穴：环跳、秩边、阿是穴为主穴。阳陵泉、委中、承山、飞扬、昆仑为配穴。

操作：常规消毒后，选用28号3寸毫针，采用双手夹提法缓缓垂直进针，使针尖直达病所，行提插捻转手法，可得到较强烈的酸、

麻、胀、痛针感，沿坐骨神经方向向下、足背传递。然后将针提至浅层皮下，分别沿条索状隆起的肌束上、下、左、右进行多向针刺，最后于垂直位施温针灸3壮，同时针刺同侧的阳陵泉、委中、承山、飞扬、昆仑等穴，行平补平泻或泻法，留针20~30min出针。隔日1次，急性期可每天1次，10次为1个疗程。

中医学认为，本病乃筋脉痹阻，气滞血凝，不通则痛，治当祛瘀通络止痛，消除痉挛。根据《灵枢经》十二刺之恢刺、五刺之合谷刺为基础发展成为“多向刺”，通过直接作用于病变部位，多方向针刺拘急的筋肉组织，明显的促进病变局部气血运行，达到舒缓拘急而镇痛的作用。足太阳、少阳二脉之会环跳穴下正值梨状肌下孔，为坐骨神经穿出处。秩边穴下乃坐骨神经出坐骨大孔处，在此施以多向刺，可使拘急的梨状肌得到舒缓，减轻对神经的压迫，复加温针灸更助温经散寒之功，配合筋会之阳陵泉、膀胱经之络飞扬等穴舒筋通络止痛。

赵某，男，47岁，工人，1999年1月5日初诊。主诉：右臀部及下肢疼痛1周。患者于1周前挑重物下楼梯，不慎致右臀部及下肢疼痛，并逐渐加剧，患部呈刀割样疼痛，不能翻身，跛行，曾在他院针灸、理疗均无效，遂来针灸科就诊。查：右臀部环跳穴处压痛明显，梨状肌投影区可触及条索状肌束，腰部压痛（-），右直腿抬高试验（+），梨状肌紧张试验（+）。诊断：右侧梨状肌综合征。遂用多向刺治疗，留针20min，患者当晚疼痛大减。每日治疗1次，4次后疼痛消失，活动自如即告痊愈，随访2年无复发。

四、阿是穴 巨刺拔罐

张明霞在多年的临床实践中采用巨刺拔罐法治疗梨状肌综合征，效果满意。

取穴：在梨状肌体表投影部压痛最明显处拔罐（患侧），继而在健侧相应点巨刺。

操作：选用直径5~6cm铝制火罐或玻璃火罐在压痛点利用负压拔罐，15min后起罐，在健侧相应点施以巨刺，强刺激得气后留针20min，其间每5min行针1次，隔日1次，10天为1个疗程。

梨状肌综合征常因梨状肌受损或变性，加以受寒伤湿等诱发，

属于中医痹证范畴。《素问·阴阳证象大论》说：“善用者，从阴引阳，从阳引阴，以左治右，以右治左……见微之过，用之不败。”巨刺则是根据经络气血阴阳，左右倾移，上下互调的一种手法。梨状肌体表投影部压痛点拔罐，能改善局部血液循环，促使无菌性炎症导致的轻度水肿及病理分泌物的吸收。两种治法协同互补，相得益彰，共奏运行气血，疏通经络，通则不痛之功。

秦某，女，32岁，工人。左侧腰腿痛21天来院就诊。检查：左侧梨状肌体表投影部压痛（+），左直腿抬高试验（+），“4”字试验（+）。经该法治疗8次，症状完全消失，左侧梨状肌体表投影部无压痛，左直腿抬高试验（-），“4”字试验（-）。

五、阿是电针 环跳穴注

夏智对梨状肌损伤综合征患者行电针加穴位注射治疗，疗效较好。

取穴：主穴：阿是穴，或梨状肌体表投影确定腹肌中点。其旁开1寸两点定为配穴。

操作：用28号3寸毫针与皮肤成45°角刺入约2.5寸，提插至出现酸麻胀感。针刺得气后接G6805-I治疗仪，选取疏密波，频率为30Hz，主穴接负极，配穴接正极，强度以患者能耐受为宜。留针30min。每天1次，7天为1个疗程，疗程间间隔1~2天。

穴位注射：取患侧环跳穴，以0.5%盐酸布比卡因注射液2ml，醋酸泼尼松龙注射液20~25mg，当归注射液2ml，行穴位注射。于电针治疗后，患者取侧卧位屈膝，患侧在上，用5ml无菌注射器及7号穿刺针抽取上述药物垂直刺入，稍加提插，待有针感且回抽无血时，注入药物。出针后按压针孔片刻。每隔2天1次，疗程同上。

齐刺是临床常用的一种针刺方法。《灵枢·官针》曰：“齐刺者，直入一，傍入二，以治寒气小深者，或曰三刺，三刺者，治痹气小深者也”。梨状肌的浅层有肌肉丰厚的臀大肌，部位较深，病损亦较局限，和其他针法相较而言，齐刺对本症更为适宜。电针刺激能解除局部肌肉痉挛，松解粘连组织，缓解梨状肌对其周围神经的压迫，具有良好的止痛作用；并能调节血管功能，改善局部血液循环，促进组织营养代谢。

环跳穴属足少阳胆经，是治疗腰腿痛的常用穴。穴位注射所选0.5%布比卡因注射液，止痛时间长、能松弛因痛而致痉挛的肌肉，并改善局部血液供应。醋酸泼尼松龙可消炎祛肿、松解粘连。当归注射液具有活血、通经之功，活血可以生新，通经可以止痛。各药相伍，注入环跳，既利用了穴位的治疗功能，又发挥了药物的药理作用，故疗效较好。

胡某，男，39岁，1999年6月12日初诊。3个月前抬重物时扭伤髋部，左侧臀部呈刀割样疼痛，并向股后小腿外侧放射。就诊前3天因醉酒跌倒在地，疼痛加剧。诊见：痛苦面容，时有呻吟，强迫体位。检查：腰椎生理曲度正常，腰椎棘旁无明显压痛，臀肌紧张，左侧梨状肌体表部位压痛（++），可扪及结节，直腿抬高试验右60°，左25°。舌淡苔薄白，脉沉紧。诊断：左侧梨状肌损伤综合征并坐骨神经痛。遂用上法治疗。第2天，疼痛减轻，能自行走动。1个疗程后，疼痛消失，恢复工作。随访3个月未复发。

六、辨证取穴 白虎摇头

吴琦采用齐刺结合白虎摇头手法治疗梨状肌综合征，取得了较满意的疗效。

取穴：血瘀型：环跳、秩边、承扶、阳陵泉、太冲；风寒湿型：环跳、秩边、风市、承山、丰隆、昆仑；湿热型：环跳、秩边、殷门、委中、丰隆、行间。

操作：首先令患者侧卧而患侧臀部朝上，下肢微屈。以3寸28号不锈钢毫针在环跳穴先刺1针，然后在环跳穴左右1寸各刺1针。此3针均施以白虎摇头手法：将针捻入，并用中指拨动针体使针左右摇动，再行上提，同时进行摇振，有如用手摇铃一般，待得气后，其他腧穴再按常规针刺，留针30min，每天1次，12次为1个疗程。

梨状肌综合征属中医痹证，其疼痛部位在臀部较深的部位而往往压迫坐骨神经，引起剧烈疼痛。用齐刺的方法三针集合直刺病所，再结合白虎摇头手法以疏导经气，加强通经活络、蠲痹止痛之作用，故能收到较好的疗效。

七、腿三针为主 气至病所

舒洪文在临床上几经摸索筛选，针刺环跳、阳陵泉、悬钟（腿三针）治疗梨状肌综合征，疗效较好。

取穴：环跳、阳陵泉、悬钟。

操作：患者健侧卧位，患肢屈髋屈膝，健肢伸直，暴露针刺部位，局部常规消毒。针环跳用3寸毫针，快速刺入一定深度稍待候气，再直达深入，即有触电样酸麻胀针感传导，施雀啄法2~3次加强，勿捻转免伤神经干。阳陵泉、悬钟用2寸毫针直刺，出现针感施相应捻转补泻手法。留针30min，15min运针1次，每天1次，12次为1个疗程，疗程间休息3天，再行治疗。

《玉龙歌》云：“环跳能治腿股风。”《天星秘诀》有：“冷风湿痹针何处，先针环跳次阳陵。”梨状肌综合征患者，疼痛沿足少阳胆经分布，少阳者多气少血之经，针刺易得气而针感强，诸穴共奏疏导少阳气机，气行则血行，血行则通，通则不痛。尤其环跳穴作用更显著，针时有强烈的针感传导，则有相当好的止痛效果。达到消炎止痛，缓解痉挛，改善循环，促进代谢的治疗目的。

沈某，女，71岁，农民，1990年4月12日诊。右臀腿放射性疼痛，症状时轻时重已10月，此次受凉发作15天，经他院对症服西药无效。检查：跛行，右梨状肌压痛，右腿抬高40°，梨状肌紧张试验（+）。诊断：右梨状肌综合征。治疗：取右环跳、阳陵泉、悬钟穴，施捻转泻法，治疗3次疼痛症状改善明显，针治5次症状体征消失而愈，至今疗效巩固。

王某，男，52岁，农民，1992年5月26日诊。左臀部跌伤，疼痛反复发作3年，因劳累放射性疼痛加剧15天，迈步受限，经他院封闭治疗3次无效。检查：跛行，左腿抬高40°，梨状肌压痛呈放射性，紧张试验（+）。诊断：梨状肌综合征。治疗按上法针环跳、阳陵泉、悬钟。施提插泻法，针治2次，症状体征消失而愈，随访至今未复发。

八、膀胱俞—胞育 重在手法

齐惠涛采用以针刺为主，配合电针的方法治疗梨状肌综合征，

效果显著。

取穴：患侧膀胱俞、胞育为主穴，伴整个下肢痛者加环跳、委中、飞扬。

操作：刺膀胱俞时针尖向脊椎方向 15° 角斜刺，进针深度约 1.5 寸，使针感扩散至整个腰骶部；刺胞育穴时采用直刺，针尖指向压痛点，针刺深度约 2~2.5 寸，针感能放射至整个下肢效果更佳。根据辨证，应用提插、捻转补泻手法，针感要强。然后，在针柄上接 G6805-1 型电针仪，采用疏密波，以患者能耐受为度，留针 30min。每天 1 次，10 次为 1 个疗程。

梨状肌综合征主要表现为臀部及大腿后侧疼痛，疼痛常可放射至整个下肢，行走困难伴跛行，腹压增高（如排便）时疼痛加重。俯卧位可在臀部触及条索状物或隆起的梨状肌，压痛明显。在中医学中，此病属“痹证”、“伤筋”等范畴。膀胱俞、胞育均是足太阳膀胱经穴，臀部及大腿后侧为足太阳经循行所过之处，针刺此经络的腧穴可以主治与筋脉损伤有关的病症。脉冲治疗仪可促进局部炎症水肿的吸收，解除神经组织压迫。针刺与电针两者配合，从而取得了较好疗效。

王某，男性，53 岁。2002 年 6 月 2 日初诊。主诉：右侧臀部疼痛 20 余天，伴右下肢疼痛，行走困难，夜间卧位时疼痛更甚，不能入睡。患者自述 20 多天前锻炼时扭伤出现疼痛，经外贴止痛膏、理疗、中药熏洗等治疗，症状未见好转。检查：右侧梨状肌压痛，局部可触及条索状硬块，直腿抬高 60° ，前呈阳性，髋关节内旋、内收受限，且疼痛加重。诊断为右侧梨状肌综合征。取患侧膀胱俞、胞育、环跳、飞扬、悬钟，针刺得气后接 G6805-1 型电针仪，采用疏密波刺激留针 30min。起针后疼痛明显减轻，治疗 7 天后痊愈。

九、局部用穴 综合治疗

张有圣采用针刺配合火罐、手法治疗，取得了较满意的疗效。

取穴：按“以痛为腧”的原则取穴。

操作：用酒精在局限性束状隆起的条索状梨状肌处常规消毒后，用 3 寸毫针在条索状紧张的梨状肌两头斜刺 45° ，施行强烈提插捻转，局部产生酸、麻、重、胀的感觉，并向大腿前侧放射传导为宜。

再在条索状紧张的梨状肌中点处直刺强提插捻转，以泻法为主，然后在毫针直刺处拔火罐，把毫针罩在火罐中，留针罐 20min，局部拔出青紫为佳。

手法治疗：取针罐后用弹拨法弹梨状肌 3 ~ 5min 即可。每天 1 次，5 次为 1 个疗程，每疗程后休息 2 天。

张有圣认为采用针刺配合火罐及手法治疗本征，既可以抑制梨状肌局部血管通透性的升高，使充血、水肿、痉挛减轻，改善局部微血管和淋巴循环，控制炎症，加速功能恢复，又可用手法弹拨梨状肌，以使梨状肌的粘连松解，压迫减轻，解除疼痛，标本兼治，以达到活血祛瘀，疏通经络，消炎止痛恢复功能之目的，使疗效得到提高并巩固。

张某，男，38 岁，工人。1994 年 8 月 3 日就诊。主诉：右侧臀部及下肢疼痛 2 年余，加重 2 天。现病史：患者 2 年前因工作中搬重物扭伤右侧臀部，疼痛并放射右腿疼痛，经多次封闭治疗无明显好转，反复发作剧痛，翻身困难，右下肢不能行动。查体：右侧臀部可触及梨状肌呈局限性束状隆起，压痛明显，右侧腘窝、小腿外侧、外踝压痛明显。诊断：慢性梨状肌综合征急性发作。按上述方法治疗 1 个疗程痊愈，随访 1 年未复发。

十、八髎 - 秩边 重刺法

梨状肌综合征是骨伤科常见病种，也是引起干性坐骨神经痛的主要原因之一。王声强从梨状肌及支配梨状肌的骶神经两方面入手，以针刺八髎、秩边为主穴治疗，疗效满意。

取穴：上髎、次髎、秩边为主穴，环跳、昆仑为配穴，均取患侧穴。

操作：常规消毒后，上髎以 60° 角向下进针 1.5 寸；次髎以 65° 角向下进针 2 寸。二穴进针均朝向耻骨联合。秩边直刺 2.5 寸，针感以局部酸、胀为度。环跳、昆仑分别刺 2.5 寸、1 寸，得气即可。诸穴均施以泻法，留针 30min。每天治疗 1 次，6 次为 1 个疗程。疗程间隔休息 1 天。

梨状肌起自骶前孔的外侧，经坐骨大孔止于股骨大转子，受 S₁、S₂ 神经的支配。故治疗上取上髎、次髎、秩边穴更为直接有利。采

用适当的手法和角度针刺上髎，次髎穴，能对支配梨状肌的 S_1 、 S_2 神经产生直接的影响，从而部分地阻滞了骶神经的传导。同时又可使脊髓背角细胞对伤害性刺激反应受到抑制，进而能有效地缓解梨状肌痉挛，减轻对坐骨神经干及其血管的压迫刺激。针刺秩边穴，可通过皮下筋膜经臀大肌直达梨状肌肌腹，并有可能使其内微环境得以充分改善。由此可见，以八髎、秩边为主穴的针刺治疗，是以梨状肌及支配梨状肌的骶神经为基点，通过对其神经、血管和淋巴循环的作用，抑制了疼痛刺激及其反应，改变了局部的组织代谢和营养，从而有效地改善了梨状肌综合症的病理状态。

宋某，男，32岁，工人，1999年6月8日初诊。主诉：右臀及下肢疼痛1周。现病史：患者于1周前下楼转弯过猛，感觉臀部及大腿受到牵拉。其后疼痛逐渐加重，行走站立困难，疼痛由大腿后侧向小腿前外侧放射。经服用消炎痛等药物治疗无明显疗效，遂来针灸科就诊。检查：患侧臀肌松弛，皱襞较健侧低，梨状肌紧张、增厚、压痛。直腿抬高试验、梨状肌紧张试验、内收试验均为(+)。诊断：梨状肌综合征。穴取上髎、次髎、秩边、环跳、昆仑，诸穴均施以泻法，留针30min。治疗2次后，疼痛减轻；4次后，症状基本消失，仅梨状肌处按压时稍有不适；治疗6次后，症状及体征完全消失而告愈。

十一、阿是穴小针刀 通络止痛

吴绪荣采用小针刀治疗梨状肌损伤综合征，疗效显著。

取穴：阿是穴（痛点）。

操作：

(1) 患者取俯卧位，术者先用手指在患者臀部梨状肌处探明压痛敏感点，如发现条索状或结节性痛点，即用1%的龙胆紫作出标记；

(2) 对痛点进行严格消毒；

(3) 将刀口（针体长8cm）压在进针点上，使刀口线和大血管、神经及肌肉纤维走向平行；

(4) 右手拇指、食指捏住针柄，其余三指托住针体，加压分离，快速刺入皮内，至需要深度，再行纵行切割，横行剥离；

(5) 取出小针刀后, 注射 1% ~ 2% 普鲁卡因 2ml 与醋酸泼尼松龙 1ml (25mg) 混合液, 再用 2% 碘酒消毒刀口, 最后用创可贴敷贴刀口。每周 1 次, 每次做 1 ~ 2 个痛点, 2 周为 1 个疗程, 3 个疗程后休息 1 周。一般治疗 1 ~ 3 个疗程。

小针刀疗法源于古代“九针”, 既有中医针刺的作用, 又有西医手术刀的松解功能。针刺时, 由于针刀比传统的毫针粗大, 刺入肌肤后接触面广, 治疗定位准确, 所以会产生强烈的针感。加之施以纵向疏通、横向剥离的手法, 故能起到活血化瘀、疏通经络和濡养筋脉的作用。行松解术时, 用 0.8mm 宽的刀刃切割硬结、条索和软组织紧张点, 可以破解瘀阻、通络止痛, 使粘连、结疤、挛缩的病变组织得到剥离松解。

陈某, 男, 57 岁, 干部。1998 年 10 月, 下蹲搬物后突觉右侧臀部及大腿后外侧疼痛, 其后逐渐加重, 当地医院诊为坐骨神经痛, 经治无效。臀部呈针刺样的剧痛, 不能入睡。某医院用维生素 B₁、维生素 B₁₂ 及超短波治疗仍未见效, 而于 1999 年 6 月来我科就诊。诊见: 右侧臀部肌肉萎缩, 弹性减弱, 可触及条索状改变、钝厚, 压痛明显。梨状肌紧张试验 (+), 诊为右侧梨状肌损伤综合征。用上法治疗 3 次后疼痛完全消失, 活动正常, 即告痊愈。随访 1 年未复发。

十二、综合治疗 标本兼顾

侯书伟采用综合疗法治疗梨状肌综合征, 疗效满意。

穴位封闭: 梨中 (梨状肌体表投影区域内压痛最著点); 药物: 泼尼松龙 25mg, 利多卡因 2ml, 注射用水 2ml; 用 5ml 注射器配 6 号针头, 依次抽取上述药物, 穴封点常规消毒, 执笔式进针, 回抽无血后缓慢注入药物。两次穴封间隔 3 ~ 5 天, 该法应用 1 ~ 2 次。

针刺治疗: 秩边、殷门、委中、承山、飞扬、昆仑。操作: 患者俯卧位, 诸穴 (均取患侧) 常规消毒, 均用 30 号毫针, 秩边直刺 2 ~ 4 寸, 余穴酌情直刺 0.5 ~ 2 寸, 均予平补平泻, 留针 30min, 每隔 10min 行针 1 ~ 2min, 每天 1 次, 6 次为 1 个疗程。

穴位注封: 承山、秩边、飞扬, 两组穴位逐日交替使用 (注: 避开当日穴封点); 药物: 维生素 B₁ 100mg、维生素 B₁₂ 250μg; 操

作：用5ml注射器配6号针头，穴注点常规消毒，执笔式进针，回抽无血后缓慢注入药物、每穴注入1.5ml；每天1次，6次为1个疗程，疗程间休息1天。

其他疗法：电针：承山、秩边、飞扬，两组穴位逐日交替使用，进针得气后采用连续波持续刺激30min。拔罐：取秩边穴，起针后留罐10min，起罐后用罐体（玻璃罐）揉揉局部3min。电针及拔罐时间同针刺治疗。

梨状肌综合征临床较多见，属中医痹证范畴，证候以实为主，病因主要为感受风、寒、湿、热之邪，闭阻经络，或瘀血阻络，气血不能畅行所致，散寒除湿，化瘀通络为其主要治则。

多种疗法治疗本病均可获得较好疗效，但综合疗法可弥补单一疗法的局限性，使疗效明显提高。穴位封闭止痛效果明显，且可消除坐骨神经、梨状肌及周围组织水肿、粘连，减轻梨状肌相对于坐骨神经的张力；针刺治疗中若病人压痛点较弥散或有多压痛点，局部可采用扬刺法，极少数病人坐骨神经放射痛以下肢外侧为重，可加用环跳、阳陵泉，辅之以电针、拔罐可明显提高针刺疗效；中药活血化瘀、散寒除湿作用明显，病重患者可增加服用天数，并应酌情增加药物：瘀象明显者加三棱、莪术；兼气虚者加黄芪；伴血虚者加熟地、白芍；腰膝酸软无力者加狗脊、川断；兼脾虚者加炒白术；寒邪偏重者加制附子；偏热者加秦艽、忍冬藤；舌质黯红、苔白腻、脉沉滑者加黄柏、苍术；穴位注射可发挥经络、腧穴、药物的多重作用，增强针刺治疗舒筋散寒，通络止痛的功能。诸法合用，标本兼顾，故获良效。

十三、辨经取穴 齐刺配火罐

王康社应用针刺和拔罐法治疗此病，疗效满意。

取穴：阿是穴（臀部压痛点）为主穴；太阳型加委中、昆仑；少阳型加阳陵泉、绝骨；混合型加委中、阳陵泉、绝骨、承山。

操作：患者左或右侧卧位，健侧在下，腿伸直，患腿在上屈曲，医生先轻轻按揉阿是穴，常规消毒后，取3寸毫针3根，在压痛点正中直刺1针，提插捻转产生酸困感后，在两旁各直刺1针，使臀部产生强烈的胀困感，再用闪火法拔罐，3针留于罐内，这一方法即

带针坐罐法，余穴用 1.5 寸毫针直刺，产生胀困感后留针，火罐留 15min，针留 30min，每 10min 行针 1 次，7 次 1 个疗程。

梨状肌综合征是由于身体下蹲、弯腰、站立旋转或坐姿旋转躯体时，引起梨状肌肿胀、痉挛或充血等压迫坐骨神经，出现臀区神经疼痛症候群，中医学将其归属于“痹证”范围，认为是由于风、寒、湿三邪侵袭少阳并滞留于肌体，阻滞经络，使气血瘀阻，出现少阳经证，臀部疼痛，小腿外后侧胀困，行走跛形。针刺具有疏导经气、通经止痛之功用；火罐有温经散寒、止痛消肿之功用；二者结合，共同完成治疗目的。

《灵枢·官针》：“齐刺者，直入一，傍入二，以治寒气，小深者。或曰三刺。三刺者。治痹气小深者也。”臀部肌肉深厚、梨状肌深而小，疼痛深藏，寒气深小，因而采用 3 寸毫针齐刺，并用火罐扣于针上，针与罐共同完成消肿、止痛、消炎之效，也叫带针坐罐法。

田某某，男，50 岁，工人，1995 年 6 月 5 日初诊。主诉：昨天搬炭时不慎扭伤臀部，未作治疗。今晨起床后左侧臀部出现“刀割样”疼痛，小腿外侧胀痛，行走困难。刻诊：臀部梨状肌体表投影区压痛（+），小腿外侧阳陵泉、悬钟压痛（+），委中压痛（-），梨状肌紧张性试验（+），直腿抬高试验（+）、大于 60° 时（-）。X 线片提示：无骨质损伤。诊断为梨状肌综合征，中医属少阳型。治疗以活血通络止痛为原则，用针刺加罐法。取穴：臀部压痛点、阳陵泉、悬钟。患者右侧卧位，右腿在下伸直，左腿在上屈曲位，暴露左侧臀部及小腿，在臀部压痛点轻柔按摩片刻，常规消毒后，取 3 根 3 寸毫针，用双手进针法，直刺压痛点，提插捻转泻法，臀部出现酸困感后，在两旁各直刺 1 针，使酸困感向下传导，用闪火法在 3 针上拔罐。阳陵泉、悬钟 2 穴用 1.5 寸毫针直刺得气，留针 30min。10min 行针 1 次，留罐 15min，7 天为 1 个疗程。6 月 8 日，自诉疼痛基本消失，臀及小腿余留胀感，继续治疗。6 月 10 日，患者疼痛，胀困感消失，行走自如，臀部压痛（-），直腿抬高试验及加强试验均（-），梨状肌紧张性试验（-），总治疗 5 天。

参考文献

- [1] 钟泽鑫. 傍针刺治疗梨状肌综合征 40 例. 福建中医药, 1999, 30 (4): 23~24
- [2] 汤忠军. 刺血配合小针刀治疗梨状肌损伤综合征 50 例. 安徽中医临床杂志, 2001, 13 (3): 195~196
- [3] 吴汉阳. 多向刺治疗梨状肌综合征 80 例疗效观察. 吉林中医药, 2002, 22 (5): 47~48
- [4] 张明霞. 巨刺拔罐法治疗梨状肌综合征 30 例. 皖南医学院学报, 1996, 15 (3): 274~275
- [5] 夏智, 简晓春. 齐刺加穴位注射治疗梨状肌损伤综合征. 湖北中医杂志, 2000, 24 (12): 43
- [6] 吴琦. 齐刺结合白虎摇头手法治疗梨状肌综合征 161 例临床观察. 中医杂志, 2002, (7): 506
- [7] 舒洪文. 腿三针治疗梨状肌综合征疗效观察. 针灸临床杂志, 2000, 16 (5): 47~48
- [8] 齐惠涛, 齐惠景. 针刺配合电针治疗梨状肌综合征 68 例临床观察. 北京中医药大学学报, 2004, 11 (2): 31~32
- [9] 张有圣. 针刺为主治疗梨状肌综合征 56 例疗效观察. 甘肃中医, 1999, 12 (6): 40~41
- [10] 王声强, 王蓬. 针刺治疗梨状肌综合征 30 例疗效观察. 中国针灸, 1995 (6): 17~18
- [11] 吴绪荣. 小针刀治疗梨状肌损伤综合征 31 例. 湖北中医杂志, 2001, 23 (4): 45
- [12] 侯书伟. 综合疗法治疗梨状肌综合征 30 例. 中医药学刊, 2004, 22 (10): 1949
- [13] 王康社. 针罐法治疗梨状肌综合征 45 例. 中国针灸临床杂志, 2005, 21 (2): 34

【坐骨神经痛】

坐骨神经痛是指沿坐骨神经通路（腰部、臀部、大腿后侧、小腿后外侧及足外侧）以放射性疼痛为主要特点的综合征。

中医学对本病早有认识，古代文献中称为“坐臀风”、“腿股风”、“腰腿痛”等。在《灵枢·经脉》篇记载足太阳膀胱经的病候中有“脊痛，腰似折，髀不可以曲，腠如结，如裂……”，形象地描述了本病的临床表现。认为腰部闪挫、劳损、外伤等原因可损伤筋脉，导致气血瘀滞，不通则痛；外居湿地，或涉水、冒雨，衣着单薄、汗出当风，风寒湿邪入侵，痹阻腰腿部；或湿热邪气侵淫，或湿浊郁久化热，或机体内蕴湿热，流注足太阳、少阳经脉，均可导致腰腿痛。主要属足太阳、足少阳经脉及经筋病证。

本篇收录了十多位针灸医家的临床治验，在取穴上，有的以环跳为主穴，有的采用循经取穴，有的以阳陵泉为主，有的以头穴为主；在针刺手法上，有的采用龙虎交战法，有的采用首尾齐刺法，有的采用齐刺、输刺，有的采用盘针刺等，均取得了一定效果。

针灸治疗坐骨神经痛效果显著，急性期应卧床休息，椎间盘突出者须卧硬板床，腰部宜束阔腰带。劳动时须采取正确姿势，平时注意

防寒保暖。如因肿瘤、结核等引起者，应治疗其原发病；腰椎间盘突出引起的可配合牵引或推拿治疗。

一、长针刺环跳 诱导循经感传

管辉以针刺患侧环跳穴为主，并诱导循经感传现象，治疗坐骨神经痛取得了满意疗效。

取穴：以环跳穴为主穴，腰部病变加气海俞、关元俞、大肠俞，臀部病变加秩边、新建、环中，髋部病变加居髎、髀关。

操作：患者侧卧位，髋关节自然屈曲，患侧向上。每次以环跳穴为主，配取病变部位一个穴位并常规针刺。针环跳时以2~3寸长毫针刺入，务必使针感沿病变经络向下传导，如出现下肢明显麻感则将针上提少许，不捻转。每天1次，10次为1个疗程。每个疗程之间可5~7天。

环跳穴与足三阳经有着极为密切的关系。针刺环跳能疏通三经之气血，治疗足三阳经脉所过之病变，使之达到“通而不痛”。本法针刺时注重诱导循经感传现象，不仅要使针感传导至下肢足部，更应注重病位归经，气至病所，从而达到事半功倍的效果。

董某某，男，45岁，工人，右腰腿痛病一月多，加重一周，痛沿左臀向足跟放射，伴腓肠肌后侧麻木，曾在外院行药物及针刺治疗未奏效，现疼痛难忍，步履艰难夜眠不得，腰椎生理弧度小，呈轻度右侧畸形，L₄、L₅椎体左侧深压痛明显，左直腿抬高30°，加强试验(+)，左足踝背伸减弱，弯腰活动明显受限。取左环跳、大肠俞，一次治疗后疼痛锐减，夜能入睡，二次治疗后小腿麻木感显著减轻。12次治疗后症状、体征全部消失并能正常工作，10个月后随访未复发。

二、循经取穴 火针刺

李萍采用火针治疗坐骨神经痛，效果满意。

取穴：以足太阳膀胱经分布区内疼痛为主的，取：夹脊穴(L₄~L₅)、秩边、承扶、承山、腰阳关、殷门、飞扬、昆仑。以足少阳胆经分布区疼痛为主的，取：环跳、风市、阳陵泉、绝骨、丘墟。

操作：找准穴位，在穴位上按常规消毒。火针在酒精灯上烧至

白亮，对准穴位速刺入，留针 1min，针后拔火罐 10min。以上治疗 2 天为 1 次，5 次为 1 个疗程，最多治疗 2 个疗程，火针刺后，局部 5 天内不宜沾水。

火针刺俞穴，其热力能深透肌层，以扶阳培元，驱散风寒湿之邪，以固其根本。人若阳气常盛，则病邪不易侵犯，为此火针能起卫阳而为固，能温通经络，使气血运行流畅的作用。

患者，男，32 岁，农民，初诊日期为 1992 年 2 月，主诉：左腰部持续性疼痛 3 月余。病史：因在田地间劳动，久坐湿地，感受寒湿之邪侵袭，最初感左臂部及大腿外侧疼痛，逐渐加重，经服用各种药物及理疗治疗，疗效不佳。查：左侧疼痛沿坐骨神经通路上有放散性疼痛和明显压痛（足太阳膀胱经），左直腿抬高试验阳性，诊断为坐骨神经痛，中医辨证风寒湿痹。治疗：取腰椎夹脊（ $L_4 \sim L_5$ ）、环跳、秩边、承扶、承山、腰阳关、殷门、飞扬、昆仑等穴。每次选穴 2~3 穴，留针 1min，然后拔火罐 10min，按上述方法治疗 1 个疗程，病情明显好转，巩固 1 个疗程后，恢复正常。

三、经络辨证 首尾齐刺

徐以经在临床上根据疼痛部位，取太阳膀胱经或者足少阳胆经首尾穴齐刺治疗坐骨神经痛，均取得了较满意的疗效。

取穴：病人取仰卧位，凡是其痛自臀部沿大腿后侧外缘下行，经足外踝后至足背外侧者，取足太阳膀胱经的首穴睛明，尾穴至阴；凡是其痛自臀部沿大腿外侧，膝关节外缘腓骨前面，经外踝之前至足背者，取足少阳胆经的首穴瞳子髎，尾穴足窍阴。

操作：穴位先行常规消毒，两名医者合作，一名站在患者头部，右手持针，左手食指掐住首穴，另一名站在患者足部，右手持针，左食指掐住尾穴，然后喊一声“刺”，两人同时将针刺入穴位，其深度为 0.5 寸，再轻捻转 6min 候气，但捻转幅度不能超过 180° ，勿行提插捻转，留针 20min，行针两次。出针后针眼行补法，用棉球按压 5min 即可。每天针 1 次，5 天为 1 个疗程，针刺时尾穴加艾条灸 10min 则效果更好。

李某，男，32 岁，煤矿工人，于 1983 年 10 月 6 日来诊。患者自述长期从事井下采煤工作，因受潮湿和寒冷而发病年余。经治疗

后时轻时重，反复发作，近3天明显加重，特来就诊。检查：疼痛由左侧腰部经大腿后侧外缘下行，经足外踝后至足背外缘放散，其疼痛持续，动则加重，直腿抬高试验（+），舌苔白，脉弦紧。诊断：原发性坐骨神经痛（其痛部位属足太阳膀胱经循行部位受病）。取穴：取足太阳膀胱经首穴睛明和尾穴至阴齐刺疗法。经首次施针后其痛减半，活动改善。共针刺两个疗程后，其痛完全消失，功能活动自如，一年后随访无复发。

四、主穴阳陵泉 龙虎交战

坐骨神经痛是指坐骨神经通路及其分布区的疼痛综合征。刘景洋以龙虎交战手法针刺阳陵泉为主治疗坐骨神经痛，取得较为满意的效果。

取穴：主穴为阳陵泉。配穴取大肠俞、关元俞、环跳、委中、承山、昆仑，均取患侧。

操作：令病人俯卧或侧卧（患侧在上）。取28号2寸不锈钢毫针，用75%酒精棉球将穴位常规消毒。阳陵泉按龙虎交战手法施术，即：将针刺入穴位得气后，将针退至0.5寸处，以左转为主，即大拇指向前用力捻转9次；再以右转为主，即大拇指向后用力捻转6次；然后刺入1寸处、1.5寸处各重复上述手法1次。针感不能太强，以病人能忍受为限，要求针感向风市穴或昆仑穴传导为最佳。留针30min。大肠俞、关元俞、环跳、委中、承山、昆仑施以平补平泻手法，均留针30min。每日针刺1次，每周针5次，10次为1个疗程。

龙虎交战手法为“大补、大泻”法，手法较重，刺激量较大，分别在天、人、地三部都施行补泻手法，以达到经气内外相通、上下相接。通则不痛，故其止痛作用较强。阳陵泉为胆经之合穴，为八会穴之筋会穴。《马丹阳天星十二穴歌》曰：“阳陵泉居膝下，外廉一寸中……冷痹及偏风，举足不能起，坐卧似衰翁，针入六分止，神功妙不同。”故针阳陵泉用龙虎交战手法，有舒筋活血，通络止痛之功效。

李某，男，41岁，工人。1996年6月3日初诊。主诉：右侧腿部放射性疼痛1个月，行走时尤甚。查：右腿直腿抬高试验45°，

额胸试验 (+)。大肠俞、关元俞、环跳、阳陵泉、昆仑穴压痛 (+)。X线片示: L₄、L₅ 增生。诊断: 继发性坐骨神经痛。治疗: 针阳陵泉用龙虎交战手法, 施术后即感疼痛减轻, 30min 后出针。查: 右直腿抬高试验 75°。共治疗 5 次, 症状体征消失, 活动自如。1 年后随访, 未见复发。

五、循经取穴 盘针刺

赵俐黎采用盘针配合穴位封闭治疗坐骨神经痛, 获得满意效果。

取穴: 取足太阳、足少阳经的腧穴为主。肾俞、膀胱俞、大肠俞 (双), L₃ ~ L₅ 夹脊穴 (双), 环跳、承扶、委中、承山、阳陵泉、飞扬, 均取患侧穴位。

操作: 患者侧卧位或俯卧位, 将患肢充分暴露, 局部常规消毒, 采用 1.5 ~ 4 寸毫针, 对准穴位, 快速将针刺入皮下, 先盘针 3min。即是用食指按压针柄顶端, 使针体与患者皮肤成 45°角, 然后依病情之虚实, 顺时针或逆时针转动针体, 以快速得气。得气后, 以提插捻转的针法综合使用, 轻插重提, 捻针应幅度小且频率快, 使针感向下肢迅速放射为佳, 然后留针 30min, 间隔 15min 行针 1 次, 每天 1 次, 10 次为 1 个疗程。

封闭: 选用维生素 B₁₂ 针剂 500μg, 加 2% 普鲁卡因 1ml 穴位封闭。以最痛处封闭效果最佳; 或用复方丹参针剂 6ml 穴位封闭, 每穴 2ml。一般每次选用 3 个穴位, 其余穴位轮流使用, 隔日 1 次, 5 天为 1 个疗程。

郑某, 男, 32 岁, 司机, 1995 年 10 月 6 日前来针灸科就诊。患者自诉 2 天前因冒雨修车受凉而出现腰部及侧臀部疼痛, 并波及下肢, 疼痛如刀割样, 经服用中药及按摩治疗, 症状无明显改善。查: 患者跛行, 腰弯向健侧, 夜间疼痛加重, 彻夜难眠。左侧腰部第 4、5 椎体旁明显压痛。坐骨孔处有明显压痛, 并向下肢放射, 腘窝及腓肠肌处亦有明显压痛。麦氏试验 (+), 直腿抬高试验 (+) (低于 40°)。诊断为坐骨神经痛。即予以上法治疗, 经治疗 20 次后, 疼痛消失, 活动自如, 病已痊愈。1 年后随访, 患者工作生活正常, 未曾复发。

六、理据内经 主穴齐刺

胡幼平采用《内经》齐刺法加电针治疗坐骨神经痛，疗效满意。

取穴：主穴：环跳、秩边、承扶、阳陵泉（均取患侧）；配穴：肾俞（双）、气海俞（双），委中、足三里、承山、悬钟（以上均取患侧）。

操作：常规消毒，主穴用齐刺法（直入一，傍入二），先选用28号3寸毫针直刺1针，施捻转手法，令局部得气；再在其上下1寸处各斜刺1针，针尖朝向主穴，用捻转手法使其得气，针感向深层与四周扩散为好；再在傍入2针处接G6805-1型电针仪，选疏密波，电流强度大小以患者能够耐受为度，时间30min。配穴用常规针刺法。每日治疗1次，10次为1个疗程，疗程间休息2~5天。

齐刺法为《内经》十二刺之一。《灵枢·官针》：“齐刺者，直入一，傍入二，以治寒气小深者。或曰三刺，三刺者治痹气小深者也。”由于坐骨神经痛的部位较深，一般针刺法难以见效。齐刺法三针同用，刺激量大、针感强、接触面多，可作用于病变部位较深之痹痛，更适合于治疗该病。齐刺法加电针，可以增强局部的血液循环及淋巴循环，使痉挛的组织得以松弛，代谢致病产物及时排出，有利于组织的正常修复，疼痛缓解、消除。

王某，男，47岁，建筑工人，1998年1月12日初诊。主诉：左下肢疼痛1年，加重5天。患者1年前因劳累过度，并居住于潮湿阴冷工棚，出现左下肢放射性疼痛，咳嗽、伸腿时疼痛加重。曾服用中药、西药及推拿治疗，症状减轻。5天前因工作中感受寒湿，左下肢疼痛加剧，白天不能活动，夜间无法入眠，疼痛难忍。查体：左下肢疼痛自臀部沿下肢外侧向小腿放射；腰部无明显压痛；环跳、承扶、委中、阳陵泉穴多处压痛；直腿抬高试验30°，左膝反射、跟腱反射减弱。舌淡苔薄白，脉濡。西医诊断：坐骨神经痛；中医诊断：痹证。取患侧环跳、秩边、承扶、阳陵泉齐刺，捻转得气，留针30min；配穴肾俞（双）、气海俞（双）、委中（左）、足三里（左）、承山（左）、悬钟（左），常规针刺法。得气后接G6805-1型电针仪，选疏密波治疗30min。治疗3次后，疼痛大减，可行走；治疗10次后，疼痛完全消失，生活自理，直腿抬高试验达70°，临

床治愈。1年后随访未见复发。

七、委阳 - 飞扬 - 跗阳 顺序针刺

罗平采用三阳开泰法针灸治疗坐骨神经痛，疗效迅速显著。

主穴：取委阳、飞扬、跗阳。配穴：取腰背部阿是穴（即压痛点）、 $L_4 \sim S_1$ 夹脊穴。痛向外踝放射，病在太阳经者，配秩边或承山；痛向外踝前放射，病在少阳经者，配环跳或风市；痛向足背或胫前内侧放射，病在阳明经者，配髌关或丰隆，均取患侧。

操作：病人取俯卧位或侧卧（患肢在上）位。根据其胖瘦分别采用适当长度的毫针，首先刺委阳穴1~1.5寸，轻捻重插导气，使针感向下放射至脚；然后针飞扬穴，直刺1~1.5寸，用提插泻法，使针感放射至脚后留针；再针刺跗阳穴，进针1~1.5寸，以提插泻法，使针感放射至脚。然后根据情况针刺配穴，均按常规方法取穴，行平补平泻法。留针30min，每隔10min行针1次。每天针刺1次，10次为1个疗程，休息3天，再针下1个疗程。

坐骨神经痛多因风寒湿邪痹阻经脉，或跌仆闪挫致气血瘀滞，经络受损，而造成气血运行不畅所致。其疼痛多见于足太阳、足少阳两经分布区。委阳、飞扬、跗阳均处于坐骨神经主干区，应用三阳开泰法治疗，以疏导经气为主，疏通太阳、少阳经脉，驱邪外出，通经活络。

杨某，男，39岁，农民，2003年4月18日初诊。左侧腰腿部放射性疼痛至下肢及脚趾外侧20余天，行走、咳嗽时疼痛加剧，有时天阴或夜间睡觉疼痛更甚。查：左侧直腿抬高试验45°，呈强阳性，小腿肌力轻度减退，在腰骶部肾俞到膀胱俞之间有压痛。诊断：原发性坐骨神经痛（急性期）。按上述方法施以针刺治疗。术毕复查：左侧直腿抬高试验可达90°，无局部或放射痛，压痛点消失。为了巩固疗效，复针5次，共治疗6次痊愈。1年后随访，未复发。

八、次髂 - 环跳 温针灸

坐骨神经痛是临床常见病之一，病情严重者可影响工作、学习和生活，张连生采用温针治疗坐骨神经痛。

取穴：次髂、环跳。

操作：次髎穴用 28 号，3 寸毫针直刺 2.5 寸，使针深入骶孔，以有麻电感向下肢放散为宜。环跳穴用 28 号，4 寸毫针直刺，以有麻电感向下肢放散为宜。针刺后将艾条剪长度约 25mm 许，套在针柄上点燃（针刺前先用硬纸剪成 8cm 圆纸片 2 个备用，待针刺后将其套在针体上紧贴皮肤，以防艾火烫伤皮肤）。留针 20min，每天 1 次，10 次为 1 个疗程，疗程间休息 3 天。

坐骨神经痛属中医痹证范畴，是由于风寒湿邪侵入人体，闭阻经络，气血运行不畅，不通则痛。辨证多在足太阳膀胱经和足少阳胆经，治疗上取膀胱经穴位次髎、胆经穴位环跳乃“经络所过，主治所及”之理。中医学认为，寒则拘急，热则弛缓，因而，张连生采用针刺以疏通经络气血壅滞，灸疗来温通经络散寒。

李某，男，74 岁，干部。3 天前因洗澡汗出当风，感受寒凉，突然出现左下肢剧痛，于 1986 年 3 月 1 日上午 10 时急症入院。被动体位，不得平卧，腰部及左下肢痛， $L_4 \sim L_5$ 左旁压痛（++），左侧坐骨神经通路明显压痛，左膝腱反射减弱，左跟腱反射消失，左直腿抬高试验（+），X 线检查示正常腰椎。诊断为原发性坐骨神经痛。温针治疗 2 次后，疼痛明显减轻，已能平卧。治疗 5 次后，能下床行走，左下肢稍感不适。治疗 10 次后，疼痛消失活动自如，痊愈出院。随访 2 年，一直未复发。

九、行气针 重手法

坐骨神经痛是临床常见病、多发病，属中医痹证范畴，多因风寒湿邪客于经脉，气血阻滞不通所致。宫军采用行气针法治疗本病，疗效显著。

取穴：大肠俞、环跳、承伏、委中、承山、昆仑。以上各穴除大肠俞取双侧外，其余均取患侧。

操作：各穴用直刺法进针，不做捻转，仅做提插手法，得气后术者以意领气达于刺手，然后由天部徐徐插至地部，再由地部疾提至天部，反复操作 5~7 次，然后刺手紧捏针柄，行气达病所，行气 3~5min，患者将感觉到沿针刺穴位所属经络呈带状流水样传导至病所，留针 30min。施术时必须全神贯注于针尖，心无杂念，用力均匀，针刺方向应垂直于皮肤。1 次/天，10 次为 1 个疗程，疗程间隔

5~7天。

王某，女，36岁，工人，于1989年11月5日就诊。左下肢疼痛12天，12天前因劳累后，汗出当风，渐觉左下肢疼痛，曾服用“布洛芬”、“木瓜丸”等中西药物及TDP照射治疗，效果欠佳。其痛有定处，遇寒则剧，得热则舒，舌淡苔白，脉沉弦。查：左下肢直腿抬高15°，布拉加尔征（+），分髋试验（-），腰椎部无压痛，但沿坐骨神经分布区有压痛，梨状肌紧张试验阴性。诊断：中医之寒湿痹，西医之原发性坐骨神经痛。予行气针法治疗5次，症状体征消失，恢复工作，随访至今未见复发。

十、攒竹-风池 疏导经气

王彩云试用针刺攒竹、风池治疗坐骨神经痛，效果较佳。

取穴：攒竹、风池，均取双侧。

操作：病人取坐位，局部皮肤常规消毒后，选以28号0.5~1.5寸不锈钢毫针，先用提捏进针法，迅速直刺攒竹穴2~3分深，行小幅度轻而快捻转手法，使局部产生胀麻感觉，术毕，令其蹙眉而针眼无痛感为宜，然后取刺风池穴，针尖向对侧眼眶之内下角徐徐进入1.0寸许，只行捻转，不做提插，务使局部酸胀并向肩部感传，留针30min，每天针1次，10次为1个疗程，疗程之间可休息2~3天。

攒竹、风池属于足太阳膀胱经和足少阳胆经穴。太阳、少阳二经自腰臀往下傍依坐骨神经通路而循行。故据“经脉所过，主治所及”之原理，王彩云试用针刺攒竹、风池穴方法以疏导经气，达到终止和缓解坐骨神经痛的预期目的。

赵某，男，42岁，工人，2000年5月18日初诊。右侧腰、臀部及下肢疼痛五个月左右，症状明显加重1周，自述因受凉而得病，复感寒凉而增剧，从下腰部沿坐骨神经走向，顺着股后，小腿后外及足背外侧呈抽掣样疼痛，每遇咳嗽，呵欠、排便时锐痛难当。查体：偏身而坐，跛足而行。右腿肌肉轻度萎缩，肌力右<左。右侧L₄、L₅棘突旁，小腿外侧及外踝后方有明显压痛，直腿抬高试验、屈髋抬腿试验均（+）。X线示：骨质未见异常。诊断为原发性坐骨神经痛。经用本法治疗9次，即告痊愈。随访至今未见复发。

十一、环跳为主 随症加减

向诗余采用环跳穴齐刺法为主配合电针治疗坐骨神经痛，疗效满意。

取穴：主穴：环跳；配穴：1组：肾俞、大肠俞、阳陵泉、绝骨；2组：肾俞、大肠俞、阳陵泉、承山、昆仑。均取患侧。少阳型：主穴加1组配穴；太阳型：主穴加2组配穴；混合型：主穴加1、2两组配穴。

操作：主穴环跳穴采用齐刺法。双侧疼痛者取俯卧位，单侧疼痛者取侧卧位，患侧下肢屈膝，健侧下肢伸直，用3~5寸毫针，垂直进针，进针2~3.5寸时，患者突然感到有触电感向下肢放射即可，然后在主穴上、下方各一寸各刺一针，使针感向下传导，配穴常规针刺，根据病情采用补泻手法，然后用G6805治疗仪，一极接环跳穴，另一极可任意接上方或下方齐刺穴，用连续波，电流强度以患者能忍受而无不适为度，此时可见电流小而针感强，下肢抽动幅度大。每天1次，10天为1个疗程。

齐刺源于《灵枢·官针》：“齐刺者，直入一，傍入二，以治寒气小深者。或曰三刺，三刺者，治痹气小深者也。”是言齐刺善驱散聚于小范围内的、位置较深的寒气而解痹痛，说明齐刺法有良好的散寒止痛的作用。环跳穴为足少阳太阳两经之交会穴（《素问·气穴论》王冰注），且常为坐骨神经痛的首发痛点，又为坐骨神经穿出梨状肌循行的体表对应点，故取环跳穴齐刺法针刺治疗坐骨神经痛能收到良好的疗效。

肖某，男，45岁，1999年6月就诊。主诉：复发腰痛伴右下肢疼痛1周。有腰痛史，因劳累复发腰痛伴右下肢后侧疼痛，动则痛甚。不能站立及行走，翻身困难，咳嗽、喷嚏时疼痛加剧。检查：腰椎侧弯，后突畸形，腰肌紧张，L₄~L₅椎旁叩击痛，L₄右侧压痛明显，并向下肢放射，直腿抬高试验右腿30°，左腿70°，右侧沿坐骨神经干压痛。CT示：“L₄、L₅椎间盘突出，右侧硬膜囊神经根受压。”诊断：坐骨神经痛（腰椎间盘突出症），按经分型为混合型。取主穴齐刺法配合电针及选用两组配穴治疗，每天1次，连续治疗17次，治愈。随访至今未发。

十二、辨经取穴 温和灸配针刺

坐骨神经痛属于中医学“痹证”、“腰腿痛”范畴。周怡采用温和灸配合针刺治疗本病，取得了满意的疗效。

取穴：主穴：大肠俞、关元俞、腰3~5夹脊穴、环跳、委中、阳陵泉。配穴：足太阳型配殷门、昆仑；足少阳型配绝谷、丘墟。

操作：患者采取俯卧位或侧卧位。大肠俞、关元俞向棘突的方向斜刺2寸，华佗夹脊穴直刺5分，环跳直刺2~3寸，阳陵泉直刺1寸，委中穴浅刺。行提插泻法得气，其中环跳、委中、阳陵泉三穴的针感须放散至患肢足部。若年老体弱、久病不愈、正气不足者，手法不宜过重，应施以提插平补平泻法，其他配穴得气即可。留针20min，其间行针1次以保持适量针感。起针后在大肠俞、关元俞行温和灸10min。温和灸配合针刺治疗10天为1个疗程，1个疗程完毕后休息2天，再进行下1个疗程。

中医学认为，本病是由于机体素虚，正气不足，腠理不固，风寒湿邪乘虚而入，客于经脉，气血运行不畅而致。周怡选用背腧穴大肠俞、关元俞以及华佗夹脊穴，从现代解剖学角度看，坐骨神经由L₄~S₃神经前支组成，深刺大肠俞、关元俞，可刺激L₄及S₅神经，而华佗夹脊穴恰位于神经发出处。大肠俞、关元俞为足太阳膀胱经的循经腧穴，针刺二穴可治疗足太阳经脉、经筋之疾。此外，在治疗本病时还可选用主穴环跳、委中、阳陵泉。其中环跳为足少阳胆经与足太阳膀胱经之会穴，阳陵泉为八会穴之一，委中为足太阳膀胱经的特定穴合穴，此三穴可有效地行气血、利关节。诸穴相配，共奏疏通经络、调畅气血之功，达到通则不痛的目的。周怡认为，在大肠俞和关元俞针刺完毕取针后加用温和灸，可进一步调整脏腑，扶助正气，振奋元阳，使风寒湿之邪无所依附，起到调治根本的作用。

李某，男，42岁，工人。1999年3月21日初诊。患慢性腰痛3年，每逢寒冷天气加重。1周前，因负重、受寒后复发，右侧臀部、大腿后侧痛，小腿前外侧持续性剧烈疼痛，夜晚尤甚，呈阵发性刀割样痛，并由臀部向外侧足尖放射。查：患者痛苦面容，步履艰难，屈腿翻身受限，右直腿抬高20°。臀部正中、大腿后侧、腓肠肌处压

痛明显，局部无红肿。腰椎 X 线摄片未见异常。舌质淡、苔薄白，脉沉弦。诊断为原发性坐骨神经痛，证属痛痹。治以散寒除痹，通经活络。取穴：大肠俞、关元俞、 $L_3 \sim L_5$ 夹脊穴、环跳、委中、阳陵泉、殷门、丘墟。按上法针刺后施灸。1 个疗程后，疼痛明显好转，压痛减轻，右直腿抬高 60° 。2 个疗程后，疼痛及压痛点消失，直腿抬高 90° ，病获痊愈。续治 3 次以巩固疗效。1 年后随访，未见复发。

十三、头穴缪刺 疼痛自除

范郁山在临床上运用头穴缪刺治疗坐骨神经痛，取得理想疗效。

取穴：百会、通天（左侧痛取右通天，右侧痛取左通天）。

操作：将百会穴按常规消毒后，以 1.5 寸毫针平刺，并透通天穴，行平补平泻法，留针 30min，每隔 10min 行针 1 次，每天 1 次，7 次为 1 个疗程。

本病的病因病机，多缘于人体阳气不足，感受寒邪，使气血运行不畅，经脉痹阻，不通则痛。头为诸阳之会。百会是督脉与三阳经气的交会穴，又称“三阳五会”，是治疗本病的重要穴位。针刺百会可补督脉阳气，有升提收摄之功，提壶揭盖之意，能鼓动气血上荣髓海，改善脑部血液循环；透通天穴，使阳气直达足太阳经脉，通调气血，太阳主一身之藩篱，寒邪被驱除，疼痛自除。

患者，女，54 岁。左侧腰髋部疼痛 3 个月，疼痛呈放射状，沿臀、大腿、小腿外侧放射，遇寒冷、劳累、休息不好加重。服中西药逾月无效，而改推拿、理疗，仍未能好转，现要求针灸治疗。查体见病人一般情况尚可，脊柱无病理改变， $L_4 \sim L_5$ 有压痛，并向下肢放射，左大肠俞、关元俞、环跳、合阳、承山、昆仑等处压痛明显；直腿抬高试验（+），腰椎正侧位片无异常，舌苔白，脉弦。拟诊为原发性坐骨神经痛，风寒侵袭太阳、少阳经脉。用头穴缪刺，取百会透右侧通天穴，行平补平泻法，留针 30min，每 10min 行针 1 次。次日来诊时述疼痛已去五、六成，连续针刺 1 星期，症状消失。随访 3 个月，未见复发。

十四、阿是穴为主 齐刺输刺

坐骨神经痛是由多种因素引起的一组综合征，郭元琦采用齐刺与输刺结合方法治疗该病，收到满意疗效。

取穴：主穴：阿是穴（病变腰椎棘突患侧旁开 0.5 寸）；配穴：足少阳胆经型加环跳、阳陵泉，足太阳膀胱经型加秩边、委中。

操作：阿是穴常规皮肤消毒，以消毒 28 号 3 寸毫针直刺，深达椎弓板骨膜后退针少许，施以提插捻转，令局部产生强烈酸重感，再在其上下 1 寸各加刺 1 针斜向病所，分别捻搓针柄，以增强针感，使针感向深层与四周扩散，留针 30min，其间行针 2~3 次配穴常规针刺得气后接上海 G6805-1 型电针机，选用连续波，频率为 100 次/min，留针 30min。

《内经》谓：“输刺者，直入直出，深内之至骨，以取骨痹”。方法为深刺至骨而久留针。而齐刺则是在患处中央 1 针，两旁 2 针，直刺或斜刺，3 针齐下，是治疗寒痹之小且深者。故范围局限而病位较深的骨质组织压迫刺激神经根引起的根性坐骨神经痛选用督脉旁阿是穴，运用齐刺和输刺结合治疗，加强了局部刺激，针刺直达病所，更有效地激发经气，振奋阳气，温通经络，祛瘀消肿。

张某，男，42 岁，司机，1993 年 2 月 3 日初诊。主诉：腰部及左下肢疼痛半年，加重 1 周。患者半年前因劳累过度，兼受风寒，出现腰骶部及左下肢放射性疼痛，咳嗽、伸腿时疼痛加重。曾用中西药、针灸治疗，症状减轻。1 周前打喷嚏时用力过猛，即感腰痛加剧，并向左下肢后面放射，且腰部不能活动，坐卧不安，行走痛剧。查体：腰活动明显受限，左下肢屈伸不利， $L_4 \sim L_5$ 椎旁压痛及叩击痛明显，臀、腘、踝点压痛轻微，屈颈试验（+），直腿抬高试验 30° ，左肢膝反射、跟触反射减弱，舌淡、苔白，脉沉细。CT 示 $L_4 \sim L_5$ 椎间盘脱出。西医诊断： $L_4 \sim L_5$ 椎间盘脱出，坐骨神经痛；中医诊断：痹证。依上法取 L_4 棘突左侧旁开 0.5 寸为阿是穴，并在 L_3 棘突及 L_5 棘突左侧旁开 0.5 寸各取 1 穴，3 针齐下，直刺至骨，退针少许，施以提插捻转，令针感向患部深处及四周扩散留针 30min，其间行针 2~3 次。配以秩边、委中电针 30min，治疗 1 周后，疼痛大减，可行走，生活完全自理，直腿抬高试验达 70° 。为巩

固疗效，再治疗1个疗程，腰腿活动如常人，痊愈出院。1年后随访无复发。

十五、长针一支 独刺环跳

徐渊采用单穴针刺治疗坐骨神经痛患者，取得了满意的效果。

取穴：患侧环跳穴。

操作：医者两手及患者穴位用酒精棉球消毒后，取3寸不锈钢毫针，采用右手拇、食、中3指握住针柄，左手拇、食2指握住针身，左手无名指固定穴位，作轻度爪切，进针时两手同时操作，右手稍作捻转向下输送，左手拇、食2指迅速将针尖刺入皮内，然后提插，使患者能感到沿足少阳胆径循股后外侧、腓、足跟、足底到5趾出现酸麻等放射样的感觉。行泻法，每隔5min行针1次，留针30min。每天1次，10次为1个疗程。

《灵枢·周痹》说“风寒湿气，客于外分肉之间”，其痛“随脉以上，随脉以下，不能左右”，坐骨神经痛多因感受风寒湿热之邪、气血虚弱、跌打损伤、负重等所引起。《针灸甲乙经》曰：“胫痛不可屈伸，痹不仁，环跳主之。”明·高武《针灸节要》说：“邪客于足少阳之络，令人留于枢中，痛痹不可以举，刺枢中以毫针，寒则久留针，以月死生为数，立已。”可见独取环跳，有通经活络止痛之功，对坐骨神经痛有较好的疗效。

梅某某，女，34岁，售货员，1995年4月9日初诊。主诉：腰部酸胀疼痛，牵引右侧下肢肌肉剧烈疼痛，痛苦刀割针刺，夜间加剧，起病半年余，活动受限，劳累及受寒冷刺激后疼痛加重。经针灸、理疗、按摩及服用中药治疗无效。查体：腰部侧弯畸形，屈、伸、侧弯、旋转均受限，直腿抬高试验阳性，腰椎旁有明显压痛；沿坐骨神经有压痛。腰椎X线正侧片提示：腰椎生理曲线度改变。用上法治疗1个疗程后疼痛消失，沿坐骨神经亦无压痛感，1年后随访未复发。

十六、针药并用 疏通经络

朱利运用针刺疗法结合中药治疗坐骨神经痛，取得了满意疗效。

针刺：以循经取穴为主，以经络辨证取穴为辅。足太阳型（腰

背部以及下肢后疼痛)取穴大肠俞、环跳、昆仑、腰3~5夹脊、委中、承山、阳陵泉、承扶;足少阳型(下肢外侧痛)取穴环跳、阳陵泉、秩边、绝骨、次髎;混合型(以上两型症状并有者)取穴大肠俞、环跳、阳陵泉、昆仑、次髎、殷门、委中。以上穴位环跳、殷门、阳陵泉、昆仑、大肠俞为主穴,以L₃~L₅夹脊、秩边、承扶、委中、绝骨、承山、次髎为配穴。每次取主穴和配穴各3~5个。用提插或捻转补泻手法,留针30min,每隔10min行针1次,每天针刺1次。如急性期疼痛剧烈者,每天可针刺2~3次,10天为1个疗程。

中药:独活寄生汤加减,独活、寄生、云苓、桂枝、川芎、当归、赤芍各10g,熟地15g,党参、甘草、秦艽、防风各10g,细辛3g,牛膝、杜仲各10g。若拘急痛甚者加元胡10g,蜈蚣1条;阴雨天痛加木瓜20g,苍术10g;瘀血久病者加土虫10g,鸡血藤20g。加水600ml,煎取200ml,二煎加水300ml,煎取200ml,两次药液混合,早晚各服200ml。每日1剂,10剂为1个疗程。

坐骨神经痛是临床常见的疼痛综合征,多由外伤、寒湿之邪侵袭,筋脉经络闭阻,气血运行不畅而致,“不通则痛”,按经络辨证多在足太阳膀胱经和足少阳胆经,因此治疗上以循经取穴为主,并确立环跳、阳陵泉等几个主要穴位。环跳是足少阳与足太阳之会穴,筋会阳陵泉是八会穴之一,两穴易得气,治疗坐骨神经痛有较好的止痛效果,配合其他腧穴则可加强疏通经络的功效。

独活寄生汤具有益气养血,祛风散寒胜湿,疏通经络的作用,是治疗慢性腰腿痛的常用方剂,中药结合针刺治疗坐骨神经痛能起到协同作用,明显提高疗效。

参 考 文 献

- [1] 管辉. 刺环跳并诱导循经感传治疗坐骨神经痛94例临床报告. 宁夏医学院学报, 2001, 23(6): 460~461
- [2] 李萍, 王黎明. 火针治疗坐骨神经痛73例疗效观察. 青海医药杂志, 1997, (10): 46

- [3] 徐以经. 经脉“首尾齐刺”法治疗坐骨神经痛. 针灸临床杂志, 1995, 11 (2): 29
- [4] 刘景洋. 龙虎交战手法治疗坐骨神经痛的疗效观察. 中国针灸, 2000, (2): 91~92
- [5] 赵俐黎. 盘针配合穴位封闭治疗坐骨神经痛 78 例. 河南中医, 1999, 19 (5): 62
- [6] 胡幼平, 金荣疆, 冯媛. 齐刺法加电针治疗坐骨神经痛的临床观察. 四川中医, 2005, 23 (11): 106~107
- [7] 罗平, 张淑忆. 三阳开泰法针刺治疗坐骨神经痛 85 例. 中国民间疗法, 2004, 12 (12): 8~9
- [8] 张连生. 温针治疗坐骨神经痛 518 例. 上海针灸杂志, 1998, 17 (3): 33
- [9] 宫军. 行气针治疗坐骨神经痛 126 例. 天津中医学院学报, 2003, 22 (2): 50
- [10] 王彩云, 马晶华, 肖丽. 针刺攒竹、风池治疗坐骨神经痛 50 例. 针灸临床杂志, 2001, 17 (2): 52
- [11] 向诗余, 瞿涛. 环跳齐刺法为主治疗坐骨神经痛疗效观察. 针灸临床杂志, 2002, 18 (8): 46~47
- [12] 周怡. 温和灸配合针刺治疗坐骨神经痛 40 例. 江苏中医药, 2002, 23 (1): 34~35
- [13] 范郁山, 姚春. 头穴缪刺治疗坐骨补经痛 32 例. 上海针灸杂志, 2003, 22 (6), 39
- [14] 郭元琦, 陈丽仪. 齐刺结合输刺治疗根性坐骨神经痛 160 例. 新中医, 2001, 33 (1): 45~46
- [15] 徐渊. 单穴针刺治坐骨神经痛 30 例. 江西中医药, 1998, 29 (5): 54
- [16] 朱利. 针刺加中药治疗坐骨神经痛的临床观察. 针灸临床杂志, 2005, 21 (3): 25

【膝关节炎】

膝关节炎是中老年常见病，其发病与外伤劳损、骨质增生有关，多因年体弱或局部长时间劳损，而致局部组织出现炎症或渗出。中医学认为：本病多因老年肾亏，或气滞血瘀，复感风寒湿邪，阻滞经络，痹阻气血，不通而痛。

本篇共收录了 13 位针灸医家的临床治验，有的以局部取穴为主，短刺、恢刺并用；有的取膝眼穴透刺；有的采用局部针刺，配拔罐发泡；有的取足三里、鹤顶为主，行拔河针法；有的采用随证取穴，飞针配合水针等，均取得了一定疗效。

一、局部取穴为主 短刺恢刺

老年性膝关节炎临床表现为膝关节疼痛，关节活动受限，突出特点是上下台阶，特别是下台阶时疼痛加剧。膝关节周围压痛明显，偶有关节腔积液，局部肿胀，患者起立或下蹲开始时困难。严书荣采用恢刺、短刺等综合治疗，取得理想疗效。

取穴：委中、阴谷、委阳、阿是穴为主，配合血海、梁丘、阳陵泉、阴陵泉。

操作：采用短刺、恢刺法。患者先俯卧位，取委中、阴谷、委阳、阿是穴，常规消毒，用 28 号 2.5 寸毫针直刺入穴位，得气后轻微提针，

针尖靠近骨膜不断更换针刺方向，提插捻转，待病人酸胀放射感明显，留针 20min，出针后再取仰卧位，同法针刺血海、阳陵泉、阴陵泉。每天 1 次，10 次 1 个疗程。

按摩：采用局部腧穴部位拇指揉法，配合擦法、掌揉法，先针后按摩，每天 1 次，10 次为 1 个疗程。

老年性退行性病变，在全身任何关节均可发生，但以膝关节退行性关节炎多见。通过短刺、恢刺，针刺至骨，上下摩骨，配合按摩刺激硬化肿胀的筋膜使之软化，重新建立有效的血液循环，达到疏通经络，活血消肿止痛的目的。严书荣认为，本病膝关节后侧的肌腱、筋膜的硬化，更为突出，针刺以后侧的委中、委阳、合阳为主，配合前面的腧穴治疗。针刺过程中，要充分采用揣穴之法，更注重对腧穴周围的硬化物给以充分的刺激，采用提插捻转，上下摩骨，使硬化的组织得到软化，经络疏通，气血通畅，达到“通则不痛”的目的。

女，72 岁。2001 年 4 月 21 日初诊。主诉：双膝关节疼痛，活动受限 10 年，曾长期服中药、西药治疗无好转，现在不能上下楼梯，检查见双膝关节肿胀，髌骨周围压痛明显，并可触及肿胀的韧带及条索状硬化。取穴：委中、委阳、阴谷、合阳、梁丘、血海、阳陵泉、阴陵泉。先针刺后面腧穴，采用短刺法、恢刺法，进针后慢慢摇动针身直达骨面，得气后在近骨处上下轻轻提插捻转，不断变化针刺方向，以疏通经气，舒缓筋脉。间断行针并留针 20min，出针后再针刺前侧腧穴，方法同前。针刺 3 次疼痛明显减轻，2 个疗程后痊愈，随访 3 年未复发。

二、透刺膝眼 祛风散寒

王利耀在临床上采用膝眼穴透刺为主治疗膝关节炎，疗效显著。

取穴：患侧内膝眼、外膝眼、阳陵泉、阴陵泉、血海、足三里。

操作：32 号 1~3 寸毫针，患者屈膝端坐位，取穴处常规消毒，用 3 寸毫针从内膝眼或外膝眼刺入，达对侧膝眼而不出皮肤，行针得气后，退进捻转 6 次，不留针，闭针眼。然后针刺阳陵泉、阴陵泉、血海、足三里，行针得气后，留针 30min，当中行针 3~4 次，每天 1 次，10 次为 1 个疗程。

膝关节炎属中医痹证范畴，是临床常见病。治疗上主要祛风散寒，除湿清热，疏通经络。透刺膝眼可以疏通局部经气，促使经气旺盛，经血流通，通则不痛；阳陵泉为筋会之穴，可以调整筋脉功能，阴陵泉为脾经之穴，刺之可以健脾除湿；“血行风自灭”，针刺血海可以养血祛风胜湿；足三里可以益气补血，鼓动气血，驱邪外出，达扶正祛邪之效。该疗法共奏祛风散寒，清热除湿，疏通经络之功。对非积液性膝关节炎疗效颇佳。透刺膝眼时，应注意，进针要在髌腱后侧，髌下滑囊之前进针，不可过深或过浅，过深则易刺伤滑囊，过浅则易刺入髌腱，都会降低疗效。

刘某，女，32岁，干部。初诊日期1994年9月18日。自述右膝关节疼痛4个月，经多次口服药物及外贴药膏，效果均不佳，近日来，右膝关节着凉，疼痛加剧，行走不利，求治。查：右膝关节轻度肿胀，浮髌试验（-），内外侧膝眼处压痛，右膝关节活动伸60°，屈90°，舌苔白，脉弦滑，X光摄片揭示右膝关节未及异常，诊为“右膝关节痹证”（寒湿型）。采用上述疗法，治疗2个疗程后，患者行动自如，疼痛肿胀消失，功能活动恢复正常，随访2年未复发。

三、散寒除湿 温针灸

退行性膝关节炎多见于中老年人，特别是女性体胖者，特点是随着病情的发展症状逐渐加重。艾鹏飞以温针灸配合火罐治疗退行性膝关节炎，取得满意效果。

取穴：犊鼻、膝眼、鹤顶、阴陵泉。配穴：梁丘、血海、足三里。

操作：患者取仰卧位，用物品将患膝稍垫起。取2寸毫针，用指切进针法直刺，施提插捻转手法令其得气，以产生酸麻沉胀感为度，进针后将针留在适当深度。取艾炷（艾条打开挑出渣物搓捏成枣核形状大小适合的艾团）套在针柄上，用拇食中指围捏，使艾炷固定在针柄上。燃烧5~10min后艾炷可自行熄灭，每穴灸1壮。（配穴只针不灸）留针30min，起针后在犊鼻、膝眼、鹤顶三穴拔火罐，留罐15min左右，加TDP照射。每天治疗1次，7次为1个疗程。

膝关节炎在中医学属痹症范畴，由于风寒湿邪痹阻经络，血行

瘀滞，不通则痛，治疗在于散寒除湿、活血通络以消肿止痛、恢复关节的运动功能。《医学入门》载“药之不及，针之不到，必须灸之”。《名医别录》载“艾叶苦，微温，无毒，主灸百病”。艾叶，气味芳香，易燃，具有温经通络，行气活血，散寒除湿的作用。当艾炷燃烧时皮肤灼热感很强，这种热感渗透到皮肉筋骨之中，促进血管扩张，血流加速，从而改善局部血液循环，促进新陈代谢。拔火罐有祛风除湿，温经散寒，活血通络，消肿止痛的作用。膝眼、犊鼻、鹤顶三穴，为局部取穴法，以达通其气血，调其经脉，通络止痛的目的。阴陵泉具有健脾祛湿之效，配血海可加强健脾祛湿之功，配梁丘主治膝关节肿痛，配足三里可治疗下肢不遂痿痹。由于本法治疗目的明确，治疗过程中可直达病所，故效果明显。

四、局部针刺 拔罐发泡

膝关节炎属中医痹证范畴，是临床常见病、多发病。刘一儒近年应用针刺拔罐疗法治疗本病，疗效显著。

取穴：以犊鼻、膝眼为主，委中为辅。屈膝位，用75%酒精棉球常规消毒，根据病人胖瘦选择不同长度的毫针，将针刺入穴位得气后，再根据病人的年龄选用不同的手法，年轻病人选用泻法，中年病人选用平补平泻法，老年病人选用补法。用闪火法将穴位上的毫针扣在火罐内，留针留罐1h以上，达到出水泡为止（根据病人的耐受能力决定留罐时间，留罐的时间越长，水液就出得越多，治疗的效果就越佳）。取下罐和针，用针刺破水泡，让泡内水液流出体外，用较薄的消毒棉花盖在皮损处，并盖上消毒纱布，第一次治疗完毕。第二次治疗时，只揭开纱布，直接在棉花上消毒取穴，与第一次治疗的方法相同。第二次治疗用的火罐要稍大，将穴位上的棉花扣入罐内，可减轻病人的疼痛。以皮损处水液出尽为准，皮损处不用任何药物涂抹，待其自然痊愈，皮损处只要有水液流出就不能停止拔罐，如果病人耐受能力差，可进行交叉拔罐，皮损处只可用75%酒精棉球消毒。每天1次，10次为1个疗程。

刘一儒认为膝关节炎的原因是内伤“七情”导致水液代谢不能正常运行，长时间稽留在双膝关节处而致病。用针刺拔罐发泡疗法将病理产物从局部拔出体外，内病外治，使局部血液、水液恢复正

常的运行,使炎性物质排出体外。其机制为先通过针刺穴位,以疏通经络,祛风除湿,行气活血,消肿止痛;再在针刺的基础上,立即加上拔罐发泡,达到标本同治的目的,是一种特殊的非药物疗法。

王某,女,59岁,工人。初诊日期:1998年4月16日。主诉:双侧膝关节疼痛、肿胀8年半。近年来严重影响行走,生活靠人照顾。经多家医院确诊为双侧膝关节炎合并风湿性关节炎、膝关节滑膜炎。采用中药、西药、针灸治疗收效不佳,经常疼痛、肿胀,症状逐渐加剧,查:双侧膝关节疼痛、肿胀发热,皮色发亮,浮髌试验(+),关节僵硬不能屈伸。X线拍片提示:双侧膝关节骨质增生,关节间隙有增宽现象出现。血沉80mm/h,血化验:白细胞 $12.3 \times 10^9/L$,红细胞、白细胞分类及抗链球菌溶血素“O”、类风湿因子未见异常。舌质绛红,舌苔黄,脉滑数。西医诊断:老年性关节炎,风湿性关节炎合并膝关节滑膜炎。中医诊断:风湿热痹,骨痹。治则清热通络,祛风除湿。采用针刺拔罐发泡疗法治疗,治疗首次,出水量达80ml,双侧膝关节疼痛、肿胀明显减轻,治疗10次共出水205ml,复诊化验,恢复正常,浮髌试验(-),诸症消失。随访5年多未复发。

五、针刺为主 中药外敷

退行性膝关节炎是常见病、多发病。陈育德采用针刺配合中药外敷治疗本病,疗效肯定。

针刺:取足三里、阳陵泉、内外膝眼、血海、委中、阿是穴,得气后留针30min,中间行针2次。

药物外敷:药用熟地20g,当归12g,川芎12g,防风12g,防己12g,寄生15g,威灵仙30g,鸡血藤各30g,乳香12g,没药12g,川草乌各12g,马钱子5g,桂枝9g,细辛5g,牛膝、杜仲、川断各15g。寒甚加附子10g,肿甚加土茯苓12g。将药物粉细装入布袋(布袋大小正好能裹住整个膝关节)浸湿后入蒸锅,每次热敷30min,每天2次,每副药用3天,12天为1个疗程,疗程间休息5天。治疗期间配合功能锻炼。

本病属中医学痹证之“骨痹”,多由年老肾亏,气血瘀阻、经络不通所引起。针刺治疗能活血通络、祛风除湿、通络止痛之功效,

而本方药具有补肾除湿、发散风寒、舒筋止痛之功，二者合用故对本病有较好的疗效。但在临床应用中对膝关节间隙变窄者效果不佳。

田某某，女，62岁，农民。2000年4月17日初诊。主诉：双膝疼痛8年，加重1个月。8年前，自觉双膝僵硬、疼痛，常服中成药及西药，症状时轻时重。1个月前因劳累过度，症状加重，行走困难，甚至影响睡眠。就诊时检查，双膝微肿，有广泛压痛，以右膝为重。X线片示左右膝关节骨质增生，右膝关节间隙明显变窄。每日针刺1次，并配合中药外敷，1个疗程后症状明显减轻，休息5天后再治1个疗程，左膝症状消失，右膝长距离行走时还有疼痛，继续用中药外敷1个疗程，至今未复发。

六、针罐并用 重在手法

增生性膝关节炎是中老年人易患的一种慢性退行性膝关节病。李得顺采用针刺配合拔罐治疗该病，疗效显著。

取穴：阿是穴、血海、梁丘、犊鼻、膝眼、足三里、三阴交。

操作：患者仰卧位，双下肢伸直，常规消毒后，用28号1.5~2.0寸不锈钢毫针进行针刺。阿是穴用扬刺法，足三里用补法，三阴交用强刺激，使针感上行至膝部，余穴平补平泻。起针后立即用火罐拔在阿是穴上，令出血0.5ml左右。每天治疗1次，10次为1个疗程。

增生性膝关节炎在中医学中属痹证范畴，多因中老年人正气渐衰，风寒湿邪乘虚侵袭，留于膝部造成经络阻滞，气血运行不畅而发病。阿是穴用扬刺法能使局部毛细血管扩张，促进血液循环，使炎症吸收，复加拔罐出血，有温中散寒、通经活络、消瘀散结、活血逐痹之功能。足三里、梁丘益气养血，扶正祛邪，通经活络止痛；血海养血祛风，膝眼、犊鼻祛风除湿，宣散局部经气；三阴交健脾养肝强肾。通过以上治疗，共奏疏经通络止痛、祛风散寒湿之功效。

马某，女，57岁，工人，1997年7月20日初诊。主诉：双膝关节疼痛4年，加重半年，走平路时症状较轻，上下坡疼痛尤甚，有时步行偶有突然卡住现象。X线片示：双膝关节边缘骨刺形成，关节间隙狭窄，关节面不整齐，诊断为增生性膝关节炎。用前法治

疗2次,疼痛明显减轻,治疗1个疗程,疼痛完全消失,功能活动恢复,随访1年未复发。

七、足三里-鹤顶 拔河针法

陈翔飞采用拔河针法治疗膝关节炎,取得了较好的疗效。

取穴:均取患侧。主穴:足三里、鹤顶。配穴:梁丘、血海、膝眼、阴陵泉、委中、阳陵泉。主穴每次必用,配穴每次选2~3穴交替运用。

操作:皮肤常规消毒后,先针配穴,得气即可,再针刺足三里,针尖斜上成45°角快速进针,施以平补平泻手法,使针感向上(膝关节)传导,然后针刺鹤顶,针尖斜向上成45°角快速进针,施以平补平泻手法,使针感朝下(膝关节)传导,最后分别用双手在足三里和鹤顶同时行针,使两者针感相接。针感的传导和双手同时操作时的姿势均形似“拔河”,故称之为“拔河针法”。在临床运用中,当针感相接后,双手拇指向前捻转,使针感相聚为补,多用于虚证;双手拇指向后捻转,使针感相离为泻,多用于实证。每次留针20min,每隔5min行针1次,每天1次,10次为1个疗程,每疗程间隔休息1天。

退行性膝关节炎多见于中老年肥胖女性,它可能是由于老年人关节各部分功能退化以及自身体重过重而使膝关节受累、磨损加重,活动时的摩擦和刺激使其产生代偿性骨质增生,形成软骨性骨赘,最终导致关节肿胀畸形、功能活动障碍;再加上老年人素体气虚血瘀,膝关节受累后易使瘀血凝集、阻滞经脉而使气血运行不通,不通则痛,故临床上该病多以关节疼痛为主症。拔河针法是中国传统针术之一,它通过针刺足三里和鹤顶,使经气上行下达,汇于病所以调理气血、疏通经脉,使经脉运行通畅,通则不痛,从而在临床上达到治疗的目的。

王某,女,52岁,教师,左膝关节疼痛反复发作1年,经多方治疗无明显效果,疼痛逐渐加重,步行和下蹲困难。查体:神清体胖,ASO<500U,RF(-),左膝关节肿胀明显,膝内侧腓骨粗隆压痛点明显,关节屈伸活动均受限。X光片示左膝关节间隙狭窄,关节软骨下骨端象牙质状骨质增生,初诊为退行性左膝关节炎。陈

翔飞遂用拔河针法为之治疗，2个疗程后关节肿胀消退、活动自如，随访两年无复发。

八、针刺调之 中药电疗通之

侯文凤运用电针配合中药电疗治疗增生性膝关节炎，疗效比较满意。

电针：主穴：取内、外膝眼；配膝阳关、梁丘、阴陵泉、阳陵泉、足三里等穴。患者取坐位或仰卧位，每次选2~4穴，常规消毒皮肤，进针得气后针柄与G6805治疗仪导线连接。用疏密波通电20~30min，强度以其能耐受为限。

中药电疗：中药组成：川乌、草乌、威灵仙各30g，乳香、没药、红花、川芎、赤芍、元胡、白芷、公英、天南星、伸筋草、透骨草各15g，羌活10g。上药共研细末，加水2000ml浸泡3h以上，文火煎2遍，将2次药液滤出后混合并浓缩至1000ml，加碳酸氢钠配好酸碱度备用。治疗时采用（北京海淀电器五金厂制造的：骨质增生治疗机）。取药液适量放入容器中加热，放入2个药垫（2层绒布或4~6层纱布制成）使其充分浸润后用手轻拧以药液不下滴为好，将药垫放在病变膝关节上，放好电极板，用塑料纸盖好压上砂袋，检查无误后接通电源，缓慢调节电流流量，以患者感到舒适为度。时间20~30min。

侯文凤在临床上观察发现：电针配合中药电疗治疗该病较单一采用一法为佳，且疗程较短。其机制在于电针能使患部肌肉有节律的收缩，从而激发经气，增强了人体的调整作用。电疗的电效应和热效应能使患部毛细血管扩张，加速血液循环，松解局部组织的紧张状态，缓解了增生骨刺对局部组织的刺激，从而减轻了疼痛和肌肉痉挛。中药通过电疗将其有效成分离解为中药离子，提高了皮肤对药物的通透性，有效的增加了病变部位的药物离子浓度，从而使其直接对病变组织发挥其药理作用。中医学认为痹证主要是由于经络阻滞，气血不通或痰浊瘀阻，筋脉失养所致，故中药选用川乌、草乌行气散寒止痛；乳没、红花、川芎、赤芍、元胡行气活血止痛；羌活、白芷、威灵仙祛风燥湿消肿止痛；公英、南星清热解毒利湿；伸筋草、透骨草祛风通络、强筋健骨。诸药合用通过电疗从气、血、

湿，各方面围攻痹证，自然痹证得除，疼痛得消，筋脉得舒。

徐某，女，60岁，退休工人。1995年9月3日被背来就诊。自诉左膝关节疼痛反复发作10余年，近2月来疼痛持续性加剧关节僵硬，屈伸不利，活动受限。经查左膝关节肿胀粗大，积液明显，内膝眼与腘窝处压痛（+），舌质淡、苔白腻，脉沉细弦。X线拍片诊断为本病。中医诊断为骨痹（肾阳虚型），西医诊断为左膝增生性关节炎。用电针加中药电疗治疗1个疗程后，关节积液消退，肿胀消除，疼痛明显减轻，能自行2里路不觉困难。后又觉腘窝处疼痛，针刺改用委中、承山，电针改用连续波治疗30min，中药电疗如前。经10次治疗后关节疼痛完全消失，屈伸自如，行走如常，随访半年无复发。

九、针推并用 温经通络

王远长采用推拿配合温针灸治疗骨性膝关节炎，取得了确切疗效。

推拿：①患者仰卧位，医生用双手拿法在膝关节处由下至上推拿20遍，手法轻柔，可以舒筋活络；并配合点按内、外侧膝眼、血海、阴陵泉、阳陵泉等穴位，起到止痛作用；然后用双手掌擦膝关节，以患者感到发热舒适为度；最后做屈伸膝关节活动，一般10次左右，起到松解粘连，滑利关节的作用。②患者俯卧位，医生滚法施于腘窝及大腿后侧肌肉、使之放松；并点按委中、承山等穴位；最后使患肢屈曲尽可能使足跟臀部，约10次左右。以上治疗每天1次，15次1个疗程。

温针灸：患者取仰卧位，于膝下窝处垫一枕头，使膝关节屈曲。用2.5寸毫针针刺内外膝眼穴，同时配合针刺血海、阳陵泉，并在内外膝眼穴针柄上揉捏上艾绒少许，点燃，以求温经通络止痛，要求针在髌韧带与髌内侧支持带之间经膝关节囊入翼状皱襞，进入关节腔。该法对有关节腔积液的患者更为有效。每天1次，15次1个疗程。

中医学称骨性膝关节炎为痹证，认为年龄增大，脏腑发生病变，肝肾亏虚，气机失调而不能濡养筋、骨，使关节抗邪能力减弱，风、寒、湿邪侵入肌肤、关节而致病变。

推拿治疗可以疏通经脉，使气血通畅，激发经气，使之通达，通则不痛，则关节得到营养，肌肉筋恢复弹性，使关节间隙增大，骨质增生得到缓解，关节肿胀及疼痛自然消失，功能活动得到恢复。

温针灸是通过艾绒的温热效应借助针灸针传入关节腔内，起到温经通络，活血化瘀之效，增强了关节抗病能力和祛除病邪的能力。

邹某某，男，53岁，工人，于2003年10月13日就诊。主诉右膝关节疼痛1年。无外伤史，初期轻度疼痛，不影响行走，近半月来走路时疼痛明显加重，膝关节肿胀，以上下楼时症状明显，天气转凉及夜间加重。查体右膝关节活动受限，X线示关节边缘尖锐增生，间隙狭窄，诊断为增生性关节炎。经上述治疗7天后症状明显减轻，肿胀消失，一个疗程后症状基本消失，功能恢复正常，一年后随访，疗效满意。

十、膝三针 标本兼治

增生性关节炎是中老年人常见的一种膝关节病，奚向东采用针刺阳陵泉、阴陵泉、梁丘（简称膝三针）治疗本病，疗效显著。

取穴：阳陵泉、阴陵泉、梁丘。

操作：患者仰卧，患侧下肢半屈曲位（腘窝下用软物支持，以使下肢肌肉放松）。常规消毒穴位，取30号2寸不锈钢毫针，阳陵泉直刺1.2寸，阴陵泉直对阳陵泉刺1.5寸，梁丘直刺1.2寸。手法为平补平泻，得气后留针30min。留针期3穴均于针尾插艾条段温灸。隔日1次，10次为1个疗程，休息3~5天进行下1个疗程。

增生性关节炎属中医学“痹证”之范畴，乃由血气虚，复感受风寒湿邪而成此病。《济生方·诸痹门》说“皆因体虚，腠理空疏，受风寒湿气而成痹也。”本病多由于中年以后肝肾渐亏，气血不足，风寒湿邪乘虚侵袭，留于膝部，阻滞气血所致。治疗当祛风散寒，除湿通络，补气益血为大法。脾胃为后天之本，气血生化之源，脾胃健则寒湿除。取足太阴脾经之合穴阴陵泉，健脾除湿，散寒镇痛。足阳明胃经为多气多血之经，其郄穴梁丘为本经气血聚集之处，取之补气养血，活络通经，祛风化湿。膝关节为诸经会集之处，取八脉交会穴之筋会阳陵泉祛风散寒除湿，舒筋通络。三穴合用，共达标本兼治之功。复加温灸更助散寒除湿，温经通络。另外，此三

穴均在膝关节之周围，有局部近治之效。

王××，女，56岁，工人，1994年6月16日就诊。主诉：右膝关节疼痛3月余。阴雨天及上下楼梯时疼痛尤甚，无明显外伤史。查：右膝关节外观无肿胀、畸形，浮髌试验（-），研磨试验（+），膝关节过伸试验（+），X线膝关节正侧位片示：右膝关节间骨质增生。抗链球菌溶血素“O”、血沉及类风湿因子均正常。诊断：增生性膝关节炎。取右侧阳陵泉、阴陵泉、梁丘，操作同上。当晚疼痛明显缓解，经5次治疗后疼痛基本消失，活动自如，仅上下楼梯及长时间站直、行走时稍感酸痛。共治疗8次痊愈，随访半年未复发。

十一、飞针配水针 随症取穴

段祥余采用飞针为主，配合水针治疗风湿性关节炎，疗效满意。

（一）飞针

取穴：风湿性肩关节炎取肩髃、肩贞、肩前、阿是穴、曲池、外关、合谷；风湿性肘关节炎取曲池、阿是穴、天井、外关；风湿性腕关节炎取阳池、外关、阳溪、合谷；风湿性髋关节炎取环跳、阿是穴、髀关、阴廉；风湿性膝关节炎取犊鼻、阿是穴、内膝眼、鹤顶、足三里；风湿性踝关节炎取丘墟、昆仑、照海、商丘。

操作：穴位皮肤常规消毒后医者左手食指指甲掐切在穴位旁，右手拇、食两指紧捏26号粗毫针针根部，将针飞速刺入其穴应至的深度，如飞燕点水，一气呵成，此时患者感觉基本无痛苦。留针30min，每隔5min捻转行针1次，出针时采用缓慢退出的方法。每天1次，10次为1个疗程，每疗程间隔2天。

（二）水针

取穴：风湿性肩关节炎取肩髃、肩贞；风湿性肘关节炎取曲池、阿是穴；风湿性腕关节炎取外关、阳池；风湿性髋关节炎取环跳、阿是穴；风湿性膝关节炎取犊鼻、阿是穴；风湿性踝关节炎取昆仑、丘墟穴。

操作：穴位处皮肤常规消毒，用6号注射针头刺入穴位得气后待回抽无回血时注入醋酸泼尼松注射液15mg，每次共注射药物30mg。3天1次，3次为1个疗程，每疗程间间隔3天。

飞针针刺强调进针要快,1次就进到应刺的深度,出针时引气往外,慢慢地分层而退,使病邪随针引伸由深出浅,由里达表,从而起到祛除病邪的作用,这正好符合《灵枢·九针十二原》“徐而疾则实,疾而徐则虚”的原则。

风湿性关节炎属中医“痹证”范畴,多因风、寒、湿、热等外邪侵袭人体,闭阻经络,气血运行不畅所致,关节多以酸痛、麻木、重着、屈伸不利及红肿为主要表现。中医认为,风湿性关节炎多属实证,“实者泻之”。飞针针刺有泻的作用,能祛邪通络,故临床上选取局部穴位及循经远取穴位,进行飞针针刺,能够泻除其邪气,疏通经络气血。同时配合少量醋酸泼尼松注射液进行穴位注射,既可发挥水针的针刺作用,又能发挥水针药物的消炎作用。

唐某,男,58岁。2000年6月16日初诊。主诉:双膝关节红、肿、痛、热及运动功能受限2月。自诉2月前因外感寒湿后诱发双膝关节出现红、肿、痛、热等症状,运动功能障碍,曾在某医院应用氨苄青霉素注射剂、阿斯匹林片剂及中药“宣痹汤”等治疗,未见明显好转,于2000年6月16日来针灸科求诊。诊见:双膝关节疼痛,轻度红肿及有热感,运动功能受限,舌质淡红,舌苔薄黄,脉弦。既往有“慢性咽峡炎”史20年。体查:双膝关节轻度肿胀,皮肤稍红,皮温稍高,屈伸功能受限,双膝眼穴有压痛。X线摄片示双膝关节周围软组织轻度肿胀,关节面及骨质未见异常改变。诊断为风湿性关节炎,治宜祛邪通络。以飞针针刺为主治疗1个疗程后痊愈,随访2年未见复发。

十二、温针灸配水针 活血化瘀

徐一新在临床上采用温针灸及水针综合疗法治疗膝关节慢性滑膜炎,疗效显著。

温针灸:首先让患者取仰卧屈膝或坐位屈膝使之感到舒适的体位,取准穴位,局部常规消毒后,直刺进针,其中针阳陵泉穴时,可透刺到阴陵泉,一针两穴。再用剪刀将艾条剪成长约2cm的小艾段,插在主穴针柄上,点燃艾条施灸,各穴各灸1~2个艾段,灸完后再留针10min。隔日1次,10次1个疗程。

水针:在穴位注射前先判断患膝有无积液,如有积液,应先抽

液（抽液部位可在髌骨外缘上 2cm 处即在髌上滑囊处穿抽），然后再用 5ml 一次性注射器抽取 0.5% 布比卡因 1.5ml，曲安奈德 10mg，当归注射液 2ml 混合药液，在所选取的主穴上，快速刺入皮下后，缓慢进针，得气后，回抽无血，将药液慢慢注入穴位，每穴注射 1.5 ~ 2ml 药液，隔 2 日 1 次，10 次为 1 个疗程，疗程间休息 1 周。

膝关节慢性滑膜炎属中医“膝痹”范畴。其病因病机为膝部劳损日久，感受风寒湿邪，侵袭人体，注于经络，留于关节，气血痹阻而致。临床表现为患膝疼痛肿胀，屈伸不利，步履艰难等症。治疗上以祛风化湿，温经散寒，活血化瘀为原则。温针灸是针刺和艾条结合应用的一种疗法。借艾灸之热量通过针体传入穴位深层，达到温通经络，行气活血，祛寒散湿的作用。水针则是一种针刺和药物穴位注射相结合的疗法。通过药物对注射穴位的滞留效果，既增强了针刺的感应，又使局部药液得到充分的吸收作用，起到消炎、镇痛、活血化瘀的作用，加强局部的血液循环，两法有机结合，有利于加强机体对膝关节功能的调整作用，使顽痹得除。

赵某，女，57 岁，农民，右膝关节酸痛 6 年余，近 1 月来，因右膝关节酸痛加重，行走困难，夜不能寐而来诊。刻诊：患者右膝关节肿胀、局部皮肤光泽透亮，皮肤温度低于左侧健膝，髌上囊壁处摸之有韧厚感，内外膝眼凹陷消失而变凸出，浮髌试验（+），治疗先给予温针灸，起针后，再抽取关节积液约 20ml，最后行水针疗法。仅 1 次患者就感患膝肿胀等症明显减轻，已能伸屈行走，后又依上法治疗 17 次，诸症痊愈行走如常。又嘱其注意膝关节休息，保暖，勿受潮湿等注意事项，随访半年未发。

十三、扬刺为主 标本兼治

姚聪英以扬刺为主治疗风湿性膝关节炎，疗效显著。

取穴：内外膝眼、血海、梁丘、犊鼻。

操作：患者仰卧，患侧下肢半屈曲，常规消毒穴位，取 30 号 2 寸不锈钢毫针，先向后内斜刺犊鼻穴 1.2 寸，梁丘、血海向下针刺 1.5 寸，内外膝眼向上斜刺 1 寸，待捻转得气后在针柄接 G6805 - 2 型电针仪，采用连续波，强度以患者能够耐受为宜。每次留针 20 ~ 30min 后取针。隔日 1 次，10 次为 1 个疗程。并在留针时用自制的

木质灸盒内放点燃的微烟艾条数小段，进行悬灸。灸至皮肤潮红为度。

中医学认为本病多因卫气不固、腠理空疏、风寒湿邪乘虚而入留滞经络、关节、气血运行受阻发为痹证。祛风散寒、除湿疏通经络。以扬刺法刺之，取犊鼻穴为主治膝痛，取足阳明胃经为多气多血经，其郄穴梁丘为本经气血聚集之处外，取之补气养血，活络通经，祛风化湿。“治风先治血，血行风自灭”针血海可养血祛风，扶正祛邪是风寒之痹的首选要穴。膝眼是奇穴，且均在膝关节之周围，有局部近治之效，所以本法取穴具有双重的意义，共达标本兼治之功。同时电针产生的电磁场可以增加局部血流量，改善微循环，消除疼痛。复加艾灸更助温通经络、祛除寒湿、调和气血、促进功能旺盛之作用。

患者，女，40岁。患者两膝关节疼痛、肿胀，不断加重已2个月之久，坐卧均痛，屈伸不利，步履困难，甚则不能站立，得暖则舒，诊断为寒痹。姚聪英针上述穴位，治疗方法同上，2次后膝肿痛减轻，第四、第五次后疼痛显著减轻，行动自如，经治疗1个疗程后，症状消失。

参 考 文 献

- [1] 严书荣，孙乐芹．恢刺、短刺配合按摩治疗老年性膝关节炎64例．中国社区医师，2005，7（18）：53
- [2] 王利耀，田爱徐．透刺膝眼治疗膝关节炎48例．陕西中医，1998，19（8）：368
- [3] 艾鹏飞，潘月财．温针灸配合火罐治疗退行性膝关节炎60例．吉林中医药，2006，26（8）：51~52
- [4] 刘一儒．针刺拔罐发泡疗法治疗膝关节炎42例．中国针灸，2005，25（1）：39~40
- [5] 陈育德，韩海玉．针刺加中药外敷治疗退行性膝关节炎54例．针灸临床杂志，2004，20（10）：14
- [6] 李得顺．针刺配合拔罐治疗增生性膝关节炎218例疗效观察．甘肃中医学院学报，2000，17（4）：32~33
- [7] 陈翔飞．拔河针法治疗退行性膝关节炎38例．针灸临床杂志，1998，14

(5): 30~31

- [8] 侯文凤. 电针加中药电疗治疗增生性膝关节炎 90 例. 陕西中医, 1997, 18 (12): 557~558
- [9] 王远长, 李同军, 于志国. 推拿配合温针灸治疗骨性膝关节炎的疗效观察. 针灸临床杂志, 2005, 21 (10): 44
- [10] 奚向东, 张鑫海. 膝三针治疗增生性膝关节炎 190 例疗效观察. 中国针灸, 1996, (3): 25~26
- [11] 段祥余. 飞针为主治疗风湿性关节炎 128 例. 湖南中医杂志, 2004, 20 (2): 26~27
- [12] 徐一新. 温针灸结合水针治疗膝关节慢性滑膜炎 68 例疗效观察. 针灸临床杂志, 1998, 14 (8): 34~35
- [13] 姚聪英. 扬刺为主治疗风湿性膝关节炎 128 例. 实用中医内科杂志, 2005, 19 (5): 483

【踝关节扭挫伤】

踝关节扭伤主要是指踝关节内侧副韧带、外侧副韧带和下胫腓韧带的损伤。一般是骑车、上下楼突然跌倒或道路不平时由于踝关节不稳定而使其过度向内和向外翻转所致。临床分为内翻型和外翻型 2 种，以前者多见。本病可发生于任何年龄，以青壮年常见。运动员在进行田径、球类和体操等身体训练时，尤易发生此病。此外，踏空、高坠等均可导致踝关节扭伤。本病属中医学“筋伤”的范畴，是由于经筋损伤，脉络受阻所致。

本篇共收录了 17 位针灸医家的临床治验。有的穴取威灵、精灵，配合运动疗法；有的采用巨刺法，配合紧松补泻；有的采用内外关为主，配合交经刺；有的根据生物全息理论，采用综合治疗；有的以阿是穴为主，傍针刺；有的独取上廉，强刺激；有的以八脉交会穴为主，配阿是穴扬刺；有的取丘墟照海、电针透刺等。

一、威灵 - 精灵 运动疗法

杨继若采用上下对应交叉取穴配合运动法治治疗急性踝关节扭伤，疗效较理想。

取穴：精灵、威灵。

操作：患者坐位，患侧踝关节离地面 10cm，针刺部位常规消毒后，施者用 30 号 1.5 寸毫针

直刺手背精灵、威灵二穴，得气后，针刺手法采用捻转与徐疾补泻相结合的泻法。即针刺时，疾速刺入穴内，得气后，捻转时右转角度大，频率快，用力重，并同时嘱咐患者慢慢旋转活动患侧踝关节，行针1min，徐徐出针。

杨继若采用上下对应交叉取穴治疗扭伤是根据《内经》中缪刺和巨刺的原则“左病治右，右病治左”，结合《灵枢·终始》说：“病在上者，下取之，病在下者，高取之，……”的上下配穴法，再按照《灵枢·经脉》说“盛则泻之，虚则补之”进行治疗。

精灵、威灵二穴别名“腰痛穴”，此二穴对腰部软组织损伤有特效。腰部软组织损伤和急性踝关节扭伤均导致人体的气血郁滞，二者的病机相同，根据异病同治的原则，取“腰痛穴”治疗踝关节急性扭伤。

针刺配合运动疗法，疏通了经气，使气血畅行于经脉，并正常输布于经筋、皮部，四肢百骸得以濡养，局部组织的微循环得以改善，加速了渗出液的吸收，故而起到了消肿、止痛散瘀、利关节之效。

张某，女，42岁。1988年8月10日就诊。患者于8月9日下午因走路不慎扭伤左踝关节，现患者不能站立，左足疼痛甚，踝部肿胀，外展时疼痛加剧，X线片排除骨折及脱位。诊断为左踝关节急性扭伤。杨继若先针刺阿是穴（外踝处最疼的2个反应点），用泻法、留针15min，起针后患者踝关节仍然疼痛不能站立行走，遂改刺右侧手背的精灵、威灵二穴，按捻转与徐疾补泻相结合的泻法，行针1min，并同时嘱咐患者活动左侧扭伤的踝关节，起针后患者能下地行走，踝关节疼痛明显减轻，第2次治疗后，患者踝关节肿痛消失，行走正常。

二、巨刺法 配紧松补泻

巨刺法为“左病取右，右病取左”的针灸疗法，临床应用较广，尤其是治疗急性软组织损伤性疾病，疗效尚可。骆方采用巨刺法配合紧松补泻手法治疗急性踝关节扭伤，效果满意。

取穴：照海、太溪、丘墟、昆仑、阳陵泉、解溪，均为健侧。

操作：照海、太溪行泻法，丘墟；昆仑行补法；阳陵泉、解溪

行平补平泻法。用 32 号 1.5 寸毫针针刺。补法为快速刺入皮内约 0.1 寸，然后缓慢插入 1 寸，得气后拇指后退，捻转角度稍大，同时将针提至 0.6 寸处，轻轻地行小幅度拇指向前捻转，再将针提至 0.2 寸处，行拇指后退、大角度捻转。如此操作 9 次。泻法为快速刺入皮内约 0.1 寸，随即拇指向前、食指向后捻转，用力重，速度快，同时将针插至 0.2~0.3 寸处，接着轻缓退回至 0.1 寸处，同样方法将针分别重插至 0.6 寸、1 寸，如此反复 9 次。针刺过程中嘱患者反复轻缓地活动患侧踝关节。每天 1 次，3 次为 1 个疗程，两疗程间休息 1 天。

巨刺法为《灵枢·官针》九刺之一，“巨刺者，左取右，右取左”。这是一种交叉取穴施治的方法。由于踝关节扭伤在急性期局部肿胀，有瘀血，疼痛明显，故局部取穴往往会使患者有痛上加痛之虑。若手法不当，亦可造成不必要的损伤或继发感染。故采用巨刺法可以避免患处局部取穴的弊端，并且能使患者在针刺的同时能主动活动患足，达到疏通经脉气血，缓解疼痛之目的。

三、内外关 配交经刺

朱建斌采用内、外关配合交经刺治疗踝关节软组织扭挫伤，疗效显著。

内外关穴疗法：外踝痛或损伤取外关穴，内踝痛或损伤取内关穴，内踝痛或损伤引及外踝痛取内关透刺外关，外踝痛或损伤引及内踝痛取外关透刺内关。

交经刺取穴疗法：先查明患足损伤最痛点位置所属经脉及相应的穴位，然后取对侧手上相对应位置的同名经上相对应的腧穴。①痛点位于左踝足太阳经申脉穴，取穴以右侧手太阳经相应位置的养老穴。②痛点位于左踝足少阳经丘墟穴（原穴），取穴以右侧手少阳经相应位置的阳池穴。

《灵枢·终始》“病在上者，下取之，病在下者，高取之”，《素问·缪刺论篇》“左盛者右病，右盛者左病”。交经刺取穴法，遵循和总结了古典医籍在针灸治疗原则方面的精萃，在临床中得到了较好地验证。内、外关分别为八脉交会穴通于阴、阳维脉，与阴、阳维脉分别通络于内、外踝，在治疗踝关节损伤中有着较好的运用，

交经刺与内、外关穴相配合在踝关节损伤的治疗中起到了相得益彰的效果，并在临床中得到了非常理想的疗效。

李某，男，40岁。1999年12月28日就诊。患者于2天前右外踝下楼时不慎扭伤，当时疼痛不堪，自贴膏药缓解，昨日骑车时再次扭伤右外踝部，当即疼痛，行走困难。查体：右外踝下方肿胀明显，外踝尖部相当于申脉穴处压痛最甚，关节功能受限，X片显示：未见明显骨质异常。即诊断：右踝关节腓侧副韧带扭伤。治疗取：①患侧外关节；②健侧养老穴。两穴皆用捻转泻法，针刺后令患者动足，即感疼痛消失，行走自如，唯有外踝尖部微胀感，经过3次巩固治疗后，病愈。

四、据生物全息 综合治疗

陈明达运用生物全息理论，针刺加药物外敷配合功能锻炼治疗踝关节扭伤，疗效满意。

针刺：根据同侧对应原则，取患肢同侧的第二掌骨侧足穴，用30号华佗牌1~1.5寸不锈钢毫针直刺进针，行提插捻转结合补泻手法1min后，留针。再在健侧胫骨下端周围用手按压找到一敏感点，用30号华佗牌0.5~1寸不锈钢毫针直针进针，留针。

局部外敷：将事先备好加醋调成糊状的中药粉末（乳香、没药各25g，血竭、红花各20g，自然铜40g，黄柏30g）涂患处，再用绷带包扎固定。

功能锻炼：急性扭伤，伤情较重者在治疗上做脚趾的屈伸活动，轻伤者，下地做下蹲，慢行走；损伤超过24h者，皆行下地做下蹲，慢行走。根据患者的伤势情况，逐步加大功能锻炼强度。以上治疗必须在药物外敷，绷带包扎后进行。药物外敷、功能锻炼均在针刺后留针的同时进行，整个过程约20h左右。每天1次。

陈明达根据生物全息理论：凡是机体某一器官或部位有病，就必然地要在特定的穴位上有所表现。同时还运用中医学的“巨刺之法”。《素问·调经论》曰“巨刺者，左取右，右取左”，“邪客于经，左盛则右病，右盛则左病……如此者，必巨刺之”，利用健侧经气，在针刺刺激下调动患侧经络之真气。同时又不碍患者下一步的药物外敷及带针功能锻炼。这样针刺一上一下，一左一右，有利于

协同调整整体内的阴阳平衡，达舒经活血之功。药物外敷有消肿止痛，散瘀止血的功效，加上醋可起着局部冷敷防肿，引经入内的作用。同时，绷带的包扎，起到了固定、压迫止血的功能。在治疗上，运用整体的、全息的观点，把针刺、药物外敷、功能锻炼有机结合起来，使之三个环节相互作用，相互制约，各尽其能，共同达到消肿散瘀，活血止痛，预防关节粘连之功效。

聂某某，女，31岁，因夜间下楼不慎左踝关节扭伤，6h后，由家人扶来就诊，经X光检查未见骨折，查见患者踝关节周围红肿明显，左脚下地不能，痛苦状，诊断为急性左踝关节扭伤，行上述治疗3次后，红肿消失，下地行走如常。后随访1年，患者无创伤性关节炎，阴雨天未发作疼痛。

五、阿是穴为主 傍针刺

慢性踝关节扭伤，是临床上常见的运动性创伤。吴亿中采用傍刺加温针灸治疗该症，疗效肯定。

取穴：主穴：阿是穴；外踝疼痛配丘墟、申脉、昆仑、悬钟、阳陵泉等；内踝疼痛配商丘、照海、太溪、三阴交、阴陵泉等；内外疼痛则交替取以上配穴3~5个。

操作：先在踝关节附近寻找最痛点（阿是穴），如痛点不明显则外踝以丘墟、申脉，内踝以商丘、照海作为痛点，常规消毒后，用29号，2寸毫针刺入痛点中心，斜向傍刺1针，得气后行小幅度捻转提插约1min，再根据症状选取相应的配穴3~5个，实施常规针法，然后于各穴针柄上行温针灸3~5壮（如枣核大小）。以上各穴间断行针3~4次，留针20~30min。隔日1次，7次为1个疗程。

慢性踝关节扭伤，属中医学“筋痹”、“痹证”范围。阿是穴是主要的病理变化反应点，依据邻近取穴的原则，刺激该穴能祛瘀活血，通调经络，散寒止痛。傍针刺是《内经》十二刺法之一，临床上多用于治疗痛点比较明显，而且固定不移，久久不愈的痹证。据此，吴亿中采用阿是穴傍刺，以加强针感，取得比单针刺法更为显著的效果。同时，艾灸可温通经络，逐寒祛湿，在针刺的同时，实施温针灸，使热力通过针身深透病所，起到温经通络，散寒活血，逐痹止痛的作用。从而，弥补针之不足，提高针刺的疗效。

六、运动针刺 舒经通络

陈苏赣采用运动针刺结合按摩治疗踝关节扭伤，取得了满意效果。

运动针刺：取患足对侧阳溪、阳池，常规消毒后，用 34 号，1 寸毫针快速刺入，针阳溪时针尖向太渊方向透刺，针阳池时直刺。提插捻针，得气后留针 20min，留针期间，每隔 5min 捻针 1 次，并令患者做行走练习，待病人感觉患处疼痛减轻时，再令其做原地双脚跳起练习。每天 1 次，10 次为 1 个疗程。

按摩：患者取坐位或仰卧位，嘱患者放松患肢，医者拿矮凳子坐于患者对面，用正骨水或万花油涂于施手法的部位，以防损伤皮肤。踝关节呈中立位，医者用手大拇指桡侧及鱼际在患者脚背至外踝向小腿做推摩 6 次，再用点按法点昆仑、丘墟、解溪、申脉等穴。以通经络之气。再一手握住患足内外踝，一手握住患足靠近足趾部脚背，在适当牵引的情况下，使患足做被动绕环运动，顺时针、逆时针各绕 3 圈，再从足背至小腿中部推摩 3 次结束。

踝关节扭伤后，受伤部位出现瘀血肿胀，经络痹阻，气血运行不畅，不通则痛。运动针刺结合按摩能使离槽之筋复位，舒通经络，经通痛止，祛瘀消肿。在留针时，令患者行走和跳跃，可以促进局部血液循环，使瘀血更快地消除，组织更快地得以修复。此法操作简单，有利于患肢的活动，患者痛苦小，疗程短，恢复快。

程某某，男，20 岁，学生，1996 年 6 月 3 日就诊。因篮球比赛跳起落下时不慎踩到别人的脚背而扭伤。当时疼痛难忍，左足不敢着地，由同学背至我处治疗。检查见左踝外侧明显肿胀，压痛明显，脚内翻时疼痛加剧，但无骨折症状，诊断为左踝关节急性扭伤。按上法治疗 1 次。患者自我感觉疼痛大减，左足可以下地行走，但活动不那么自如，治疗 4 次后肿胀、疼痛全部消失而痊愈。

七、独取上廉 强刺激

孙学英采用针刺上廉穴治疗踝关节扭伤，取得显著疗效。

取穴：上廉。

操作：患者站立（重者他人在后面抱住），将健侧上肢屈于胸

前，轻握拳，掌心置于患侧乳头下方。用毫针直刺上廉穴，行间断性强刺激，医者以左手托住肘下部，感到有针尖波动为度。同时令患者大力活动受伤下肢，尤其是踝关节。当感到疼痛明显好转时即速起针，一般不超过2min。起针后自行活动5~10min，不愈者，第二天再针。

踝关节扭伤多由筋脉、关节受损。气血壅滞不畅，络脉运行受阻所致。上廉穴为手阳明大肠经腧穴，主治头痛、半身不遂、手臂麻木等。用本法可通过督脉及手足三阳经，起到活血行瘀、通络舒筋的作用。即《灵枢·本脏》所谓：“血和则经脉流行，营复阴阳，筋骨劲强，关节清利矣”。

王某，男，21岁，1993年6月23日就诊。1h前，因打篮球不慎将左踝扭伤，局部疼痛不能站立。X线拍片示骨质结构未发现异常，速针上廉穴，行捻转强刺激，约0.5min，即觉踝部疼痛消失，并能蹒跚行走，5min后完全恢复正常。

八、外关—三阴交 消肿止痛散瘀

何良元近年来采用针刺穴位治疗急性关节扭伤，取得显著疗效。

取穴：外关、三阴交，单侧扭伤取单侧，双侧扭伤取双侧。

操作：局部常规消毒后，用28号毫针1.5寸，快速刺入外关、三阴交，待有酸、胀、麻感后，采用强刺激捻转泻法，留针30min，每隔10min行针1次，拨针后嘱患者活动扭伤关节，每天1次，7天为1个疗程，疗程间歇4天，可行第二疗程。

踝关节扭伤是由于经筋损伤，脉络受阻，而致气滞血瘀，故气血运行不畅则局部肿胀，气血瘀滞，“不通则痛”，疼痛不适，关节肌肉活动不利。因而治法应以：“疏通经络，舒筋活血，行气化瘀”为宜。外关穴为手少阳三焦经络穴，三阴交穴为足太阴、厥阴、少阴经交会穴，针刺外关、三阴交穴具有行气活血，疏经通络，使局部组织的微循环得以改善，加速了渗出液的吸收，故而起到了消肿、止痛、散瘀、利关节之效。

杨某，男，29岁。1995年8月30日初诊。主诉：左踝关节疼痛，伴活动障碍7天，经某医院诊断为“左脚踝关节软组织挫伤”，给予局部冷敷，对症处理等效果不佳前来就诊，检查左脚背踝关节

肿胀、瘀血、局部压痛，活动受限，行上法治疗4次，疼痛、瘀血、肿胀消失，功能活动恢复正常，参加日常工作。

九、循经远取 巨刺

张连记根据远道经络辨证取穴，采用针刺运动疗法治疗急性踝部软组织损伤，疗效颇佳。

针刺：取穴：主穴取外关。外踝部损伤配阳溪透太渊，内踝部损伤配神门透阳谷。均取患侧穴位。操作：局部皮肤常规消毒，用28号毫针快速进针，得气后用捻转提插泻法。留针30min，在留针期间进行运动疗法。

运动疗法：针刺得气后，在留针期间使患者主动或被动地运动踝关节，做屈伸、旋转、内外翻、行走、跳跃等各种动作，以患部不痛为度。如在运动过程中出现残余体位性疼痛（如外翻痛、背伸痛等），则保持此疼痛体位，并行捻转提插泻法，其针感以患者能耐受为度，疼痛即可解除。每天1次，3次为1个疗程。

张连记根据中医学巨刺“病在下者而上取之”的原则，针刺外关、阳溪透太渊、神门透阳谷穴治疗急性踝部软组织损伤。外关穴为止痛奇穴，八脉交会之一，具有行气活血止痛作用，取之针刺意在“远道随证取穴”。取阳溪透太渊、神门透阳谷穴是由于针刺部位和病变部位形态相似，功能相似，寓于“远道按部位取穴”，透穴重在行气止痛，与外关相伍共奏舒通经络、畅通气血，消肿止痛之功。远道取穴由于远离患部，避免了直接针刺病人的疼痛区，并且不妨碍患部活动，所以又为配合运动疗法奠定了基础。根据现代康复医学的观点，踝关节扭伤宜早“动”，以促进踝关节功能的恢复，减轻肿胀，防止复发。当然，损伤早期的运动并不是无限制的活动，而是有其康复的原则：主动为主，被动为辅，主动宜缓慢，被动宜轻缓而柔；不痛为度，不断调整，具体掌握，运动量以不疲劳为度，活动强度在最大耐受极限内；严禁超负荷运动。

王某某，男，18岁，学生。1994年12月3日就诊。2h前，因打篮球不慎扭伤右踝部，当即肿痛，屈伸、行走时疼痛加剧，跛行。查体：右踝部外侧明显压痛，外侧韧带牵拉试验（+）。X线拍片未见骨折及脱位。诊断：急性右外踝部软组织损伤；遂取外关、阳溪

透太渊穴针刺，并配合踝关节活动，即感疼痛锐减，屈伸明显好转。唯作内翻动作时感轻度疼痛，遂保持该体位，行大幅度捻转泻法，疼痛当即消失。30min 后完全恢复正常，第二天随访无复发。

十、八脉交会穴 配阿是穴扬刺

吴初竹选用八脉交会穴针刺配阿是穴扬刺对急性运动性踝关节扭伤进行治疗，取得较显著的效果。

取穴：申脉、照海、后溪，再循经取 1~2 穴，另外取阿是穴，并以其为中心在上、下、左、右各浅刺 1 针。

操作：患者取坐位或卧位，常规消毒后，取申脉、照海，得气后以提插法平补平泻，再循经取 1~2 穴，有酸胀感即留针。阿是穴用提插泻法，根据损伤部位面积大小，在阿是穴的上、下、左、右各浅刺一针，以上各穴留针 15~20min。取后溪穴进针，然后快速提插捻转数次，同时以另一手拇指点按申脉，嘱患者主动活动踝关节数次后即可出针。每天 1 次，5~7 天为 1 个疗程。

《灵枢·本藏》说“经脉者，所以行气血营阴阳，濡筋骨，利关节者也。”跷脉起于内、外踝的申脉、照海，上行于下肢内、外侧至头面，具有交通一身阴阳之气，调节肢体运动的功用，使下肢灵活矫健。并且申脉、照海为八脉交会穴，分别通阳跷、阴跷，取之可调阴阳，行气活血，舒筋活络。申脉属足太阳膀胱经经穴，后溪属手太阳小肠经经穴，亦为八脉交会穴，与督脉相通，上下相应，且“督脉为阳脉之海”，气行则血行，瘀肿自然消散。另外，后溪穴为手太阳经输穴，“俞主体重节痛”，取之快速捻针，并配合踝关节主动活动，对止痛和恢复关节活动有显著疗效。压痛点是脏腑经络病变在体表的反应，常为损伤部位，取之直达病所，泻其邪气，“扬刺者，正纳一，傍纳四而浮之，以治寒气之博大也。”因踝关节扭伤后多有明显的痛点，筋脉拘急，肿胀面积较大，所以取阿是穴为针刺中心，在其上、下、左、右各浅刺一针，针刺作用面积大，改善局部血液循环，大大加速了炎症渗出的吸收速度，有利于组织的修复，防止组织粘连，从而尽早恢复正常的关节活动。

郭某，女，30 岁，体操教师，1999 年 5 月 17 日初诊。主诉：2 天前右踝扭伤，疼痛剧烈，伤后以足尖点地行走。检查：右踝外侧

肿胀明显，皮肤青紫，外踝前下方压痛明显，踝关节背屈、跖屈明显受限；踝关节强迫内翻试验出现外踝痛剧，但无关节不稳现象；抽屉试验无异常活动。X线未见明显异常。诊断：右踝外侧韧带（距腓前韧带）部分扭伤。治疗：取右侧申脉、照海、阳陵泉、阿是穴及其上、下、左、右各刺一针，除阿是穴用泻法，其余各穴平补平泻，留针20min。出针后，取后溪穴进针，然后快速提插捻转3~4次，同时以另一手拇指点按申脉，嘱患者主动活动踝关节数次后即出针。每天1次。治疗2天后，局部肿痛明显消退，踝关节屈伸活动有所改善，能全足着地行走。

十一、电针为主 大七厘散外敷

熊小燕运用大七厘散外敷配合电针治疗踝关节韧带损伤，疗效肯定。

针刺：取患侧申脉、丘墟、照海及阿是穴。方法：患者取坐位或仰卧位，穴位常规消毒后，用40mm毫针快速刺入皮下至得气，用捻转泻法，接通G6805型电针治疗仪进行通电，用连续波，频率为120~200次/min，电流强度以患者能耐受为度，留针20min，取针用泻法摇大针孔，同时局部用TDP照射，每天1次，6次为1个疗程。

药物外敷：大七厘散15~45g，以白酒调敷患处，绷带包裹，每天1次，每次外敷可持续24h，并用白酒频频淋于患处，以保持药物的湿润，3次为1个疗程。

大七厘散由大黄（酒制）、血竭、乳香（煨）、没药（煨）、三七、当归尾（酒制）、骨碎补、土鳖虫（甘草制）、自然铜（煨、醋淬）、硼砂（煨）、冰片等药物组成，为棕褐色的粉末或易松散团块，气香、味微苦，略辛凉。主要功能：化瘀消肿，止痛止血。以外敷为主，如对酒精过敏者，可用醋调，肿胀明显、瘀斑显著时，先以大七厘散酒调外敷，以化瘀消肿，止痛止血，敷药3天后，肿胀明显减轻，瘀斑基本消散，再给予电针治疗，TDP局部照射，以加强疏通经络、散瘀消肿之力。在治疗期间应少活动或不运动，休息时将伤足抬高。

雍某，男，48岁，2004年6月16日初诊。诉3天前下楼时踏空

而致右踝关节内翻，感踝关节处疼痛剧烈，不能触地，继而出现外踝下方、前方肿胀，足背肿胀瘀血，用力痛甚，经X线检查示踝关节及骨质未见骨折及脱位。诊断踝关节韧带损伤。给予大七厘散调酒外敷3次，局部肿胀、瘀血明显减轻，针刺6次后，症状消失，可触地行走，病情痊愈。

十二、丘墟—照海 电针透刺

赵义造采用电针透刺治疗慢性踝关节扭伤，取得了理想疗效。

取穴：丘墟透照海。

操作：患者仰卧位，略抬高患肢，腓窝垫一软枕，放松踝部。对丘墟穴按常规消毒，采用30号，2寸一次性毫针，针尖放于无疼痛区（皮肤上三个毛孔之间的三角形小区域）上，捻转进针，待穿透皮肤后，调节针尖向照海方向透刺，动作宜慢，使针身大部进入，直达照海穴下，以局部酸胀、麻重或酸麻向胫前外侧放射为得气。得气后，用G6805电针治疗仪导线一端接在针柄上，另一端接在照海穴处，采用疏密波，刺激量以患者能耐受为度，留针30min，隔日1次，7次为1个疗程。

踝关节结构复杂，需要负重，又在远心端，一旦肌腱、韧带损伤，气血瘀滞，关节内微环境发生改变，造成炎症渗出水肿，致痛物质堆积，从而影响局部新陈代谢、自身修复能力及关节内应力，导致病情迁延难愈。

透刺具有刺激强烈，取穴精确，创痛轻微，沟通表里经及邻近经脉气血之优点。赵义造认为丘墟透照海治疗本病，关键在于熟悉踝关节解剖，灵巧运针，避免疼痛，使针感直达病所，激发筋肉深部经气，促使邻近经脉气血运行，加强炎症消散吸收，解除肌肉痉挛和疲劳状态，松解粘连，缓解疼痛，以达到治病的目的。

十三、针刺放血 疏通经脉

苏华荣对急性踝关节扭伤患者，采用局部针刺放血疗法，疗效颇佳。

点刺放血：采用患处局部放血及趾端放血，配合健侧“对应点”放血，对局部按常规消毒，用三棱针或7号针头施治。患侧放血量

3~5滴，一般放出患侧血，血色由紫黑转为鲜红为度；健侧“对应点”放血，放血量1~3滴。

针刺：取丘墟、解溪、悬钟、列缺、后溪、阿是穴等，常规针刺。上述方法每天1次或隔日1次，7次为1个疗程。休息3天，可进行下1个疗程。

治疗踝关节扭伤，主要是疏通经脉，恢复诸骨的正常解剖位置，本法采用局部趾端及健侧“对应点”放血，其目的就是要疏通郁闭的经脉，可改变患处的血液循环，加速其新陈代谢。列缺、后溪分别为多气少血之手太阴络穴及多血少气手太阳之经穴，也是通任、督脉之八脉交会穴，刺此二穴，可调节气血、阴阳，气血和，阴阳平，疾病自愈；针刺解溪、丘墟、绝骨等穴，亦可调节气血，促进疾病痊愈。值得注意的是：操作时手法要轻，进针时速度要快，不宜针得太深。

杨某，男，21岁，1993年10月14日初诊。当天军体训练中，左内踝关节扭伤。患者感觉剧痛，不能行走活动。查：左内踝关节及足背肿胀，关节活动功能障碍，X摄片：无骨折。治疗：取健侧“对应点”和患侧阿是穴，用三棱针呈梅花形，快速放血。患侧放血3~5滴，健侧1~2滴后，患者即感疼痛减轻，再在患侧指端放血1~2滴，加针丘墟、解溪，及左上肢后溪、列缺，使用平补平泻法，留针20min。次日复诊，病人已能着地行走，肿胀基本消失，但仍感不适，再行患侧三角形放血1~2滴，趾端放血1滴，针刺方法及穴位同上，第三天，病人即行走如常，能继续进行军事训练。

十四、针刺穴注 消肿止痛

吴必会对踝关节扭伤患者采用针刺和穴位注射效果显著。

针刺：主穴：申脉、昆仑、丘墟、绝骨、照海、太溪、商丘、三阴交、解溪、阿是穴等。配穴：太冲、足三里、地五会、阴阳陵泉、公孙等。穴位常规消毒后，用28号1~1.5寸毫针，快速刺入所选主穴后，出现针感，行强刺激，用泻法；患肢局部出现灼热感后，疼痛随之减轻，再配上述穴位，进针有针感后捻转提插用平补平泻法，留针30min。每天1次，7天为1个疗程

穴位注射：取踝前注射点（胫距关节线前下方皮肤进针），踝后

注射点（跟腱内侧、内踝上方之间进针），内翻者加注外踝侧韧带注射点（距腓前韧带处进针），外翻者加注内踝侧三角韧带注射点（内踝下端0.5cm处进针），选用5号细针，10ml注射器，避开血管进针，有酸胀感，抽无回血，视扭伤程度轻重，用鱼腥草注射液4~8ml分别在每个注射点注入1~3ml，注射完毕后用无菌棉球压针眼片刻，每天1次，7天为1个疗程。必要时，可用绷带包扎患部，进行软固定。早期局部注射注意休息，抬高患肢40°左右，肿痛消退后，应在不负重的情况下早期活动关节。

针刺上述穴位和局部注射，首先疏通血脉和经络，使局部瘀血水肿尽快吸收，达到消肿止痛，气滞血瘀祛除，“通则不痛”之原则。而鱼腥草注射液做局注可直达病灶，具有解毒、消肿排脓，同时有抗炎镇痛，增加免疫力等作用。从解剖学可知，踝关节远离躯干，针、药难以到达局部以发挥疗效。经采用针刺穴位和运用鱼腥草注射液直接作用于局部，二者并进，以最快的速度送到病灶处，达到最佳治疗效果。

李某某，男，22岁，武警部队勤务中队班长。于1999年7月4日初诊。主诉：因打球不慎扭伤右踝关节外侧，感肿痛，活动受限及不能行走。前来门诊就诊，查体：右踝关节内外侧及胫腓骨下段肿胀明显，内外侧前下方压痛（+），背屈伸试验（+），经X线片检查未发现骨折及脱位。诊断为踝关节内外侧韧带扭伤伴皮下瘀血水肿。先采用针刺穴位，尔后在右踝关节皮肤常规严格消毒，用5号细针，10ml注射器抽取鱼腥草注射液8ml，避开血管，在外侧韧带处注射点注入3ml，踝前注射点注入3ml，踝后注射点注入2ml。注射完毕后用棉球按压针眼片刻，并抬高患肢40°左右。每天1次。次日患者来院诉肿痛基本消退，可以下地行走。再行上述治疗5天，症状体征消失，关节功能活动恢复正常，行走如常，病告痊愈。

十五、独刺攒竹 配合运动

踝关节扭伤，一般药物难以控制，韩新强采用针刺攒竹穴治疗踝关节扭伤，方法简单，疗效显著。

取穴：攒竹。

方法：患者端坐，消毒后，持1.5寸长毫针直刺双侧攒竹穴

12mm, 刺后快速捻转, 重刺激, 用泻法, 针毕后令患者行走, 或站立足趾抵地, 患踝做旋转运动, 幅度由小到大。留针 30min, 每日针 1 次。

攒竹穴属足太阳膀胱经的穴位, 膀胱经起于内眼角的睛明穴, 上额到头顶、项后, 分两支: 一支夹脊柱两旁下行, 经腰、股后至腘窝; 另一支经肩胛下行, 到臀、股后下行腘窝委中, 经小腿后外踝到足小趾外侧端至阴穴。在《灵枢·经脉》记载: “膀胱足太阳之脉……是动则病……是为踝厥。是主筋所生病者……” 韩新强根据以上的中医理论及“经脉所过, 主治所及”原理, 治疗踝关节扭伤的患者, 取得了满意效果。

十六、独取阿是 扬刺

周光英采用针刺阿是穴治疗急性踝关节扭伤, 并主张发病后立即治疗, 取得满意的疗效。

取穴: 阿是穴。

操作: 患者取坐位, 局部常规消毒。选用 1.5 ~ 2 寸毫针为宜。手法采用杨刺法。先选内踝或外踝肿胀压痛点进 1 针, 快速直刺, 得气后留针。然后在肿块边缘选 4 ~ 6 穴, 捻转进针, 沿皮下斜刺至肿胀中央, 得气留针。局部 TDP 直照。每隔 5min 行针 1 次, 留针 20 ~ 30min, 缓慢出针, 摇大针孔, 以针孔微出血为佳。每天 1 次。5 天为 1 个疗程。

急性踝关节扭伤是临床常见病和多发病。常规治法: 一般在急性扭伤 24h 内, 冷敷, 制动; 24h 后方可作理疗、针灸按摩和中药外敷等。此法能获得一定效果, 但疗程长, 见效慢, 在一定时期内给患者带来生活和工作的困难。少部份患者若失治或误治容易导致病情迁延, 反复发作, 而发展成慢性损伤。近年来, 周光英开展针刺阿是穴治疗急性踝关节扭伤取得显著效果, 从临床观察中发现, 患者扭伤后, 就诊越及时疗效越好, 疗程亦短。

针灸理论认为: 急性踝关节扭伤, 导致局部经脉受损, 经气运行受阻, 气滞血瘀, 故局部出现肿胀疼痛, 进而关节活动不利。针刺阿是穴能迅速疏通经脉, 宣通气血, 使经气流畅, 改善局部血循环, 调节血管、神经功能, 因此具有止痛、散瘀之功效, 尽快改善

踝关节的功能活动，使早日康复。

刘某，女，58岁，干部。1994年11月8日诊。患者右踝关节扭伤3h，踝部疼痛，肿胀状如鸡蛋大小，不能行走。局部皮肤无瘀斑，外踝前下方压痛明显，作X光照片无异常改变。诊断为急性右踝关节扭伤（内翻扭伤）。即予针刺治疗，取患部阿是穴。首选压痛点进1针，然后在肿块边缘浅刺6针，针法如上述。留针半小时，局部直照TDP神灯。取针时，摇大针孔，令针孔微出血。针后患者自述疼痛缓解，当即能下地短暂行走。次日，就诊时，痉挛疼痛，肿胀明显缓解，踝部皮肤出现瘀斑。继续上方案治疗，连续治疗1个疗程（5天）后痊愈。3个月后随访，患者一切正常。

十七、针推并用 通则不痛

刘洪宝采用针刺结合手法治疗踝关节扭伤，疗效满意。

针刺：常用穴取阳陵泉、压痛点，如踝关节内翻扭伤者加丘墟、申脉、昆仑；外翻扭伤者加照海、商丘、中封。如踝关节错缝者加解溪、悬钟、太溪。用强刺激，如年迈体弱者可用中等刺激，用泻法，每次留针20min，每隔5min加强1次刺激量，每天1次。

推拿：患者取坐位或仰卧位，嘱患者放松患肢，医者面向患者，取润肤油（如凡士林、冬青油等）涂于施行手法的部位，以防止损伤皮肤。踝关节呈中立位状，术者用拇指的指端用力于阳陵泉、绝骨、承山、解溪、昆仑、太溪、压痛点等处作一指禅推法约10min左右。然后术者的一手拇指、食指紧按在踝关节内、外侧间隙处，另一手捏住足背前半部及足趾，两手稍加力作对抗牵引，然后作踝关节内翻、外翻、旋转摇晃、背伸、背屈活动数次。术者一手掌托住患者足跟，并握住踝关节，另一手作拿捏、弹拨踝关节四周肌腱，顺肌腱走向理顺肌腱。最后术者用单手小鱼肌摩擦踝关节周围，以热量渗透到踝关节腔内为度。每天1次，注意初伤患者中踝关节肿胀较甚者，手法宜轻。

中医学认为“不通则痛，痛则不通”。踝关节的扭伤导致了经脉受损，气血流行失畅，故临床上出现了肿胀、疼痛，活动不利，针刺穴位，能调节经脉功能，使之恢复正常，使气血正常地于脉中流行，不致流溢于脉外。加上手法的机械作用使毛细血管扩张，加速

血液运行,两者结合起协同作用,气血就更加流畅,从而使瘀血更快地消除,组织更快地得以修复,进而使疼痛较快地治愈。

参 考 文 献

- [1] 杨继若.耳体对照治疗急性踝关节扭伤 120 例临床分析.甘肃中医,1996,9 (3): 38
- [2] 骆方.巨刺法治疗急性踝关节扭伤 39 例.浙江中医药杂志,2002,(8): 362
- [3] 朱建斌,薛亮.内外关配合交经刺治疗踝关节扭伤 132 例.辽宁中医杂志,2004,31 (3): 250
- [4] 陈明达,许友慧.生物全息疗法治疗踝关节扭伤 57 例.中医药学报,1999,(5): 32~33
- [5] 吴亿中.傍针刺治疗慢性踝关节扭伤 83 例.上海针灸杂志,2003,22 (8): 40
- [6] 陈苏赣.运动针刺结合按摩治疗踝关节扭伤 58 例.针灸临床杂志,2000,16 (10): 44~45
- [7] 孙学英,杨仁升.针刺上廉穴治疗踝关节扭伤 56 例.山东中医杂志,1994,13 (11): 502
- [8] 何良元,徐健康,董立新.针刺穴位治疗急性关节扭伤 142 例.甘肃中医,1998,11 (2): 41
- [9] 张连记,桑爱芹,左金惠.针刺运动疗法治疗急性踝部软组织损伤 140 例.中医外治杂志,1997,(3): 12~13
- [10] 吴初竹,熊东萍.针刺治疗急性运动性踝关节扭伤.宜春学院学报,2004,26 (4): 108
- [11] 熊小燕.大七厘散外敷配合电针治疗踝关节韧带损伤 34 例.江西中医药,2005,36 (5): 55
- [12] 赵义造.电针透刺治疗慢性踝关节扭伤 43 例.上海针灸杂志,2005,24 (7): 31
- [13] 苏华荣,阮建林,乔生才.针刺放血疗法治疗急性踝关节扭伤 82 例.山西中医,1996,12 (4): 25
- [14] 吴必会.针刺加穴位注射治疗踝关节扭伤 64 例.针灸临床杂志,2003,19 (4): 15~16

- [15] 韩新强. 针刺攒竹穴治疗踝关节扭伤 18 例. 中国针灸, 2005, 25 (11): 802
- [16] 周光英, 秦幼平. 针刺阿是穴治疗急性踝关节扭伤 60 例. 四川中医, 1995, (7): 53
- [17] 刘洪宝. 针刺结合手法治疗踝关节扭伤 64 例. 上海针灸杂志, 1997, 16 (4): 27

【足跟痛】

足跟痛是急性或慢性损伤引起的足跟部疼痛。症状虽然简单，但病因复杂，且多缠绵难愈。一般多为从高处落下，强大暴力撞击足跟底部，或走路时足跟部被高低不平的路面或小石子顶挫致伤。因职业关系长期站立于硬板地工作，扁平足，跑跳过多，足底跖筋膜、肌肉韧带长期处于紧张状态，反复牵拉跟骨附着处可引起足跟底痛。跳跃运动员踏跳过多，长跑运动员用前足掌蹬地过多，由于跖腱膜、屈趾短肌、跖方肌以及跖长韧带等反复牵拉，日久也可发病。

根据不同的损伤原因，可致跟底脂肪垫、滑液囊及骨膜挫伤，或跖腱膜、屈趾短肌等在跟骨结节前方附着处的牵拉伤。损伤后，跖筋膜附着处可发生充血性渗出，脂肪垫充血、肿胀，滑囊慢性炎症，跟骨骨膜增生，产生骨刺等改变。

中医学认为，该病的形成是以肝肾亏虚、气血失和、筋脉失养为先决条件，复因风、寒、湿邪侵袭及外伤、劳损等致使气血阻滞而成。

本篇共收录了八位针灸医家的临床治验，有的采有针法，有的采用灸法，有的采用针药并用；从取穴上看，有的以局部穴位为主，有采用辨经取穴，有的采用经验穴治疗，均取得

了一定疗效。

针灸治疗本病疗效可靠,但对有些病例非一时能治愈,须坚持治疗或配合其他疗法综合施治。急性期应注意休息,症状缓解后应减少站立和步行。平时宜穿软底鞋,或在患足鞋内放置海绵垫。

一、局部多针刺 通则不痛

李景华运用局部多针治疗足跟痛取得满意疗效。

取穴:阿是穴。

操作:嘱患者俯卧位,两腿伸直,足跟向上,暴露其足跟部。常规消毒后,用2寸28号毫针于痛点中央垂直刺入1针,其他3针间隔1寸,呈等角三角形以45°角各进1针,针刺方向朝向第一针。边进针边询问患者感觉,必须得气有酸、胀、麻等针感。留针30min,5~10min行针1次。每天1次,10次为1个疗程。

中医学认为足跟痛为肝肾亏虚,以及寒湿之邪外侵,或长期行走、站立导致足跟部位经脉受阻,气滞血瘀,不通则痛。局部多针刺法,可在病灶处形成网状针刺,所有病灶都能贯通,较大幅度地改善了病变部位血液循环状况,有利于局部新陈代谢和致病物质的清除,促进炎症物质的吸收和组织碎片及代谢物被转运,从而使气血调和,经脉通利,达到通则不痛的目的。

二、隔姜灸 祛湿散寒

足跟痛是一种常见病,表现为晨起或久坐后站立时,跟骨不敢着地,步履艰难。张广礼采用隔姜灸治疗。

操作:取姜切成薄片,置于足跟底疼痛点下方,用中等艾炷如枣核大小点燃。以能耐受热为度,且让皮肤有温热感觉或局部皮肤有红润为好。每次灸3壮,每天1次,10次为1个疗程。

足跟部由于肌肉少,用针刺疗法,患者往往痛上加痛,而不易接受。用直流电药物离子导入法,足跟角质层较厚,且多数40岁以上者足跟多干裂,易发生电极烧伤。隔姜艾炷灸,有温经、祛湿逐寒、散瘀通络活血功效。局部温度可达50℃左右,患者有明显的温热感,自觉寒气随温而去。

李某某,女,26岁。1993年6月因产后受风寒致右足跟疼痛不

敢着地5月余而前来诊治。经拍X光片，跟骨未见异常。诊断为右足跟疼痛症。采用艾隔姜灸足跟痛点，每次以中等艾炷灸3壮，每天1次，共灸6次痊愈。随访2年半无复发。

三、自拟经验穴 针药并用

管遵惠选用经验穴跟腱、失眠、肾根为主穴，循经配穴；运用“短刺”、“输刺”、“齐刺”等内经针刺方法；配合“骨痛灵洗方”，治疗足跟痛，疗效显著。

取穴：主穴：跟腱：位于太溪、昆仑穴连线上，足跟腱之中点；失眠：位于足跖下后跟部的正中点；肾根跟骨前缘，涌泉与失眠穴的连线上，失眠穴前1.5寸。配穴：阳陵泉、悬钟、复溜、太溪、然谷、金門。

操作：根据《灵枢·官针》篇记载，采用了“短刺”、“输刺”、“齐刺”法的针刺。①短刺：“短刺者，刺骨痹，稍摇而深之，致针骨所，以上下摩骨也”。将针刺入深部，接近骨骼，主治骨痹证。②输刺：“输刺者，直入直出，深内至骨，以取骨痹。”将针直入直出，深刺至骨，主治骨痹。③齐刺：“齐刺者，直入一傍入二，以治寒气小深者。”直刺1针，再在两旁各刺1针，治疗受病部位较深的痹证。按上述刺法，进针得气行针后，采用温针灸或电针，留针30min，隔日1次，6次为1个疗程。

中药熏洗：自拟“骨痛灵洗方”，方药组成：丹参30g，骨碎补20g，补骨脂、当归、川芎、赤芍、麻黄、桂枝、牛膝、木瓜、乳香、没药、伸筋草各15g，红花、露蜂房各10g。上药碾碎装入纱布袋内，加入白酒10ml，醋20ml，水煎熏洗足跟，每天2次，每次30min。在治疗期间，不宜久立远行，宜穿宽大的厚底鞋，鞋内放置海棉厚垫，以保护足跟和减少跖筋膜张力。

中医认为：肾气亏虚，筋脉失养，是本病发生的主要内在因素；劳损和外伤经筋，或寒湿入络则是常见的外因。如活动过多，局部挫伤，负重行走，长途跋涉等外伤经筋，可引起跖筋膜劳损。此外，如感受寒湿，气滞血瘀；或跟骨结节退变钙化，骨刺形成，亦可导致纤维脂肪垫炎、跟下滑囊炎而形成典型的足跟痛。

根据“肾主骨”、“肝主筋”的理论，结合局部取穴与循经选穴

的配穴方法，选用跟腱、失眠、肾根三个经外奇穴为主穴；按照《内经》“短刺”、“输刺”、“齐刺”法，使之针达病所，直接起到疏经通络的治疗作用。因足跟部为经筋所聚，病位较深，故配合“骨痛灵洗方”，以助行气活血，祛湿散寒。经络气血得热则舒，加用醋以软坚、酒能活络，针药相辅，相得益彰，故能收到较好的临床疗效。

王某，女，68岁，离休干部，1996年11月21日初诊。患者于1996年4月到省外旅游后，感足跟疼痛，劳累及活动后加重。1996年10月26日参加老年登山比赛，下山后感右足跟剧烈疼痛，不能站立，跛行。经云南省某医院X线跟骨摄片示：“未见异常”。诊断为：①跟下滑囊炎；②跖筋膜劳损。予理疗及中、西药物治疗3周，无效。仍感晨起下床或坐后站立时足跟下及足心部撕裂样疼痛。检查：右足跟部轻度肿胀，跟骨结节前缘明显压痛，足趾背伸时足底疼痛加重。脉沉细紧，舌黯红夹瘀，苔薄白。辨证：肝肾亏虚，筋脉失养；气血凝滞，脉络痹阻。治疗：按照上述方法治疗，针刺5次，配合中药熏洗，10天后足跟疼痛消失，行走自如。随访1年，疗效巩固。

四、雀啄灸 温经散寒

足跟痛是中老年人的一种常见病，其表现为站立或行走时，足跟及足底有酸胀疼痛感，严重时呈针刺样痛，难以举步，给老年人的生活造成极大的痛苦。宋宇用雀啄灸治疗本病，取得比较满意的效果。

操作：取足底最痛点，或者是经X线确定的骨刺的部位。将艾卷燃着对准选择的部位，类似麻雀啄食般的一起一落忽近忽远的施灸，给以较强烈的温热刺激。一般可灸5~15min左右，以局部出现深红晕为度。另外也可均匀地上、下或向左右方向移动或作反复地旋转施灸，注意不要烫伤患者。每周2~3次，2周1个疗程。

足跟痛中医认为是由于人体气血不足，肾经气虚，肌腠不固，导致寒湿之邪乘虚而入筋脉，造成经脉痹阻不通，而引起疼痛。而雀啄灸具有温经散寒，通经活血，使气血运行通畅，筋脉充盈，起到了通则不痛的作用。

患者，男，60岁，2002年7月12号初诊，患者半年前突然出现足跟痛，经过多方治疗没有缓解，而且还进行性的加重，故来诊，经骨科推荐来针灸科就诊，就诊时跛行进屋，足跟不能够落地，准备为患者针灸但患者惧怕，坚决要求不针刺，故选择雀啄灸足底最痛点，1个疗程后患者痛大减，后巩固1个疗程，随访半年没有复发。

五、针刺肩奇 立竿见影

周晓卿采用针刺肩奇穴治疗足跟痛，收效明显。

取穴：肩奇穴（位于肩峰内侧寸许凹陷处）。单足跟痛取同侧穴，双侧疼痛取双侧穴，隔日治疗1次。

操作：用28号1.5寸毫针。患者取坐位，双臂自然下垂，充分暴露肩部。皮肤消毒后，针尖快速刺入肩奇穴皮下，行重提插捻转手法，得气后留针5min，第二次反复提插捻转得气后出针，并嘱患者病侧足跟轻踩地面即可。

肩奇穴为治足跟痛特效穴，尤其是对跟软骨炎引起的疼痛可收立竿见影之效，对跟骨骨刺所致的疼痛也有较好止痛效果，但对骨刺严重者疗效较差。另外，还应注意找准穴位，正确行针刺手法，恰当掌握针刺深度，得气即止，切勿过深，以防刺伤肺尖造成气胸。

某女，54岁，教师，1998年6月12日就诊。主诉：双侧足跟痛2年余。曾局部注射波尼松等药物，疗效不显，就诊时因足跟痛行走困难。X线片示：双侧跟骨有骨刺。采用上法治疗1次后疼痛明显减轻，行走轻快，经3次治疗疼痛消失，行走正常，随访3个月未复发。

六、针刺强刺激 配中药外洗

常英采用针刺配合中药外洗治疗足跟痛，疗效显著。

针刺：取穴昆仑，太溪，阿是穴，均为患侧。患者俯卧，暴露患足，局部常规消毒，用30号1.5寸毫针，先针刺昆仑、太溪，垂直进针，行提插捻转手法，使针感传至足跟部，然后以痛点为中心，呈品字形斜刺向痛点中心，采用强刺激，足跟部有酸胀感。留针30min，出针后干棉球轻按针眼部位。每天1次，10次为1个疗程。

中药外洗：药物组成：透骨草、伸筋草、当归、熟地黄各 20g，赤芍、川芎、地丁、桂枝各 15g。将上药加水 3500ml，煎约 20min，取 3000ml 药液，将药液滤入盆内，先熏患处，待药液温度适宜时，再泡洗患足 20min。为促进疗效，可边浴足边按摩患足底部。每天 2 次，每剂可用 3 天，10 天为 1 个疗程。

中医认为足跟痛是风寒湿邪内侵，留滞于经脉，使气血运行不畅，瘀阻经筋，经脉不通，不通则痛而发病。治疗以祛风散寒，活血散瘀，行气止痛为主。针刺局部可以使治疗直达病所，患处血液循环加快，疏通经络，通则不痛；透骨草和伸筋草有温经通络，散寒祛风湿的作用；桂枝有温经散寒的作用，与当归、川芎同用可以活血止痛；将上述中药煎成药液熏洗可以使局部软组织受热后毛细血管扩张，改善微循环，使药物有效成分能更好的渗透吸收，药效发挥迅速，起到活血祛瘀、通痹止痛的效果，从而缓解肌肉痉挛，抑制无菌性炎症的反应，达到治疗的目的。针刺和药物结合，共同起到疏经通络，调整气血，刺激局部小血管扩张，改善局部血液循环，从而达到祛除病邪的目的。

男，62 岁，2002 年 10 月 10 日就诊。诉右侧足跟部疼痛 1 月余。由坐位站立时右足跟疼痛，行走时加重，经 X 线诊断“右跟骨骨质增生”。曾服用西药、做理疗、封闭等治疗，但效果不明显。常英采用先针刺后中药外洗的方法治疗，5 次后疼痛减轻，共治疗 10 次，疼痛消失，行走自如，随访半年，未复发。

七、同名经远取 运动针刺

张连记根据远道经络辨证取穴，采用针刺运动疗法治疗跟骨刺，疗效较佳。

取穴：足跟内侧疼痛、压痛者取神门，足跟外侧疼痛、压痛者取养老；足跟正中、下部疼痛、压痛者取足跟痛点（大陵穴下 0.8 寸）。均取患足的同侧穴，双足同病取双侧穴。

操作：局部皮肤常规消毒，用 28 号毫针快速进针，得气后用捻转提插泻法。留针 30min，在留针期间使患者主动或被动的运动足跟部。嘱患者用足跟着地行走、跺脚，踩在木棒等硬物上由轻到重自行滚压足跟痛点，或者医者以痛为腧，用木棒叩击、压推患足跟，

被动运动患部。主动运动宜缓慢，被动运动用力不宜过猛。运动能使针刺部位产生针感，即运动针感。运动以患处温热、出汗为度，此时患者即感足跟部酸软舒适、疼痛消失。隔日1次，3次为1个疗程。

在取穴上，张连记借鉴了下病取上、上病取下的原则。根据经脉循行的规律和同名经经气相通分别取神门、养老。神门穴为手少阴经所注输穴，“输主体重节痛”，而足跟刺又因肾虚所致者多见，故针刺神门穴可以疏通经脉、调补经气、和畅气血、补肾壮骨。养老为手太阳经的郄穴，郄穴经气聚集，主急性痛证，刺之重在行气止痛，效若桴鼓。足跟正中、下部疼痛，据“远道按部取穴”的规律，取手针足跟痛点。诸穴并用，针刺时配合运动疗法可改善跟骨刺周围组织的血液循环，促进了劳损组织的修复；控制和减缓炎症反应，吸收由炎症反应所致的渗出、充血和水肿。

八、独取足跟穴 巨刺

足跟痛是临床常见病之一，常由肾虚或骨质增生而致。曾学清应用针刺足跟穴的方法治疗足跟痛，收到较为满意的疗效。

取穴：足跟穴（位于手掌大陵穴与劳宫穴连线内1/3处），取健侧。

操作：患者直立，穴位处常规消毒，用30号，1.5寸毫针直刺0.5寸，行提插捻转手法，令患者踩患侧足跟，每隔30s运针1次，直至疼痛减轻或消失。如果痛点转移至足跟外侧，针刺方向转至小指方向提插捻转；如果痛点转移至足跟内侧，针刺方向转至手桡侧提插捻转。留针20min，留针期间令患者往返行走。每日治疗1次，7次为1个疗程。

足跟穴乃治疗足跟痛的验穴，此穴出自金伯华著《单穴聚锦》（甘肃卫生出版社出版）。足跟痛乃足部经外络脉失养、气血运行不畅所致，采用“左取右，右取左”的巨刺法治疗，疗效甚佳。此法取穴简便，见效快，痛苦少，易于为患者接受。

于某，男，45岁，机关干部，2003年6月来诊。主诉：右足跟痛1月余。现疼痛难忍，1月来渐加重，尤其坐卧时久，起立后足跟疼痛难以着地；X线检查无骨质改变；舌淡苔白，脉弦细。证属肾

阴亏虚，脉络失养。拟滋补肾阴、通络止痛之法。取左侧足跟穴，进针后行提插捻转法，同时令患者踩右足，当即疼痛大减，30s后继续运针，疼痛继减，留针10min，疼痛基本消失，继续运针，而后令患者往返行走20min，起针后疼痛完全消失。次日言足跟部略有酸痛，依前法，共针3次而愈。

参 考 文 献

- [1] 李景华, 魏建惠. 局部多针刺法治疗足跟痛 39 例. 中国实用乡村医生杂志, 2006, 13 (5): 33
- [2] 张广礼. 隔姜灸治疗足跟痛 48 例. 江西中医药, 1997, 28 (6): 50
- [3] 谭保华, 徐杰. 管遵惠治疗足跟痛的经验. 针灸临床杂志, 1999, 15 (2): 5~6
- [4] 宋宇. 雀啄灸治疗足跟痛 38 例. 上海针灸杂志, 2007, 26 (3): 14
- [5] 周晓卿. 针刺肩奇穴治疗足跟痛 25 例. 河南中医, 1999, 19 (6): 69~70
- [6] 常英. 针刺配合中药外洗治疗足跟痛 68 例. 山东中医杂志, 2004, 23 (10): 606~607
- [7] 张连记, 郭祥坤, 孔祥庚. 针刺运动疗法治疗跟骨刺 56 例疗效观察. 中国针灸, 1997, (12): 731
- [8] 曾学清, 何小花, 滕东时. 针刺足跟穴治疗足跟痛. 中国针灸, 2006, 26 (7): 486

【外伤性截瘫】

外伤性截瘫是指由外伤而致的脊髓横断性病变。属中医学“痿证”的范畴。临床多见于胸椎、腰椎压缩性骨折、粉碎性骨折或合并脱位后脊髓受损。

根据脊髓损伤部位的不同，出现损伤水平面以下的瘫痪。胸段损伤可引起双下肢痉挛性瘫痪；腰段以下损伤可出现下肢弛缓性瘫痪。同时伴有损伤水平面以下各种感觉缺失以及尿潴留或尿失禁，大便秘结或失禁，患肢皮肤干燥、脱屑，汗腺分泌功能异常等。颈脊髓前方受压严重者，可引起前侧脊髓综合征，有时可出现四肢瘫痪，但下肢和会阴部仍有位置觉和深感觉。脊髓半横切损伤，损伤平面以下同侧肢体运动及深感觉消失，对侧肢体痛觉和温度觉消失。

中医学认为，肾经贯脊属肾，督脉贯脊入络脑，二脉与脊髓和脑的关系极为密切。因此，脊髓受损则阻遏肾、督二脉，气血运行不畅，筋骨失养，必致肢体瘫痪失用。

本篇共收录 13 位针灸医家的临床治验，大多从调补督脉入手进行治疗，从治疗手法来看：有的采用排针刺，有的采用电针，有的采用齐刺法，有的针推并用，有的针药并用等。

本病目前尚无满意的治疗方法，针灸对其

中部分病例有一定的疗效。其恢复的程度视损伤的程度、年龄、体质、病程、治疗方法等多主面的因素而定。对下肢穴位针刺无任何反应、经数个疗程无改善者效果不佳。自主锻炼和被动锻炼是配合针灸治疗、早日康复不可缺少的环节。针灸治疗本病疗程较长,有的病人需要治疗数年之久,故需鼓励病人树立战胜疾病的信心,坚持治疗和功能锻炼。

一、调补督脉 益气活血

脊髓损伤是临床上比较常见的严重创伤,患者常留下截瘫、二便障碍而致残。熊华采用电针治疗脊髓损伤的截瘫患者,取得较好的康复效果。

取穴:受损脊髓节段上、下端督脉经穴(如大椎、身柱、灵台、筋缩、脊中、命门、腰阳关、腰俞等穴)及夹脊穴,上肢瘫痪加肩髃、曲池、外关、合谷,下肢瘫痪加环跳、委中、髀关、伏兔、足三里、解溪,二便障碍加膀胱俞、次髎、气海、关元、阴陵泉、三阴交、太溪、太冲。分成胸腹及下肢前侧与背腰及下肢后侧两组腧穴,每次取8~10穴。

操作:用28~30号毫针针刺,施提插捻转补泻手法后,用G6805治疗机加疏波、疏密波或断续波刺激30~50min。每天1次,10次为1个疗程,休息3~5天后开始下1个疗程,直至治愈或出院。

脊髓为督脉所过,《难经·二十八难》述:“督脉者,起于下极之俞,并于脊里,上至风府,入属于脑”。足少阴肾经“贯脊”,带脉从第二腰椎发出,《灵枢·经别篇》说:“足少阴之正,至中,别走太阳而合,上至肾,当十四椎,出属带脉”,可见肾、督、带三经脉与脊髓直接相连,当脊髓损伤,致三脉经气阻遏,督脉不能总督诸阳经,筋骨失养,肢体不用,麻木不仁,二便失司,正如《素问·痿论》所说:“阳虚则宗脉纵,带脉不引,故足痿不用”。所以治疗应调补督脉,益气活血。取大椎、身柱、灵台、筋缩、脊中、命门、腰阳关、腰俞等穴以振奋督脉阳气,使气血通调,肢体得到温煦濡养;取肩髃、曲池、合谷、髀关、伏兔、足三里、解溪等穴以通阳明多气多血之经,益气活血;取膀胱俞、次髎、气海、

关元、阴陵泉、三阴交、太溪、太冲等穴以摄下元，司二便。

针刺治疗非常重视得气，《灵枢·九针十二原》指出：“为刺之要，气至而有效”，但截瘫患者针刺时往往难以得气，影响疗效，为此，熊华从三方面来加强针感：第一，选穴上感觉缺失区与正常区相配，如督脉上、下端腧穴相配，二便障碍腹部腧穴与下肢腧穴相配；第二，选用粗针，适当延长行针时间，并多作补泻手法，早期以泻法为先，后期以补法为主；第三，加用电刺激和适当延长电针时间。开始治疗时患者感觉缺失区腧穴多无针感，随着治疗次数的增加，患者逐渐出现针感并日趋增强。

二、督脉电针 补肾益精填髓

裴萍芝采用督脉脉冲电针疗法获得了显著疗效。

操作：选用 KWD-808 II 型全能脉冲电针仪，其电源电压为 9V，输出波型为连续波，脉冲宽度为 0.5ms。确定脊髓损伤平面后，在其头、尾两端置入针灸针，深度为 0.5~1.5 寸，连接治疗机，正极在上端，负极连下端，打开治疗仪输出旋钮，引起负极以下相应的各肌肉出现节律性收缩。收缩频率与脉冲刺激频率相同步，收缩强度中等，以患者自觉适度为宜，每天 1 次，每次 30min。10 次为 1 个疗程，间隔 2 天后进入下 1 个疗程。

督脉起于胞宫（属肾），贯脊入脑，总督一身之阳，为髓居藏之处。截瘫病为伤髓所致，故调督脉意在补肾益精填髓，通调督脉阳气，使肾强髓满而达治疗目的。不完全性截瘫患者，督脉气血虽受损尚未完全被阻滞，采用督脉脉冲电针疗法，可直达病所，促进气血循流，疏达阳气，以助督脉统诸阳之功。

裴萍芝在临床上观察发现：外伤性截瘫患者脊髓的损伤程度不同，其针刺治疗结果亦不同，一般对于脊髓断裂造成神经细胞完全坏死的病人，基本无治疗价值。对于脊髓挫裂伤、震荡伤造成的神经细胞部分坏死的病人，经积极治疗可不同程度地使病情得以好转。

三、夹脊穴为主 随症加减

欧阳学采用针刺夹脊穴与膀胱经穴为主治疗因外伤造成的脊髓性截瘫，疗效满意。

取穴：脊髓病变的相应节段上下、左右各1对夹脊穴。上肢加：肩髃、肩内陵、曲池、偏历、合谷、后溪（双侧）；下肢加：承扶、殷门、委中、秩边、承山、跗阳、昆仑（双侧）。

操作：常规针刺，平补平泻法，针感向四肢末端放射为佳，留针30min。每天1次，10次为1个疗程。疗程结束后，休息3天继续下1个疗程治疗。

督脉为诸阳之会，主动。夹脊穴在督脉之经别上，夹脊穴能资助督脉之力，而且又近膀胱经，所以针刺夹脊穴可以疏通督脉、膀胱经气，治疗脊髓和膀胱病变。采用平补平泻的手法可有效地预防因痉挛所引起的滞针、弯针。治疗中要求患者必须配合功能锻炼，以防关节、韧带硬化。冬季睡眠时，足部最好能做一支架，以支持棉被重量，防止日后病足形成下垂足。

巩某某，男，34岁。因翻车颈部损伤，造成四肢瘫痪，经当地医院抢救与治疗2个月后，转来本院。查体：双上肢麻木，肌力Ⅲ级，双下肢迟缓性瘫，肌力0级，痛温觉、关节位置消失，小便失禁，阳痿。颈部X光片示：C₄横突骨折。颈部核磁共振检查：颈C₄~C₅水平脊骨变细，外伤后萎缩性改变。诊断：高位颈髓损伤后截瘫。治疗：选颈C₃，C₆椎旁夹脊穴2对，针尖向脊柱方向斜刺1寸许，同时针刺四肢穴位，针施平补平泻手法，以促进肌力恢复。3个疗程后，双上肢肌力基本恢复；6个疗程后可以拄拐下地行走，二便功能基本恢复正常；10个疗程后可以自由行走，右脚稍有跋行。

四、足三阳配夹脊 排针治疗

外伤性截瘫是脊髓损伤后的并发症，失治者，往往终身残疾。邹仁明运用排针疗法加电针治疗外伤性截瘫，取得了较好的疗效。

排针：即自上而下、排列有序的密集针刺方法，在经络循行线路上，隔1寸左右扎1针。手法以传统提插捻转为主，每穴针刺得气后运针1~2min，间隔10min再运针1次，运针2~3次后出针。一侧治疗结束再在另一侧采用同样方法进行治疗。背部取穴为华佗夹脊穴，下肢部取穴以足三阳经穴为主，亦可以取足三阴经穴或阿是穴。

电针：使用上海产DG-1治疗仪，A、B频调节，串、并联接，

选择疏密波，分别在单侧用2组穴位进行，先经毫针刺入穴位得气后，接上电流，强度约在2~6度之间，以病人能耐受为度，频率约为30~40次/min，每侧治疗30min左右，每天或隔天1次，30次为1个疗程，休息1周后继续进行下1个疗程。

华佗夹脊穴与神经结节相靠近，排针刺截瘫面以下的华佗夹脊穴可促使神经系统功能恢复，同时加电针治疗，目的亦在于加强刺激，激发和增强局部肌肉神经的功能。

包某，男，46岁，1993年2月15日初诊。患者于3个月前因交通事故撞伤颈部，出现全身瘫痪。经行颅骨牵引术及行颈前路C₆、C₇钻孔、潜行减压、C₅、C₆髓桥摘除术等治疗，病情无好转。诊见：肢体均不能自主活动，全身肌肉萎缩，吞咽缓慢，小便失禁，大便障碍，臀部褥疮。遂用本法进行治疗，吞咽困难配天突、廉泉；小便失禁配中极、曲骨；大便不通配天枢、大横；褥疮加灸局部。治疗30次后，双上肢能自主活动，双下肢能自行屈伸，全身肌肉渐丰，吞咽食物通畅，小便已能控制，大便可借助开塞露排出，褥疮干燥结痂脱落。继续原法治疗，并嘱其加强功能锻炼。通过近10个月的治疗，患者可拄双拐行走500m左右，生活基本自理。

五、局部取穴为主 齐刺

外伤性截瘫是随着脊柱的损伤而发生的，盛国滨应用《灵枢·官针》十二刺法之一的齐刺法配合电刺激治疗外伤性截瘫，疗效满意。

取穴：主穴：上点在脊髓病变节段的上1个节段，下点在脊髓病变节段的下2~3个节段，即上点距离脊髓损伤平面较近，下点远离脊髓损伤平面。配穴：上肢呈弛缓性瘫痪的配双侧的肩髃、曲池、外关、合谷，下肢呈弛缓性瘫痪的配双侧的髀关、伏兔、阳陵泉、足三里。

操作：患者以卧位或侧卧位，上、下点常规消毒后，以30号2.0寸毫针先在上、下正中点即督脉线上各刺入一针，然后再在其两旁各向内斜刺一针，上下共6针（不可刺入椎管，以免伤及脊髓），然后应用长城KWD-808Ⅱ电针仪，上、下同侧联线，正极接上点，负极接下点，波型用密波。配穴为同侧上下联线，波型用疏波。每

天1次，每次30min，10次为1个疗程，间隔2天行下1个疗程。

中医学认为脊髓性截瘫为督脉损伤所致。督脉总督一身之阳气，督脉失养，造成肢体痿废不用。本法应用的齐刺法上下点均位于督脉与足太阳膀胱经之间，可调理督脉与膀胱经之气。因五脏六腑之俞穴聚会于足太阳膀胱经脉，所以本组主穴又可调整脏腑气血的平衡，疏通经脉之通路，有利于疾病的恢复。

六、针药并用 疏通督脉

张小娥以针刺督脉穴为主配合中药对证治疗，疗效满意。

主穴：人中、百会、大椎、陶道、身柱、神道、至阳、筋缩、脊中、悬枢、命门、腰阳关。配穴：华佗夹脊及足三里、丘墟、太冲、悬钟、解溪、阳陵泉、地机、气海、关元、三阴交。每次选用3~4个主穴和3~5个配穴交替使用，

操作：每天1次，12次为1个疗程，满1个疗程后休息7天，再开始下1个疗程。

从上向下依次施针，针尖要达到棘突间硬脊膜外，或接近硬脊膜，使病人产生较强的针感上下传导，时或放散于两侧。若穴位正当损伤部位则不宜刺。也可以从大椎或陶道穴始，针从皮下棘突外向用接针透刺法一直透到腰骶部。在无感觉区域要强刺深刺（年老体弱者可用较细毫针，但必须要引起一定的传导性针感为度）随着神经功能的恢复，感觉障碍平面的下移，针刺的重点也下移。针下得气后强刺激，不留针。

中药：病变早期即瘀血期，可适当配用活血化瘀，疏通督脉，续筋接骨之中药内服。处方：狗脊15g，土鳖虫6g，自然铜15g，当归尾15g，丹参30g，桃仁15g，红花15g，地龙15g，制乳香、制没药各9g，川断15g，三七粉（另冲服）6g，瘀血期过后改用温经通络，健脾温肾法，处方：党参12g，黄芪45g，益智仁12g，山药15g，杜仲12g，牛膝15g，熟地30g，菟丝子15g，焦术15g，当归15g，炙甘草6g。

外伤性截瘫主要损伤了椎体和督脉，督脉循于脊里，上络于脑，统帅全身阳气，故在治疗中要抓住“督伤络阻”这个主要矛盾。针刺以督脉穴位为主，用强刺激不留针或透针接刺的方法，同时适当

配伍任脉及循行所过经脉的穴位，以疏通督脉，调理气机，疏通经络气血，使阳气上行下达，调节整体功能，改善局部损伤，以促使患者的早日康复。

王某某，男，22岁，工人，1990年10月5日，从三层楼高度摔下，病人呈昏迷状态，经检查诊断为腰椎压缩性骨折，双下肢瘫痪，小便潴留，大便秘结，随即行脊髓减压手术，术后双下肢瘫痪，二便失调，导尿管留置导尿，大便经灌肠才能排出，于1990年11月3日转入针灸科治疗。按上法针刺治疗，配服瘀血期方。1991年1月5日患者感觉障碍平面下移，左脚尖已能微动，大便失禁，小便已能用点力，以手压下腹部能自行排出尿液50~100ml，中药改温经通络，健脾温肾法。针刺选穴和手法的重点转向了感觉障碍平面附近和下肢部穴。1991年4月4日已能丢杖行走，二便恢复正常，痊愈出院。1992年11月随访，患者已能骑自行车上班。

七、疏调督脉 益气活血

外伤性截瘫在中医学中属痿证的范畴。王玲运用中医基础理论，结合现代医学采用针刺方法，取得了一定疗效。

操作：

(1) 损伤平面上(1~2个棘突)，下(1~2个棘突)的华佗夹脊穴，选用26~28号毫针，进针深度一般为1~1.2寸，针向脊柱方向斜刺，行提插捻转泻法，使针感沿脊柱放射，并于夹脊穴排列的首尾两针分别接入阴极阳极的脉冲电刺激，刺激量以病人耐受为度。

(2) 经筋排刺 取足阳明胃经，足太阴脾经的经筋排刺，直刺1.5~2寸，施平补平泻法。

(3) 另取中极、关元、肾俞、膀胱俞、命门、小肠俞、关元俞等直刺1.5~2寸，施捻转补法，使针感向会阴部放射，并配以脉冲电刺激，水道、归来、外水道、外归来、丰隆等，直刺1.5~2寸，施捻转泻法。

每天针刺2次，30~45天为1个疗程。

《素问·缪刺》指出“人有所堕坠，恶血流内，腹中胀满，不得前后。”主要是督脉受损，导致带脉不引，足痿不用。采用疏调督

脉，益气活血，通经活络之法针刺治疗，即针刺华佗夹脊可疏调督脉，调理气血，改善局部损伤，足阳明经筋及足太阴脾经筋排刺可增加刺激范围，帮助那些瘫痪的肌肉恢复功能，改善肌肉萎缩。根据临床研究，证明完全性脊髓损伤的针刺疗效远远低于不完全性脊髓损伤，提示损伤程度与预后的关系，判断损伤程度即可判断其预后。

此外，针刺治疗的时机与疗效也有密切关系，损伤初期即可接受针刺治疗者，疗效显著。脊髓是感觉运动信息在脑和躯体之间穿过的一个主要通路，脊髓损伤在中医学属督脉受损，督脉、脊髓和脑有着密切联系。

八、醒脑开窍针法 疏通督脉

外伤性截瘫是脊髓损伤后最常见的并发症，它以肢体截瘫及二便功能障碍为主要特点。对于本病的治疗一直是医学界的难点。丁淑强在传统取穴的基础上运用“醒脑开窍针刺法”及头针疗法治疗本病，疗效显著。

取穴：主穴：内关、人中、三阴交、极泉、尺泽、委中；头皮针运动区、感觉区；损伤平面上（1~2个棘突）、下（1~2个棘突）的督脉穴或夹脊穴、瘫痪肢体的阳明经筋排刺；关元、中极、天枢、丰隆。

操作：严格按照“醒脑开窍针刺法”要求规范操作。取头皮针运动区、感觉区沿头皮各分3段刺入帽状腱膜下，施小幅度高频率捻转手法，再配以电针增加刺激量。

督脉穴直刺1.5~2.5寸，针至横韧带时即可有酸胀感觉，如继续进针可有阻力突然减低感觉。或即出现触电感向下肢及二阴放射。夹脊穴向脊柱方向45°角斜刺。深度为1~1.5寸，提插手法，向脊柱两侧放射或出现相应部位的体内紧束感为度。分别配以电针增加刺激量。

瘫痪肢体的阳明经筋排刺，直刺1.5~2寸，施捻转提插泻法，每间隔2~3针于针柄上施艾灸，或配以电针以增加刺激量。

关元、中极直刺1.5~2寸（提前排空尿液）、针感向生殖器放射。天枢、丰隆直刺进针1.5~2寸，捻转提插泻法。

截瘫属于中医痿证的范畴,从经络学说来看,即为督脉损伤所致。《难经》云“督脉者,起于下极之俞,并于脊里,上至风府,入属于脑。”由此可见督脉、脊髓和脑之间有着密切关系,督脉受损可影响及脑,这是运用“醒脑开窍针刺法”及头针疗法治疗本病的理论依据。

丁淑强发现不完全性截瘫的疗效明显优于完全性截瘫,而且可能早期治疗是恢复其功能的有效途径。针刺治疗越及时则功能恢复越快,这可能与脊髓的再生能力有关。还认为针刺的方向,深度及手法是取得疗效的关键,针刺过程中加以温灸及电刺激也是必要的,这有利于激发经气,促进针感上下走窜,较快地使“气至病所”。

九、电针推拿 分期治疗

外伤性截瘫是由于外伤损及脊髓神经而导致的一组综合症候。成道友采用电针加推拿治疗腰椎外伤性截瘫,收到较好疗效。

(1) 急性期 术后1月定为急性期,手术后五天开始电针、推拿治疗。

电针:髌关、伏兔、膝眼、风市、足三里、阳陵泉、昆仑、解溪、太溪。每天选用6个穴位,取2寸毫针,穴位消毒后针刺入穴,尽量在找到针感后接上电针,电针用疏密波,深度肌肉抽动及患者能忍受为准,留针30min。

推拿:采取仰卧位,先点按膝眼:伏兔、足三里、解溪,后用滚法自髌前上棘向下至大腿前面,到小腿、踝关节、足背、脚趾;再拿委中、承山、涌泉,同时配合髋关节、膝关节、踝关节以及趾关节的活动,时间约25min。

(2) 恢复期 手术1个月后定为恢复期。

电针:穴位分为两组,第一组采用仰卧体位,穴位为髌关、伏兔、膝眼、足三里、解溪等;第二组采用俯卧体位,穴位为夹脊穴、环跳、委中、承山、昆仑等。操作上则每日用一组穴,其他方法同急性期。

推拿:分为两步,第一步同急性期,时间则缩短为15min;第二步采用俯卧位,先点按环跳、委中、承山、涌泉,再施滚法于臀部、股后部、小腿后部(随着腰椎操作的康复、治疗部位还可扩展到脊

柱两侧),治疗重点在环跳、委中、承山、涌泉及跟腱部位,时间约15min。

陈某,男,35岁,农民,病案号64482。患者于1999年3月19日因矿井事故致L₁后突畸形,L₁、L₂压缩性骨折而入院,双侧感觉仅在膝上8cm处无反射,肌力为0级,并有尿潴留及便秘,进行手术复位及内固定后第5天开始针灸推拿治疗,治法同前述,入院1个月时,肌力已恢复到Ⅳ级,小便可自行解出,5月22日出院时已能拄双拐行走,感觉、反射完全恢复,大小便能自理。

十、督脉温针 宣通气血

截瘫是由于脊柱疾病和脊柱骨折造成脊髓损伤,导致下肢运动障碍,大小便失常及皮肤感觉障碍的疾病。秦家超采用督脉温针治疗截瘫,取得了较满意的疗效。

取穴:主穴:在脊髓损伤节段上方和下方各取督脉一穴(椎间隙处),两穴尽量靠近损伤脊髓节段。配穴:上肢取肩髃、曲池、合谷、外关;下肢取环跳、风市、足三里、昆仑、太冲。

操作:主穴针刺时应避开瘢痕,沿棘突方向进针,得气后,施以捻转行针,强刺激1min。然后在针柄上套置艾条2cm,点燃后施灸,每穴灸2壮。配穴按常规方法针刺,留针30min。每天1次,15次为1个疗程,疗程间休息3天,再进行下1个疗程。

温针是针刺与艾灸结合使用的一种方法,既能宣通气血,又起温通经络的作用。中医学认为,截瘫的主要病机为督脉受损,经络闭阻。督脉为奇经八脉之一,经脉循行于背部脊柱正中,总督全身之阳气,为阳经之海。督脉受损,经脉阻滞,气血不通,阳气不达肢体,故肢体麻木,不能活动;阴阳开阖失司,脏腑经络失去阳气温煦以及阴津不得布散濡养,气化不利,则二便不能。《素问·阴阳应象大论》曰:“治病必求其本”。温针督脉经穴通过神经纤维直接作用于脊髓,有利于温经通络,改善脊髓血液循环,促使受损的神经元核蛋白合成,活化脊髓。因而能使气血通畅,阴阳平衡,气化正常,二便通畅。

李某,男,26岁,农民,重庆市梁平县人。就诊日期:1994年8月1日。主诉:右侧上、下肢瘫痪,左侧上、下肢麻木,二便困

难，伴阳痿。病史：患者因北京打工，于1994年7月9日晚12时许，被人连刺数刀，当即送往朝阳医院，次日转入北京市武警总医院，诊断为全身多处刀割伤，颈髓损伤，蛛网膜下腔出血，颈部CT片提示：C₅脊髓部分横断损伤。经抢救脱离危险后转入本院治疗。检查：右侧上下肢肌力0级，左侧上下肢麻木，二便困难，伴阳痿。经上述治疗3个疗程后，右侧上下肢肌力均恢复，行走微有跛行，二便正常，生活完全自理，并能从事一般体力劳动。

十一、夹脊 - 背俞穴 交替取穴深刺

米建平师从郑宗昌主任医师采用交替取穴法深刺夹脊穴、背俞穴治疗截瘫，取得了较满意的治疗效果。

主穴：在受损脊髓平面上两个椎体开始针刺，右侧取夹脊穴，左侧取背俞穴，或右侧取背俞穴，左侧取夹脊穴，每一个针刺平面只进1针，穴位呈“之”字形分布。每一个穴位针刺至横突骨膜近神经根处，由上至下到第五腰椎为止点。将两个电极分别连接两侧夹脊穴高点和背俞穴低点，或背俞穴高点和夹脊穴低点，然后接通电流，痉挛性瘫以密波为主，弛缓性瘫以疏波为主，电流强度以引起肌肉收缩，患者能够耐受为准，或以患者诉有酸、麻、胀、触电样感觉为主，强度不能过大，以免引起脊髓再损伤。

配穴：秩边、关元、次髂、涌泉，涌泉穴宜强刺激，其他配穴常规针刺。

穴注：当归Ⅰ号、Ⅱ号各2ml（为米建平所在医院制剂），在受损脊髓平面棘突下0.5~1寸选2个穴位（右夹脊、左背俞或右背俞、左夹脊交替），每个穴位注射2ml。

辅助疗法：根据病人损伤的部位和损伤程度，配合按摩、功能锻炼等进行全面康复。

针刺每次治疗30min，均每天1次，12次为1个疗程，休息2天，再进行下1个疗程。

截瘫，脊椎骨受损为现象，而损其督脉为实质。督脉为奇经八脉之一，总督一身之阳气，为阳经之海，具有调节阳经经气之功能，督脉受损，阳气不达肢体，故出现肢体麻木，不能活动；阴阳开阖失司，气化不利，腑气不通，则大小便失常。《素问》：“治病必求

其本”。华佗夹脊穴、背俞穴靠近督脉，针刺直接作用于脊髓，又避免直接针刺督脉所产生的脊髓损伤和脊髓炎症之虞，具有安全性。根据解剖学分析，每一条神经由椎间孔发出后分成两条神经纤维，隔穴而针，可避免重复刺激，以减少病人痛苦。

十二、针灸为主 综合治疗

刘志良以针灸为主治疗外伤性截瘫病人，收到满意效果。

(1) 电针

取穴：①百会、夹脊（从受伤脊椎上2椎体到S₅、旁开0.5寸）、环跳、承扶、殷门、承山、昆仑；②肩髃、曲池、外关、合谷、髀关、阳陵泉、足三里、三阴交、太冲、八风。

两组穴交替使用。小便失禁加关元、气海、肾俞，大便失禁加天枢、支沟、大肠俞。用30号1.5寸不锈钢毫针，快速刺入皮肤，要求进针得气后，再把电针机的两根输出线分别横连在经脉对应的穴位针柄上，用G6805型电针治疗仪分别在腰脊、四肢穴通电，取连续波，频率60~80次/min，刺激量为患者能耐受为度，留针30min，每天1次，15次为1个疗程，疗程间隔2~3天。

(2) 灸法

取穴：背部取穴夹脊、背输穴，四肢取曲池，足三里、血海，腹部取关元、气海，将鲜姜切成0.3~0.4cm的薄片，面积要大于艾炷底面，用三棱针把姜片刺数个小孔置于穴位上，再在姜片上放蚕豆大的艾炷施灸。当患者有灼热感时轻轻拍打周围皮肤，当患者呼痛时取下，作一壮，连灸五壮，灸后以灸处皮肤潮红，温热为度（尽量不要产生灸疮，难愈），每次2~3穴，每天1次。

(3) 穴位注射

根据病人的不同情况，选择一定的穴位，用当归注射液，维生素B₁、维生素B₁₂，神经生长因子等中西药进行小剂量注射，每天1次，每次选2~4穴交替。操作方法：局部常规消毒后快速进针，针要刺入穴位，待得气后，回抽针栓，若无回血，方可注入药物。

(4) 心理康复与功能锻炼

脊髓损伤造成躯体致残，患者精神上的痛苦，远远超过疾病本身的折磨，因此医者应综合病人情况，既治病人疾病，也要充分调

动病人的积极性。除医者使用点、揉、按、拿等手法促进患者肌肉、关节的运动，并按照循序渐进的原则，锻练其意志，应引导做躺、坐、爬、站、走的运动，使患者的主动运动与医者的协助运动相结合，逐渐过度超负荷运动法（即负重运动法），调动病人的最大能动性。

外伤性截瘫的病变部位主要在督脉，《难经·二十八难》云：“督脉者起于下极之俞，并于脊里，上至风府，入于脑。”《素问·骨空论》指出：“督脉起于少腹胞中，下抵阴器至会阴部绕臀，与足太阴、足太阳的中络会合，贯脊属肾。”是以督脉因外力损伤致病，造成气乱四溢，阻滞不通，则主要出现瘫痪不仁，肌肉萎缩，二便失禁等症。故取督脉及足少阴、足太阳经之腧穴为主，电针治疗，配合艾灸，以温通经脉，活血化瘀。

针刺治疗要求医者自身之静，运气于手，行之针则疗效健，要求患者心静神归，气顺不乱，治之则宜，为加强针刺之疗效，针刺后必导引之。

长期顽强的功能锻练甚为重要，不但提高患者机体抵抗力和耐受力，同时还可以促进患者肢体肌肉强度，畸形等得以被矫正，消除废用，促进肢体肌群血液循环，增加肌肉血液回流量，防止水肿，促进肌肉代谢产物排出，保证肌肉正常代谢活动，维持肌力，部分功能得以重建。

张某，男性，25岁，于95年6月不慎从3米处跌下，腰部着地，觉腰痛甚，双下肢无力，小便失禁。送本院骨科诊治，作腰椎X光照片提示：“L₁压缩性骨折并脱位”，经作L₁椎体减压固定手术，手术证实脊髓横断性损伤，术后20天转入本科继续治疗，症见：双下肢瘫痪，肌肉萎缩，二便失禁，舌质淡暗，苔少，脉细。检查：双下肢肌力Ⅰ级，肌张力减弱，膝跟反射、肛门反射、提睾反射均消失，双足下垂及内翻，脐下痛温觉消失。中医诊断：痿证（气血不足，瘀血内阻），西医诊断：L₁压缩性骨折术后并截瘫。治疗按本法治疗，经针灸、穴注、推拿等治疗2个月，双下肢肌力恢复到Ⅲ级，拔除导尿管自行排尿，可站立；治疗4个月，双下肢肌力恢复至Ⅳ级，可扶拐行走，肌肉萎缩改善，大小便随意自排，肌电图检查结果明显好转；半年后可独立行走及二便自控，生活基本

能够自理及参加轻体力劳动。

十三、上中下三部同取 综合治疗

谭晓红采用以针灸为主的综合治疗，取得较好疗效。

(1) 经穴治疗

督脉电针：在损伤脊髓上下两个椎体棘间隙，各进1针，深度为1~2寸，得气后停止进针，深度不要超过硬膜外，用G6805电针治疗仪选疏密波或断续波（硬瘫用疏密波，软瘫用断续波），通以微弱电流。每天1次，3月为1个疗程。

夹脊穴温针灸：取损伤脊髓上2个棘突至下2个棘突间的夹脊穴进针，斜向棘突两旁透刺，针感以酸、麻、重、胀或向下放射为度。胸部宜浅，腰部可适当深刺，再加用艾条、温针灸或隔姜灸。每天1次。

头针：百会、足运感区、感觉区、运动区。

足针：①肾区（涌泉穴旁开1寸，左右各1穴），气端（足趾端10穴）。②涌泉、内八风（足掌面趾缝端穴与八风穴相对应）。③足背部取解溪加八风穴。3组穴位交替使用，每天1次。

常规配穴：以随证取穴为主。①调理二便：八髎、天枢、气海、中极、曲骨。②食欲不振：足三里、中脘、梁丘、内关。③发热：风池、合谷、曲池。④褥疮：血海、肾俞、命门、膀胱俞、腰俞。同时用WS-301C周林频谱仪照射患处30min，每天1次。

火罐：取督脉、背部膀胱经为主，外涂红花油走罐、闪罐或梅花针叩刺闪罐。每天1次。

(2) 中药治疗

用截瘫方（黄芪30g，党参10g，地龙10g，红花3g，补骨脂10g，骨碎补10g，枣皮10g，当归10g，川芎6g，枸杞10g，狗脊10g，川断10g，甘草3g），硬瘫者加葛根30g，柴胡5g，远志3g；软瘫者加升麻6g，黄精10g，淮山10g。每天1剂，水煎，分2次服。

(3) 辅助治疗

心理康复：应鼓励其家属给予患者高度同情和认真照顾，帮助患者进行功能锻炼。充分调动患者的积极性，使病人树立战胜困难

的勇气和决心，主动配合治疗，才能取得较好的疗效。

功能锻炼：截瘫病人的功能锻炼是长期艰苦的过程，必需循序渐进，持之以恒，方能奏效。对损伤初期或刚施行椎板减压术的患者，脊髓刚受到损伤，须保持脊柱的稳定性，故只宜在床上进行膝、髋等关节的被动功能锻炼。脊柱损伤稳定后，逐步开始床上锻炼，由扶坐→自坐→床边坐→垂足坐→固定膝关节扶持站→固定膝关节双杠走→去固定双杠走→去固定架拐走→独立行走。在锻炼过程中活动范围应适当，注意防止关节韧带扭伤、脱臼或骨折。

外伤性截瘫是由于外界暴力损伤脊柱，使脊椎骨折、脱位，引起脊髓损伤而成，是以肢体麻痹及二便功能障碍为主要临床表现的疾病。中医学把本症归属于“痿证”、“痹证”、督脉病候等病证之中。损伤部位与督脉关系密切。就本病的发病机制而言，中医学认为，督脉行于脊里，为奇经八脉，总督一身之阳气，为“阳经之海”。脊柱损伤后，督脉也常受损，以致气血溢乱，阳气不达四肢，故肢体废萎不用，阳气受阻，大肠不能传送糟粕，膀胱气化无权，故二便失禁，而成截瘫。

督脉穴通调督脉，统理十二经脉之阳气，夹脊穴内挟督脉，外循膀胱经，挟脊而行于督脉与膀胱之间，针刺效应通过督脉与膀胱经得以发挥。督脉电针和夹脊穴温针灸直达病所，通督起废，乃治病求本之法。

头针、足针为病变的远端取穴。头针以大脑生理解剖为理论基础，大脑皮层的功能与其相应的头皮有关，在其相应的头皮上针刺就可以调整位于其下的大脑皮层的功能，针刺患者的运动区和感觉区具有较好的恢复肢体功能的作用。足针是根据全息律原则取穴，全息律理论认为生物每一相对独立的部分，在化学组成的模式上与整体相同，是整体成比例的缩小。谭晓红临证体会到足针针感强，针刺涌泉、肾区、气端、内八风等穴后，无知觉的患肢出现足心、足趾发热发麻感。对患肢运动、感觉恢复帮助较大。在治疗外伤性截瘫中运用督脉，夹脊穴局部取穴，配合头针、足针远端取穴，可使全身经脉气血贯通上下，流畅全身，加快废用功能的康复。

参考文献

- [1] 熊华, 何扬子. 电针治疗脊髓损伤 17 例疗效分析. 海南医学, 1995, 6 (2): 107~110
- [2] 裴萍芝, 郭静, 江宁. 电针刺治疗不完全性截瘫 30 例疗效总结. 中国医刊, 1999, 34 (4): 45~46
- [3] 欧阳学, 管敬华. 脊柱外伤性截瘫的针刺治疗. 针灸临床杂志, 2003, 19 (5): 13
- [4] 邹仁明. 排针疗法为主治疗外伤性截瘫 32 例. 新中医, 1999, 31 (10): 29
- [5] 盛国滨, 唐英. 应用齐刺法治疗外伤性截瘫 48 例. 中医药学报, 2002, 30 (1): 40~41
- [6] 张小娥, 王书红, 王太生. 针刺督脉穴为主治疗外伤性截瘫 14 例. 山西中医, 1995, (1): 38
- [7] 王玲. 针灸治疗外伤性截瘫 149 例临床观察. 针灸临床杂志, 2005, 21 (3): 19~20
- [8] 丁淑强. “醒脑开窍针刺法”为主治疗外伤性截瘫 98 例疗效观察. 针灸临床杂志, 1998, 14 (5): 18~20
- [9] 成道友, 唐植纲, 万芳圆. 电针加推拿分期治疗外伤性截瘫 27 例疗效观察. 针灸临床杂志, 2001, 17 (3): 20
- [10] 秦家超. 督脉温针治疗截瘫疗效分析. 中医外治杂志, 2002, 11 (4): 42
- [11] 米建平, 蒙昌荣, 李建强. 以华佗夹脊穴及背俞穴为主治疗截瘫疗效观察. 中国针灸, 2000, (9): 517~520
- [12] 刘志良. 针灸为主治疗外伤性截瘫 224 例临床观察. 针灸临床杂志, 2001, 17 (5): 25~26
- [13] 谭晓红, 章威, 刘伍立, 等. 针灸为主综合治疗外伤性截瘫 53 例. 湖南中医药导报, 1996, 2 (6): 11~12